

Maximiliano Peverelli

**CAMPO, PRÁCTICA
Y EXPERIENCIA DE UNA CLÍNICA
ENTRE VARIOS**

ACOMPañAMIENTO TERAPÉUTICO EN EQUIPO

Con la colaboración de

Lucas Minervino - Diego Zafa Valenzuela - Bruno Pietracatella
Miranda Soriano Dagnino - Franco de Negri - Natalia Rotbard
Carlos Bove - María Noelia Gómez González - Nicolás Isla
Rodrigo Santillán - Laura Ramírez Montoya - Ezequiel Urribarri
Analía López - Vanesa Carballo

*Letra
Viva*

Autor, nombre

Título del libro

- 1ª ed. - Buenos Aires: Letra Viva, 2023

XXX p.; 23 x 16 cm.

ISBN XXXXXXXXX

1. Psicoanálisis. I. Título

CDD 150.195

© 2023, **Letra Viva, Librería y Editorial**

Av. Coronel Díaz 1837, (1425) Ciudad de Buenos Aires, Argentina

Tel. (54 11) 4825-9034

WEB PAGE: www.letravivalibros.com / E-MAIL: editorial@letravivalibros.com

DIRECTOR: LEANDRO SALGADO

ASISTENTE EDITORIAL: NADIR MANRIQUE SALIM

© 2023, **Nombre autor/a**

E-MAIL: maildelautor@xxxxxxx.com

Corrección: XXXXXXXXX

Arte de tapa: XXXXXXXXX

Primera edición: XXXXXX de 2023

Impreso en Argentina - *Printed in Argentina*

Queda hecho el depósito que marca la Ley 11. 723

Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra bajo cualquier método, incluidos la reprografía, la fotocopia y el tratamiento digital, sin la previa y expresa autorización por escrito de los titulares del *copyright*.

ÍNDICE

Prólogo de Pablo Dragotto y María Laura Frank	7
Introducción	9
El equipo Ágora: Una historia entre muchos.	11
Nota al lector. Sobre el marco de experiencia que recorre este libro	15

Primera parte

ACTUALIDAD DEL ACOMPAÑAMIENTO TERAPÉUTICO

CAPÍTULO 1

Apuntes sociopolíticos	19
----------------------------------	----

CAPÍTULO 2

El acompañamiento terapéutico hoy	23
---	----

Segunda parte

FUNDAMENTOS CONCEPTUALES

Capítulo 3

La propuesta pedagógica	39
-----------------------------------	----

CAPÍTULO 4

La clínica del acompañante	51
--------------------------------------	----

Tercera parte

LA IMPLEMENTACIÓN DEL DISPOSITIVO: CLÍNICA ENTRE VARIOS Y TRABAJO EN EQUIPO

Introducción	121
------------------------	-----

CAPÍTULO 5

El equipo en acompañamiento terapéutico. 123

CAPÍTULO 6

Fundamentos de la coordinación en acompañamiento terapéutico 135

CAPÍTULO 7

La experiencia de coordinación 151

CAPÍTULO 8

La clínica entre varios. 179

Cuarta parte

ÁMBITOS DE INSERCIÓN Y EXPERIENCIAS DEL CAMPO AT

CAPÍTULO 9

Territorios del acompañamiento terapéutico.

Diálogos, tensiones y prácticas situadas 187

Quinta parte

Módulo 4

LA GESTIÓN DEL EQUIPO

CAPÍTULO 10

Organizar para cuidar. 233

CAPÍTULO 11

La articulación con los financiadores 245

CAPÍTULO 12

La gestión como herramienta de articulación 257

Bibliografía. 269

Para contactos con el autor del libro y sus colaboradores.... . 271

PRÓLOGO

El libro que ha llegado a tus manos es un objeto precioso, comparable con esas piedras que han necesitado millones de años para formarse a través del influjo de las fuerzas y elementos naturales, o algunos productos del ser humano, como un buen queso, un vino o un dulce, que requieren paciencia, trabajo, saber y tiempo para lograr un resultado que el paladar entrenado puede distinguir y disfrutar. Es posible que cuando comiences a leer sientas el impulso de avanzar a toda velocidad y devorarte el texto en una sentada. ¡Adelante! Date el gusto. No osaríamos intentar frenarte ya que lo mismo hemos hecho. Pero sí, te invitamos a volver luego al texto con tiempo, sin prisa, a descubrir sus matices, sus aromas sutiles, producto de la decantación reflexiva de muchos años de experiencia en el trabajo compartido del equipo Ágora coordinado por Maxi Peverelli. Como él lo dice: *una concepción del Acompañamiento como “clínica entre varios”, donde la intervención se anuda a una red de lectura, escucha y elaboración colectiva.*

Somos testigos de ese trabajo comprometido, sostenido en el tiempo con convicción en una idea de construcción colectiva de un conocimiento que surge, decanta, se destila desde la praxis concreta en la atención del padecimiento subjetivo de personas y grupos, que este equipo lleva a cabo todos los días desde hace más de 20 años, generando respuestas creativas, dispositivos potentes y hospitalarios al mismo tiempo, poniendo en acto el pensamiento complejo para abordar situaciones complejas.

Nos conocimos con Maxi despuntando el siglo en alguna jornada o congreso de acompañamiento terapéutico, compartimos espacios de discusión, generamos talleres de intercambio de equipos de acompañamiento, en Córdoba, Buenos Aires y tantos lugares de nuestro país y de Latinoamérica. Tantas veces le pedíamos “Maxi, escribí. Escriban lo que hacen porque es impresionante.” Pasaban los años y, más allá de las presentaciones en los congresos, siempre interesantes, que nos dejaban

pensando ideas nuevas, el libro no llegaba. Ahora entendemos que el libro se estaba macerando, elaborando en el taller grupal, destilándose en el alambique artesanal, reposando en las barricas elegidas, discutiéndose en las asambleas de equipo, para llegar a plasmarse en estas páginas que hoy tenemos el placer de tocar y recorrer con la mirada, para que la explosión de ideas, imágenes y escenas sacuda nuestro pensamiento.

Basta recorrer el índice para notar que no se trata de un libro *acerca del* acompañamiento terapéutico, sino un libro escrito por acompañantes de vasta experiencia y amplia formación, con deseo y fuerzas de producir conceptos y transmitir un modo de hacer clínica en contextos de vida cotidiana. Práctica situada que reflexiona sobre el campo, en la realidad socioeconómica de Argentina en esta época. Lejos de intentar trasladar y adaptar teorías y dispositivos generados en otros contextos, Maximiliano Peverelli y los autores que lo acompañan, producen teoría desde los dispositivos de tratamiento generados aquí, con las particularidades del sistema de salud argentino, discutiendo con obras sociales, prepagas, equipos de clínicas y hospitales, auditores, la burocracia en todas sus manifestaciones. Los temas abordados, el estilo claro, directo y, particularmente, las situaciones y escenas desplegadas en los textos que componen este libro lo convierten en una referencia valiosa para el campo de la salud mental, en especial para quienes ejercemos la docencia en universidades públicas donde se forman hoy los y las acompañantes terapéuticos/as.

Celebramos la edición de *Campo, práctica y experiencia de una clínica entre varios. Acompañamiento Terapéutico en Equipo*, recomendamos efusivamente su lectura y deseamos que este sea el primero de la serie de libros de Maximiliano Peverelli y de los colegas de Ágora.

Pablo Dragotto y María Laura Frank
Córdoba, septiembre de 2025.

INTRODUCCIÓN

Este libro nace de una experiencia. Pero no de cualquier experiencia, sino de una que supo ser sostenida, interrogada y colectivamente pensada durante años por un equipo de Acompañamiento Terapéutico. Una experiencia que, por su espesor clínico, por su apuesta política y por el modo en que supo organizarse, exigía ser contada. Durante mucho tiempo compartimos fragmentos de este recorrido en congresos, clases y espacios de formación. Sin embargo, sentíamos que algo quedaba disperso, como si aún nos debiéramos una escritura capaz de reunir aquello que fuimos construyendo entre varios. Este libro es, en ese sentido, una forma de reunir, de dar cuerpo, de transmitir.

Aunque el proyecto comenzó con una escritura individual, su materia es profundamente colectiva. Nada de lo que aquí se desarrolla es producto de un autor aislado. Por el contrario, lo escrito condensa tensiones, discusiones, decisiones compartidas y formas de hacer que fueron surgiendo en el entramado mismo del trabajo en equipo. Este no es un libro sobre un modelo acabado, sino el testimonio vivo de una práctica que fue encontrando, con el tiempo, su propia forma.

El texto se inscribe en una hipótesis que recorre todas sus páginas: el Acompañamiento Terapéutico encuentra su mayor potencia en el efecto superador que emerge cuando varias implicaciones logran articularse con honestidad, responsabilidad y compromiso genuino. Se trata de una práctica que, para sostener su dimensión clínica, requiere de un equipo que la piense, que la sostenga, que la aloje.

A lo largo del texto, intentaremos desarrollar una concepción del Acompañamiento como “clínica entre varios”, donde la intervención se anuda a una red de lectura, escucha y elaboración colectiva. Esta orientación no es sólo clínica, sino también política: disputar el sentido de lo terapéutico implica, en muchos casos, construir las condiciones institucionales para que el trabajo entre varios sea posible.

Uno de los aportes centrales de este libro es el desarrollo conceptual y operativo de la figura del coordinador, entendido como una función clínica insoslayable para la organización del dispositivo. No hablamos aquí de un rol administrativo o de un supervisor distante, sino de alguien que participa activamente en la construcción del caso, en el sostenimiento del lazo entre el equipo y en la estrategia general de la intervención. En este punto, creemos que el libro aporta una formalización inédita para el campo.

La organización de los capítulos retoma el recorrido formativo que brindamos dentro FUNDAT. Iniciamos con un análisis del contexto sociohistórico que enmarca la práctica del AT en la Argentina, para luego avanzar sobre los fundamentos conceptuales y clínicos del hacer del acompañante. En una tercera sección, nos detenemos en las condiciones de implementación del dispositivo: el equipo, la coordinación, la reunión como espacio de pensamiento compartido. Finalmente, abordamos las articulaciones posibles con otros campos —educativo, jurídico, institucional— y los efectos que produce el entramado del sistema de salud, incluyendo también una mirada crítica sobre el financiamiento de la prestación, aspecto pocas veces tematizado en textos sobre AT.

Este libro está dirigido a acompañantes terapéuticos, profesionales de la salud mental, estudiantes en formación y a todas aquellas personas que deseen acercarse a esta práctica desde una perspectiva crítica y comprometida. Queremos que funcione como herramienta, como punto de apoyo, como provocación. Que quien lo lea pueda vislumbrar que el trabajo en equipo es posible, que organizar acompañantes no es un lujo sino una necesidad clínica, y que pensar(se) entre varios no solo potencia el recurso, sino que lo cuida, lo complejiza y lo dignifica.

En definitiva, este libro es una apuesta. Apuesta a que contar una experiencia no es solo narrar lo hecho, sino intervenir en un campo en disputa. Ojalá estas páginas sirvan para seguir abriendo caminos, sosteniendo prácticas vivas y construyendo, en cada escena, un modo de acompañar que no renuncie a su dimensión ética ni a su potencia transformadora.

EL EQUIPO ÁGORA

UNA HISTORIA ENTRE MUCHOS

Hay historias que no empiezan en una fecha. Empiezan en un malestar, en una inquietud compartida, en un gesto de incomodidad frente a lo dado. Ágora empezó así. No como un proyecto fundacional claro y delineado, sino como un intento por habitar una práctica. O mejor dicho, por construir un modo posible de estar con otros en el territorio incierto del padecimiento subjetivo.

Recuerdo las primeras reuniones: éramos pocos, pero con muchas ganas de pensar. Estudiantes, recién graduados de la carrera de psicología, algunos haciendo sus primeras experiencias clínicas. Nos encontrábamos en cafés, en aulas vacías o en casas prestadas. Hablábamos del Acompañamiento Terapéutico como algo que intuíamos más que conocíamos. Nos resonaban ciertas referencias —el nombre de Masotta, los aportes de Pichon Rivière y sus continuadores, la experiencia de La Borde, el modelo italiano de Trieste— pero todavía no sabíamos cómo hacer con eso en nuestra ciudad, con nuestras coordenadas, con nuestros pacientes.

En aquellos primeros años —hablamos del 2003, quizás incluso antes— nos identificábamos como equipo, pero no siempre lográbamos materializar esa pertenencia en una práctica concreta. Había deseo, había encuentros, había una ética que empezaba a insinuarse, pero lo que no había era trabajo. O, al menos, no el suficiente. Como decía Pichon Rivière, lo que convoca al grupo es la tarea¹, y cuando la tarea escasea, el lazo se vuelve frágil, por más deseo que exista. Nos sosteníamos más en la apuesta que en la certeza. Hubo momentos duros en que alguno abandonó, descreído de la potencia del proyecto, empujado por necesidades urgentes o por la sensación de que esto no terminaría

1. En su libro *El Proceso Grupal* (1971, Nueva Visión), Pichón-Rivière propone que el eje que cohesiona un grupo operativo no son las personas ni las figuras de autoridad, sino la tarea que los reúne. Nada mueve ni organiza tanto al grupo como aquello que debe ser resuelto o construido colectivamente. Va a decir textualmente “Un grupo se constituye en torno a una tarea. La tarea es el factor que estructura al grupo, el motivo que da sentido a su existencia”.

de funcionar. Era lógico. Estábamos fundando algo que todavía no tenía existencia real. El equipo era más un horizonte que una práctica.

Fue recién unos años después, cerca del 2006, cuando un caso clínico exigente, en domicilio, nos obligó a indagar otra forma de intervenir. No fue una decisión teórica, fue una urgencia. Un caso que nos impuso encontrarnos de otra manera, con otra responsabilidad. Allí se hizo evidente que no alcanzaba con que un solo acompañante estuviera presente, independientemente de la carga horaria que pudiera cubrir. El peso clínico de esa presencia implicaba una trama más densa. Había que construir equipo. Hacía falta que operara un coordinador: alguien que pudiera introducir una *terceridad como soporte de la función*², que pudiera escuchar los bordes, leer los movimientos y promover la articulación desde un lugar por fuera de la escena. Incluso la conversación con las diferentes instancias (Familia, tratantes y paciente) tenía que ser continua, y trascender la presencia específica del acompañante. Ya habíamos experimentado Acompañamientos en los que más de un acompañante intervenía, pero en este caso algo era novedoso. No era posible solo acompañar, era indispensable mantenerse entre varios.

Ese modelo artesanal que fuimos hilando para ese caso paradigmático, se volvió después nuestra brújula. Lo fuimos sistematizando con cada nuevo Acompañamiento, aprendiendo en la práctica y, sobre todo, discutiendo en las reuniones. Ahora empezó a tomar forma como espacio clínico y político. No por una estructura jerárquica o institucional, sino porque nos encontrábamos a pensar qué hacíamos y por qué. En este sentido, acompañar implicaba también alojar las preguntas que no tienen respuesta inmediata.

Después vinieron los cruces con otras experiencias. La articulación con Ariel Rondinone y su trabajo en INEBA fue un punto clave. Ahí se consolidó algo de nuestro posicionamiento clínico: la importancia de la figura del coordinador, el valor de las reuniones, la idea de que el Acompañamiento debía estar enlazado a un equipo, nunca solo.

Pero también surgió otro dilema. O, más bien, una serie de decisiones y apuestas. No se trataba únicamente de pensar en la accesibilidad del recurso —aunque ese era un interrogante ético y político central—, sino también de una necesidad concreta: queríamos crecer como equipo, consolidarnos como dispositivo y, al mismo tiempo, transmitir un modelo

2. Será un tema central que trabajaremos en torno a las funciones del coordinador unos capítulos más adelante

propio de organización para la implementación del Acompañamiento Terapéutico. Imaginábamos que, si lográbamos generar una demanda sostenida de Acompañamientos, podríamos construir una estructura de trabajo más sólida, que contuviera las condiciones inciertas de una tarea históricamente fragmentaria.

Sabíamos que uno de los grandes desafíos de esta práctica es su inestabilidad: La experiencia nos había enseñado que los tratamientos muchas veces se interrumpen sin aviso, que las decisiones de corte o continuidad rara vez pasan por quienes sostenemos el trabajo cotidiano. Por eso, proyectamos un modo de funcionamiento que permitiera a cada acompañante intervenir en varios tratamientos de forma simultánea. La idea era sencilla, pero potente: que cada uno pudiera cubrir los horarios que deseara sin que su economía quedara atada a los vaivenes de un único caso. Esa decisión —aparentemente operativa— era en realidad una apuesta de gestión profundamente anclada en una concepción clínica: queríamos crecer como equipo sin perder el carácter artesanal que había dado origen a nuestras intervenciones.

Allí se jugaba una de nuestras tensiones fundantes, que todavía hoy nos acompaña: cómo sostener la singularidad del Acompañamiento en un marco colectivo que, en algunos momentos, también puede tornarse masivo.

Así, mientras trabajábamos por generar condiciones de acceso más equitativas —abrir el diálogo con las obras sociales, establecer honorarios accesibles, constituirnos jurídicamente (así nace FUNDAT)—, trazábamos al mismo tiempo una estrategia organizativa que nos permitiera sostener al equipo como tal. Definimos tiempos compartidos, estructuramos espacios de reunión, formalizamos instancias de decisión clínica, y sostenemos hasta hoy un principio que nos orienta: ninguna lógica administrativa debe pesar más que la discusión clínica al momento de decidir sobre un caso.

Todo este andamiaje fue gestando a Ágora no sólo como un nombre o una pertenencia simbólica, sino como una práctica, un posicionamiento y una forma concreta de acompañar.

Apostar al crecimiento del equipo fue también una forma de contagiar una modalidad de implementación del dispositivo de Acompañamiento Terapéutico. Fue una decisión política, y como toda decisión de ese tipo, trajo consecuencias. Crecimos. Llegaron más casos, más derivaciones, más acompañantes. Y con ese crecimiento, nuevas preguntas: ¿cómo sostener la ética clínica frente a la masividad? ¿Cómo garan-

tizar la calidad de la intervención sin caer en la burocratización? ¿Cómo transmitir una forma de trabajo sin convertirla en un protocolo vacío?

Una de las respuestas fue organizativa: consolidamos agendas, estructuramos las reuniones por caso, exigimos la participación activa de quienes intervenían. Pero la respuesta más profunda fue conceptual. Empezamos a pensar la transmisión de la experiencia como una práctica de formación situada. Así nació el programa de formación de FUNDAT: no como una grilla de contenidos a memorizar, sino como un espacio para volver a discutir, para reproducir las preguntas, para pensar en voz alta desde los casos reales. Mucho de esto está atravesado por lo que fuimos leyendo y debatiendo en todos estos años: el psicoanálisis, las discusiones sobre la lógica manicomial y los procesos de desinstitucionalización, la crítica al modelo médico hegemónico, la perspectiva social de la discapacidad, los aportes de la salud mental comunitaria. Nos sentimos parte de esa historia, la que empezó en Río Negro, en San Luis, la que tomó fuerza en la Ley Nacional de Salud Mental, la que cada día se juega en la singularidad de un Acompañamiento en la calle, en una plaza, en un hogar.

Hubo momentos felices y otros duros. Como todo equipo, pasamos por despedidas, crisis, reconfiguraciones. Algunos compañeros se fueron, otros llegaron. La historia de Ágora no es la de un grupo estable, sino la de un colectivo en movimiento. Lo que se sostuvo —y se sigue sosteniendo— es una forma de entender la práctica. Una forma que se rehúsa a la lógica del profesional liberal y que apuesta, en cambio, a una clínica del entre. Entre acompañantes. Entre institución y vida cotidiana. Entre lo que sabemos y lo que aún no.

Por eso decimos que el saber del Acompañamiento no está en uno, sino entre varios. Que no se trata de aplicar un modelo, sino de sostener una posición. Una posición que se construye en cada intervención, pero que también se hereda de una historia colectiva. La de Ágora, sí. Pero también la de tantos otros que inventaron caminos antes que nosotros.

Este libro es una invitación a recorrer esa historia. A poner en palabras lo que fuimos construyendo con el tiempo, con los cuerpos, con las decisiones compartidas. No es un manual ni una receta. Es una bitácora. Un testimonio. Un gesto de transmisión. Porque creemos, como dice una de nuestras frases más queridas, que el Acompañamiento es siempre una práctica instituyente. Y como toda práctica instituyente, se vuelve verdadera solo cuando otros pueden retomarla, discutirla, habitarla a su manera.

NOTA AL LECTOR

SOBRE EL MARCO DE EXPERIENCIA QUE RECORRE ESTE LIBRO

Es importante, antes de avanzar en la lectura, introducir una aclaración que servirá de marco para los capítulos que siguen. La experiencia de trabajo que aquí se relata —la del equipo Ágora— se ha construido fundamentalmente a partir de un modelo de Acompañamiento Terapéutico desarrollado en el ámbito domiciliario y en estrecha articulación con tratamientos en salud mental.

Esta especificidad no pretende excluir otras formas de implementación del dispositivo, sino situar con claridad el recorte desde el cual se produce esta elaboración. Existen múltiples escenarios en los que el Acompañamiento se inserta —instituciones educativas, servicios sociales, instituciones psiquiátricas, entre otros— y cada uno de ellos conlleva condiciones particulares de intervención. Si bien comparten una orientación común en relación a la función del acompañante, requieren consideraciones específicas para pensar su puesta en acto. En este sentido, lo que aquí se transmite debe leerse desde esta experiencia situada, sin pretensión de generalización, pero con la expectativa de abrir interrogantes y resonancias posibles.

Cabe señalar que, de manera paralela al desarrollo del trabajo en el ámbito domiciliario, hace ya más de quince años comenzamos una experiencia de implementación de Acompañamiento Terapéutico en contextos escolares y otra experiencia de Acompañamiento Terapéutico grupal en el marco de una internación psiquiátrica para niños, niñas y adolescentes. La complejidad y particularidad de esos campos derivó rápidamente en una separación de los equipos, en tanto las lógicas de funcionamiento institucional, los marcos normativos y las dinámicas de intervención resultaron, en muchos sentidos, excluyentes entre sí.

Esta escisión no respondió a una valoración jerárquica, sino al reconocimiento de que se trata de modalidades que requieren abordajes y estructuras de trabajo diferentes, con lenguajes y objetivos clínico-pedagógicos no siempre compatibles.

Más avanzados en el libro, haremos un breve acercamiento por estos ámbitos alternativos del Acompañamiento, no solo para delimitar sus particularidades y bordes de intervención, sino también para advertir algunas de las dificultades con las que nos hemos encontrado al intentar sostener allí la práctica.

Del mismo modo, la experiencia profesional en otros espacios institucionales fue nutriendo nuestra perspectiva. En particular, quisiera señalar los diez años de trabajo que desarrollé como perito en los equipos interdisciplinarios de las Defensorías Públicas Curadurías, dependientes de la Defensoría General de la Nación. Allí, en diálogo constante con el sistema judicial y los dispositivos del sistema de salud, fue posible comprender no solo las tramas administrativas y jurídicas que atraviesan a las personas con padecimientos subjetivos, sino también las dificultades estructurales que presenta nuestro país en términos de accesibilidad, recursos y coordinación intersectorial. Esa experiencia, sin duda, ha dejado una marca indeleble en la forma en que en Ágora concebimos hoy el Acompañamiento Terapéutico y la gestión del equipo: como una práctica clínica situada, sensible a las condiciones materiales de existencia, y anclada en una perspectiva de derechos que no se limita al enunciado normativo, sino que se verifica en el modo concreto en que habitamos nuestra tarea.

Primera parte

ACTUALIDAD DEL
ACOMPANAMIENTO TERAPÉUTICO

Capítulo 1

APUNTES SOCIOPOLÍTICOS

Buscando fundamentos - ¿Desde donde pensamos?

Antes de desplegar las formas concretas que asume el Acompañamiento Terapéutico, es necesario detenernos a pensar desde dónde lo estamos nombrando. No alcanza con definir sus funciones ni con describir las escenas donde interviene. Es necesario producir las condiciones de significación que permitan comprender por qué este dispositivo aparece, en el campo de la salud mental, como una figura posible y necesaria. Este capítulo busca precisamente eso: generar un marco de lectura que no solo sitúe al Acompañamiento en su especificidad, sino que lo inscriba en un contexto determinado, en un modo de entender el padecimiento, el lazo social y la transformación subjetiva.

Pensar el Acompañamiento Terapéutico implica, entonces, pensar también la salud mental. ¿Qué entendemos por salud, qué formas de cuidado promovemos, qué instituciones y discursos organizan nuestras intervenciones?

Apuntes ligados al desarrollo del Acompañamiento Terapéutico

Hace algún tiempo me crucé con una frase que, sin saber si era una cita literal o una elaboración surgida de alguna lectura, me quedó resonando con fuerza: “La relación social es lenguaje”. Desde entonces, no he dejado de volver a ella, de dejarme interpelar por sus implicancias. Porque en esa frase se condensa una forma de entender el mundo, una perspectiva que toca aspectos profundos sobre lo humano y sobre la forma en que construimos sentido. Allí se sintetiza una visión en la que el lenguaje no es simplemente una herramienta para comunicar, sino el entramado mismo en el que se teje nuestra experiencia del mundo.

El lenguaje nos atraviesa, nos constituye, nos sitúa en una red de representaciones que hacen posible la existencia compartida. Nuestra realidad, lejos de presentarse como un dato objetivo y verificable, se organiza más bien como una ilusión ordenada de representaciones, un sistema simbólico que da coherencia a lo que vivimos. Esta idea fue formulada con contundencia por Friedrich Nietzsche, al afirmar que “no hay hechos, solo interpretaciones”¹. La realidad no es una superficie plana, sino un campo de disputas donde se juega qué puede ser dicho, qué debe ser callado, qué se considera verdadero o legítimo. Se marca así la imposibilidad de agotar el sentido de un hecho en una única lectura. Siempre se podrá decir algo más, mirar desde otro ángulo, construir otra versión. Lo real, entonces, no es un punto fijo, sino un entramado abierto de interpretaciones en disputa.

También desde las ciencias sociales encontramos desarrollos que abonan esta perspectiva. Berger y Luckmann en su ya clásico trabajo sobre La construcción social de la realidad, sostienen que “el lenguaje no solo sirve para describir el mundo, sino que lo constituye”². Al hablar, al narrar, al compartir símbolos, vamos generando consensos sobre lo que es verdadero, válido, real. Decían que el lenguaje construye enormes edificios de representación simbólica que acaban por dominar la vida cotidiana como si fuesen presencias de otro mundo: la religión, la ciencia, el arte, la filosofía. Es decir, todo saber es también una forma de ordenar el mundo, de establecer jerarquías de sentido, de decidir qué merece ser dicho y qué queda silenciado.

Pierre Bourdieu, en esta misma línea, conceptualizó estos sistemas simbólicos como campos. Todo saber –la ciencia, la medicina, el derecho, la salud mental– es un campo atravesado por tensiones, por disputas internas, por relaciones de fuerza. En cada campo se lucha por imponer una manera legítima de nombrar, de explicar, de intervenir. Los agentes que participan en él ocupan posiciones determinadas, con mayor o menor capital simbólico, y desde allí actúan para conservar o transformar el orden vigente. Nadie habla desde fuera del campo: todo enunciado está situado, toda práctica es una toma de posición. Y esas posiciones no son neutras: son políticas.

1. Nietzsche, F. (2004). *La genealogía de la moral*. Madrid: Alianza Editorial.

2. Berger, P. L. & Luckmann, T. (1995). *La construcción social de la realidad*. Buenos Aires: Amorrortu.

En ese marco, el Acompañamiento Terapéutico debe ser entendido como una práctica situada dentro del campo de la salud mental. No es un saber autónomo, ni una técnica neutral que se añade a otras. Es una construcción de sentido que interviene en un entramado de discursos, instituciones y poderes. El paciente que acompañamos, las situaciones que abordamos, los modos de intervención que desarrollamos, todo ello forma parte de una red de significaciones en tensión. Nuestra tarea se despliega en medio de fuerzas contradictorias, de miradas que se enfrentan o se solapan, de prácticas que se refuerzan o se cuestionan mutuamente. Y en ese escenario, también el acompañante terapéutico toma posición.

Es importante tenerlo claro: nuestra intervención no es la aplicación aséptica de una técnica previamente definida. Es una práctica ética y política, en el sentido más profundo del término. No se trata de política partidaria, sino del modo en que elegimos habitar el mundo, de la manera en que nos posicionamos frente al sufrimiento, a la diferencia, al poder. Hay en el discurso del Acompañamiento Terapéutico una serie de preceptos que revelan con claridad esta orientación. Uno de ellos, frecuentemente citado, sostiene que el Acompañamiento es un dispositivo favorecedor de la integración social. ¿Qué implica esta afirmación? ¿Qué consecuencias tiene en nuestra práctica cotidiana?

La noción de integración social proviene de un linaje que no es menor. Está inscripta en las transformaciones que impulsaron las reformas psiquiátricas, en las críticas formuladas por la antipsiquiatría, en los movimientos que pusieron en cuestión la lógica de segregación manicomial. El nacimiento del Acompañamiento Terapéutico en Argentina, en las décadas de 1970 y 1980, no puede desligarse de ese contexto histórico. Fue, en parte, una respuesta a los límites del modelo médico-hegemónico, una práctica que comenzó a abrir otras posibilidades en la escena clínica y social.

Un referente clave de esa época fue el psiquiatra Franco Basaglia, impulsor del proceso de desmanicomialización en Trieste, Italia. En su texto “La utopía de la realidad” escrito en 1974, Basaglia responde a una consulta sobre cómo imaginar un servicio de salud mental ideal para una población de cien mil habitantes. Pero en lugar de proponer una organización técnica, decide cuestionar la base misma de la pregunta. Dice que no es posible pensar una estructura sin antes revisar la representación social que sostiene la relación entre quien brinda atención y quien la recibe. Para él, no existe neutralidad técnica. Toda intervención

está cargada de sentido, de ideología, de modelos de vínculo humano. No hay forma de ejercer una práctica sin que eso implique, a su vez, una forma de entender el mundo.

La institución manicomial –sostiene Basaglia– no es simplemente un edificio, sino la cristalización de una relación asimétrica entre el que sabe y el que no sabe, entre el que enuncia y el que es enunciado. El profesional aparece como portador del saber legítimo, y el paciente queda reducido a objeto de ese saber. La medicina, incluso en su forma más aparentemente objetiva, también responde a una lógica de poder y de exclusión. La ciencia, en este sentido, no es neutral.

Es en este marco que cabe preguntarse: ¿cuáles son las coordenadas políticas del Acompañamiento Terapéutico? ¿Desde dónde hablamos, intervenimos, acompañamos? ¿Qué lugar le damos al otro en nuestra práctica? Asumir que el lenguaje constituye lo social, que no hay neutralidad, que toda práctica es una forma de vínculo, nos obliga a revisar continuamente nuestra posición. Nos invita a reconocer que el Acompañamiento Terapéutico no es un saber cerrado, sino una práctica viva, situada, atravesada por tensiones y por historias. Y, sobre todo, que acompañar implica comprometerse con una forma del lazo que restituya al sujeto su lugar en la trama social. Porque, en definitiva, como decía aquella frase inicial, la relación social es lenguaje. Y acompañar es, también, una manera de hablar con otros el mundo que habitamos.

Capítulo 2

EL ACOMPAÑAMIENTO TERAPÉUTICO HOY

La práctica en expansión: entre lo singular y lo colectivo

Hoy, a más de cuatro décadas de sus primeras formulaciones, el Acompañamiento Terapéutico ha alcanzado un nivel de expansión y formalización que exige una revisión constante de sus fundamentos. Atraviesa, además, un momento de creciente visibilidad, colmado de tensiones y contradicciones que dan cuenta de su complejidad actual.

Lo cierto es que ya no se trata solo de un recurso alternativo para sostener externaciones o para evitar internaciones —como en sus orígenes más ligados a la desmanicomialización—, sino que se ha constituido como un campo de intervención que se inserta en territorios múltiples: escuelas, hogares, hospitales, comunidades, dispositivos de salud mental, centros de día, dispositivos de re-vinculación en el marco de procesos judiciales, servicios de protección de derechos, curadurías, entre muchos otros.

Esta multiplicidad de ámbitos refleja una de las mayores potencias del Acompañamiento: la posibilidad de inscribir lo terapéutico allí donde se produce la vida cotidiana. A diferencia de otras disciplinas o dispositivos que han sido incorporados tempranamente a las tramas institucionales de la salud y la educación, el AT ha debido —y aún debe— conquistar su legitimidad en un campo marcado por jerarquías disciplinares, resistencias corporativas y una tradición biomédica que tiende a subordinar lo clínico a lo prescriptivo.

El AT se posiciona en el extremo opuesto. No propone la cura como normalización ni la adaptación como objetivo. Su lógica de intervención se basa en la implicación, la presencia, la construcción del lazo y la lectura situada. La apuesta del Acompañamiento es alojar la diferencia, acompañar los tiempos del sujeto, sostener el lazo incluso en

los momentos en que este parece perderse. El acompañante no se ubica como quien dirige, sino como quien transita junto a otro un camino, interviniendo con su presencia, con su palabra, con su disponibilidad subjetiva. Por eso mismo, la función del acompañante no puede reducirse a un rol fijo: es función en acto, efecto de una transferencia, resultado de una lectura situada que requiere sostenerse en supervisión, en equipo, en redes.

La disputa a la que hacemos referencia no es solo una disputa epistemológica, sino también material: ¿quiénes toman decisiones sobre los dispositivos?, ¿qué prácticas son reconocidas como terapéuticas?, ¿qué intervenciones son financiadas por el sistema?, ¿quiénes acceden a las condiciones laborales mínimas para sostener la tarea? En este punto, la experiencia argentina en Acompañamiento Terapéutico se caracteriza por una marcada heterogeneidad: existen equipos sólidos que han logrado constituirse como referencia institucional, proyectos comunitarios que articulan con políticas públicas, cooperativas que han desarrollado formas autogestivas de organización del trabajo, y al mismo tiempo, acompañantes que permanecen en la informalidad, sin acceso a derechos básicos ni al reconocimiento profesional.

La multiplicidad de formas en que el AT se ejerce en el país expresa tanto su potencia como su fragilidad. Potencia de una práctica que ha sabido alojarse en los intersticios del sistema, en los pliegues de las políticas públicas, en los márgenes de la clínica institucionalizada. Fragilidad de una práctica que, en muchas ocasiones, sigue dependiendo del ingenio individual, de la buena voluntad de ciertos efectores o de la insistencia de quienes la sostienen. Esta tensión permanente entre invención y precariedad es uno de los rasgos distintivos de su estado de situación actual.

Sabemos que las condiciones de posibilidad de un Acompañamiento digno no dependen solo de las voluntades individuales, sino también de la existencia de marcos institucionales que reconozcan su valor; de políticas públicas o estrategias privadas de los financiadores que lo integren como parte del sistema de salud.

Sin embargo, resulta clave advertir que la consolidación del Acompañamiento Terapéutico no se juega únicamente en su inclusión formal dentro de los marcos regulatorios o las nomenclaturas prestacionales, sino en la capacidad de sostener una identidad discursiva propia. No alcanza con avanzar en normativas como si bastara con que una auto-

ridad externa viniera a ordenar el campo desde arriba. No se trata de esperar un padre que legitime por imposición. Lo que necesitamos es un crecimiento conceptual, una ampliación del campo desde donde el Acompañamiento pueda desplegar su potencia y disputar, en plano de igualdad, con otras disciplinas que abordan las mismas problemáticas.

Decíamos que no es solo una disputa epistemológica, pero no es sin esa disputa. Necesitamos una epistemología situada que dialogue críticamente con otros saberes, sin quedar subsumida por ellos. El AT no se define por lo que le falta para ser otra cosa —psicoterapia, intervención social, educación especial—, sino por su modo específico de habitar el lazo con el padecimiento. Fortalecer esa especificidad no implica encajarse en una identidad rígida, sino construir herramientas conceptuales que permitan sostener la práctica, defenderla, transformarla y desde allí apostar por su legitimación.

Esta especificidad, sin embargo, no puede pensarse al margen del campo social y político que la produce. La creciente presencia del AT en escenarios diversos —desde Acompañamientos judicializados hasta experiencias de inclusión educativa o comunitaria— implica también una exposición a los dispositivos de control, a las demandas de eficacia, a las lógicas de mercado. En ese cruce, el AT corre el riesgo de verse capturado por exigencias externas que desdibujen su apuesta clínica. De ahí la importancia de sostener instancias de formación, supervisión y organización colectiva que permitan resguardar el sentido ético y político de la práctica.

Reconocimiento, legitimación y riesgo de captura

El lugar que hoy ocupa el AT es, entonces, el de una práctica frontera: entre lo clínico y lo social, entre la escucha singular y el trabajo en red.

Hablar del Acompañamiento Terapéutico en la actualidad exige no solo definir un dispositivo, sino también tomar posición respecto del modo en que pensamos la salud, el padecimiento psíquico y la construcción del lazo social. Lejos de poder encasillarse en un formato único o en una función estrictamente técnica, el AT se ha constituido históricamente como una práctica en tensión: se despliega en los márgenes de lo instituido y, al mismo tiempo, busca habilitar nuevos modos de

institucionalidad. Es una práctica artesanal, colectiva, flexible; ligada a la singularidad de los recorridos subjetivos, pero sin desligarse de las coordenadas sociales que los atraviesan.

Quizás uno de los desafíos actuales más importantes del Acompañamiento Terapéutico sea evitar su fetichización. Resulta crucial alejarnos de la imagen del acompañante idealizado, casi heroico, que “salva” al paciente con su sola presencia como si fuera un actor excepcional, auto-suficiente, capaz de resolverlo todo por su cuenta. Esta mirada tiende a aislarlo del resto del sistema de salud, a sobrecargarlo emocionalmente y a desvirtuar la lógica colectiva del dispositivo. En el otro extremo, debemos estar atentos a eludir su burocratización. Necesitamos recuperar su cuerpo y evitar reducir al acompañante a un engranaje más dentro de una estructura formal, que simplemente cumple con protocolos, informes y horarios, sin una implicación real en la singularidad del padecimiento. En ese extremo, el AT se vacía de su potencia clínica, ética y vincular.

Ni héroe solitario ni engranaje institucional vacío. El acompañante por definición es alguien que se implica, que forma parte de un dispositivo clínico, que sostiene una posición frente al sufrimiento subjetivo. Sin embargo, esa implicación no puede sostenerse en soledad, ni basarse únicamente en la vocación o la intuición. Por ello, proponemos la consolidación de equipos de trabajo, la formación continua y el fortalecimiento de la articulación con otros actores del campo de la salud. Condiciones necesarias para que esa implicación no se transforme en desamparo, improvisación o arbitrariedad clínica.

En suma, el Acompañamiento Terapéutico en Argentina se encuentra hoy en un punto de inflexión: suficientemente instalado como para haber dejado de ser una rareza, pero aun disputando su lugar en el reparto legítimo de saberes. Su futuro dependerá, en buena medida, de la capacidad del campo de sostener su complejidad, de la capacidad de producir teoría a partir de la práctica, y de construir alianzas que permitan resistir su reducción a una función accesorio o a una práctica de baja intensidad clínica. Lo que está en juego, en última instancia, no es solo el destino de un dispositivo, sino el tipo de sociedad que queremos construir en relación con el sufrimiento y la diferencia.

El Acompañamiento Terapéutico, en tanto práctica que se inscribe en los márgenes de la clínica tradicional, ha sabido, desde sus inicios, habitar una zona de inestabilidad productiva. Esa inestabilidad no fue

solo precariedad, pues le permitió escapar del cerco de las disciplinas, no quedar fijado a un paradigma teórico único, y mantener una capacidad de invención que lo convirtió en una herramienta fundamental para alojar lo que otras prácticas no podían o no querían alojar. Sin embargo, lo que alguna vez fue una ventaja táctica se ha vuelto, en el contexto actual, una fuente de ambigüedad e incluso de riesgo.

La expansión del Acompañamiento Terapéutico en Argentina, su creciente presencia en territorios diversos y su incorporación parcial a sistemas de salud, educación y justicia, traen consigo un desafío que ya no puede posponerse: ¿es posible consolidar al AT como campo discursivo sin que esa consolidación lo vacíe de su potencia clínica? ¿Cómo ganar reconocimiento sin ser capturados por las lógicas burocráticas, prestacionales, normativas que muchas veces anulan aquello mismo que buscan legitimar?

No hay práctica clínica que pueda sostenerse de forma indefinida sin reconocimiento simbólico, institucional y material. Las y los acompañantes terapéuticos lo saben bien: sus trayectorias están marcadas por el trabajo en la informalidad, por el esfuerzo individual para sostener intervenciones complejas sin un equipo que las respalde, por la demanda permanente de legitimación ante efectores, auditorías o profesionales de otras disciplinas. En ese sentido, el deseo de consolidación, de reconocimiento, de inclusión plena en los sistemas de salud y protección social, es legítimo y urgente.

En las últimas décadas, se han producido avances significativos. Pero el reconocimiento no es neutral. Viene acompañado de exigencias, de regulaciones, de formas específicas de inscripción que no siempre dialogan con la especificidad del Acompañamiento. Es allí donde emerge la tensión.

Institucionalizar no es simplemente alojar: es también clasificar, controlar, reglamentar. Y muchas veces, al intentar encajar el Acompañamiento Terapéutico en los marcos existentes, se lo somete a lógicas que le son ajenas: la lógica del tratamiento estandarizado, la del tiempo cronometrado, la del objetivo medible, la de la técnica replicable. El riesgo es que, al ganar un lugar en el sistema, el AT pierda el lugar que le es propio.

Esto se expresa con claridad en ciertos modos de regulación prestacional: se exige que el Acompañamiento esté subordinado a diagnósticos previos, que se inscriba en marcos de duración limitada y bien

proyectados. Se pierde así la posibilidad de una lectura situada, de una clínica del lazo, de una escucha que no esté pautada por los tiempos del sistema administrativo sino por los tiempos del sujeto.

Lo mismo ocurre en el plano de la formación. A medida que se multiplican las ofertas educativas, también se expande el riesgo de una formación técnica, protocolar, desimplicada.

La masificación del Acompañamiento Terapéutico en los últimos años fue acompañada por la proliferación de espacios —formales e informales— de transmisión del saber. Este crecimiento, sin dudas necesario para ampliar el acceso y fortalecer la práctica, ha estado mayormente centrado en la construcción conceptual de la figura del acompañante. Se ha hecho un esfuerzo por delimitar funciones y definir características del rol. Sin embargo, esa transmisión centrada en la definición tiende a dejar por fuera un aspecto fundamental: las condiciones concretas para la implementación del dispositivo. Se enseña a “ser acompañante” sin atravesar el vacío subjetivo que esa función implica. Se forma en protocolos y no en posición clínica. Se aprende a intervenir, pero no a escuchar. Así, se produce un tipo de profesional que puede ser fácilmente insertado en el sistema, pero que no necesariamente encarna la apuesta clínica y ética que hace del AT una práctica singular.

Como resultado, muchos acompañantes egresan de sus formaciones creyendo que el saber adquirido es suficiente para contener cualquier situación, sin haber interrogado aún la estructura en la que ese saber debería inscribirse. Esto conlleva un problema que atenta contra la función misma: se consolida la idea de que el bienestar del paciente dependerá, en última instancia, de lo que el acompañante logre producir con su intervención. Así, el acompañante queda imaginariamente sobredimensionado, como si fuera un superhumano capaz de resolver por sí solo lo que en realidad solo puede tramitarse en el marco de un dispositivo.

En última instancia, el Acompañamiento Terapéutico—lejos de ser una herramienta dependiente de las capacidades individuales de quien lo ejerce— es un dispositivo que requiere condiciones institucionales para su inclusión, y cuya eficacia no radica en el saber del acompañante, sino en el modo en que se inscribe en una trama clínica, política y colectiva.

No hay práctica clínica que pueda sostenerse de forma indefinida sin reconocimiento simbólico, institucional y material

En este escenario de expansión y riesgo, en el que el Acompañamiento Terapéutico se consolida como una práctica reconocible pero aún en disputa, emerge con fuerza una pregunta que atraviesa al campo: ¿qué papel podría jugar una ley específica en la consolidación de esta práctica?

El debate sobre una Ley de Acompañamiento Terapéutico expresa, en buena medida, las tensiones que hemos venido desarrollando: el deseo de legitimación frente a los dispositivos que históricamente han marginado al Acompañamiento, pero también el riesgo de que esa legitimación se obtenga al precio de su burocratización o subordinación. En este apartado, nos proponemos revisar críticamente esa posibilidad. No para negar la necesidad de marcos legales, sino para pensar —desde la clínica, desde la historia del dispositivo, y desde sus potencias actuales— qué tipo de ley podría realmente habilitar y no clausurar, reconocer sin cristalizar. Porque cuando se legisla una práctica que nació en los márgenes, lo que está en juego no es solo su estatuto jurídico, sino su capacidad de seguir produciendo hospitalidad allí donde lo instituido aún no alcanza.

¿Qué ley para qué práctica?: entre regulación y deseo

En este escenario de disputa por el lugar, el saber y las condiciones de la práctica, aparece cada vez con más fuerza la propuesta de una Ley de Acompañamiento Terapéutico. Se trata de una demanda largamente sostenida por sectores del campo que buscan el reconocimiento jurídico y profesional de la figura del acompañante, la regulación de su formación y el acceso a derechos laborales específicos. La iniciativa suele presentarse como la vía natural hacia la consolidación definitiva de la práctica.

Sin embargo, su sola mención activa nuevamente la tensión que atraviesa al Acompañamiento desde sus orígenes. Sabemos que no toda legalidad garantiza legitimidad clínica, ni todo reconocimiento institucional resguarda la singularidad de una práctica. El debate sobre una eventual Ley de AT nos obliga, entonces, a preguntarnos qué ley, para qué práctica, en qué contexto, con qué efectos.

¿Una ley bien diseñada podría representar un avance sustancial en el proceso de consolidación del Acompañamiento Terapéutico como campo clínico específico? Lo que se pretende es otorgar un reconocimiento formal a la función del acompañante como actor clínico, no subordinado ni residual dentro del sistema de salud. Es un hecho ya comprobado que una ley permite establecer criterios comunes y mínimos para la formación, que garantizan una base ética y teórica compartida. No es tan claro, que una legislación de este tipo pueda asegurar, en términos generales, las condiciones laborales dignas, con acceso a derechos, estabilidad y reconocimiento económico. La expectativa, ampliamente compartida en el campo, es que una ley permita incorporar al Acompañamiento Terapéutico como prestación obligatoria dentro de los sistemas de salud públicos y privados, contribuyendo así a reducir las arbitrariedades que hoy persisten en su cobertura. Sin embargo, conviene advertir que una ley no garantiza por sí sola ese resultado. Ninguna normativa, por más precisa que sea, puede definir el uso efectivo que el sistema de salud hará de un recurso. Podrá establecer condiciones de acceso, regular marcos formales y delimitar responsabilidades, pero no tiene el poder de forzar su implementación concreta si no existe una voluntad institucional y política que lo respalde.

Por otro lado, el afán por una regulación deja velados algunos riesgos que dicha regulación también implica. Una ley ajena a la especificidad de la práctica podría tener efectos regresivos. Entre ellos, se encuentra el riesgo de normalizar de manera forzada una práctica que, por definición, requiere flexibilidad, invención clínica y una lectura situada de cada caso. Si bien persiste en el campo una voluntad de construir una identidad propia para el Acompañamiento Terapéutico, lo cierto es que aún no ha logrado consolidar una densidad conceptual suficiente que le permita disputar sentidos, ni construir un peso específico dentro del campo de la salud mental.

Esa fragilidad teórica tiene efectos concretos. En la actualidad, el Acompañamiento sigue dependiendo, en la mayoría de los casos, de una indicación realizada por equipos tratantes en el marco de un tratamiento clínico más amplio. Esa indicación, que podría pensarse como acto de terceridad, como una apertura al armado de un dispositivo específico, se traduce muchas veces —por inercia institucional o por desconocimiento— en una subordinación conceptual que relega al acompañante al lugar de un auxiliar operativo. Es una confusión frecuente: la

indicación clínica no implica jerarquía funcional, pero al no haber una conceptualización sólida del Acompañamiento como práctica autónoma, termina significándose como una función secundaria.

Una ley que no aborde críticamente este estado de situación corre el riesgo de cristalizar esa jerarquía implícita. Podría consolidar la subordinación del Acompañamiento a lógicas biomédicas estandarizadas, transformándolo en una técnica auxiliar, prescriptiva, despojada de su espesor ético-clínico. Asimismo, una legislación que no contemple la diversidad de experiencias territoriales, comunitarias y autogestivas que han sostenido al dispositivo desde sus inicios, podría desplazar esas formas de intervención en favor de un modelo único, homogéneo y centralizado.

Finalmente, el intento de definir por ley las funciones del acompañante podría derivar en la fijación de marcos rígidos y definiciones cerradas, que desdibujen la dimensión transferencial de la práctica y la conviertan en una tarea asistencial de baja intensidad clínica.

Lejos de habilitar la potencia del Acompañamiento, una normativa de ese tipo podría clausurarla. Por eso, insistimos: no se trata solo de tener una ley, sino de construir una ley que esté a la altura de la complejidad y del deseo que sostiene la práctica. Una ley construida sin clínica será apenas una norma más, útil para ordenar papeles, pero incapaz de resguardar el corazón de la intervención.

Más que confiar en la ley como solución automática, es necesario comprenderla como parte de una estrategia más amplia que combine regulación, formación, legitimación clínica y organización colectiva.

Sin embargo, en la actualidad del campo del Acompañamiento Terapéutico no se escuchan con claridad estos interrogantes. La construcción de los marcos legislativos se orientan hacia la construcción del rol. El modo en que se reclama la ley de Acompañamiento Terapéutico constituye una de las formas más evidentes en que se expresa la tensión entre consolidación y captura. Lo que se observa es que el eje dominante del reclamo gira en torno a la regulación de la relación con obras sociales y prepagas, con la esperanza de que una ley logre ordenar pagos, fijar valores prestacionales y evitar arbitrariedades.

En este marco, se ha vuelto habitual nombrar al acompañante como trabajador. Este giro tiene raíces legítimas: rompe con la mirada vocacional-sacrificial, visibiliza el desgaste emocional y habilita reclamos por derechos. Pero también tiene efectos: muchas veces, el acompa-

ñante como trabajador se presenta en oposición al acompañante como profesional clínico. La función queda vaciada de contenido, reducida a la tarea.

El problema no es reclamar condiciones laborales, sino hacerlo al costo de desplazar la dimensión clínica. Una legalidad que no contemple la especificidad de la práctica, que reduzca el Acompañamiento a un trabajo, termina empobreciendo lo que busca proteger.

El Acompañamiento Terapéutico está en un punto crítico. Consolidarse sin quedar capturado, regularse sin desactivarse, formalizarse sin burocratizarse. Esta es la tensión que deberá ser sostenida, pensada y discutida. No hay futuro para el AT sin derechos laborales, pero tampoco sin clínica. No hay ley posible sin deseo de práctica, ni práctica viva sin condiciones dignas.

El Acompañamiento no necesita una definición final. Necesita marcos que no impidan el gesto clínico, tiempos que no opaquen el lazo, regulaciones que no cierren la escucha. En definitiva, necesita una institucionalidad que no lo convierta en institución cerrada, sino en una red viva que sostenga su apuesta por alojar la diferencia.

La ley Nacional de Salud Mental y el AT

En el campo de la salud mental, las leyes no solo organizan prácticas: las habilitan, las limitan, las tornan visibles o las condenan al margen. El Acompañamiento Terapéutico encuentra su fuerza en la experiencia, pero también en el modo en que las leyes —aun sin nombrarlo— lo contienen, lo convocan y lo hacen posible.

En el apartado anterior, en el recorrido por la actualidad del Acompañamiento Terapéutico, nos permitimos dimensionar la complejidad de su posición en el campo de la salud mental: entre su potencia como práctica situada y los riesgos de su desactivación a través de formatos normativos ajenos a su lógica. En función de ello, y en ese contexto, resulta fundamental revisar cómo ha sido —o no— incorporado el AT en los marcos legales existentes.

La Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657, sancionada en 2010, representa un punto de inflexión en el diseño de políticas públicas en el área. Pero ¿qué lugar le otorga al Acompañamiento Terapéutico? ¿Cómo habilita —o limita— su desarrollo como dispositivo clínico singular?

Estas preguntas abren un nuevo eje de análisis que conviene abordar detenidamente.

Es sabido que la Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657 constituye un hito de inflexión en las políticas públicas argentinas. Vino a interpelar profundamente los modos de atención hegemónicos y a proponer, al menos en su letra, una transformación estructural del modelo de abordaje del sufrimiento psíquico.

No es menor que esta ley —reconocida internacionalmente por su enfoque de derechos— haya sido el resultado de una intensa lucha de movimientos sociales, colectivos de usuarios, profesionales, organismos de derechos humanos y experiencias territoriales que venían cuestionando las formas crónicas, asiladas y medicalizadas del tratamiento en salud mental. En esa genealogía, el Acompañamiento Terapéutico no aparece como una invención reciente, sino como una práctica ya en marcha, sostenida desde hacía décadas por equipos que venían haciendo cuerpo lo que la ley, tiempo después, inscribiría en el plano normativo.

Sin embargo, hay un dato que no puede pasarse por alto: la Ley Nacional de Salud Mental no menciona de forma expresa la figura del Acompañante Terapéutico. Tampoco lo hace su decreto reglamentario. Esa omisión —que podría interpretarse como un olvido, un gesto táctico o una desconfianza institucional— deja al Acompañamiento en una zona de reconocimiento parcial. Su inclusión queda librada a la interpretación de cada provincia, a las decisiones administrativas de los efectores de salud, a la voluntad política de los organismos intervinientes, o a la fuerza que los colectivos profesionales logren ejercer en su defensa y legitimación.

Pero que no se lo nombre no significa que no esté. En rigor, muchos de los principios que establece la ley constituyen un andamiaje potente para pensar y legitimar la práctica del Acompañamiento Terapéutico. Desde el artículo 7 en adelante, la ley establece que las personas tienen derecho a recibir atención en el ámbito más cercano a su vida cotidiana, con la menor restricción posible y mediante dispositivos comunitarios. El artículo 11 es aún más preciso: *“La Autoridad de Aplicación debe promover que las autoridades de salud de cada jurisdicción, en coordinación con las áreas de educación, desarrollo social, trabajo y otras que correspondan, implementen acciones de inclusión social, laboral y de atención en salud mental comunitaria. Se debe promover el desarrollo de dispositivos tales como: consultas ambulatorias; servicios de inclusión*

social y laboral para personas después del alta institucional; atención domiciliaria supervisada y apoyo a las personas y grupos familiares y comunitarios; servicios para la promoción y prevención en salud mental, así como otras prestaciones tales como casas de convivencia, hospitales de día, cooperativas de trabajo, centros de capacitación socio-laboral, emprendimientos sociales, hogares y familias sustitutas” (Ley 26.657, art. 11). En síntesis, el proceso de atención debe asegurar el mayor grado de inserción social y autonomía posible, evitando que la respuesta sea exclusivamente farmacológica o restrictiva de derechos. Esta afirmación, que interpela directamente las prácticas institucionales, constituye un respaldo implícito pero contundente a aquellas intervenciones que, como el Acompañamiento, se desarrollan en el territorio, sostienen el lazo con la comunidad y promueven la autonomía subjetiva.

El impulso hacia un modelo comunitario de atención, la sustitución del manicomio por estrategias territoriales, la necesidad de garantizar la vida en comunidad, el respeto por la singularidad subjetiva, la atención interdisciplinaria y la promoción de dispositivos que eviten internaciones innecesarias: todos estos lineamientos no solo son compatibles con el Acompañamiento, sino que lo vuelven una pieza clave en la arquitectura posible del nuevo modelo.

En ese sentido, puede decirse que la ley no promueve al Acompañamiento por nombramiento, pero sí por necesidad. Allí donde la internación prolongada deja de ser una opción legítima, donde se busca habitar la comunidad y sostener la vida cotidiana sin encierro, se vuelve imprescindible la presencia de figuras que puedan intervenir en la cotidianidad, sin medicalizar, sin excluir, sin normativizar el padecimiento. El Acompañamiento Terapéutico —con su posición cercana, su disponibilidad en el territorio, su apuesta por el lazo y por la escucha— responde justamente a esa exigencia. Responde con presencia, con práctica, con ética.

Este marco legal no es una isla. La Ley de Derechos del Paciente N.º 26.529 (2009) refuerza la centralidad del sujeto en los procesos de atención, estableciendo el derecho a recibir información clara, a decidir sobre los tratamientos y a contar con prácticas respetuosas de su dignidad. A su vez, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Básica de Salud N.º 153 y la Ley de Salud Mental N.º 448 (pionera en el país) ya habían anticipado —una década antes— muchos de los principios que luego retomaría la ley nacional: enfoque comuni-

tario, desinstitucionalización progresiva, participación del usuario, y promoción de prácticas interdisciplinarias.

En ese marco, el Acompañamiento Terapéutico puede pensarse como un eslabón vital de una red de cuidado centrada en la presencia del vínculo, la escucha y la articulación con otros dispositivos. No se trata solo de sostener al paciente en la comunidad: se trata de hacerlo desde una posición clínica, desde una lectura ética del sufrimiento, y desde una apuesta a su elaboración simbólica.

Ahora bien, si el espíritu de la ley habilita al Acompañamiento, las críticas que ha recibido —y que en los últimos años se han intensificado— tienden a desplazarlo o desfigurarlos. Desde ciertos sectores del campo médico y judicial, se ha sostenido que la ley impide internaciones necesarias, que abandonó a su suerte a personas en situación de vulnerabilidad, que debilitó el rol del psiquiatra, que burocratizó los tratamientos. Más allá del análisis puntual que merecen estas afirmaciones, lo cierto es que muchas veces son utilizadas como argumento para reinstalar una lógica tutelar, custodial y asilar.

En este punto, se juega una tensión central para la práctica del Acompañamiento. Cuando se impugna la ley en nombre del orden, del control o del peligro, el acompañante puede ser convocado como extensión del sistema de vigilancia. En esta nueva lógica, se espera que contenga, que monitoree, que evite la “crisis” o la “conducta disruptiva”. Se lo empuja a ocupar el lugar del cuidador o del técnico en control de daños. En esa operación, la función clínica se diluye, y el Acompañamiento pierde su potencia.

Frente a esta deriva, se vuelve fundamental recuperar el sentido original del Acompañamiento Terapéutico como una práctica clínica singular, que interviene allí donde el sufrimiento se manifiesta, y que lo hace desde una posición ética. El acompañante no reemplaza a otros profesionales, no se inscribe en la lógica del saber experto, ni responde a protocolos prefijados. Su herramienta no es el diagnóstico, sino la transferencia. Su campo no es el del control, sino el del lazo. Su ética no es la de la eficacia, sino la de la presencia.

En este sentido, el Acompañamiento Terapéutico no necesita ser nombrado en la ley para existir, pero sí necesita ser defendido frente a las lecturas que buscan restringir el campo de la salud mental a lo exclusivamente médico o institucional. La ley abrió una posibilidad. Una puerta. No se trata de idealizarla ni de defenderla de forma acrítica,

sino de habitar sus grietas con una práctica que, lejos de clausurar el sentido del sufrimiento, lo escuche, lo acompañe y le permita —cuando sea posible— tramitarse de otro modo.

El desafío sigue siendo político, clínico e institucional. Y como toda práctica instituyente, el Acompañamiento Terapéutico deberá seguir inventando modos de sostener su lugar, aun cuando los marcos normativos lo ignoren, lo distorsionen o lo cuestionen. Porque, como tantas veces en nuestra historia, será en el cuerpo a cuerpo, en el barrio, en el domicilio, en el estar con el otro, donde se volverá verdaderamente necesario.

Desde nuestra práctica, lo vemos con claridad: la ley no garantiza por sí sola el Acompañamiento Terapéutico, pero sin ella, su existencia es aún más frágil. Por eso, no alcanza con la práctica: también hay que defender, discutir, incidir con la altura que el campo requiere.

Segunda parte

FUNDAMENTOS CONCEPTUALES

Capítulo 3

LA PROPUESTA PEDAGÓGICA

Introducción

Este capítulo se propone recorrer algunos de los puntos neurálgicos que configuran la clínica del Acompañamiento Terapéutico, entendida como una práctica viva, situada y en permanente construcción. Lejos de presentar una sistematización cerrada o una doctrina aplicable, nos interesa compartir los modos en que hemos ido construyendo, en la experiencia concreta del trabajo clínico y en la trama colectiva de nuestro equipo, una forma de estar con otros que apuesta a habilitar lugar para el sufrimiento subjetivo.

Para ello, tomaremos como punto de partida la historia particular de nuestro equipo de trabajo, entendida no solo como contexto institucional, sino como campo de elaboración clínica y formativa. La trayectoria compartida, el sostenimiento de espacios de discusión, la articulación entre acompañantes y el entrecruzamiento constante entre teoría y práctica han sido elementos decisivos en la construcción de un modo específico de concebir la clínica en Acompañamiento Terapéutico.

Este capítulo retoma, como eje organizador, el mismo ordenamiento que guía la Formación interna de FUNDAT que desarrollaremos a continuación, donde se articulan cuatro núcleos de trabajo fundamentales. Se trata de una serie de conceptos y coordenadas que consideramos centrales para pensar la tarea clínica: la escena del acompañamiento, la implicación del cuerpo del acompañante, la dimensión afectiva como brújula de la intervención, la articulación entre pares y la articulación con otros dispositivos. Cada uno de estos apartados se presenta como una apuesta teórica y política que se sostiene en la experiencia acumulada y en la reflexión colectiva.

Entendemos que la formación en Acompañamiento Terapéutico no puede escindirse de la práctica misma. Por eso, este texto articula dimensión formativa y elaboración conceptual a partir de un enfoque situado, que reconoce en el hacer cotidiano y en las preguntas que este suscita, el motor principal de la construcción clínica. En este sentido, el capítulo se inscribe en una tradición que asume la clínica como un campo en permanente construcción, abierto a la revisión crítica, al encuentro con lo inesperado y a la invención de modos de estar con otros que habiliten subjetividad.

* * *

De la experiencia al concepto: una propuesta de formación en Acompañamiento Terapéutico

Maximiliano Peverelli
Lucas Minervino
Diego Zafa Valenzuela

Introducción

Ágora es un Equipo de Acompañamiento Terapéutico que pertenece a la Fundación para el Desarrollo del Acompañamiento Terapéutico (FUNDAT). Nació con el deseo de pensar una clínica del Acompañamiento Terapéutico, entendida como una forma singular de intervenir en el campo de la salud mental. En el inicio, el equipo fue pequeño: algunos acompañantes, un coordinador, y muchas preguntas. La principal: ¿cómo organizar el dispositivo de Acompañamiento Terapéutico? Aquella búsqueda, lejos de cerrarse, fue desplegándose en el tiempo, y encontró su nombre en una expresión que se volvió brújula para nuestras prácticas: *una clínica entre varios*¹.

La consolidación del equipo trajo, como consecuencia natural, la necesidad de pensar juntos. Así nació lo que llamamos “*Formación entre pares*”: un espacio compartido por estudiantes avanzados y psicólogos recién recibidos, en el que nadie se erigía como autoridad, y donde cada línea de pensamiento habilitaba nuevas preguntas. No había respuestas fijas, pero sí una disposición a interrogar lo que hacíamos.

Fue una etapa fértil para el equipo, atravesada por el deseo de comprender y de construir. Allí nacieron muchos de los pilares que aún hoy sostienen nuestra práctica. Con el tiempo, el equipo fue cambiando: algunos compañeros se alejaron y llegaron otros, con menos recorrido, pero con la misma entrega. La diferencia no tardó en hacerse visible: donde antes había referencias compartidas, empezaron a aparecer dudas, desconciertos y una necesidad creciente de orientación. Lo que

1. Se trata de un concepto extraído de una experiencia con pacientes graves en 1974 relatada por Antonio Di Caccia. Es un concepto que trabajaremos en profundidad más adelante en este mismo libro.

en un primer momento se leía como errores, pronto se reveló como una demanda genuina de formación.

Es recién en este contexto que surge, por primera vez, la pregunta por la transmisión. Ahora no se había organizado como un espacio de formación, pero fue allí donde la demanda interna de los nuevos acompañantes puso en escena la necesidad de promover un equipo más homogéneo, capaz de incorporar nuevos acompañantes que pudieran asimilar rápidamente una concepción del Acompañamiento y un modelo de trabajo. Así surgió una pregunta que todavía nos acompaña: ¿cómo se forma un Acompañante Terapéutico? ¿Qué se transmite, y cómo, para habilitar una posición ética y clínica en el marco de un dispositivo que se sostiene entre varios?

La formación en Acompañamiento y su contexto

El Acompañamiento Terapéutico transita hoy una etapa marcada por su expansión, pero también por su heterogeneidad. Si bien podemos apreciar algunos avances en materia de regulación y en la definición de criterios mínimos para la formación de quienes pretenden desempeñarse como acompañantes terapéuticos, lo cierto es que el impacto de estas regulaciones en el conjunto del campo sigue siendo limitado. Mientras algunos territorios avanzan hacia un mayor ordenamiento, en otros predomina una dinámica caótica y desarticulada, en la que proliferan propuestas formativas que muchas veces responden más a lógicas de mercado que a la complejidad clínica y ética que la práctica requiere.

En Buenos Aires, por ejemplo, florecieron cursos breves que prometían una rápida salida laboral sin formación previa. Tres meses, seis, un año como máximo: un recorrido acelerado para formar acompañantes capaces, en teoría, de sostener escenas de alto sufrimiento subjetivo. La lógica era clara. Las instituciones necesitaban alumnos. Y para atraerlos, ofrecían títulos que, en el marco de la falta de regulación, eran aceptados por algunas obras sociales o reparticiones estatales. En ese paisaje, el programa educativo se convirtió en un producto más del mercado, con todas las reglas que eso implica: ser vendible, fácil de cursar, de corta duración y con una promesa inmediata de inserción laboral.

Claro que también existieron propuestas más serias, más comprometidas, que entendieron la formación como un proceso y no como una

acreditación. Pero en un escenario donde prima lo urgente, lo inmediato suele ganar. Así, mientras las tecnicaturas de tres años apenas logran sostenerse, los cursos exprés no dejaron de multiplicarse.

A este panorama se suma otro fenómeno: muchos estudiantes avanzados de psicología ven en el Acompañamiento una puerta de entrada al campo clínico. Con deseo de hacer, con formación en curso y con necesidad de sostenerse económicamente, se integran a la práctica sin haber atravesado procesos formativos específicos. A veces solos. A veces en equipos. Y eso también forma parte del estado actual del campo.

El resultado es un escenario en el que bajo una misma denominación —Acompañamiento Terapéutico— conviven prácticas muy diferentes, sostenidas por personas con trayectorias, saberes y posicionamientos éticos disímiles. En ese contexto, se vuelve difícil incluso definir qué es el Acompañamiento Terapéutico hoy.

La propuesta pedagógica: de la experiencia al concepto

La formación en Acompañamiento Terapéutico que desarrollamos en el Equipo nace de una práctica. Es hija de la experiencia, de los aciertos y de los tropiezos, de las preguntas que emergen en el hacer. No pretendemos formar técnicos ni depositar saberes; lo que buscamos es abrir un espacio donde sea posible pensar(se) haciendo clínica. Lo que se enseña aquí no se impone desde el saber acumulado, sino que se produce en la tensión entre lo vivido y lo elaborado.

La propuesta se organiza en torno a dos ejes centrales: uno práctico y otro teórico. El primero se despliega en el ejercicio mismo del Acompañamiento; el segundo, en la reflexión que se genera a partir de esa experiencia. No hay teoría sin práctica, pero tampoco hay práctica que no convoque a pensar. Ambos planos se implican mutuamente y encuentran su desarrollo en tres espacios articulados:

1. Un conjunto de módulos temáticos que problematizan aspectos centrales del dispositivo.
2. La participación activa de los acompañantes en formación en experiencias clínicas reales.
3. Las reuniones de equipo, donde se discute el caso, la estrategia, las coordinadas y el sentido de cada intervención.

Estos tres espacios comparten una estructura grupal que recupera una tradición en la que el grupo no es solo un modo de organizar personas, sino una herramienta para pensar lo vivido.² Es en ese entramado donde se construye la escena formativa como una oportunidad de interrogación colectiva. No se trata de un espacio de transmisión vertical. La formación no sucede al margen de la experiencia, sino que emerge de ella, de los intercambios, los desacuerdos, las resonancias. En lugar de fijar contenidos cerrados, buscamos habilitar la circulación de preguntas que tensionen lo que se da por sabido, y que permitan hacer lugar a nuevas formas de entender y de intervenir.

En este marco, la formación no se concibe como un proceso de acumulación de conocimientos, sino como una práctica crítica que parte del supuesto de que todo acompañante tiene algo para decir sobre su hacer. Y que ese decir —cuando se arriesga, se expone y se pone en diálogo con otros— puede devenir saber. Lo que aquí se promueve no es la repetición de fórmulas, sino el ejercicio de una responsabilidad: la de asumir una posición frente a lo que se hace, a lo que se escucha, a lo que se transmite.

Desde este lugar, nos alejamos de toda lógica educativa que imagine al otro como un recipiente vacío al que hay que llenar de contenidos³. Por el contrario, creemos que pensar es un trabajo colectivo, a veces incómodo, pero siempre necesario. No buscamos consensos automáticos ni verdades únicas. Lo que sí promovemos es una elaboración comprometida, una implicación genuina en cada pregunta que se abre. En este recorrido, no todos piensan igual. Pero nadie puede evadir la tarea de pensar.

Para ordenar el recorrido, estructuramos el proceso pedagógico en cuatro módulos, que siguen una lógica progresiva inspirada en los tiempos del grupo operativo: *la pretarea, la tarea y el proyecto*⁴. *En cada uno de ellos se parte de la experiencia concreta de los acompañantes en*

2. Inspirado en las conceptualizaciones de Pichón Rivière y Armando Bauleo sobre el grupo operativo.

3. Hacemos referencia a los que Paulo Freire llamó la “educación bancaria” en su texto *Pedagogía del oprimido* (1970), Ed Siglo XXI. Freire utiliza este concepto para criticar el modelo tradicional de enseñanza, en el que el educador es quien “sabe” y el educando es un receptor pasivo al que hay que “llenar” de conocimientos.

4. Estos tres conceptos son trabajados por Armando Bauleo en su texto *Psicoanálisis y grupo operativo* (1971), en el capítulo “Tiempos del proceso grupal: pretarea, tarea y proyecto” y son presentados como los tiempos estructurales del grupo.

formación, y se intenta ir del relato al concepto, del acontecimiento a la elaboración, de la escena clínica a la posición ética.

Módulo 1: ¿Qué es acompañar?

El primer módulo propone una inmersión en los fundamentos del dispositivo de Acompañamiento Terapéutico. Si tuviéramos que pensarlo en términos de una imagen, podríamos decir que la cámara se ubica dentro del acompañante, captando lo que él ve, lo que él escucha, lo que él experimenta. Es una mirada hacia afuera, pero desde adentro.

Aquí se problematiza el punto de partida: ¿Qué es acompañar? ¿A quién se acompaña? ¿Desde dónde se acompaña? ¿Con qué objetivos? ¿Y bajo qué condiciones? La propuesta no es definir de una vez y para siempre, sino abrir preguntas que acompañen todo el recorrido formativo.

El módulo aborda los elementos que estructuran la práctica: el encuadre, los límites, los tiempos, los espacios, el dinero, el diagnóstico, la demanda. Se analizan los distintos interlocutores que habitan la escena del acompañamiento —familiares, profesionales, instituciones— y se piensa que implica acompañar en contextos de crisis, en el marco de una indicación o en situaciones donde el pedido no está claramente formulado. A través del análisis de escenas clínicas, se busca que cada quien pueda situar su mirada, su intervención y su responsabilidad.

Este módulo representa el tiempo de la pretarea, según la perspectiva de Bauleo. Es el momento en que se despliegan ansiedades, resistencias y desorganizaciones propias del ingreso a un espacio nuevo. También es el momento en que comienzan a desestructurarse ciertos esquemas previos, para dar lugar a la construcción de otros.

Módulo 2: ¿Qué me pasa cuando acompaño?

El segundo módulo gira en torno a la implicación del acompañante en la relación con el paciente. Si en el primero la cámara miraba desde dentro del acompañante hacia la escena, ahora se ubica por encima de él y lo observa: lo ve afectarse, conmoverse, tambalear, implicarse. Se revela que ese acompañante no es una figura neutra, sino un sujeto con historia, con cuerpo, con deseo.

Aquí, los afectos ocupan un lugar central. Se trata de leer cómo cada acompañante es tocado por la experiencia clínica, cómo lo atraviesa lo que ocurre en el vínculo, qué le pasa con el sufrimiento del otro, y cómo esas marcas influyen —consciente o inconscientemente— en su modo de estar. Detectar esas resonancias no solo es necesario, sino que se vuelve una herramienta fundamental para construir una relación terapéutica.

Trabajarse a sí mismo es, en este sentido, una parte constitutiva del acompañar. No hay posición clínica posible sin una interrogación ética sobre lo que uno pone en juego. Este módulo, entonces, invita a revisar no solo lo que hacemos, sino lo que nos pasa mientras lo hacemos. Y lo que dejamos que nos pase.

Módulo 3: ¿Cómo construimos un caso entre varios?

El tercer módulo parte de una premisa: el Acompañamiento Terapéutico no se ejerce en soledad. Se construye entre varios. Y por eso, también el caso debe construirse colectivamente.

Aquí se introducen herramientas para localizar las coordenadas clínicas que organizan una intervención: ¿qué elementos hacen de un acompañamiento un dispositivo con dirección? ¿Qué permite o impide intervenir? ¿Qué diferencia una presencia del simple estar? El módulo se centra en la elaboración de una cartografía del caso, una lectura compartida que oriente las decisiones del equipo y que permita sostener una estrategia clínica conjunta.

Este es el tiempo de “la tarea” en la secuencia propuesta por Bauleo: la instancia en la que se metaboliza lo desplegado en la pretarea, y se produce una transformación subjetiva que permite intervenir de otro modo. La tarea es el eje organizador: no es sólo el objetivo declarado, sino el proceso de elaboración y transformación que se produce en torno a ese objetivo.

La imagen sería, nuevamente, la de una cámara que se aleja, y muestra que el acompañante no está solo. Lo rodea un equipo, y es en ese equipo donde se inscribe su hacer.

Módulo 4: ¿Dónde se inscribe lo que hacemos?

El último módulo propone un desplazamiento hacia el contexto más amplio en el que se inserta la práctica. Ahora la cámara se eleva aún más: ya no mira al acompañante ni al equipo, sino al sistema en el que se inscriben. El sistema de salud, las políticas públicas, las instituciones, las regulaciones, los discursos sociales que atraviesan y condicionan el hacer.

Se trabaja aquí sobre las dimensiones éticas, legales, clínicas y políticas que enmarcan al Acompañamiento Terapéutico. Se interroga qué implica acompañar en este tiempo histórico, qué tensiones se juegan entre lo deseable y lo posible, entre lo que se intenta construir y lo que el sistema permite sostener. Es también una oportunidad para pensar el lugar que cada quien quiere ocupar, el proyecto clínico, el posicionamiento futuro.

Este módulo corresponde “al proyecto”, el último tiempo del grupo operativo. El momento en que se enlazan los aprendizajes, se integran las tensiones, se proyectan sentidos. La formación no termina aquí, pero sí se coagula. Queda resonando una pregunta: ¿qué tipo de acompañante quiero ser? ¿Qué implica asumir un posicionamiento clínico?

Cierre: lo que se transmite no es un saber, es una posición

La pregunta por la formación no estuvo desde el inicio en el horizonte de Ágora. No fue una inquietud originaria ni un objetivo a perseguir. Surgió después, como consecuencia de lo que implica sostener una práctica entre varios. De pronto, el equipo se volvió espacio de pensamiento colectivo. Y ese pensamiento comenzó a delinear, casi sin proponérselo, una pedagogía posible.

Así fue como aparecieron, primero de manera informal, ciertas líneas que organizaban la transmisión. No como contenidos cerrados, sino como experiencias compartidas que abrían interrogantes, proponían posiciones, sostenían una ética. Antes que exista una instancia formal de formación, ya existía una forma de trabajar, una manera de estar, un modo de construir la clínica.

Desde el comienzo, Ágora estuvo conformado por estudiantes avanzados y egresados de la carrera de psicología. Esa pertenencia no fue una decisión ideológica, sino un efecto de los recorridos de quienes dieron

origen al equipo. Con el tiempo, sin embargo, esa característica se volvió también una decisión fundada. No porque creamos que el título de psicólogo habilite automáticamente una práctica ética, ni porque consideremos que exista un saber previo que garantice el acompañar, sino porque entendemos que el deseo de habitar el padecimiento del otro, de interrogarlo, de implicarse, suele estar más cerca de quienes ya han recorrido un camino sostenidos por una pregunta en torno a la subjetividad.

Es posible que ese andamiaje vocacional que reconocimos con más frecuencia en quienes transitaban la formación en psicología, comience a encontrarse también en quienes se formen específicamente como acompañantes terapéuticos, en la medida en que dicha formación logre consolidarse, formalizarse y convocar un caudal significativo de aspirantes. Tal movimiento podría impactar de manera sustantiva en la dinámica global del campo, ampliando sus horizontes y complejizando sus recorridos de formación y pertenencia.

De hecho, podríamos decir que ese tiempo ya ha comenzado: hoy es el tiempo de los acompañantes de profesión. Y el desafío actual no es solo sostener su formación, sino encontrar los modos de dar cuenta de la motivación que los impulsa, de ese deseo de estar allí donde el padecimiento irrumpe, reflejado en las preguntas singulares que el propio campo del Acompañamiento Terapéutico se anima a producir. En definitiva, la pregunta por la subjetividad y el padecimiento, más que cualquier acumulación de contenidos, es la que orienta la práctica. Creemos que, en un contexto de alta heterogeneidad, esta estrategia nos ha permitido acercarnos a un deseo de acompañar impulsado por lo vocacional, mas que una necesidad. Un Acompañamiento que no aparece como salida laboral, sino como entrada clínica. Y esa diferencia, que parece menor, lo cambia todo.

Trabajar en Acompañamiento Terapéutico no requiere únicamente una caja de herramientas. Requiere, sobre todo, una pregunta. Y esa pregunta —¿cómo habitar la escena del otro sin borrar su diferencia?, ¿cómo alojar la diferencia sin encerrarla en un saber?— es el verdadero umbral de esta práctica.

Nuestra formación no apunta a brindar una acreditación. No compete con las tecnicaturas ni pretende reemplazar los contenidos teóricos indispensables. Lo que proponemos es otra cosa: un espacio donde la experiencia clínica se convierta en material de pensamiento. Se trata de una especialización clínica, donde se pasa del acontecimiento al concepto, y

del concepto a una nueva forma de intervenir. Una formación que no se mide por lo que se sabe, sino por la posición que se asume.

No todos los acompañantes llegan con el mismo recorrido. Pero sí creemos que todos deben llegar con la disposición a dejar en suspenso sus saberes previos, a entrar en conversación con otros, a sostener la incomodidad que implica no saber del todo. Solo en ese vacío puede comenzar a construirse un equipo. Solo en esa exposición mutua puede aparecer una clínica entre varios.

Sabemos que esta propuesta tiene límites. No pretende sustituir la formación técnica ni la regulación oficial que, tarde o temprano, organizará el campo. Pero sí creemos que ofrece algo irremplazable: un modo de habitar el Acompañamiento que pone en el centro la posición ética, la construcción colectiva del caso, y la experiencia como materia viva para pensar.

Transmisión, entonces, no como entrega de contenidos, sino como posibilidad de implicación. Formación, no como obtención de un título, sino como producción de una posición. Porque en Acompañamiento Terapéutico, lo que se transmite —cuando se transmite algo— no es un saber. Es una forma de estar.

Capítulo 4

LA CLÍNICA DEL ACOMPAÑANTE

El recorrido por los módulos

La experiencia de formación en el equipo Ágora, tal como fue presentada, se sostiene en una concepción dinámica y situada del saber. Una formación que no responde a modelos tradicionales, sino que se construye en estrecha relación con la práctica, habilitando un espacio donde la elaboración colectiva, la problematización constante y la implicación subjetiva resultan fundamentales.

En esta sección, nos proponemos desarrollar los distintos núcleos temáticos que estructuran dicha propuesta formativa. Cada uno de los módulos responde a un eje conceptual y clínico que ha resultado decisivo en la organización de nuestro modo de acompañar, así como en la transmisión de la práctica. Estos módulos no deben ser leídos como compartimentos estancos ni como una secuencia lineal, sino como territorios de sentido que se entrecruzan y que encuentran su fuerza precisamente en la tensión entre teoría y experiencia.

Lo que sigue, entonces, es una presentación de esos núcleos, a través de los cuales se intenta dar cuenta de los fundamentos ético-políticos de nuestra práctica, de los modos en que se construye la escena del Acompañamiento, de las herramientas clínicas que se despliegan y de los desafíos que implica el trabajo en equipo. La apuesta de fondo es que cada módulo habilite nuevas preguntas, más que respuestas cerradas; que propicie el pensamiento crítico, más que la repetición de fórmulas.

Este recorrido tiene como finalidad abrir un campo de reflexión que permita formar acompañantes capaces de leer las condiciones singulares de cada intervención, de intervenir con responsabilidad subjetiva y de sostener una posición ética comprometida con los derechos y la dignidad de las personas con las que trabajamos.

MODULO 1: La escena en Acompañamiento Terapéutico

Este primer módulo se propone abordar un punto crucial para toda práctica de Acompañamiento Terapéutico: la posición clínica del acompañante. Lejos de pensar el AT como una figura auxiliar o de simple compañía, lo que aquí buscamos delimitar es el lugar desde el cual el acompañante se implica en el vínculo, con sus complejidades, sus tensiones y su potencia singular.

Hablar de “posición” no es un juego terminológico. Es una apuesta clínica y ética. Porque no se trata solo de estar presente, sino de cómo se está. De qué modo se entra en la escena del Acompañamiento. Qué lugar se asume frente al padecimiento del otro. Cómo se sostiene la intervención sin quedar atrapado ni en la repetición de lo que no funciona, ni en la tentación de reparar desde un lugar imaginario de saber o de poder.

En este módulo, pensamos al acompañante más allá del rol, más allá de la tarea o del protocolo. Lo que se plantea, en cambio, es que el Acompañamiento es una práctica clínica en tanto opera en el lazo. Y que esa operación exige una posición subjetiva singular, que se construye en acto, que se revisa permanentemente, y que se anuda a una ética del no saber, a una disponibilidad afectiva que no se confunde con la identificación o con la proximidad ingenua.

Lejos de ofrecer respuestas cerradas, apostamos a mantener abierta la pregunta sobre qué significa acompañar clínicamente a alguien. Es desde esa pregunta —que no cesa, que incomoda, que exige trabajo colectivo— que se empieza a delinear la posición acompañante: una práctica situada e implicada, que no se improvisa ni automatiza.

Este módulo no busca definir de una vez y para siempre qué es un acompañante terapéutico, sino ofrecer herramientas para que cada quien pueda construir su posición en diálogo con los casos, con el equipo, con el dispositivo, y, sobre todo, con el otro al que acompaña.

Posición clínica: posición acompañante

Nombrar al Acompañamiento Terapéutico como práctica clínica no es una concesión metafórica, ni un gesto reivindicativo. Es el reconocimiento de que el acompañante, lejos de ocupar un lugar auxiliar o complementario, asume una posición clínica específica, con un estatuto propio y con

implicancias técnicas, éticas y políticas de gran complejidad. Se trata de una función que no puede reducirse a la ejecución de tareas ni a la mera presencia, porque implica una lectura de la escena, una disponibilidad subjetiva sostenida, y una inscripción en una lógica de tratamiento.

Lo clínico de esta posición no reside solo en su cercanía al padecimiento, sino en el modo particular en que se relaciona con él: el acompañante se ofrece como presencia disponible, como cuerpo en vínculo, como instancia que habilita el lazo sin intentar colonizarlo. Esa relación no es espontánea ni natural: está mediada por una construcción técnica que se expresa en cómo se posiciona frente al otro, en cómo sostiene el límite, en cómo lee lo que sucede sin apresurarse a intervenir.

Pero hay algo más: el acompañante trabaja sobre sí mismo. No se trata simplemente de “tener buena disposición”, sino de asumir una ética de la implicación que exige revisar permanentemente los efectos de su propia subjetividad en la escena. Implica poder distinguir cuándo habla el deseo de acompañar y cuándo se infiltran fantasías de reparación, omnipotencia o salvación. La posición acompañante se construye, entonces, como una práctica de disponibilidad regulada, un cuidado que se articula con una estrategia terapéutica compartida.

El Acompañamiento no se improvisa. No alcanza con el deseo. Requiere formación, supervisión, trabajo en equipo, y una inscripción clara en el dispositivo clínico del cual forma parte.

¿Qué implica asumir una posición clínica en AT?

Y así llegamos, otra vez, a las preguntas que organizan este recorrido: ¿cómo opera el acompañante? ¿Dónde se ubica en la relación con el paciente para que lo que allí acontece tenga valor clínico? ¿Qué condiciones deben existir —organizativas, vinculares, simbólicas— para que su presencia no sea solo compañía, sino también efecto?

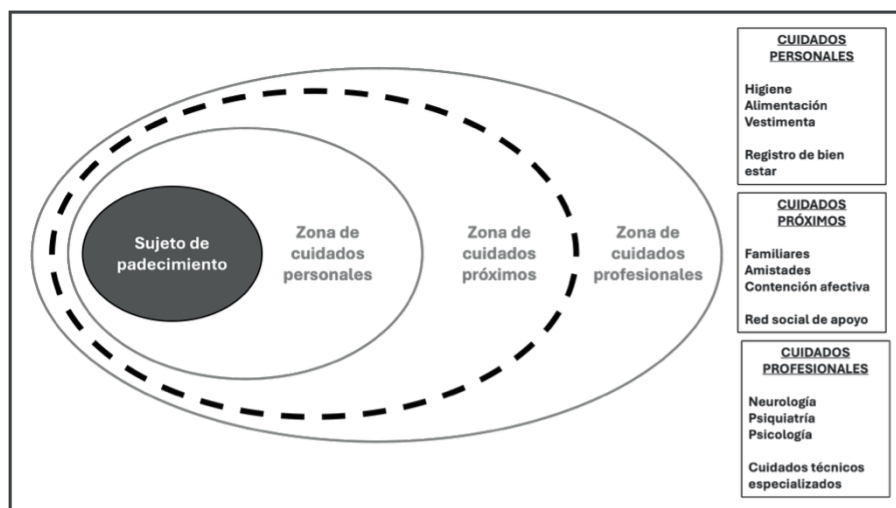
Hablar de Acompañamiento Terapéutico implica, necesariamente, hablar de posición clínica. Es decir, de un modo particular de estar en el lazo, de un posicionamiento subjetivo que no se reduce a una técnica ni a una mera función instrumental. Asumir la posición acompañante no equivale a ocupar un rol asignado de antemano, sino a inscribirse en una lógica clínica singular, que articula el lazo con el paciente desde un punto preciso: el entrecruzamiento de lo cotidiano y lo terapéutico.

Ahora bien, ¿qué significa, en términos concretos, asumir una posición clínica en el Acompañamiento? ¿Cómo se delimita esa posición, que no es la del amigo, ni la del familiar, ni la del terapeuta tradicional?

Podemos pensar esta pregunta a partir de una hipótesis de trabajo: toda persona, para sostener su vida cotidiana, se apoya en distintos niveles de cuidado. En primer lugar, encontramos lo que podríamos llamar cuidados personales: acciones que cada quien realiza para sí mismo, orientadas al bienestar físico y emocional —alimentarse, higienizarse, descansar, organizar rutinas. Es un nivel de autonomía básica que, en los procesos de padecimiento, suele verse debilitado o interrumpido.

En un segundo nivel, aparecen los cuidados próximos. Se trata de aquellos sostenes que provienen del entorno afectivo: familiares, amistades, vecinos, personas con las que se comparte cierta intimidad o confianza. Son lazos que operan desde el interés subjetivo por el otro, desde una preocupación personal, desde el afecto, y que muchas veces se activan con fuerza frente a situaciones de crisis.

Por último, identificamos los cuidados profesionales, definidos por los marcos disciplinares específicos desde los cuales se produce el vínculo. Un médico, un psicólogo, un trabajador social: cada uno se posiciona desde un discurso técnico, con sus reglas, sus conceptos y su campo de intervención delimitado. Esos marcos dan sentido y legitimidad a la práctica, pero también acotan el modo en que el otro es reconocido y abordado.



La singularidad del Acompañamiento Terapéutico está en que se sitúa en el borde mismo entre los cuidados próximos y los cuidados profesionales. Se inscribe en la cercanía, en la presencia compartida, en la cotidianeidad de un vínculo que remite a formas relacionales conocidas, familiares, incluso amistosas. Pero al mismo tiempo, no se trata de un lazo espontáneo ni natural: el acompañante no es un amigo, ni un familiar, ni un confidente. Está allí por una función clínica, por una decisión terapéutica, por una responsabilidad profesional.

Este borde —esta ambigüedad constitutiva del lugar del acompañante— exige una operación subjetiva sostenida: abstenerse de hacer jugar el propio deseo en la escena, en la relación con el otro, sustraerse del goce personal que pudiera activarse en el encuentro, y trabajar sobre las propias resonancias para no instalarse en ellas como verdad. Porque si hay algo que define la posición clínica del acompañante, es el trabajo permanente sobre sí mismo. Estar con el otro para el otro; sostener el lazo sin apropiárselo.

La función del acompañante se encarna en una presencia, en una palabra y una escucha que no interpreta desde un saber previo. No se trata de lo que el acompañante piense, ni de lo que le pase, sino de cómo se trabaja con eso que le pasa para no hacerlo jugar en el vínculo. Es esa ética del silencio, de la espera, del estar sin imponer, lo que permite que el Acompañamiento se vuelva clínicamente significativo.

Así, la posición clínica del acompañante no se define únicamente por lo que hace, sino —y sobre todo— por el lugar desde el cual se inscribe en la escena. Es una posición que se construye en acto, en el vínculo mismo, en la implicación sostenida con el otro, pero también con el dispositivo, con el equipo, con la lógica institucional del tratamiento. Una posición que no es neutra, que no es aséptica, tampoco es personal: es una posición ética, anudada a una práctica colectiva, orientada por una clínica del lazo.

* * *

Un modo posible de empezar a hablar de un Acompañamiento Terapéutico

Bruno Pietracatella

¿Cómo empezar a hablar de un Acompañamiento Terapéutico? ¿qué es lo primero que se suele escucharse, o decirse, cuando uno se acerca a la práctica en esos primeros encuentros con un paciente, dentro del marco de este dispositivo?

Podemos centrarnos en la información que brinda un coordinador que nos convoca a sumarnos a un equipo; en los datos que aporta algún familiar, o en los objetivos que señala el profesional tratante.

Veamos un caso: Marcos es un paciente adolescente. Tiene diagnóstico de retraso mental. Vive alternadamente entre casa de su padre y la de su madre –separados hace 4 años–, y tiene una hermana mayor. Le gusta la música y mirar documentales, pero presenta dificultades para salir de su hogar. Los objetivos del tratamiento apuntan a fomentar su autonomía.

“Los padres están muy cansados, como te podrás imaginar. Lo quieren mucho, pero ambos trabajan y él es muy dependiente para todo. La hermana está presente, pero es más grande y hace su vida” –introduce el psicólogo tratante en una primera charla telefónica– “Los objetivos del tratamiento son que pueda ir ganando más autonomía, que el acompañante lo busque a la salida de la escuela y vuelvan juntos a su casa, que preparen una merienda, y puedan hacer alguna salida recreativa”

Luego será el padre quien cuente su historia. La madre aportará algo de la suya. Cómo recibieron el diagnóstico, cuándo notaron que algo le pasaba a su hijo. Relatarán también su historia como pareja, el motivo de la separación. Ahora tienen buena relación, pero están agotados... Aparece lo que funciona, lo que no, lo que cada uno espera, donde se frustran, donde sienten hartazgo.

Este primer acercamiento está poblado de relatos. Se empieza a conocer algo del paciente a través de la mirada de los tratantes, de su familia, y en algunos casos incluso del equipo de Acompañamiento si ya está en funcionamiento –aunque todavía el acompañante no se haya situado en el encuentro directo con el paciente.

Entonces ¿Podemos situar un momento en el que empieza un Acompañamiento Terapéutico? ¿Cuándo conviene decir “aquí hay un Acompañamiento Terapéutico”? ¿Comienza con el primer contacto con la

familia? ¿Con los tratantes? ¿O con el primer encuentro entre el acompañante y el paciente? Me pregunto si el Acompañamiento Terapéutico es algo que tienen un inicio y una continuidad hasta que se termina: ya sea por el alta del paciente, por la interrupción de la cobertura de la obra social, por decisión del equipo tratante, por el deseo de la familia o del propio paciente, o por la salida del acompañante.

Estas preguntas nos llevan, inevitablemente, a otra: ¿qué es un Acompañamiento Terapéutico? ¿Es simplemente el encuentro entre un acompañante terapéutico y un paciente? ¿Es la instalación de un dispositivo en términos administrativos, de articulación con otros dispositivos de tratamiento?

Estas preguntas —con su tono capcioso— no ocultan su intención: comprometerse con una práctica, pensar sus coordenadas, esbozar una manera de empezar a hablar del Acompañamiento Terapéutico. Pero ese comienzo es intrincado: algo se ramifica y en la motivación de lo que allí está naciendo es menester delimitar.

Los psicoanalistas, en un intento de formalizar la incidencia de su quehacer cotidiano, se reservan la nominación de su función y de su ser a momentos específicos. No se es analista todo el tiempo... El acto analítico no se confunde con todo lo que hace el psicoanalista, sino que refiere a un tipo de intervención en particular. Ser analista implica dar lugar a una función, a cierto tipo de intervención, no simplemente ocupar un título. El analista no mantiene activa su función por el solo hecho de nombrarse psicoanalista.

Sin entrar en las diferencias entre el dispositivo analítico y el del Acompañamiento Terapéutico, podemos tomar algunos lineamientos del primero que nos ayuden a pensar el segundo. ¿Cómo pensar el “Ser” del acompañante terapéutico?, ¿Desde su formación?, ¿por su inclusión en el equipo? ¿Por su relación a una prestadora de servicios de salud? Nuevamente se abre un abanico de posibilidades, dejando entrever la complejidad del asunto y las múltiples aristas desde donde podemos pensarlo.

Aquí nos detendremos en una: un modo posible de entrada, que permita situar algo de ese “Ser”, ¿qué pasa si definimos el “Ser” del acompañante como un rol?

Es decir, un rol que nos daría la pauta de un papel que cumple una persona en determinado contexto, de quien se espera algo en función de ese papel asignado. De este modo, el tratante de Marcos esperaría que el acompañante terapéutico, asumiendo su rol, cumpla con ciertos

objetivos de tratamiento indicados por él: fomentar la autonomía del paciente, buscarlo en la escuela, acompañarlo a casa, preparar la merienda, hacer salidas recreativas. Sus padres esperarían algo similar, sumando el deseo de que se descomprima algo del vínculo simbiótico, que sea más independiente, que se prepare sus comidas, colabore en el hogar, que pueda salir a hacer compras.

Pero lo que sucede cuando el acompañante se encuentra con Marcos, y lo que se sostendrá durante muchos años, es muy distinto a esas expectativas.

Marcos camina fatigado por la calle, no presta atención a los semáforos, se fastidia cuando se lo convoca a decidir el momento oportuno para cruzar la calle. Depende del otro: delega en el acompañante la conducción del regreso al hogar. Al llegar a su casa se sienta siempre en el mismo sillón. Prende la televisión y puede pasar horas mirando documentales de todo tipo, incluso los más aburridos. Se muestra reacio a las propuestas del acompañante: pasear por el barrio, ir a la plaza, o cumplir con tareas que le indican sus padres, la mayoría de las veces centrada en realizar las compras y otras tareas del hogar.

El rol del acompañante aparece entonces, desde el comienzo, como un lugar fallido: no se cumple aquello que se espera de él. Sin embargo, es desde ese mismo punto que, muchas veces, se empieza a hablar del Acompañamiento Terapéutico: desde lo que se debiera hacer y no funciona, desde la dimensión del fracaso. Algo se aplasta, se torna tedioso, difícil de asimilar para los tratantes, para la familia, para el paciente... y para el acompañante.

Ahora bien, pensar el ser del acompañante en términos de rol tiene sus consecuencias, el problema no reside solamente en las expectativas del entorno: lo que esperan los tratantes, los familiares, el paciente, o incluso la prestadora de salud, sino en lo que espera el mismo acompañante respecto de su propio quehacer. Cuando se define a sí mismo en términos de rol, queda atrapado en la lógica de la frustración, donde el único lugar posible es el de una reproducción. La reproducción de lo que allí no funciona, de las expectativas frustradas. El acompañante ubicado en términos de un rol espera aquello que se espera de él, que repare lo que no opera en otras instancias, lo que no alcanza con los tratamientos convencionales del paciente, lo que agota la dinámica familiar. Los efectos conducen a lo estanco, a la falta de movimiento. Un sillón, el mismo lugar, el encierro. ¿Qué esperar de un lugar que no hace más que girar en falso?

Ante esta escena repetitiva, el psicoanálisis puede tender una soga. Nos permite pensar no solo en un rol, sino en una función. En un tratamiento analítico, el analista ocupa un lugar articulado a una función. ¿Podemos pensar el Acompañamiento Terapéutico en esos términos?

En un momento del tratamiento Marcos finaliza su ciclo en la escuela de educación especial. Para sus padres, esto inauguraba un nuevo problema: “¿ahora qué va a hacer? ¿va a estar en la casa todo el día sin hacer nada?”. Tras una búsqueda activa por parte de su madre consultando a diversos especialistas, investigando dispositivos relacionados con la discapacidad, da con un lugar que, entiende, puede ser funcional para su hijo. Se trata de un taller de huerta para pacientes con discapacidad que depende de un hospital público de niños. El espacio es coordinado por una terapeuta ocupacional y un psiquiatra, además de la participación de pasantes de carreras afines. Los integrantes del taller producen alimentos, mantienen la huerta en funcionamiento y perciben ganancias de los productos que logran vender a la comunidad. El acompañante terapéutico es convocado a acompañar a Marcos en esta nueva etapa, a lo cual se suma el objetivo de favorecer la adherencia al taller y las actividades que de este se desprenden.

Sin embargo, la escena vuelve a repetirse: Marcos se niega a participar del grupo, rechaza las actividades, se angustia, llora, insulta y golpea cuando se lo interpela directamente. Mientras sus compañeros cosechan, transportan abono o venden productos, él permanece aislado, sentado en un banco. Se hace presente la mirada desaprobatoria de las autoridades del espacio y la insistencia desesperada de un acompañante que ha quedado una vez más en el centro de la escena ¿Qué hace el acompañante? Parece que no hace nada, Marcos no hace nada. No hay integración. No hay producción. No hay movimiento. El acompañante, nuevamente centrado en la dimensión del rol, reproduce aquello que no opera, que no tracciona. Envuelto en el anhelo de un ideal, cumplir lo que se espera de él —que no es otra cosa que lo que se espera de Marcos— y desde ese lugar se encuentra engeguado, abrumado. Nuevamente ha perdido el registro fundamental: ¿a quién está acompañando?

¿Cómo ayudarlo?, ¿cómo ayudarnos?

La propuesta es empezar a hablar del Acompañamiento Terapéutico desde la dimensión de su función. Esto no se traduce en negar su rol,

todo lo contrario. Se trata de localizarlo, delimitarlo, para ubicar que ha caído en la trampa, la de reproducir un mandato ideal: reparar lo que no funciona, resolver la falla. Lo paradójico de este entramado es la pretensión de una reparación con las mismas herramientas que históricamente han demostrado un fracaso rotundo. El resultado no deja de percibirse, Marcos se enoja, grita, agrede, escupe. Se quiere escapar.

Escapar, ¿de dónde?, ¿hacia dónde?

Primero, ubiquemos el ideal en juego: autonomía, separación de sus padres, adherencia al tratamiento, integración al grupo, realización de actividades. Eso se espera de Marcos. Y el acompañante, en su rol, queda atrapado en el mismo lugar: favorecer ese ideal. Así, se produce un efecto de desdoblamiento. Lo que se espera del paciente se traslada al acompañante, y ese lugar común, compartido, abre un campo de posibilidad para producir un giro, una torsión, con aquello que podríamos llamar punto de padecimiento del paciente, la dimensión de lo sintomático.

Allí donde se encuentran dos elementos, justamente en el lugar de un ideal que no se alcanza (*una de las acepciones de acompañar es “juntar o agregar algo a otra cosa”*) es posible pensar un movimiento en una misma dirección (*otra de las acepciones es “estar o ir en compañía de otra u otras personas”*) escapando del mismo lugar, hacia un lugar diferente. No pretendemos desembocar en una posición de identificación del acompañante con el acompañado, sino localizar que están en un mismo lugar (*una acepción más del término indica “participar en los sentimientos de alguien”*) ¿Acaso se puede acompañar a alguien cuando los elementos se mueven en direcciones opuestas?

Esto no implica reducir todos los Acompañamientos a este tipo de experiencia. Hay una enorme variedad de casos y configuraciones posibles. Pero sí podemos afirmar que esta lectura habilita un modo de abordaje: empezar a hablar de la práctica a partir de ubicar el rol, delimitar el ideal que lo atraviesa, y pensar qué función puede operar allí.

Para poder despejar el rol del acompañante, es necesario construir la escena del Acompañamiento. Dicho trabajo es posibilitado en un segundo momento del trabajo, el tiempo donde se piensa en lo acontecido, tiempo de trabajo clínico. En un primer momento, el Acompañamiento se desarrolla en su dimensión práctica: el encuentro, el horario, la forma que indican el encuadre, donde surgen diversas situaciones. La escena del

Acompañamiento no es la totalidad del encuentro, no es un relato fenomenológico de lo que allí ocurre. Su delimitación requiere de un trabajo posterior al momento de lo acontecido y nos va a permitir localizar los diversos elementos que la componen y su modo de interacción.

En este caso podríamos situar una escena en particular, la cual además cobra valor en tanto posee un carácter repetitivo. Los elementos que la componen serían: el acompañante se encuentra con el paciente en una institución de carácter terapéutico. En la dinámica de dicha institución llega un momento donde se reparten las actividades a realizar durante la jornada. El paciente se muestra reticente a participar de las actividades e integrarse al grupo. Las indicaciones por parte de las autoridades no producen el efecto esperado, el paciente se niega a realizarlas. El acompañante en dicho momento se siente compelido a reforzar la indicación, ya que parte de los objetivos del tratamiento establecidos por el equipo tratante se centran en la adherencia al tratamiento, con lo cual interviene en esa dirección. Insiste al paciente en acompañarlo a realizar la tarea adjudicada. Prueba diversos métodos y estrategias: comienza suave, amable, resaltando los beneficios de cumplir el objetivo, va a tener su propio dinero con lo cual podrá acceder a comprarse cosas que le gustan y le interesan. El problema es que al paciente nada le genera suficiente interés como para acceder a hacer esos trabajos que, además, implican forzar el cuerpo. Prueba otra metodología – ya fallida de entrada – comportando un semblante de autoridad. La negativa y la insistencia no suelen ser buenos complementos. Marcos, al comprobar que su palabra no basta acude a otro recurso, el cual le resulta bastante efectivo: lo empuja, lo escupe, lo insulta. El acompañante deja de insistir. El problema se redobla, ya que el acompañante siente que además de no lograr los objetivos del tratamiento, está siendo observado él mismo: es ineficiente, no hace nada.

Una vez recortada la escena se sitúa el rol. Aquello que el acompañante piensa que tiene que hacer, lo que piensa que se espera de él, para comenzar a desnaturalizarlo. De este modo el ideal empieza a hacerse escuchar: lo que piensa que tiene que hacer, ¿por qué lo hace? “Porque es lo mejor para el paciente, trabajar en la autonomía, en la adherencia al tratamiento, en que no dependa tanto de sus padres”. Pero el resultado es el rechazo. El saldo: la ineficiencia, la sanción de que no se hace nada. Ese saldo es compartido por ambos. Es un lugar que ocupaba el acompañado y que ocupa, ahora también, el acompañante.

¿Y si tomamos ese saldo, ese resto que produce el ideal, el de la ineficiencia y lo improductivo, sin pretender eliminarlo?

Nos queda entonces el resto, aquello que no se enlaza al ideal, a la expectativa. ¿Qué pasa si se acompaña desde allí? El acompañante se encuentra con Marcos. La jornada comienza, como es habitual, mediante un desayuno. Hasta ahí sin conflicto. El problema se desata al momento de repartición de las tareas: Marcos debe encargarse de los plantines y las miradas se dirigen hacia el acompañante como si dijeran “a ver cómo te las vas a arreglar con eso”.

El acompañante intuye lo que va a suceder, de algún modo ya está advertido, ha sucedido tantas veces: Marcos se va a quedar sentado en el banco, tal vez va a continuar comiendo las galletitas, varias personas van a intentar disuadirlo, comprometerlo con la actividad, las miradas van a empezar a deslizarse hacia el acompañante. “¡Hace algo!” El acompañante está advertido de lo que se espera que haga, de lo que genera determinados efectos en el paciente, ya estuvo allí. La oportunidad que se presenta es la de cuestionar ese ideal, aquello que se supone que es lo mejor para el paciente y producir una pregunta, ¿qué estoy acompañando? Se abre un nuevo campo y la posibilidad de un desplazamiento. En lugar de acompañar el ideal, se podría acompañar el resto, el saldo, aquello que se pretende resolver y un lugar del cual el paciente no tiende a moverse.

Se comienza a acompañar a Marcos desde ese lugar. No ya intentando convencerlo de hacer tal o cual actividad asignada, sino escapándose juntos, al banco, bajo un árbol al refugio de las miradas. Marcos se sorprende, parece divertido a la vez que un poco temeroso. Se genera una complicidad: “qué bueno es estar tirado en el pasto, bajo un árbol”, “hablemos despacio, que nadie nos vea”. Se empieza a constituir un código compartido, desde el disfrute por el descanso hasta el temor por ser descubiertos. Ya nos es solo Marcos el que no se integra, ahora hay alguien más con quien poder hablar de eso. Se habla de lo tedioso de las actividades, de lo cansador que es poner el cuerpo para cargar tierra con la pala en la carretilla. Se abre un dialogo donde cada uno puede poner en palabras aquello que le genera conflicto, lo que falla. Incluso se inventa un modo de poder insultar sin ser sancionados, cambiando las palabras que suelen ser consideradas como las malas.

El momento de relax dura unos minutos, hasta que de pronto el escondite pierde su eficacia. Al notar la ausencia el psiquiatra encargado de la coordinación del dispositivo comienza la patrulla y no tarda

en dar con los desertores. La llamada de atención, el reto, se hace en plural. En acompañante soporta esa mirada desaprobatoria, esa incomodidad, aunque tiene un recurso a su disposición, una carta para jugar si es necesario. Podrá argumentar su apuesta, su lectura, la construcción que ha realizado sobre un circuito que lo único que produce es que Marcos rechace cualquier invitación al lazo.

A partir de ese momento algo cambia. La construcción de un código compartido les va a permitir tanto a Marcos como a su acompañante habitar un espacio común. Un espacio donde es posible el disfrute, pero donde también existe el riesgo, y ese es un problema que tienen ambos. Podrán insultar en sus modos camuflados cuando los manden a juntar abono, cronometrar el tiempo de recreo antes de llamar la atención y ser descubiertos. Marcos empieza a aparecer en las actividades, empieza a encontrarse con sus compañeros, hay algo para compartir, para enseñarle al otro, ese modo de trasgredir sin ser vistos. El código construido comienza a ser una posibilidad para interactuar con los otros. No ya por medio de la eficacia de una tarea, sino a través de lo que falla, del humor, de lo gracioso, de eso que trasgrede sin dejar de dimensionar el cuidado. Marcos se entusiasma, encuentra que los demás comparten esa sintonía.

La posibilidad de trabajar sobre el rol del acompañante y los ideales que de este se desprenden, permite comenzar a localizar puntos de intervención. No es un ejercicio que ocurra en un mismo tiempo ni de forma definitiva. Su posibilidad requiere de otros tiempos: el tiempo del encuentro con el paciente, de experimentar aquello que se repite, localizar el malestar y el conflicto, etc. Encontrarse obturado en un rol específico no es un elemento a evitar. Proponemos pensarlo como un punto de relanzamiento, una ocasión para localizar puntos sintomáticos de un paciente. No se trata de superar el lugar del rol, sino de poder leer en él una oportunidad y para lo cual es imprescindible tener presente que esta lógica puede repetirse con un mismo paciente en distintos momentos del tratamiento.

Para ello hay un tiempo de la reflexión, de la elaboración, del trabajo clínico. Este segundo tiempo se construye en un marco colectivo: en el intercambio con otros miembros del equipo de Acompañamiento, con la coordinación, con la supervisión.

Lo que aquí se intenta situar es un modo posible de comenzar a hablar del Acompañamiento Terapéutico. Es decir, pensar qué tiene de

terapéutico un Acompañamiento, entendido como el tratamiento del síntoma de un paciente. Comenzar a hablar de este modo nos acerca a la dimensión de la función, rescatando un elemento operativo en la dirección de un tratamiento, despejando lugares de intervención que, comandados por ideales, solo perpetúan el circuito del padecimiento.

* * *

Del Rol al Dispositivo: síntesis conceptuales

Según el texto recientemente presentado a cargo de Bruno Pietracatella, el Acompañamiento se vuelve terapéutico cuando habilita un movimiento. No hacia el ideal esperado, sino hacia una forma de habitar lo fallido que permita abrir el lazo. Ese movimiento no es visible de inmediato. A veces se manifiesta en una broma compartida, en un código secreto, en una pausa cómplice bajo un árbol. Otras veces, en soportar la mirada crítica y sostener la apuesta.

Marcos comienza a vincularse. No porque se haya convencido de lo que debe hacer, sino porque algo en la escena se alteró. Porque ahora hay otro con quien se puede compartir lo que no funciona. Y desde ahí, inventar otra cosa.

Ese es, quizás, el punto donde el Acompañamiento Terapéutico deja de ser un intento de corrección y se convierte en una posibilidad de tratamiento: cuando no busca modificar al otro desde el lugar de la norma, sino acompañarlo desde el lugar donde duele, donde se fracasa, donde algo no encaja. Y desde ahí, hacer lazo. Crear condiciones para que lo imposible pueda ser dicho, compartido y alojado.

Ese es también nuestro desafío como acompañantes: estar ahí, sostener la incomodidad, no huir del síntoma, no caer en la trampa del ideal, y a la vez —cuando se pueda— acompañar el movimiento: acompañar sin imponer un rumbo, pero sin soltar la mano.

En el recorrido del Acompañamiento Terapéutico, no es extraño que las primeras preguntas —de quien acompaña, pero también de quien coordina, solicita o incluso financia— giren en torno a lo que hay que hacer. “¿Qué tiene que hacer un acompañante?” Esa pregunta, aparentemente operativa, anida en sí misma una concepción del acompañamiento como rol: un lugar definido, funcional, que conlleva una serie de expectativas más o menos cristalizadas.

El problema no es que haya una función —la hay—, ni que existan coordenadas —son necesarias—. El problema aparece cuando esa idea de ‘rol’ se liga rígidamente a una carga idealizante, a una lista de objetivos que el acompañante debería cumplir: generar autonomía, reducir la angustia, asegurar la adherencia al tratamiento, garantizar la integración social, habilitar el lazo, descomprimir a la familia, evitar internaciones. Cada ítem parece responder a una demanda legítima. El riesgo es que esa acumulación de expectativas convierta al acompañante en un operador de lo que no funciona en otros espacios, un agente de reparación de fallas estructurales del sistema o del lazo familiar.

Esa lógica —la del rol asignado por el ideal— tiende a individualizar la práctica. El acompañante queda a solas con la demanda, con el paciente, con el síntoma, con el fracaso. La soledad estructural del Acompañamiento se ve entonces reforzada por un modelo que lo ubica como el portador de una función totalizante. Y cuando eso no se logra, lo que aparece es la frustración, el malestar, el agotamiento. El rol, así concebido, se vuelve lugar de clausura. Se transforma en una tecnología de control, más que en una apertura de sentido.

Este encierro en la lógica del rol no solo responde a coordenadas clínicas o institucionales, sino también a los marcos legales y administrativos que regulan la práctica. En la elaboración de leyes y regulaciones que intentan reconocer la figura del acompañante terapéutico, se realizan esfuerzos monumentales por definir el rol de manera acotada. Estas definiciones buscan fijar incumbencias, establecer funciones precisas, delimitar alcances. Y si bien este trabajo resulta fundamental en la disputa por el reconocimiento, tiene efectos directos a la hora de proyectar la dimensión clínica: allí donde el rol se cristaliza en un recorte funcional, se restringe también la posibilidad de pensar una clínica que exceda ese marco y que se articule con el padecimiento singular.

Podemos pensar, por ejemplo, en el caso de Lucía, una adolescente con intentos reiterados de suicidio, que participa en un hospital de día. El acompañante es convocado con una indicación precisa: contener, prevenir, sostener. Durante las primeras semanas, el acompañante intenta todo: propone rutinas, diálogos, actividades. Pero Lucía responde con silencio, fastidio o ironía. El equipo comienza a impacientarse: “¿y el acompañante? ¿no genera vínculo?”. El acompañante, en silencio, empieza a preguntarse si está fallando. El dispositivo se reduce a una interpelación al rol: ¿por qué no puede lograr lo que se espera de él?

Frente a esa trampa, proponemos pensar el Acompañamiento Terapéutico como dispositivo. Un dispositivo no es un rol ni una suma de tareas. Es una estructura móvil, situada, que se construye en función de las coordenadas singulares de cada caso. Implica una lógica de articulación: entre acompañante, paciente, familia, equipo tratante, institución. Y también entre acompañantes entre sí. Lo que se instala no es solo un vínculo individual, sino una red simbólica de trabajo, un entramado de miradas, de decisiones, de efectos posibles.

Desde esta perspectiva, el Acompañamiento no se define por lo que se espera de él, sino por lo que hace operar. No se trata de cumplir metas, sino de producir condiciones para que algo del síntoma pueda alojarse, tramitarse, desplazarse. Esa operación no depende de una sola persona, sino que requiere de una clínica entre varios. Es en verdad un efecto del dispositivo. No se trata de lo que una práctica contiene, sino lo que es capaz de producir cuando se articula con otros saberes, con otras prácticas, con otras presencias.

Una escena lo ilustra con claridad: en una casa convivencial, una paciente con diagnóstico de esquizofrenia presenta crisis diarias de angustia que la llevan a gritar y encerrarse. El acompañante, conmovido, intenta calmarla, hablarle, contenerla. Nada parece alcanzar. Es en una reunión de equipo donde otro acompañante propone algo inesperado: cuando ella se encierra, se puede esperar del otro lado de la puerta en silencio. Esa intervención, mínima y no intervencionista, no surge del saber individual, sino del pensar entre varios. El dispositivo habilita un viraje: del hacer compulsivo al gesto disponible.

Pensar el Acompañamiento como dispositivo no elimina la singularidad del encuentro uno a uno —al contrario, la potencia—, pero la descomprime. Le devuelve al acompañante un lugar de interlocución real, donde lo que ocurre en el terreno puede ser leído, compartido, reelaborado. Donde la repetición no se cristaliza en fracaso, sino que puede volverse insumo clínico. Como señala Lewkowicz (2004)⁵, la clínica no es una técnica sino una política del encuentro: implica leer, intervenir y sostener un modo de hacer lazo que nunca es propiedad de un solo sujeto.

Es en esa transición —del rol al dispositivo— donde se juega una de las claves para sostener el Acompañamiento en el tiempo. Porque cuando el dispositivo se activa, el acompañante deja de ser un ejecutor

5. Lewkowicz, I. (2004). *Pensar sin Estado*. Buenos Aires: Paidós.

de mandatos y se convierte en lector, en intérprete, en interlocutor. Y en esa lectura compartida, que requiere tiempo, espacio, palabras, afectos, es donde empieza a construirse lo terapéutico.

No se trata, entonces, de descartar el rol. Toda función requiere un punto de partida. Pero sí se trata de desnaturalizarlo, de ponerlo a circular en una lógica más amplia, menos idealizante, más situada. Esa lógica es la del dispositivo: una práctica viva, en construcción permanente, que solo puede sostenerse entre varios. Allí donde el acompañante puede dejar de ser 'el que hace algo por el otro' y convertirse en parte de un proceso colectivo de elaboración, invención y cuidado.

* * *

La posición acompañante terapéutico: un lazo posible

*Miranda Soriano Dagnino
Franco de Negri*

En esta ocasión proponemos reflexionar sobre el lugar desde el cual se interviene en el vínculo con la persona acompañada. Para ello, tomaremos como referencia algunas variables que se ponen en juego en el encuentro: el encuadre, las funciones específicas del acompañante terapéutico (at) y la diferencia entre una posición clínica y una posición de compañía. A partir de estas nociones, buscamos desplegar uno de los ejes centrales del trabajo en equipo que caracteriza la práctica en Ágora.

También resulta necesario precisar algunas generalidades del Acompañamiento Terapéutico que orienten la elaboración de nuestra propuesta. Partimos de una premisa: El trabajo de un Dispositivo de Acompañamiento Terapéutico apunta a la restitución, reforzamiento o promoción de los lazos sociales. Si el trabajo tiene que ver con el lazo social, consideramos también que hay un problema libidinal en juego: la dificultad de un movimiento libidinal que permita enlazar con el entorno. Entonces, la herramienta fundamental con la que contamos es la posibilidad de lazo con la persona acompañada. Ahora bien, ¿cómo hacer lazo con quien, justamente, padece de una perturbación en el lazo social?

Si bien la posición del acompañante terapéutico se puede pensar desde otros lugares, nos interesa el psicoanálisis porque ofrece una manera de pensar la posición como aquella en movimiento, cuestión que será crucial para el Acompañamiento Terapéutico: poder cuestionar, repensar y rectificar cómo posicionarnos ante una forma de enlazar. A su vez, este movimiento implica suspender momentáneamente el saber y prestarse a los avatares del encuentro con el acompañado.

El encuadre. Condición y puesta en forma del lazo

Conviene pensar esta posición particular en relación al encuadre de un Acompañamiento Terapéutico. Este encuadre supone tres dimensiones que nos permiten pensar esta relación. Por un lado, el encuadre en su dimensión formal que abarca desde el pedido de Acompañamiento hasta la puesta en funcionamiento de dispositivo con sus condiciones específicas (carga horaria, lugar, objetivos, honorarios, etc.). Un Acompañamiento suele ser pedido para abordar cierto tipo de problemas o padecimientos en un tratamiento. Hablando desde un aspecto universal, el Acompañamiento es una respuesta. Es un dispositivo que viene a responder a una problemática específica de alguien, de una situación. Las condiciones del encuadre van a tener que ver justamente con ese problema. Si consideramos que el trabajo del Acompañamiento Terapéutico tiene que ver con la posibilidad de un paciente de hacer lazos con su entorno, estamos suponiendo que el espectro de trabajo no es solamente con un sujeto aislado —el paciente— sino también con su entorno. En este sentido, generalmente la familia toma un lugar central en la cotidianidad, pero también podemos pensar en relaciones de pares, escuela, clubes, centro de día, etc. En todos estos vínculos se pone en juego la dificultad en el lazo, con sus consecuencias más o menos visibles: retraimiento, aislamiento, abulia, desconfianza, suspicacia, etc. El dispositivo de AT es convocado ya que, a veces, estas variables vinculares cobran significación cuando el sujeto es abordado en la cotidianidad de su entorno. A su vez, la organización de las dinámicas vinculares de la cotidianidad muchas veces tienden al mantenimiento de las dificultades que devienen sintomáticas.

Habría, entonces, un encuadre previo, que tiene que ver con las condiciones de acompañabilidad, es decir, con establecer las condiciones a partir de las cuales uno va a acompañar en determinado lugar a deter-

minado paciente. Esta característica específica del Acompañamiento Terapéutico, el abordaje e intervención sobre lo cotidiano, se diferencia de otros dispositivos como el Hospital de Día, el consultorio, etc. Además, este marco fijo que propicia el encuadre sirve para estructurar un cotidiano que en muchos casos carece de cortes en el tiempo, favoreciendo una estructura semanal que ordene actividades y momentos.

Entonces, mencionamos el encuadre como respuesta a un pedido de tratar algún problema, con ciertas condiciones previas. A veces viene dado, formalmente, otras se construye en acompañamiento. O ambas.

La segunda dimensión a tener en cuenta del encuadre es la puesta en forma de éste a partir del encuentro presencial. Si bien decíamos que el encuadre nos precede, este puede verse modificado por la dinámica del encuentro con el paciente. Cuántas veces nos hemos encontrado envueltos en un Acompañamiento donde nos piden quedarnos más tiempo, o irnos más temprano, o cambiar de horario continuamente. Es ahí donde comienza esta segunda dimensión a operar: el encuadre es también algo que se sostiene cada vez, algo que se sostiene en acto.

Esto supone varias cuestiones. En primer lugar, es necesario conocer la dinámica del encuentro con el paciente para poder evaluar si hay algo del encuadre previo que dificulta la posibilidad de hacer un vínculo o si la forma de establecer el vínculo entre AT y acompañado necesita de un sostén en acto del encuadre ya establecido. En segundo lugar, es también incumbencia del AT poder cumplir con lo pactado, evaluando en cada caso qué hace resistencia al encuentro. La posición del acompañante terapéutico se constituye en la medida que podamos preguntarnos sobre lo que hacemos, instaurando una pausa ante la masividad y múltiples estímulos del encuentro con un paciente y su cotidiano. De esta forma podemos pensar las tensiones que resultan del encuentro con el acompañado. Esto es: ¿Me tengo que quedar más tiempo? ¿Por qué me quisiera quedar? ¿Me pasa solamente a mí? ¿Cómo es con otros acompañantes del equipo? Si pensamos el Acompañamiento Terapéutico como cierto ordenador del cotidiano, es a partir de que el acompañante puede preguntarse sobre lo que no funciona del encuadre que pueden pensarse intervenciones posibles y qué implica esta variación en el cotidiano de la persona acompañada. Que el encuadre se sostenga en acto implica que estamos advertidos de que las modificaciones del mismo pueden generar efectos aunque no lo podamos leer

de inmediato. A su vez, eventualmente el encuadre también puede ir modificándose en función de las coordenadas clínicas de ese paciente.

Por último, la tercera dimensión del encuadre que nos permite pensar en la posición del acompañante terapéutico, y creemos esencial, son las condiciones que el acompañado necesita para establecer un vínculo. Como ubicamos, el Dispositivo de Acompañamiento Terapéutico opera en el lazo social perturbado. Esta perturbación obedece, generalmente, al estar por fuera de un discurso compartido y tiene como efecto una condición singular para el lazo. Por ende, pensar las maneras y los lugares en que otros dispositivos se han posicionado para hacer lazo con el acompañado, brinda una orientación en el encuentro con este. El encuentro con el AT supone un agente que pueda dejarse tomar por un lugar desde dónde poder actuar, es decir, supone una posición signada por la docilidad. Supone poder dejar en suspenso el saber y los ideales que se juegan en la subjetividad del acompañante, y escuchar la lógica singular del acompañado. Para operar de esta forma, es condición partir de la posibilidad de ignorar lo que ya sabemos y dar lugar al detalle, al hallazgo y la sorpresa en escena de Acompañamiento.

Esta posición, que se suele nombrar como sumisa o de objeto, permite hacer una pausa y tomar distancia del furor curandis y de los ideales imposibles, habilitando cierta escucha de los recursos singulares del acompañado y la posibilidad de hacer algo con ellos. En otras palabras, poder suspender cierta comprensión de la situación del acompañado a partir de nuestra realidad y significaciones, para dar lugar a otra forma de estar en el mundo.

Creemos esencial para el cultivo de esta posición la posibilidad de la revisión de la práctica, ya sea en supervisiones o en reuniones de equipo. A su vez, creemos fundamental el espacio de análisis propio.

La importancia de lo desarrollado hasta aquí radica en poder estar a la espera de lo que va a pasar y poder recibir lo que el otro tiene para dar. El no saber de la posición implica suponer que el modo en que el paciente está en el mundo tiene una cierta importancia para él, incluso si es de lo que padece. De ahí la dificultad, y el riesgo de querer ordenar la escena desde un parámetro externo, que desconozca la singularidad del modo en el que el acompañado estructura su vida.

Es una posición muy inquieta la del acompañante: ¿por qué pasa lo que pasa? Habría que intentar mantener en vida esa pregunta.

De la puesta en forma al padecimiento en escena: funciones específicas del acompañante terapéutico

Las funciones específicas o particulares del AT se construyen en cada Acompañamiento. En un plano general, se puede establecer un objetivo formal acordado en el equipo de tratamiento, en relación a la restitución de lazo social y la autonomía, por ejemplo. Luego, esto nos lleva a pensar cómo formalizarlo en la singularidad de cada encuentro con el acompañado. A su vez el objetivo formal tendrá un valor de indicador que se consolidará en el tiempo: oficiará como una unidad de medida sobre lo que se ha logrado o no en acompañamiento.

¿Cómo llegar al objetivo o indicación formal con el cual se inicia un Acompañamiento Terapéutico? Teniendo en cuenta lo situado anteriormente, nuestra mayor herramienta es el lazo o vínculo que podemos formar con el acompañado: éste será una puesta en forma de la resistencia o dificultad de la que el acompañado padece. Se trata de pensar cuáles son las condiciones que el acompañado requiere para enlazarse a otros. Es decir, buscamos ubicar en el despliegue de las condiciones y lógicas que la persona acompañada ha construido, el elemento que se repite o resiste, transformándolo en una coordenada que nos permita intervenir. En cierta forma, buscamos entrar en un lenguaje desconocido, que repite ciertos modos de vincularse que hacen al padecimiento y que, para intervenir, debemos hacerlo en ese mismo lenguaje.

Al poder leer esta forma sintomática y padeciente de actuar, reunión de equipo mediante, permite incluir al Acompañamiento Terapéutico en un piso común en el cual poder intervenir incluyéndose en esa dificultad del lazo. Esta lectura tendrá sus sucesivas modificaciones y rectificaciones.

Podríamos decir que lo que viene decantando de este desarrollo es que una de las funciones principales del acompañante terapéutico es poder sostener el interrogante en el Acompañamiento Terapéutico. Y ese interrogante, con el tiempo, irá moldeando estrategias y coordenadas de trabajo. No es sin el interrogante y sin una lectura posterior, obviamente, porque uno puede tener un montón de respuestas sobre lo que uno preguntó, pero esas respuestas después tienen que ser leídas en función de un padecimiento, de unos objetivos, de un tiempo, de una estrategia.

Interrogar la compañía: hacia una posición clínica del acompañante terapéutico.

A lo que llegamos es a la diferencia radical entre una posición clínica y una mera compañía o lazo de amistad. Esta es una pregunta que suele surgir: ¿qué diferencia hay entre el AT y el amigo? Y no está mal porque a veces hace las de amigo o tiende a confundirse con un vínculo amistoso. La principal diferencia es que el acompañante terapéutico se maneja en el marco de un encuadre, y una posición ética que, durante y después del Acompañamiento, le permite estar atento a lo acontecido. Preguntas como ¿pero porque es que dije esto? ¿Y por qué me respondió eso? ¿Y por qué me quedé cinco minutos más? ¿Qué estaba pasando antes?, etc. La diferencia radica en una revisión constante de lo que sucede, que es lo que forma a la posición ética del acompañante.

Las preguntas no se realizan solamente interrogando qué fue lo que dijo o hizo el acompañado. Entendemos que los afectos e impresiones del acompañante también dicen algo del Acompañamiento y del relato del padecimiento que se pone en forma en el encuentro. Entonces, no podemos tildar de casual que en tal situación yo me sienta angustiado, o enojado, o contento porque todo sale como debería salir, etc. Eso dice algo, por lo pronto ni bien ni mal, ni que trabajé mal ni que trabajé bien. Dice algo en la medida que sucede en el vínculo con el acompañado, donde se ponen a jugar las condiciones de lazo que llevan a repetir cierto padecimiento. Para identificar lo que se repite es necesaria una instancia tercera, exterior al encuentro, donde se pueda dar cuenta de que viene surgiendo. Esto puede ser en una reunión de equipo de Acompañamiento o en una reunión interdisciplinaria, o en una supervisión, o en la puesta en común con otros colegas.

No olvidemos que el acompañamiento es un artificio de lazo social. Nos convocan al lugar de la cotidianidad de alguien, a un lugar que, a priori, fue ocupado por otros. Ubicamos que la docilidad nos permite construir un vínculo que contemple las condiciones que el acompañado necesita para hacer lazo, su economía libidinal y las formas de padecimiento que leemos en lo que se repite. En principio, para poder enlazar donde falló el lazo con otros anteriormente. En otras palabras, el acompañante terapéutico debe estar advertido de lo que va a causar: transferencia. El armado y construcción de un lazo requiere provocar transferencia, es decir, la actualización en el vínculo del acompañante-acom-

pañado de las formas en que el acompañado se relaciona con los demás. Aquí también conviene pensar qué efectos se suscitan en las distintas vertientes de la transferencia. Este aspecto también hace a una posición clínica, ética y responsable.

Una parte del trabajo del acompañante tendrá que ver con la puesta en forma del lazo social, como si se ensayaran esas dificultades que responden al problema por el cual nos convocaron. En este sentido, puede pensarse que el Acompañamiento encuentra su fin cuando el acompañado logra, a través de los sucesivos ensayos que se ponen en escena en el vínculo con el acompañante, enlazarse con otros de una forma menos padeciente, sintomática y rígida.

* * *

MÓDULO 2: Los afectos en el Acompañamiento Terapéutico. Lo propio como materia de trabajo clínico

El Acompañamiento Terapéutico, tal como lo hemos venido desarrollando hasta aquí, no es una práctica neutral ni aséptica. Es una forma de implicación clínica que se sitúa en el corazón mismo de la intimidad del otro. El acompañante se hace parte de una escena que no le pertenece, pero en la que participa de un modo activo, sostenido y encarnado. Esa escena no es simplemente el “afuera” del paciente, sino su cotidianeidad vital, atravesada por afectos, hábitos, heridas, gestos y estilos de existencia.

En ese punto, acompañar implica exponerse a la diferencia, a una cercanía que desacomoda. Como hemos trabajado en el módulo anterior, la posición del acompañante parte del reconocimiento de un lugar clínico específico, que no puede ser confundido ni con el de un amigo, ni con el de un familiar, ni con el de un profesional que simplemente ejecuta una tarea. Esa posición se define, entre otras cosas, por no poner en juego el propio deseo, ni hacer del acompañamiento un escenario de goce personal. Pero eso no significa, de ningún modo, que el acompañante quede por fuera de la escena, que no se vea afectado, que no le pasen cosas. Sabemos que en el Acompañamiento uno participa con su propio cuerpo, con su historia, con sus marcas.

Es imposible acompañar sin que algo de lo propio se filtre. Lo importante no es impedir ese filtrarse –sería un ideal imposible y, en última instancia, deshumanizante– sino poder advertirlo, trabajarlo, leerlo.

En ese sentido, el Acompañamiento se convierte en un trabajo permanente sobre sí mismo. Una ética del reconocimiento de los afectos, no para clausurarlos ni para actuar desde ellos, sino para ponerlos a jugar clínicamente, en beneficio de la lectura, la elaboración y la estrategia.

Decimos entonces que el Acompañamiento Terapéutico es, también, una clínica del error. Porque el error no es un fallo a evitar, sino un dato clínico que, si es compartido, puede transformarse en potencia. Siempre y cuando esa escena que nos tocó, nos interpeló, nos incomodó o incluso nos desbordó, sea llevada al espacio del equipo, pueda ser alojada en la conversación clínica, y puesta a trabajar en la estrategia del dispositivo.

Propongo una escena: Acompañaba desde hacía tiempo a una paciente fanática del grupo Menudo. Compartíamos caminatas y, a veces, viajes en tren. En cada salida, mientras esperábamos el tren en el andén, se ponía unos walkman y solía cantar y bailar las canciones del grupo, pero en voz alta y con entusiasmo. Esa actitud generaba curiosidad y extrañamiento entre las personas, que la observaban con miradas que no eran precisamente cómplices. En mí, esa situación provocaba una intensa vergüenza. No lo decía, pero me atravesaba. No era una época en la que se concia el Acompañamiento como hoy y se me imponía una pregunta cargada de prejuicio ¿qué creará la gente que soy de esta chica? ¿Por qué me mantengo a su lado?

Pude llevar esa vivencia a una reunión de equipo, con vergüenza, con prejuicio, y allí, al ponerlo en palabras, se abrió un punto de lectura que antes no tenía. Entendimos que mi incomodidad no era solo “mía”, sino que podía ser indicio de algo de la escena misma. La paciente no podía advertir el efecto de sus acciones en los otros. Su despliegue afectivo no encontraba un límite propio, ni un registro de cómo era recibido. Eso no significaba que hubiera que censurarla, ni corregirla. Pero sí que podía ser una oportunidad para trabajar con ella una lectura más fina de lo vincular, de las reacciones que generaba, de los modos en que sus gestos podían acercar o alejar.

En los encuentros posteriores, comencé a nombrar eso que pasaba. Nombrando la vergüenza personal, pero no desde la vergüenza personal, sino desde lo que podía estar ocurriendo en el entorno: “¿Te diste cuenta que esas miradas quizás no eran de alegría, sino de incomodidad, de extrañamiento?”. La escena, entonces, dejó de ser solamente una vivencia molesta para mí, y pasó a ser un elemento de intervención. Un punto de anclaje para pensar con ella las dificultades que tenía para generar lazos.

Así, un afecto propio –la vergüenza– se transformó en un insumo clínico. No por sí mismo, sino porque fue advertido, leído y trabajado con otros.

El MÓDULO 2 propone, entonces, una lectura clínica de los afectos. Una invitación a hacerse cargo de lo que sentimos sin actuarlo, y a construir una ética del Acompañamiento que sepa alojar el error, la incomodidad, la contratransferencia y la tensión como parte constitutiva del dispositivo.

No se trata de psicologizar al acompañante, ni de exigirle una transparencia emocional imposible. Se trata de sostener una práctica que, sabiendo que lo propio se juega, se hace cargo de que eso sea parte de lo que se pone a trabajar. A veces para abstenerse, otras para hacerlo insumo clínico. Nunca para hacerlo jugar en términos propios.

La escena de Acompañamiento no se resuelve en el uno a uno. Es el equipo el que garantiza que los afectos no se desborden ni se naturalicen, sino que encuentren un cauce clínico. La estrategia no se define en soledad, sino en conversación con otros que también se hacen cargo de sus propias resonancias. Y en ese lazo, en esa red de elaboración compartida, se vuelve posible intervenir sin imponer y sentir sin desbordar.

Los textos que siguen retoman esta pregunta desde distintas escenas, perspectivas y escrituras. Lejos de cerrar el tema, lo despliegan. La invitación es a recorrerlos con la disposición de quien no busca recetas, sino modos posibles de alojar lo que nos pasa cuando acompañamos.

* * *

La transferencia y los afectos

Natalia Rotbard

Introducción: la ética desde Spinoza y Freud

En el presente desarrollo nos proponemos restituir la dimensión electiva que ha perdido la locura en este tiempo en que el capitalismo ordena los lazos sociales. En otras épocas lo loco, lo caprichoso, tenía un valor religioso, enigmático, sagrado. Con el surgimiento de la ciencia moderna y su necesidad de controlar los cuerpos bajo un saber predecible se ha rechazado, encarcelado y medicalizado lo loco que habita en cada sujeto padeciente. Las posiciones asistenciales en los dispositivos de salud mental están sujetas a los modos en que el psiquiatría garan-

tiza y ordena la idea de bien. Producir, consumir, ser feliz. La locura molesta y produce miedo.

Desde Spinoza y Freud existen dos maneras de abordar el lazo social que permiten desmontar las ficciones construidas por la razón moderna.

Desde el punto de vista Freudiano en un texto fundamental como el malestar en la cultura, propone que el lazo social implica ciertas renunciaciones a satisfacciones inmediatas sostenidas en la necesidad de reconocimiento que impone la dependencia en la que nacemos. En un comienzo el niño y la madre (en tanto teta) son complementarios. Es en el momento en que la madre falta a cubrir la necesidad del niño en que se constituye como un afuera: no-yo. El afuera es esa primera marca del dolor que adviene en la insatisfacción de la necesidad. También es ahí donde se intenta recuperar el estado de completud anterior alucinando al objeto (teta). Esta posición es abandonada porque el niño si no se dirige a otro que lo alimente, muere. Entonces la alucinación es sustituida por el deseo pensado como falta: existe una pérdida de objeto complementario que puede ser dado o negado por el Otro (materno) caprichoso y enigmático. La demanda comienza a simbolizarse, ya no se necesita el objeto que colme la necesidad sino el signo de amor como garantía de supervivencia. Si el Otro en tanto afuera enigmático se presenta, es bueno, sino malo. ¿Cómo hacer para localizarse respecto del deseo del Otro imprevisible que deja al sujeto a merced del puro capricho? Existen ciertas medidas que organizan lo posible e imposible que el Otro de la cultura impone al deseo materno. En psicoanálisis esa función de mediatización con el capricho es la función paterna. Lo que antes era un enigma (el deseo y el dolor), ahora se anuda a cierta moral que garantiza la supervivencia: si los cuerpos se someten a estas prácticas del bien serán reconocidos, amados y alimentados. Es en esos escenarios particulares, familiares, en que esos modos de lazo, rituales, maneras de comer, coger, cagar, amar, se localizaron. Así se constituyen los clichés que anudan los objetos de la pulsión y los objetos del amor: lazos sociales. El dispositivo de Acompañamiento Terapéutico será convocado para develar y transformar ciertas dinámicas en las que el deseo quedó atrapado por la necesidad de normalización que el reconocimiento impone y que ha dejado de funcionar en esos modos de lazo.

Desde una lectura spinoziana la constitución del estado como democrático implica el pasaje de la anarquía natural donde priman la amenaza y la supervivencia, a un modo de socialización basado en la pasionalidad humana. La pregunta por la libertad en este punto es fundamental para

situar un modo de lazo en la vida civil que aloje y potencie las singularidades. ¿Cómo construir una política que no apele a un trascendental que ordene los lazos en términos morales sino en la inmanencia de un límite y un deseo que puedan alojarse en la comunidad?

Es fundamental para pensar la política incluir la posibilidad de libertad, sin ser suficiente realizarse a sí mismo sino además pensar la vida pública.

“La idea de amistad critica y suspende el pacto, el mecanismo contractual: la comunidad de hombres libres imaginada por Spinoza no tiene la forma negativa de socios que contraen obligaciones, sino la dinámica afirmativa de amigos que componen su potencia de existir y de pensar. No debemos concebir la política a partir de la generalidad de la ley, sino a partir de la singularidad de los encuentros y de los procesos de formación; tampoco debemos pensar la sociedad como un conjunto estable de reglas, sino como una producción de comunidad que se reproduce sin meta. No se trata pues de normas que se aplican –y que en cuanto tales se definen por su trascendencia y su formalidad– sino más bien de totalidades que se generan según una inmanencia estricta. La amistad es el modelo de una liberación común que no se subordina a ningún desenlace de carácter histórico, despojado de todo *espíritu de utopía*”⁶.

La ética spinoziana se sitúa más allá del bien y del mal, suponiendo que no existe una común medida para el deseo en la singularidad de los sujetos que padecen y gozan. Piensa solamente en relaciones que potencian o des potencian a los sujetos en un encuentro determinado, no pudiendo señalarse a priori las normas que lo regulen. Esta idea de proceso y necesidad constante de pensar el límite que los afectos evidencian es lo que tomaremos del planteo de Spinoza.

Desde allí vamos a localizar los modos de intervención propios del dispositivo de Acompañamiento Terapéutico: no sabemos qué es bueno para el paciente, no tomaremos la moral imperante para adaptar al loco a los modos de producción de la época.

Apostaremos por un lado, al desmontaje de la transferencia (los clichés mencionados en el apartado freudiano) por constituirse como una relación de dependencia estructurada por las medidas comunes de normalidad que inhiben el deseo.

6. Tatián, D., *La cautela del salvaje. Pasiones y política en Spinoza*, Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2001 (red. en Colihue, Buenos Aires, 2015). pág. 136.

Por otro lado, tomaremos los afectos que los acompañantes sienten en la escena del Acompañamiento como un emergente sintomático de ese vínculo. El afecto como signo de una des-potenciación de los cuerpos enlazados a las pasiones tristes; miedo, rivalidad, impotencia, etc. Estos afectos son producto de la necesidad de que otro reconozca, rescate y diga sobre el loco, silenciando su voz. Son saberes exteriores que nacen de las reglas y los contratos sociales que legislan sobre los sujetos desconociendo la potencia de los procesos deseantes.

Estos dos signos, la transferencia y el afecto, son ordenadores clínicos y éticos desde donde leemos nuestra práctica y pensamos intervenciones que restituyan la dimensión electiva retirada al loco en las demandas normativizantes de la psiquiatría.

Maneras en que el dispositivo de Acompañamiento Terapéutico responde a las demandas de tratamiento

El Acompañamiento Terapéutico se inscribe en las diferentes esferas de la vida pública y sus relaciones de dominación. Responde al pedido de tratamiento donde el paciente es pensado como un síntoma-emergente de una dinámica familiar. También como un emergente de disfuncionalidad en los lazos sociales regulados por los modos de producción e institucionalización. Es decir, somos convocados ahí donde la locura hace ruido y los intentos de control han fallado.

La demanda de tratamiento apela al control y la resolución de cierta problemática: que se adapte, que haga algo de su vida, que tome la medicación, que no pegue. Nosotros leemos allí una voz muda, que es funcional a su vez, a ciertas dinámicas que no han podido escucharla y en donde ahora tenemos oportunidad de intervenir.

La intervención apunta a cierta modificación de la economía libidinal del espacio y tiempo particulares donde tiene lugar el tratamiento. Espacio y tiempo son dos categorías simbólicas que nos hablan de la dimensión subjetiva en tanto en ellas se representan, por un lado, los modos socialmente establecidos de hacer lazo con los otros (contratos y reglas) y, a su vez, el modo singular en que esa dinámica los reproduce (ahí se abre la posibilidad de un devenir inmanete y no trascendente, estanco, del lazo).

También contamos con los afectos. Los modos de afectación de un cuerpo sobre otro nos ofrecen la posibilidad de situar una dimensión

ética que permita abandonar las relaciones de poder, sometimiento, en favor de cómo se potencian los cuerpos cuando registran sus límites sin la necesidad de apelar a una regulación exterior, moral, trascendental. La forma de burlar las relaciones de poder se va a soportar en las intervenciones apoyadas en el afecto. Los afectos tristes (aburrimiento, hastío, envidia, bronca) son efectos de las dinámicas sintomáticas que aprisionan al cuerpo, intentándolo someter a ciertas categorías morales a las que se resiste. En cambio los afectos que potencian al sujeto (alegría, entusiasmo) dan cuenta de cómo un cuerpo actúa de acuerdo con su deseo.

El síntoma porta una dimensión ética y cuestiona los saberes con los que nos incluimos en el escenario del tratamiento. Esos saberes cuestionados se vinculan tanto al espacio y tiempo como a los afectos. Por ejemplo: a qué hora debe levantarse un paciente, a qué hora debe comer, cómo debe ordenarse o higienizarse una casa. Todos saberes que apelan a diques sociales que legislan en el espacio privado, o no, y se ponen en cuestión a partir de la introducción del acompañante en la escena.

Germán García en su conferencia sobre las pasiones plantea:

“En este libro, *Psicoanálisis. Radiofonía & Televisión*, Jacques-Alain Miller hace las tres preguntas kantianas: ¿qué puedo saber?, ¿qué puedo hacer?, ¿qué puedo esperar?.

¿Qué puedo saber? Es una pregunta lanzada a la dimensión de la ciencia, en términos kantianos, es la pregunta de la razón pura. ¿Qué puedo hacer? Es más complicado, porque no hay una enciclopedia de lo que uno puede hacer, lo que uno puede hacer tiene que inventarlo, chocan las morales, las concepciones del mundo, etcétera. ¿Qué puedo esperar? Es una pregunta religiosa. (...) ¿Qué debo hacer?” La idea misma es una idea moral, tiene que ver con la razón práctica. Lo que yo hago, dice Lacan, es extraer de mi práctica una ética del bien decir. El “bien decir” no tiene nada que ver con pronunciar bien las palabras ni con hablar floridamente, tiene que ver con encontrar la palabra justa que dice lo execrable”⁷.

Cuando el acompañante interroga las dinámicas nunca lo hace teniendo como referencia las cosas, enunciados, sino más bien la enunciación, para quién y desde dónde se dan esas respuestas. Por qué una

7. García, G., *El curso de las pasiones*, Fundación Descartes, 1999, disponible en <http://www.descartes.org.ar/germangarcia/assets/files/1999-lcursodelaspasionesPDF.pdf>

madre entra sin golpear al baño cuando está su hijo discapacitado, en un espacio que supuestamente es privado y hablaría de la separación de esos cuerpos. No se opera sobre esas cuestiones que distribuyen el espacio y el tiempo desde un juicio de valor. No están en juego los ideales del *at* como ser: ¿debería la madre entrar? ¿Es invasiva o escucha a su hijo? Pobrecito no puede. Apelamos a que la educación y el control que los juicios producen se vacíen de la escena dejando espacio a la pregunta acerca de las ganancias y pérdidas en las que esa dinámica se sostiene. El lenguaje no se toma en su dimensión de comunicación sino como posibilidad de lazo social ¿desde qué dinámica un sujeto se hace representar o nombrar por el Otro? Y por eso cuando se abordan los afectos que surgen en la escena se piensan de un modo transferencial y no referencial. Los afectos no refieren a los hechos sino a los vínculos.

El dispositivo de Acompañamiento Terapéutico implica una ruptura de la satisfacción sintomática que venía operando. Es una sanción que opera como registro de aquello que por acontecer anteriormente en un ámbito privado, quedaba silenciado por las paredes del hogar. Se comienza a iluminar el mapa de tensiones donde la localización de los sujetos es un efecto de esa economía libidinal que los produce con sus ganancias y pérdidas. Pero falla y empuja la demanda de tratamiento.

Por satisfacción sintomática entendemos aquella que toma del discurso social estandarizable los modos de hacer con lo traumático de la sexualidad y la muerte y, a su vez, la falla.

¿Cómo se hace en el lazo social desde el deseo?

Al decir de Freud la manera de vehiculizar el deseo se produce en el desmontaje de la transferencia. La palabra que sale de la moraleja es aquella que toca el cuerpo de manera alucinatoria, la palabra sensorial. Freud en el cap. VII de la interpretación de los sueños propone la diferencia entre la representación cosa y la representación palabra. La primera, corresponde al proceso primario, aquel que regula la producción onírica: en este proceso la palabra es tratada como una cosa, no entra en la circulación del discurso común, sino que se mantiene como esa lengua privada del loco en donde no existen las contradicciones y todo es posible, como en los sueños. El proceso secundario, que se sostiene en la representación palabra, implica la postergación de la satisfacción en función del criterio de realidad que rige los lazos culturales, produciendo así “el malestar en la cultura”.

Germán García citando a Spinoza ya había realizado la articulación

entre la razón encarnada en una palabra sensorial y la producción de la alegría en el lazo:

“Creo que es un proceso homólogo a la ética de Spinoza cuando dice que, en tanto soy un ser universal, en mí anida esa razón universal y no la entiendo como tal porque tengo un cuerpo sensible, particular, que me impide entender. Por lo tanto, si me entiendo me realizo. Me realizo en el sentido en que Lacan dice, en un momento, realizar en lo universal su lugar de sujeto. Me hago contemporáneo de mi propia racionalidad. Y eso para Spinoza es una alegría y es una expansión, mientras que es una tristeza estar hundido en la particularidad mortal de un cuerpo que me somete”⁸.

Spinoza con su propuesta de vida en comunidad está en contra de la idea de identidad en tanto los seres no son sino respecto de las afecciones que los potencian o los despotencian. Lo identitario se sostiene en el proceso secundario que en la cita se nombra como las particularidades. Los diagnósticos son particularidades que nos incluyen en un grupo en el que compartimos ciertos mecanismos. En el tratamiento que proponemos se apela a desarmar esos mecanismos que regulan tomando del Otro social ciertos nombres que patologizan al sujeto y obstaculizan la emergencia de su singularidad. No habría una esencia del ser sino un devenir de afecciones. Esa es la forma de proponer una ética del deseo en la inmanencia del límite y no una moral utópica. Un paciente no es esquizofrénico sino por su manera de relacionarse con el Otro: se sostiene en el registro de la representación cosa, al decir de Freud, en el registro alucinatorio de la lengua, en el plano onírico en donde no comparte el sentido común y por eso parece loco su decir. Sin embargo, si se lo sabe escuchar, sin pretensiones de normalización, hay un saber mudo que podría enlazarlo al Otro de un modo singular. La transferencia es el modo en que se sostiene la posibilidad de un Otro proveedor de aquello que falta por el cual se posterga la realización del ser como deseante. Por eso es fundamental el desmontaje de esta relación al saber que ese Otro podría tener sobre mi deseo. Ese desmontaje deja al desnudo la palabra alucinatoria, representación cosa, que no se enlaza a un saber sino a una afectación singular creadora de sentidos nuevos.

La razón moderna que nace con el discurso científico inaugurado por Descartes, sostenida en el conocimiento objetivo, claro y distinto, insti-

8. García, G., *El curso de las pasiones*, Óp. Cit.

tuye las medidas comunes de los cuerpos y los lazos, velando lo traumático del sinsentido de la vida. La ciencia constituye un saber-poder que esconde su falla fundante por prometer un saber total imposible sobre lo traumático que resulta el desconocimiento respecto de la sexualidad y la muerte. ¿Cómo plantear un dispositivo que se sostenga en esa falla para darle emergencia a voz de la locura?

El cuerpo resiste a ser controlado por el saber científico y nosotros como agentes de la salud mental nos alojamos en ese borde en el que se nos demanda una curación por el control y ofrecemos un tratamiento por el deseo.

Presentación del caso

Micaela es una paciente de 23 años, esquizofrénica, que vive con su madre. El pedido de Acompañamiento se produce luego de 8 años de su primera descompensación. Durante todo ese tiempo la familia había estado intentando (también sus médicos tratantes) restituir un estado anterior de cosas. Sin ubicar que la sintomatología que se presenta de manera disruptiva es una voz que necesita un decir y una escucha en un escenario que la oprime.

Sus síntomas son: *vidrios en el ojo*, o bien se siente *presa de gran hermano*, *mi papa no es mi papa, es un impostor*. Esas las frases sueltas se ligan por momentos a *fui secuestrada*, *no me dejaron teñirme el pelo* y *por eso me hacían bulling*, *me senté en la pierna de un compañero en el micro del viaje de egresados* y *por eso no pude renacer joven*.

Sin embargo, este sujeto no produce una demanda de tratamiento porque aún su padecimiento no implica una subjetivación que apele a una necesidad de cambio. La demanda se produce de parte de la madre, a quien le pega. Y del padre, quien desconoce a su hija después del brote *pobre Mikita, era divina pero ya no se puede compartir nada, yo tengo que cuidar a mi otro hijo porque lo mata verla así*. La locura produce miedo. El dispositivo familiar nombra esto como locura para intentar normalizar a Micaela. *Ella era una nena buena, linda y dócil pero pobrecita ya no queda nada de eso*, dice su papa, a quien le cuesta mucho pasar tiempo con ella y cuando lo hace esta todo el tiempo intentando que “entienda” cosas. La hace pensar palabras en inglés, temas de geografía, para sentir que el tiempo es productivo, que su hija es normal o bien, que él es un buen padre.

Su madre, por otro lado, se llama Débora y se la ha comido. Le pide al Acompañamiento que la mire todo el tiempo, como hace ella. Le pide a la coordinación el teléfono de las acompañantes porque no tolera la distancia con su hija. Esa indiferenciación que la madre vive, sabiendo qué quiere su hija, qué necesita, si tiene frío, calor, hambre, la constituye como una mirada omnipresente frente a la cual no existe subjetivación posible. No es posible pelearse con esa madre porque nunca falla, ni falta. Está presente en todo, no se llega a constituir como un sujeto deseante que está en otro lado. El síntoma es *vidrios en el ojo y golpes* productos de la imposibilidad de distancia. La mirada no se metaforiza.

La madre ofrece comida constantemente, no es capaz de tolerar la frustración que el no saber respecto del cuerpo implica. Micaela nunca puede registrar el hambre porque el agujero siempre es llenado con comida. El miedo de la madre a que algo le falte, siendo su nombre Débora, termina produciendo un Otro omnipotente y omnipresente del que no puede restarse. Es fundamental tolerar ese vacío que implica la experimentación y subjetivación del propio cuerpo y ahí es llamado el dispositivo. Esas frases aparentemente fragmentadas implican la necesidad de introducir un intervalo en el tiempo y el espacio entre su cuerpo y el capricho materno. Ahí es donde el padre en tanto impostor no ha podido más que reenviarla al capricho de la madre. Ese padre que sólo podía amar un ideal o dejarla en las fauces maternas para ser devorada por la mirada. Falta la función paterna que organiza y da medidas al deseo de la madre. Falta el exterior que el deseo implica. El padre como función simbólica podría haber sido también la medicina. Pero esta madre no ha dejado entrar a nadie en la diada que constituye con su hija. Es por ese motivo que el Acompañamiento se introduce por vía judicial.

El significante es lo que representa al sujeto ante Otro significante. Es decir, no existe un sujeto como sustancia, no existe la locura como esencia. En este caso existe un modo relacional en donde eso que se presenta como significante no logra encadenarse con la razón del sentido común y se nos presenta como *loco*. *Tengo un vidrio en el ojo* hoy puede leerse como la mirada intrusiva que no puede ni siquiera ligarse a la queja de una adolescente respecto del control materno. *Quiero renacer joven, o no me teñí el pelo y por eso me hacen bulling* son imágenes deslocalizadas de un cuerpo que no pudo agenciarse. Se constituye una sexualidad que no logra anudarse a argumentos identitarios que permitan una separación del capricho materno.

Intervenciones clínicas tomando los postulados respecto de la transferencia y los afectos

La primera intervención del dispositivo soporta las condiciones de posibilidad para estar ahí. La madre pide el teléfono de las acompañantes a coordinación porque no tolera el intervalo entre su necesidad y la distancia que el Otro cuerpo implican. La coordinación sostiene que la regla impide que ella tenga el celular de las ats e indica que cuando no está con su hija puede llamar a coordinación si es necesario.

Más allá de las coordinadas en que la instancia de coordinación plantea condiciones de posibilidad del dispositivo, existen los cuerpos en el encuentro que reproducen o desarticulan los modos transferenciales que las dinámicas sintomáticas conllevan.

Por ejemplo, uno de los afectos que se presentaba en las acompañantes del caso era bronca. Las contradicciones de la madre de Micaela diciéndole a su hija que tenía que bajar de peso y luego trayendo varios platos de comida juntos producían bronca desde una mirada exterior que sancionaba allí a una “mala madre”. ¿Cómo es posible que alguien que tiene que cuidar a su hija, que nota las dificultades de Micaela para limitar la voracidad y sus ganas de adelgazar, luego no pueda registrar el exceso de comida que ofrece? Esa pregunta que se hicieron varias acompañantes esconde el ideal de bien en la que una madre sabe lo que el cuerpo del hijo necesita y se lo ofrece. También reproduce la pasividad en la que Micaela se encuentra, no pudiendo agenciarse de su propio cuerpo, lleno, satisfecho. Se borra la dimensión electiva para ambas.

Por un lado, el Acompañamiento Terapéutico no piensa al paciente como Micaela sino como las dinámicas en las que este sujeto se reproduce. También partimos del no saber sobre el deseo que esa dinámica implica. A lo largo del Acompañamiento esa bronca que daba cuenta de la impotencia que sentían las acompañantes por querer el bien de Micaela, se fue transformando. Débora en lugar de madre despótica y controladora empezó a emerger como madre fallada, angustiada. La imposibilidad de saber cómo acceder a la función materna que cualquier madre atraviesa, había quedado coagulada en Débora como alguien que debía compensar sus propias falencias como hija de una madre abandonica. Esta lectura fue posible porque la bronca que estaba atada al juicio de mala madre (moral trascendental) se transformó en pregunta. ¿Qué te preocupa de Micaela? Frente al ofrecimiento constante de comida,

objetos, presencia, a la exigencia de que la miremos para que nada le pase. En esa pregunta hacia la madre aparece su propia historia, su propia madre abandonica y el miedo a ser como ella.

Luego de los pedidos de control a Micaela se deslizaron hacia los reproches a su exmarido en el abandono de su función paterna. Esto era el emergente en las situaciones de violencia o cansancio donde Débora aducía que no podía más ocuparse sola de su hija. El movimiento de escucha y legitimación de su sensación de desamparo produjo la primera desarticulación de la transferencia. Ahí donde Débora ofrecía vorazmente cualquier objeto intentando colmar la demanda, no hacía espacio al deseo de Micaela. Esa voracidad partía de su propia sensación de abandono que fue alojada por las acompañantes cuando pudieron transformar la bronca en escucha. No hay un saber respecto al bien hacer de madre, hay un padecimiento de esta madre que la empuja a compensar sus faltar y reproduce una dinámica de la que padece, que su hija le pegue. Proponerle que se fuera y hacer de padre fue la primera función del Acompañamiento.

Cuando Débora fue escuchada en sus reclamos, la insistencia de colmar la falta cesó. La amenaza en que ella estaba todo el tiempo sintiéndose insuficiente pudo dar espacio a las preguntas por su deseo: tenía sus dientes podridos y mucho miedo de ir al dentista. Las acompañantes gestionaron esa ida al médico, como un tercero que empezó a mediar entre los cuerpos antes fusionados de Micaela y su madre. En algún momento también empezó a chatear con un hombre. Fantasear con su lugar de mujer, que hacía de límite a la voracidad de una madre imposible.

Este movimiento dejó espacio al compartir con Micaela sin la mirada omnipresente de su madre. Otros afectos invadieron la escena del Acompañamiento. Aburrimiento por ejemplo frente a la demanda constante de Micaela de repetir los mismos juegos de mesa en el encierro del hogar. Esa medida repetitiva, idéntica, era un intento precario de regular la presencia del Otro caprichoso y amenazante. Micaela no sabía qué hacer en el encuentro con un par. El lazo implica necesariamente el encuentro con la diferencia que Otro cuerpo es. Cuando no se cuenta con las medidas del sentido común que los contratos sociales ofrecen, las repeticiones literales funcionan como intento fallido de la determinación de la amenaza.

En esta oportunidad el trabajo fue en la línea de transformar el aburrimiento producido por ese control, en una diferencia que fuera consensuada y que no portase la dimensión amenazante. Poder decir que estaban aburridas habilitaba la posibilidad de que algo les falte.

No solamente algo le faltaba al Acompañamiento sino también algo que Micaela podía dar para cuidar su espacio. Este movimiento arranca al sujeto esquizofrénico de la pasivización que impone un Otro omnipresente y onnipotente. Comenzaron a pensar en un afuera: salir a la plaza, por ejemplo, elegir la ropa con la que vestirse, pensar si querían llevar el mate. Lidar con la mirada y la investidura de una escena en donde ya no operaba el control materno.

A modo de conclusión, otras razones para la lengua

En el recorrido propuesto a través de la transformación de los afectos de enojo y aburrimiento se ha modificado la disposición del espacio y tiempo en que Micaela y su madre reproducían el lazo sintomático. Estos afectos fueron puestos en juego leyendo que su soporte era también la negación del deseo en la escena en función de cierto reproche a Otro garante y proveedor (padre). Cuando pudieron incluirse los afectos desde el cuerpo de las ats y no desde su moral, se habilitó un exterior, primero para Débora, luego para Micaela. Este exterior no es más que la posibilidad de descompletar el destino fijado para estos sujetos sujetos a determinadas modalidades de satisfacción, sin poder elegir otras. La presencia del dispositivo restituye la dimensión electiva vehiculizando a través del afecto un lazo que aloje el no saber cada vez y el gusto, vaciando así las matrices que se reproducían de manera automática y rechazaban sus voces.

El deseo queda atrapado en los caminos del destino –eso que nos petrifica en una identidad y nos condena a ser siempre iguales a la idea que rige sobre nosotros– cuando la emergencia del deseo es vivido como una amenaza. La posibilidad de que emerja otro cuerpo está dada en que el pasaje por lo traumático no se enlace a sentidos comunes, que son finalmente quienes someten al cuerpo en las repeticiones del destino. Cuando el acompañante no impone saberes exteriores, trascendentes, que operan desde un juicio de valor acerca de lo que un paciente debería hacer, sino desde el propio cuerpo como diferencia que soporta un no saber, permite la emergencia de una medida inédita, inmanente, móvil, en ese encuentro. Cada vez es posible interrogar sobre las ganas y el gusto. Dos cuestiones que se habilitan a partir de barrer y borrar las pretensiones de ciertas metas impuestas por la productividad imperante y las demandas de curación.

“El campo político, así constituido por la unión de las potencias y de los derechos, no está inmune a los conflictos propios de la afirmación del derecho natural sino que los incorpora a la vida civil. Spinoza se mantiene equidistante de los utopismos moralizantes que imaginan una política para seres que no existen en ninguna parte (hombres que habrían abjurado sus pasiones en favor de la virtud) y de los realismos que despotencian el campo político, para defender a los hombres de sí mismos mediante mecanismos de expropiación de los derechos y de control por el miedo de aquellos restos que no puedan ser completamente extirpados”⁹.

El desafío entonces es proponer un lazo donde las diferencias no estén reguladas desde un afuera trascendental que implique el control moral sino en la inmanencia misma del lazo y sus límites. Ahí es donde el cuerpo y el territorio funcionan como regulación “Lo que Lacan toma de Spinoza es que la alegría es un acuerdo del sujeto con su deseo y esta tristeza, es un rechazo. Cuando el sujeto asiente a su deseo va por el lado de la alegría, cuando rechaza su deseo va por el lado de la tristeza, al punto de que considera a la psicosis misma como un rechazo absoluto del deseo”¹⁰ dice Germán García.

Para terminar, tomando la última cita de Germán García, podemos situar la importancia del registro de los afectos en el dispositivo de Acompañamiento Terapéutico. Es fundamental que el at no soporte o silencie el malestar que la locura en tanto capricho impone. Las posiciones asistenciales en los dispositivos de salud mental esconden las ideas religiosas de sacrificio y cuidado, obstaculizando la posibilidad del encuentro con el deseo. Es reintroduciendo el afecto en la escena desde donde es posible transformar las relaciones de poder que atrapan a los participantes en una lógica sintomática.

* * *

9. Tatián, D. *La cautela del salvaje. Pasiones y política en Spinoza*, Óp. Cit. Pág. 139

10. García, G. *El curso de las pasiones*, Óp. Cit.

Acompañamiento Terapéutico: una apuesta subjetiva en la discapacidad

Carlos Bove

María Noelia Gómez González

Introducción

En el ámbito de la salud mental es frecuente encontrar abordajes de la discapacidad sostenidos en el modelo médico, entendido éste como aquel que apunta a la rehabilitación de funciones y la normativización de conductas. Dicho orden médico responde al discurso de la ciencia, el cual, según Lacan a la altura del Seminario XVII, se desprende del discurso universitario. Este último se caracteriza por la primacía del saber disciplinar y supone una orientación que empuja a “seguir sabiendo”. Se trata –según la expresión lacaniana– de un “todo saber” que se dirige al objeto, forcluyendo al sujeto, el cual resiste y reaparece en su división, efecto de producción de dicho discurso. Operatoria que anula la singularidad, sometiéndola a lo que dicho saber dicta respecto a un “para todos los sujetos con discapacidad”, arrasando así con las diferencias que son las que hacen verdaderamente especiales a estos, y en definitiva, a todos los sujetos. A ese objeto en que deviene el sujeto que padece una discapacidad, se le asigna un determinado lugar y una serie de actividades que podrá realizar, y otras tantas que no. Si pensamos que los abordajes de la discapacidad están regidos por la lógica de un discurso universitario, esto da lugar a que los profesionales intervengan desde una modalidad que fácilmente desliza a la del discurso del amo. Desde una posición de autoridad, desde el lugar del agente, se le dice al otro qué es lo que tiene que hacer por su propio bien, se le dan directivas, indicaciones, amparado en un saber científico acerca de eso que le pasa. Esto obtura cualquier pregunta, cualquier emergencia de la subjetividad, y por el contrario, promueve su aplastamiento.

Este es el marco que encontramos como trasfondo en el momento en que se solicita Acompañamiento Terapéutico para Romeo, sobre el que versará el presente trabajo. Y es aquí entonces donde se articula la pregunta por la pertinencia y la especificidad del dispositivo de Acompañamiento Terapéutico en casos de personas con alguna discapacidad

física y/o sensorial. El caso de Romeo nos condujo a éste interrogante dado que se destaca allí desde un primer momento el hecho de que la solicitud del Acompañamiento Terapéutico quedara tomada enteramente por la cuestión de la discapacidad del paciente. Sin embargo, pensamos que la implementación e intervención del dispositivo no puede reducirse a la asistencia de aquella, a la demanda por ocuparnos de la discapacidad, sino que allí desde la posición que se asume se propone un más allá de la discapacidad. La propuesta, la apuesta en realidad, es hacer con eso y más allá de eso.

El caso

Romeo es un joven de treinta y ocho años de edad con un diagnóstico de encefalopatía crónica no evolutiva. La misma se manifiesta en un desorden del movimiento, la postura y el tono muscular, con una consecuente alteración del equilibrio, por lo que no puede mantenerse de pie por sí mismo ni caminar sin un soporte o apoyo. Sumado a esto, están afectadas la visión, la audición, el habla y la sensibilidad.

En el ámbito del Acompañamiento Terapéutico los pedidos de implementación del dispositivo son de lo más variados, pueden ser realizados por diversos agentes y responder a numerosos motivos. Es por esto que en los inicios de un Acompañamiento Terapéutico surge con frecuencia la pregunta por ¿qué lugar que se nos otorga? Esta pregunta implica un primer momento de encuentro con el paciente, con su entorno y con la dinámica familiar o institucional en la que se encuentra inserto. Podríamos situar este momento como un instante para considerar tanto la situación a la que se nos convoca como el lugar que allí se nos ofrece.

En el caso de Romeo, el pedido de Acompañamiento Terapéutico fue realizado por la institución a la que concurre (Centro Educativo Terapéutico) ya que el paciente quedaba relegado de las actividades grupales por necesitar un apoyo más personalizado. La familia solicita que los acompañantes asistan a Romeo durante el momento de la cena y el baño. Para dichas tareas nos son dadas una serie de indicaciones: ¿cómo asistir la marcha de Romeo en sus traslados dentro y fuera de la casa?, es decir, ¿cómo “llevarlo”?, ¿cómo asistirlo para que pueda llevarse la comida a la boca?, ¿cómo higienizarlo (afeitarlo, lavarle los dientes, peinarlo)?; ¿cómo ingresar con él a su casa? (pidiendo expresamente al

acompañante que no deje que Romeo haga esto por sus propios medios – buscar la llave, abrir las puertas, entrar al ascensor), y algunas otras más. Incluso se nos convoca a oficiar de intérpretes o traductores en la comunicación del paciente con otros interlocutores. Asimismo se nos solicita intervenir frente a las llamadas “crisis” que suele tener con cierta periodicidad y las cuales no parecen tener motivos aparentes. Sobre este punto volveremos más adelante.

Volviendo a la cuestión del pedido de Acompañamiento Terapéutico, por un lado, una primera lectura es que en él se convoca al acompañante a compensar aquello que no anda: andamiar la cotidianeidad de Romeo en términos de cierta adaptación a espacios y tiempos comunes.

Por otro lado, y frente a esta situación, surge inevitablemente una nueva pregunta: ¿Qué lugar para Romeo? ¿Qué lugar se propone para él en un dispositivo que se inserta en su cotidianeidad, incluso en las situaciones más personales e íntimas? ¿Qué lugar le queda en un pedido que lo nombra como un cuerpo a ser asistido? Surge en éste punto la pregunta por el tipo de lazo social que se pretende establecer con él desde el dispositivo de Acompañamiento Terapéutico.

Finalmente, y retomando lo planteado acerca de los discursos, podemos pensar que el pedido de Acompañamiento Terapéutico queda captado en su totalidad por la lógica del discurso universitario: se nos pide asistir la discapacidad ya sea desde el saber que se nos supone como agentes de salud mental o desde el saber que nos aportarían otros respecto de Romeo. En otras palabras, el pedido de Acompañamiento es realizado suponiendo un saber-hacer con la discapacidad, frente a lo cual el lugar que queda para Romeo es el de objeto respecto de ese saber.

El cuerpo-el saber

Como lo venimos desarrollando, en el Acompañamiento de Romeo el encuentro con la discapacidad física es ineludible. No sólo porque estamos convocados a hacer algo con eso –después veremos qué es lo que hacemos– sino porque efectivamente el necesita de cierta asistencia.

Este pedido de asistencia –como ya anticipamos– no tiene en consideración al paciente más que como un objeto a ser higienizado, alimentado, medicado, comprendido, etc. Al mismo tiempo, tampoco se consideraba necesario preguntarle qué prefería hacer o qué le pasaba puesto

que siempre había allí algún otro que respondía por él. Esta necesidad de asistencia deja a Romeo en un lugar de objeto sobre el que se focaliza una falla: la discapacidad. Se plantea una escena donde la falla queda evidenciada en alguien, respecto del cual aparece un Otro completo. A propósito, resuenan las palabras de Zelis y Salinas: "... el sujeto afectado de discapacidad soporta por parte del discurso familiar y social (y muchas veces institucional) la focalización de una falla sobre su persona, que no es más que la de ese mismo grupo, –no es más que la de todos los grupos–. A esta falla (la universal, la de ser sexuados y mortales) que queda corporeizada y suturada en la falla de la discapacidad, le sigue un segundo movimiento de ocultamiento o aislamiento por ese mismo discurso [...] este movimiento le sirve a ese "otro" que se sitúa como "normal" para velar o reprimir lo "universal de nuestra especie, la falta estructural al sujeto hablante".

Ahora bien, los acompañantes no son ajenos a ésta lógica que aboga por velar dicha falta estructural. El encuentro con el cuerpo afectado por la discapacidad física es un (des)encuentro permanente e inevitable con lo que de ilusorio tiene la unidad yoica, en tanto vela la fragmentación que nos habita como seres "sexuados y mortales". Sin duda no se trata de cualquier cuerpo, sino de aquel que hace evidente aquello que no lo es en otros cuerpos, esto es, la castración. Sabemos que frente a la castración se suscita la angustia, y que en el encuentro con ésta existen múltiples y variadas respuestas: las que taponan, las que racionalizan, las evitativas, las huidizas, etc. Sin embargo, es notorio para quien escucha éste trabajo o para quien ejerce ésta práctica, que aquí no hablamos de la angustia del paciente, sino la de los acompañantes. Este es un aspecto central en la clínica del Acompañamiento Terapéutico tal como la concebimos. Es a partir de la reflexión sobre nuestro posicionamiento que se orienta el Acompañamiento con un paciente.

En este punto, presentaremos una pequeña viñeta para intentar dar cuenta de lo dicho hasta ahora:

En primer lugar, una de las situaciones características en donde acompañamos a Romeo es en el sencillo acto de ingresar a su domicilio. Sus movimientos son lentos, por lo que toma su tiempo para cada acción (buscar sus llaves, abrir las puertas, marcar el ascensor). ¿Por qué este ingreso a su casa es una situación que amerita ser recortada? ¿Cuál sería el obstáculo que allí se presenta? El obstáculo se paten-

tiza en la impaciencia e incomodidad frente a la escena de parte de la familia y los vecinos e incluso la angustia de parte de los acompañantes. Entonces, ¿de qué lado queda la discapacidad? ¿Quién es el que no puede llevar adelante ese acto de ingresar a la casa?

Aquello que hace obstáculo en esta escena responde a la consideración de que hay un único modo de hacer, un único modo de ingresar al edificio, que implica un tiempo “normal”. Cualquier situación que implique un tiempo que no sea ese, es una situación a ser corregida o en su defecto –en una versión más políticamente correcta– andamiada. Vemos entonces cómo queda planteada la escena en la que Romeo queda en un lugar de objeto a ser normativizado, en tanto se supone un saber incuestionable respecto del modo en que se debería ingresar al edificio.

En segundo lugar, quisiéramos retomar algo que ya habíamos anticipado. Se trata de las “crisis” –nombradas como tales por el entorno familiar y profesional– que suele padecer el paciente. Hacemos una descripción sucinta de ellas: consisten en momentos de frustración y enojo de Romeo que se caracterizan por insultos y golpes a sí mismo. Las mismas eran interpretadas como fenómenos inmotivados a las que se les daba respuesta ya sea vía contención física o farmacológica. Nos encontramos allí con un Otro completo, que sabe de esas crisis y que sabe cómo actuar frente a las mismas.

En las reuniones de equipo se decide poner en reserva el saber respecto de éstas escenas interviniendo en varias direcciones. En primer lugar, se las deja de nombrar como tales, generando un vacío para que Romeo pueda ponerles un nombre propio (cuestión que permanece pendiente). En segundo lugar –y en línea con lo anterior– se le empieza a preguntar a Romeo por estos episodios con la finalidad de que pueda tramitar algo de los mismos. Asimismo, se le ofrecen significantes para que pueda decir algo al respecto. Se nombra lo que describe que le pasa. El corolario de éste posicionamiento por parte del dispositivo de Acompañamiento Terapéutico es la pregunta que Romeo nos dirige explícitamente: “¿cómo se habla?”. Pregunta cuya respuesta se suspende, relanzando la apuesta por su saber respecto de esos episodios, en cuya repetición no observamos más que la resistencia del sujeto a ese Otro completo que se presenta sin agujeros en relación al saber respecto de la discapacidad.

Según entendemos entonces, no se trata de eliminar eso que aparece como lo más subjetivo en el paciente –ya sea con contención física o

farmacológica o incluso aplastándolo con un nombre que provenga del Otro— sino de hacer lugar para que pueda tramitarse vía la palabra, que es en definitiva, la apuesta que se propone a partir del sostenimiento del discurso del analista. Al respecto citamos a Pablo Peusner, quién afirma:

“cuando recibimos la consulta por un... joven con algún tipo de trastorno, siempre nos encontramos con la dimensión de que más allá de aquello que hace síntoma, a ese chico le pasa algo y no se sabe qué. Es muy importante que esté presente esto... es decir que supongan que hay en algún lugar una cadena significativa que explicaría de qué se trata el asunto que manifiesta de manera sintomática... y esa suposición abre la posibilidad de que eso ocurre por algún motivo. Y esa suposición abre la posibilidad de que en algún lugar, inaccesible por el momento, haya un saber... que lo explique”¹¹.

Subraya de este modo que en el encuentro siempre hay una dimensión de algo que no se ve, pero que afecta al sujeto y puede ser sujeto de lectura clínica.

Retomando lo planteado respecto de los discursos, desde la lógica del discurso universitario, sostenido en el discurso de la ciencia, se sostiene un saber hacer igual para todos, del mismo modo y en los mismos tiempos, incluso en un acto tan sencillo como el del ingreso a un edificio.

En contraposición, desde la lógica del discurso analítico, el equipo propone una respuesta distinta, una respuesta que admita modos diversos de hacer, que apunte a la emergencia del sujeto. El acompañante pone en reserva su saber —hacer en esa escena. Soporta la angustia y se constituye en soporte de la angustia del Otro social. Surgen allí entonces— entre el paciente y el acompañante —el juego, el chiste y el humor como emergentes subjetivos frente a esa escena que resultara angustiosa. Esto propone un tipo de lazo social distinto al del sujeto—objeto del discurso de la ciencia.

11. Peusner P. *Reinventar la debilidad mental*, Ed. Letra Viva (2010), pág. 36.

Conclusiones

A lo largo del trabajo intentamos dar cuenta del movimiento realizado por el equipo de acompañantes en el tratamiento de Romeo. Un movimiento que fue, desde un primer momento, donde nos encontramos con un pedido de asistencia, en el que desde la lógica del discurso universitario, arrasaba cualquier emergencia de la subjetividad; virando hacia un segundo momento, que podríamos pensar desde el discurso del analista, donde el equipo de acompañantes interviene apostando a un saber del lado de Romeo, en definitiva, apostando a un sujeto.

En otras palabras, la propuesta de trabajo que el equipo realizó tiene que ver con el establecimiento de un tipo de lazo social entre acompañantes y paciente que ubica al saber en un lugar distinto al comentado en relación al discurso universitario. Dicho lazo social no es ni más ni menos que el que propone el discurso analítico, al menos en cuanto a uno de sus términos –el saber– en relación al cual el equipo de acompañantes se sitúa en una posición que es de reserva respecto de lo que se le supone que sabe sobre la discapacidad. Creemos que este posicionamiento difiere radicalmente del que pueden tener otras prácticas intervinientes, así como también lo hace de las expectativas respecto al dispositivo con las que en numerosas ocasiones se acercan las familias y las instituciones que lo demandan.

El aporte específico del dispositivo de Acompañamiento Terapéutico en la clínica de la discapacidad se cristaliza en la construcción de una única indicación para acompañar a Romeo: dejarse guiar por él. Esto supone que hay algo allí que no es transmisible dado que ese saber se pone en acto cada vez “entre” acompañante y paciente y resiste a ser patrimonio de uno solo, lo cual se evidencia en el relato de los acompañantes que forman parte del equipo. “Romeo te va a guiar” es el resultado de una construcción del equipo y la única indicación que se transmite a los nuevos acompañantes.

Para finalizar, y retomando el título del presente trabajo, lo planteado hasta aquí en relación al Acompañamiento Terapéutico de Romeo, nos lleva a pensar en dos apuestas subjetivas: por un lado, un saber-hacer respecto del propio cuerpo y por otro, una subjetividad que no se circunscribe a la discapacidad.

MÓDULO 3 - El caso como posibilidad de transmisión clínica

En los apartados anteriores nos fuimos adentrando en las escenas del Acompañamiento, no para fijarlas ni codificarlas, sino para dejarnos enseñar por ellas. Nos detuvimos en la presencia del acompañante en el terreno, en el modo en que su cuerpo entra en juego, en lo que le pasa cuando se encuentra con un otro que lo descoloca, lo conmueve, lo excede. Allí donde lo clínico no se define por un saber previo, sino por la posibilidad de dejarse afectar sin quedar capturado.

Esa afectación, dijimos, no es un accidente ni un residuo: es parte constitutiva de la práctica. Lejos de entenderla como un desborde a evitar, propusimos pensarla como brújula, como señal ética. Hicimos foco en cómo esa resonancia puede transformarse en recurso, en herramienta para alojar la diferencia sin devorarla. En particular, a partir de un caso clínico vinculado a la discapacidad, trabajamos cómo lo que le pasa al acompañante puede volverse parte del dispositivo, no como confesión íntima, sino como acto clínico compartido.

En este nuevo módulo, los invitamos a dar un paso más. A interrogar qué hacemos colectivamente con esa afectación, cómo se construye un saber que no borre lo singular, pero tampoco lo aisle. ¿Cómo poner en palabras la experiencia para que circule, se despliegue, se revise? ¿Cómo evitar que el Acompañamiento quede atrapado en la inmediatez de lo cotidiano o en la ilusión de que basta con estar?

La propuesta que aquí se despliega parte de una apuesta decidida: construir casos no sólo como modo de ordenar la práctica, sino como posibilidad de transmisión, como acto que transforma una escena vivida en una coordenada clínica que pueda ser pensada entre varios. El Acompañamiento, cuando se hace en equipo, no es la suma de presencias aisladas, es una trama que se sostiene en la palabra, en el análisis compartido, en la elaboración colectiva del lazo.

El texto que sigue nace del recorrido del Equipo Ágora y recupera años de experiencia en la formación de acompañantes, en la construcción de dispositivos éticos y clínicos para habitar lo complejo. Con sensibilidad y precisión, Nicolas Isla logra poner en palabras una forma de trabajo que dignifica al acompañante, inscribiéndolo como parte activa de un tratamiento que se piensa y se construye en común.

La función del caso en el equipo de acompañantes

Nicolás Isla

Introducción

Hace unos diez años en el Equipo Ágora, equipo de Acompañamiento Terapéutico del que formo parte, propusimos un espacio de formación para los acompañantes con quienes trabajamos. Nuestro enfoque estuvo movilizado por el deseo de ofrecer una articulación entre la práctica del acompañamiento, la formalización de su clínica y la posibilidad de transmitir una clínica de trabajo entre varios. Nos interesaba generar un espacio de formación que fuese consonante con nuestro modo de acompañar.

Para aclarar los términos desde un principio, en Ágora elegimos un modo de Acompañamiento Terapéutico que funciona ofreciendo una red social estratégica para intervenir en el padecimiento, constituyendo un equipo de trabajo que tiene a varios acompañantes operando en un mismo caso, y donde se distingue la figura de un coordinador que resguarda el trabajo del equipo y abre la reflexión sobre la función de sus miembros.

Nuestro desafío respecto a la formación y la reflexión clínica fue ¿qué tipo de transmisión se puede proponer bajo los mismos principios rectores de nuestro equipo?

La formación en el Equipo Ágora

La instalación y el desarrollo de los espacios de formación tiene una historia detallada en el trabajo presentado en el Congreso Internacional de Acompañamiento Terapéutico de 2015, expuesto por Maximiliano Peverelli, Lucas Minervino y Diego Safa. Ese trabajo se tituló “Propuestas para un modelo educativo en acompañamiento terapéutico: de la experiencia al concepto”.

En dicha presentación se detalla la transformación del equipo, partiendo desde un espacio de formación colectivo, informal y entre pares; hasta alcanzar un punto de expansión que nos llevó a la nece-

sidad de planificar y poner en marcha un dispositivo de formación para quienes se sumaban desde distintos campos, experticias e incluso geografías.

Cito el trabajo presentado:

“Nos pareció coherente retomar el modo en que el Equipo Ágora había llegado a construir sus pilares. Se recuperaron temas ya discutidos que pensamos como fundamentales y que son transversales a los acompañamientos. Los ordenamos y los separamos para organizar cuatro módulos de formación. Cada módulo replicará las discusiones sostenidas años anteriores, pero a la luz de los acontecimientos y las experiencias de los casos actuales. En tal sentido, creemos más relevante el proceso de reflexión, por sobre el contenido que pudo haber sido transmitido. Es en el diálogo con otros, es en la implicación, en la reflexión permanente de la práctica, que desarrollamos una posición clínica, lo que en definitiva (para nosotros) no es más ni menos que una posición ética”¹².

Tomaré el guante de esta propuesta ética para desarrollar por qué, dentro de esos módulos de formación, propuse incluir un taller de construcción de caso de Acompañamiento Terapéutico y cuál es su función para un equipo.

Antes que eso, explico brevemente la formación.

Bajo la forma de grupos de discusión propusimos cuatro módulos que se distinguen por el tema que se proponen para el diálogo grupal y la apertura a su polifonía. La forma de grupo de discusión permite que las dificultades de la práctica del Acompañamiento se abran entre varias personas, unidas entre sí por su orientación hacia la tarea y los afectos que van surgiendo en el proceso. A veces bajo la forma del compañerismo, otras veces de amigos a la distancia nietzscheana, o ya sea como férreos opositores, siempre se respeta un marco para que la discusión esté contenida bajo el grupo de trabajo. Por ello, en cada módulo opera la figura de un coordinador de grupo, que va modulando la discusión

12. Peverelli, M. Minervino, L. Safa, D. “Propuestas para un modelo educativo en acompañamiento terapéutico: de la experiencia al concepto”. Presentación en el Congreso Internacional de Acompañamiento Terapéutico: *Clínica de las fronteras, caminos del AT en lo cotidiano*. Córdoba, Argentina, 2015. El paréntesis es mío.

y la enmarca dentro del tema de interés transversal y en la discusión particular del caso que el grupo propone.

Cada uno de los módulos dura un cuatrimestre, producen un trabajo y culmina con un ciclo de presentaciones en reuniones generales abiertas a todo el equipo.

El primer módulo, promueve la discusión acerca de escenas concretas y recortadas donde se inserta el acompañante, para así pensar su función en ellas. El segundo módulo, trata de la implicación personal del acompañante y trabaja la localización del lazo transferencial del caso al que asiste. El tercer módulo, invita a participar de un taller de construcción de caso de Acompañamiento y ubica las coordenadas de intervención que se deducen de él. Y finalmente, el cuarto módulo, conversa sobre el Acompañamiento Terapéutico y su articulación con otros discursos afines.

Coordenadas de la construcción de un caso en equipo

Voy a ahondar en el módulo tres, espacio que coordino desde sus inicios. Uno de los desafíos que surgieron a la hora de transmitir nuestra práctica a los nuevos acompañantes, fue ubicar el sentido de acompañar a alguien. ¿Por qué es preferible indicar un dispositivo de adAcompañamiento y cómo orientarse al acompañar? Hacer esta pregunta ya es a distinguir el “acompañar” como una acción que puede variar y se puede orientar según algunos parámetros, y en ese sentido, es distinto que hacerlo intuitivamente.

Si bien actualmente el Acompañamiento Terapéutico es una práctica que se abre paso a través de políticas más inclusivas que atraviesan los muros institucionales y forma parte de programas ya institucionalizados de intervención en terreno, emergió de forma bastante artesanal en una época donde se interrogaron fuertemente cuáles eran los dispositivos más adecuados para el trabajo del lazo social en personas marginadas de la circulación social y de los mismos dispositivos terapéuticos existentes en aquella época. Personas en un lugar de resto. El foco en ese entonces fueron las locuras, poniendo en cuestión los modelos de segregación y los manicomios, aunque podría ser cualquier padecimiento humano que sea lo suficientemente difícil de digerir para la vida en común.

La incorporación de los modelos de redes de atención con énfasis comunitario, los desarrollos del psicoanálisis y la salida de los profesionales de los muros hospitalarios hacia el contexto de estos pacientes, pavimentaron el camino para el surgimiento de dispositivos abiertos y en extensión al otro social. Hospital de día, comunidades terapéuticas, casas de medio camino, entre otros, dan el contexto para el surgimiento del trabajo del Acompañamiento Terapéutico.

Decir esto es bastante, pero no satura el tema. Ya en los setentas, sobre todo por tierras inglesas, se propuso que sólo el hecho de otorgar libertad en una esfera social abierta y cuidada, daría resultados beneficiosos para el tratamiento de las locuras. Lamentablemente hoy sabemos que, por mucho esfuerzo que hagamos como sociedad en aceptar las particularidades del ser, cualquiera sea éste, los padecimientos seguirán insistiendo. Es que si bien muchos sufrimientos son marginados por la sociedad, también son procesos de aislamiento, recortes, y excesos propios del desarrollo intrínseco de esos mismos padecimientos.¹³

Ahora bien, la novedad de los dispositivos que trabajan con el lazo social no sólo es cuestión de técnica, sino de una posición sobre la raíz social del padecimiento. En el ejemplo de las psicosis, una de las formas más típicas de padecimiento de las que nos ocupamos en el Acompañamiento Terapéutico, se presentan retrotrayéndose bajo perplejidades, mutismos, cuerpos fragmentados y rígidos; o bien, ensimismados en delirios o nostalgias del pasado; o al otro extremo, mostrando su cara más extravagante, ilimitada, actuadora y explosiva.

Esto es fundamental, porque localiza que el retiro del campo social no sólo se explica por discriminaciones sociales. La salida del asilo y la inclusión, como dice Antonio Quinet en su libro sobre psicosis y lazo social, es algo que no es simple ni para los otros ni para el mismo padeciente.

“La salida del asilo y la inclusión del sujeto de la psicosis en la sociedad no son simples —ni para los otros, ni para él. Por un lado, hay que respetar la singularidad especial de estos sujetos, que en ocasiones inventan síntomas muy extraordinarios para lidiar con eso de afuera.

13. Sobre este tema, hay una discusión muy interesante en el coloquio sobre “Infancia alienada” que organizara Maud Mannoni en 1967 publicado en español con el título *Psicosis Infantil*, por Editorial Nueva Visión, Buenos Aires, 1980. Allí presentan sus trabajos actores relevantes en la apertura de los dispositivos a encuadres más audaces: la misma Mannoni, Oury, Laing, Cooper, Lacan, entre otros. La discusión la enciende Lacan al comentar los trabajos sobre la libertad de la antipsiquiatría inglesa.

Por otro lado, se les pide tanto que salgan de un lugar que los mantiene al abrigo de las amarguras del mundo, como que convivan con ese Otro social muchas veces hostil y amenazador. ¿Cómo respetar la singularidad del sujeto y, al mismo tiempo, responsabilizarlo y hacerlo incluirse en la sociedad?”¹⁴

Con ese espíritu, el empuje del Acompañamiento no se podría diluir en un quehacer que sólo acompaña un tratamiento sin pronunciarse sobre su propia influencia en el área que es de su incumbencia y ante la que se implica íntimamente: el espacio cotidiano del lazo social.

¿Qué tiene para decir el Acompañamiento Terapéutico de eso? En el lazo, allí donde los acompañantes espontáneos no responden y dónde el padecimiento se aísla masificándose, es posible introducir la estrategia de un artificio en red. Este es el campo clínico del Acompañamiento. Es su oferta, su analizador, donde se ponen en juego sus obstáculos y desde dónde se miden los efectos del acompañar.

Un caso, para nosotros, debe considerar este marco conceptual y su construcción es un deber para desechar la idea de acompañar intuitivamente, sin reflexión. Es terapéutico estar acompañado por otros, pero no basta para pensar el tratamiento que puede ofrecer un dispositivo de Acompañamiento. La clínica se distingue de una terapéutica porque razona sus actos y sus efectos.

¿Por qué construir un caso de Acompañamiento Terapéutico?

Por el encuadre típico en la práctica del Acompañamiento, es decir, sosteniendo el cuerpo muchas horas en la cotidianidad, se plantea una dificultad mayor para relacionarse con los modos de vida que suele conllevar la locura, de la que podrían tener otros dispositivos más acotados. Los acompañantes entran en los tratamientos y los abandonan rápidamente aludiendo razones personales; o, al contrario, se sienten tan cómodos que son parte del mismo escenario que habitan los pacientes y terminan siendo sus amigos, al estilo del doble en el espejo. “Me pareció raro que estaba como en su casa” me dijo alguna vez un tratante sobre un acompañante con el que trabajé.

14. Quinet, A. *Psicosis y lazo social*. Editorial Letra Viva. Buenos Aires, 2016, pág. 58.

Defensas, efectos de masa y segregación

El fenómeno puede traslucir la misma estructura de segregación de los campos sociales más amplios, pero esta vez al interior del mismo dispositivo, en una microfísica, entre acompañante y acompañado. Evidentemente, es más fácil denunciar estas prácticas cuando son de otros, que animarse a elaborar hasta dónde uno mismo puede no querer saber y rechaza involucrarse en el tratamiento de un padecimiento tan extraño que llega a tocar fibras íntimas.

Hay un ejemplo muy difundido en nuestro equipo que gráfica esos modos de vida, sobre un paciente que imponía condiciones enormemente rígidas para entrar a su pequeño monoambiente: estar completamente a oscuras, no poder cruzarse de piernas, acostarse en el piso y mantenerse a una distancia equidistante de las llaves de luz de la casa. Las reglas eran impuestas para él mismo y para los otros que ingresaban a su morada, los acompañantes. Pero hay muchos otros casos: personas hundidas en la cama de la melancolía en completo silencio día y noche, con excepción de una pequeña radio a pilas que los une por un hilito a los otros, con el acompañante sentado al lado mirando una pared; o esos pacientes que ordenan sus casas y a ellos mismos de formas parecidas a un cuadro goyesco y te invitan con una sonrisa a sentarte en el sillón entre los horrores y sus obscenidades; en fin.

¿Quién quiere someterse a ello, si es que resulta pertinente hacerlo, y menos sin saber bien para qué?

Hace algunos años pensé esta cuestión en términos del psicoanálisis, guiado en parte por algunas de las discusiones que dimos en *Ágora* cuando nos enfrentábamos al problema, y en otra, por mi propio análisis.

Lacan, en una conferencia llamada “Breve discurso a los psiquiatras” de 1967, habla acerca de los mecanismos defensivos que utilizan los psiquiatras en los hospitales, incluso aquellos que están formándose como psicoanalistas, para poner distancia al padecimiento. Las denominó las “barreras protectoras” frente a la angustia que despierta dejarse concernir por el síntoma.

“Pero, en fin, al dejar de lado lo que la angustia tiene de angustiante, diría, a pesar de todo es completamente decisivo que para concebir solamente lo que es, lo que es del loco, por tener en cuenta esto, es que aquél que se postula en su presencia en esa posición que es la del

psiquiatra, está, lo quiera o no, concernido. ¡Está irreductiblemente concernido! Si no se siente concernido, eso es —eso es algo completamente demostrable, tangible, sin que se tenga necesidad por eso de hacer intervenir la experiencia psicoanalítica— si no está concernido, es por algunos procedimientos que se manifiestan cuando se mira allí de cerca, de manera no refutable, sea uno psicoanalista o no, por el hecho de que él se protege de este concernimiento, si ustedes me lo permiten. Es decir, que él interpone, entre él y el loco, un cierto número de barreras protectoras, que están al alcance de los grandes jefes, él pone, por ejemplo, a otras personas que él mismo, ¿no?, que le suministran informes... Y luego, para aquellos que no son grandes jefes, basta tener una pequeña idea, un órgano-dinamismo, por ejemplo, o cualquier otra, una idea que los separe de este... de esta especie de ser que está enfrente de ustedes, que es el loco, que los separe a ustedes de él destacándolo ¿no es cierto?, como una especie, entre otras, de extraño coleóptero, del que se trata de dar cuenta, así, en su dato natural”¹⁵.

Pues bien, con recursos distintos a los que podrían tener esos grandes jefes que refiere Lacan, los acompañantes terapéuticos también se defienden del encuentro angustiante con el padecimiento de los otros.

Una de las formas más difíciles para trabajar, en mi opinión, es la que voy a nombrar como la posición del buen samaritano, aquel que actúa por misericordia y con una empatía exagerada en términos del supuesto bien común. Esta figura, si bien es tentadora porque muestra alguien que se moviliza frente al sufrimiento del otro, es una posición que empatiza en demasía con los pacientes hasta identificarse con ellos y sus causas, borrando lo que resulta perturbador del padecimiento y actuado bajo el poder pastoral. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice la religión, porque el que está al frente es igual a ti, sufre cómo tú. Nada es distinto, nada raro, solo una masa uniforme y semejante entre dos.

¿Qué lazo se puede ofertar desde este lugar que no sea narcisista y profundamente ciego a la hora de intervenir?

Hay una defensa similar en sus efectos que se pone en juego cuando el Acompañamiento es practicado en equipo y que culmina con una forma aún más sofisticada de segregación. Son esos equipos de acompañantes que se agrupan de tal manera que lo que dicen sobre el paciente está completamente cerrado a escuchar las formas de insistencia que traen

15. Lacan, J. “Breve discurso a los psiquiatras”, 1967 (Inédito).

los síntomas: sus objeciones, las resistencias, sus modificaciones y las invenciones que pueden llegar a producir. Cuando esto pasa, se organizan reuniones, se habla de lo insoportable de tal o cual cosa, las pocas capacidades de esa persona, la burocracia de los trámites, etcétera; y no pasa nada nuevo nunca. Es que se habla de todo, menos del modo singular de hacer con el padecimiento que produce ese sujeto en particular, su estilo. Que seamos varios no garantiza que no haya efectos de masa que uniformen y promuevan la separación entre nosotros y ellos. Podemos estar todos juntos, incluso compartir espacios sin ningún tipo de muro concreto, y seguir segregando.¹⁶

Así, estas modalidades del lazo, que la mayoría de las veces operan por efecto del mismo encuadre del Acompañamiento Terapéutico, son las que la interrogación clínica con su construcción de caso viene a cuestionar.

Construir un caso es entonces una herramienta útil para que el lazo ofertado por el Acompañamiento sea puesto a trabajar bajo la forma de un dispositivo estratégico en el lugar donde habita y se aísla el padecimiento.

Por ejemplo, y pongo este ejemplo porque es ejemplar de muchas situaciones insoportables para un acompañante, permite pensar que soportar algunas formas rígidas y pesadas es una maniobra inicial para poder entrar a la fortaleza de nuestros pacientes.

“El neurótico admite bien el hecho de que cuando la verdad se hace oír, todo se sustrae y se abre el desierto. El psicótico, poco afecto a ese turismo, exige en cambio la más estricta sumisión a sus posiciones propiamente subjetivas como precio para dejar al analista ingresar en su fortaleza: entonces tal vez quiera desplegar la textura de su síntoma en el decir, abrir algunas de sus puertas, y eventualmente volver a la pólis –a trabajar, por ejemplo–. Pero, en cualquier caso, responsablemente, el psicótico exigirá que se comience por respetar las pautas del sitio en el que ha puesto a resguardo su ser, que no se entre allí por la ventana, ni por una puerta clausurada”¹⁷.

16. Freud y Lacan han desarrollado el tema a propósito de la psicología de las masas y la lógica de las fraternidades, ambas configuraciones que se agrupan dejando fuera lo que es distinto. “Sólo conozco un origen de la fraternidad –quiero decir humana, de nuevo el humus–, es la segregación”. Lacan, J. *El Seminario, Libro XVII: El reverso del psicoanálisis*. Editorial Paidós, 1992. Página 121.

17. Lombardi, G. “Delirio y lazo social. La mediación de lo imposible”, en Revista

No es lo mismo estar aguantando sentado que las horas pasen, a suponer la oferta de un lugar donde el padecimiento se pueda desplegar, con dificultad y si tenemos un poco de suerte, como primer paso a un tratamiento.

Masividad de la transferencia

Ahora bien, quisiera ahondar en otras de las dificultades comunes al Acompañamiento Terapéutico y que pone en juego la utilidad de la construcción de caso. Se trata de la masividad de la transferencia, entendiendo por ésta dos cosas. Por un lado, de forma descriptiva, me refiero a la intensidad del vínculo de que se produce por estar varias horas al día compartiendo junto a alguien en lo cotidiano de un Acompañamiento. Por otro lado, de forma más clínica y válido para otros dispositivos, me refiero a la elaboración de una forma de la transferencia en la psicosis que han hecho varios autores (Bion, Winnicott, Mannoni, por citar algunos) y que refiere fundamentalmente a un vínculo “prematureo, precipitado y de una intensa dependencia” por efecto de las características propias del cuadro psicótico.

Hace un tiempo se presentó un caso en el módulo con una forma muy ejemplar. Se trataba de una paciente adulta con un diagnóstico de esquizofrenia paranoide que tendía a sentirse amenazada por los otros, y cada tanto, por sus acompañantes. En el tratamiento intervenía un equipo de varios acompañantes que ofrecía su red para ayudar a sostener el tratamiento farmacológico y cuidar cuestiones cotidianas de su vida, especialmente referidas a la relación con el exterior de su casa. Cuando algún acompañante intervenía más decididamente, a fin de querer moverla de posiciones defensivas que la tenían retrotraída, o de señalar muy cuidadosamente alguna idea fija que pudiese perjudicarla, la paciente lo tomaba como el ataque de un perseguidor más y lo expulsaba de su casa. Por suerte, esto recaía sobre un solo acompañante y no sobre los demás. El caso, por otra parte, contaba con la figura de un coordinador que se ocupaba de mediar en estas situaciones:

Universitaria de Psicoanálisis. Vol. I. Facultad de Psicología, UBA. Buenos Aires, pp-157-184. (La versión aquí citada está provista por el autor e indica la página 19).

Bion, W. “Diferenciación entre las personalidad psicóticas y no psicóticas”. En: *Volviendo a pensar*. Ediciones Horme, Buenos Aires, 1977, pág. 66.

la paciente lo llamaba por teléfono inmediatamente para hablar del ataque, las supuestas intenciones dañinas del acompañante, las otras veces que resultó sospechoso, y así, a pesar de su intensa soledad y a los gritos, solicitaba su expulsión del equipo. El coordinador se limitaba a escuchar atentamente, abierto al testimonio, sin querer defender a su compañero de trabajo. No había mucho más para hacer en ese momento. Con el pasar de la semana, la paciente volvía sobre el tema con los otros acompañantes, quienes iban de a poco tratando de relativizar el ataque. Para el próximo turno del acompañante-perseguidor, la paciente comunicaba al coordinador que haría el esfuerzo de recibirlo y hablar sobre lo sucedido, a ver si acaso algo se rectificaba.

Me pareció sorprendente la forma en que se trabajó este caso, poniendo en juego la distinción de funciones y lugares para el manejo de la transferencia en los momentos que se prendía su intensidad. El equipo estaba abierto a la posibilidad que alguien pudiese ser efectivamente expulsado, pero actuaban con calma cuando esto pasaba, apostando a que ofertar un circuito de trabajo sobre la amenaza haría que tal se diluyera. Había una construcción operando bajo esa estrategia de manejo del lazo y sus avances al posible quiebre que imponía la persecución.

El caso me sirve para situar otro elemento relevante. Si bien la masividad de la transferencia se hacía habitable ofreciendo un circuito de contención en equipo, una intensidad repartida entre varios; en ese mismo recorrido se hacía pasar la persecución por una red de lugares, funciones y palabras que hacen un tratamiento sobre la angustia y la soledad que se presentaba concomitante al perseguidor. No es sólo la idea que se soporta mejor entre muchos, sino el circuito discursivo que oferta una práctica entre varios y donde un paciente se puede alojar, al menos durante un momento suficiente para calmar las aguas.

Así, esos fenómenos que quedan por fuera del lazo social, fuera-de-discurso como dice Lacan, o que producen una transferencia masiva, o incluso una transferencia salvaje, se van elaborando y maniobrando entre los varios del dispositivo de Acompañamiento para hacer pasar el padecimiento por el circuito que éste ofrece.

Labor y trabajo en el Acompañamiento

Las consecuencias de no detenerse a pensar lo que está pasando son prácticas, pero también se manifiestan en acompañantes terapéuticos que se sienten desanimados, sobrepasados, que actúan muchas veces en soledad y con una visión precaria del trabajo.

Construir un caso tiene una relevancia muy concreta para el tratamiento que ofrece un dispositivo de Acompañamiento Terapéutico, y también produce efectos de sentido relevantes para el acompañante.

Principalmente porque construye un discurso que le es propio, donde puede ubicarse ante otros y vincularse con ellos. Es algo que lo implica en su quehacer, que abre interrogantes y que puede movilizar su entusiasmo para sostener los encuentros con el paciente y las reuniones con los miembros del equipo. En ese sentido, la construcción de caso puede transformar el quehacer cotidiano en un trabajo que puede medirse en sus efectos, que produce algo y que interviene efectivamente en un punto del padecimiento.

Se trata entonces de una invitación a construir una posición que dignifica la función del acompañante y lo hace parte de un tratamiento que lo involucra. Digo esto, para quienes quieren profundizarlo, sostenido en las reflexiones de Hanna Arendt acerca de la vida activa, el trabajo, y sus diferencias con la labor. Una labor, dice Arendt, es aquella tarea repetitiva que no deja ningún producto y se vuelve a hacer cada vez, mientras que el trabajo deja un producto, y la vida activa es la forma de actuar en sociedad con todo el riesgo y los efectos que ello implica.¹⁸

Finalmente, para nuestro equipo, la construcción de casos invita a los acompañantes a incluirse en un trabajo de otros y con otros. Ya sea iniciando un dispositivo o en tratamientos que empezaron antes de su inserción, la invitación es a tomar una posición ética y clínica.

La construcción funciona de forma dinámica y debe estar siempre abierta al saber que estará por venir: el ejercicio de apertura a la emergencia de una novedad es bienvenida en el Ágora, sea quien sea el que

18. El desarrollo de esta triada conceptual está detalla por Arendt en su libro *La condición humana*, por Editorial Paidós. Hay una revisión más breve en la conferencia “Labor, trabajo, acción” de 1957, incluida en el libro *De la historia a la acción*, también por Paidós.

Rubinstein, A. “La construcción de caso: psicoanálisis e investigación”. En: *La terapéutica: efectos y terminaciones*. Editorial JCE, Buenos Aires, 2012, pp. 35-52.

alce la voz, algún acompañante, el coordinador, o por supuesto, el padeciente. Una polifonía, entre varios y en equipo, para poder hacer con el padecimiento que se despliega en el lazo social y darle lugar.

En concreto ¿cómo se construye un caso de acompañamiento?

Nuestra propuesta de construcción de caso toma modelos ya definidos, y los transfiere a las particularidades de nuestra tarea. Es algo que encontrarán en muchos textos, siendo mi referencia para el módulo de construcción de caso un texto muy didáctico de Adriana Rubinstein . Lo transformo e incluyo lo que para nosotros envuelve una práctica en equipo en el Acompañamiento Terapéutico.

Paso a situarlo:

1. Ubicar el motivo de consulta y las coordenadas que llevan a solicitar un Acompañamiento Terapéutico. Esto implica asentar por qué se solicita el Acompañamiento en este momento particular, qué no venía funcionando, qué objetivos se buscan y cuál es el contexto donde se insertará el Acompañamiento. Es importante dialogar con el paciente, su familia y los tratantes. Es un momento propio de la instalación del Acompañamiento, que en nuestro equipo supone un trabajo con más presencia del coordinador para encuadrar el dispositivo.
2. Poner en marcha el Acompañamiento Terapéutico y mostrarse abierto a las propuestas e intentos de lazo que surjan a fin de entablar un vínculo mínimo. Es el momento donde el equipo asiste al domicilio a ofertar su red y va observando los modos de vida, la cotidianeidad, los tonos del vínculo y las respuestas a las primeras sugerencias. Es relevante compartir una descripción en detalle de estas cuestiones con los miembros del equipo y anotar diferencias en lo que ocurre con cada uno de ellos a fin de esbozar posibles diferencias. Para nosotros es útil contar con una historia clínica en común.
3. Recortar el padecimiento más relevante al interior del dispositivo y con el que se puede trabajar. Razonar sus formas y manifestaciones, pensar los obstáculos que trae a los objetivos propuestos para el Acompañamiento, ubicar cuándo aparece de forma más

intensa y cuando se retira de la oferta de lazo. Como sitúa el psicoanálisis, el síntoma es la coordenada desde dónde nos orientamos en nuestro quehacer. En nuestro equipo, este recorte sucede en las reuniones entre los acompañantes y el coordinador, espacio nuclear donde opera la polifonía del equipo y se construye un saber que alojará lo que ocurre.

4. Ubicar el modo en que el acompañante terapéutico queda envuelto en el padecimiento; es decir, ubicar el lugar que tenemos según la oferta vincular que el paciente nos hace. Se trata de pensar que, cuando vamos estableciendo un vínculo, somos parte interesada en el padecimiento y no estamos por fuera de él, contemplándolo. Para Ágora, es el momento donde ubicamos qué tienen en común y en qué se diferencian los modos vinculares que recaen sobre cada uno de los miembros del equipo que participa del Acompañamiento, ya sea acompañante o coordinador.
5. Deducir las intervenciones concretas que surgen de nuestra lectura del padecimiento y el vínculo que sostenemos. Si bien las intervenciones pueden ser variadas y creativas, apuntan a un mismo padecimiento presente de forma nuclear en el dispositivo.
6. Evaluar los efectos de las intervenciones y rectificar en función de ello. Este es nuevamente el resorte de la reunión de equipo, la apertura al saber que está por venir y donde convocamos a los acompañantes a dar cuenta genuinamente de lo que se ha hecho, haya sido efectivo o no. Debemos considerar las transformaciones que sufre el padecimiento a lo largo del tiempo.
7. Poner a circular la lectura del caso en otras instancias que implica trabajar con otros y volver sobre los aportes que nos hacen. En Ágora, además del diálogo que tenemos con el equipo interdisciplinario de nuestros tratamientos, tenemos un modo de trabajo interno que va replicando como resorte la idea del equipo en un circuito con las distintas instancias que disponemos: los acompañantes con el coordinador, los coordinadores con los directores de área, y los directores de área con la dirección general. Es un diálogo que opera en ambos sentidos y que, según lo amerite el caso, se puede llegar a modificar.

* * *

Escenas mínimas, decisiones clínicas. Una ética del acompañar

La clínica del Acompañamiento Terapéutico no se define por grandes intervenciones ni por diagnósticos rimbombantes. Se juega, en cambio, en lo menudo: en un gesto sostenido, en una pregunta que no se formula, en un límite que no se cruza. Son escenas pequeñas, a veces invisibles desde afuera, pero que en su densidad condensan el núcleo ético y clínico de nuestra práctica.

En Acompañamiento, cada escena se convierte en texto a ser leído como parte de una construcción. El paciente que ofrece un regalo, el acompañante que duda ante un pedido de traslado, el terapeuta que pide un informe informal, el familiar que quiere saber “si está mejor”. Ninguna de esas escenas es trivial. Todas implican posiciones, deseos, imaginarios y sentidos que tensionan el encuadre.

Hay escenas que se quedan grabadas. No porque sean espectaculares ni excepcionales, sino porque algo en ellas logra condensar, con una claridad inesperada, el espesor de la función que encarnamos. El Acompañamiento Terapéutico, en su forma más desnuda, ocurre en esos instantes concretos que, sin pretensión de teoría, abren un campo de interrogación y sentido. Es allí —en la demora del relevo, en la duda ante un pedido, en la tensión con la familia, en el gesto de quedarse aunque el turno terminó— donde la clínica se escribe con cuerpo y decisión. Escenas que no se las patologiza ni se las juzga: se las piensa. Sabemos que toda práctica que no se piensa, se automatiza o se improvisa. Y el Acompañamiento, por definición, no puede permitirse ni lo uno ni lo otro.

Este apartado surge de escenas recogidas por el Equipo Ágora, no en su dimensión de anécdotas, sino como verdaderas matrices clínicas. A partir de ellas, proponemos una lectura que permita pensar al Acompañamiento Terapéutico no solo como intervención técnica, sino como función ética, situada y colectiva..

El relevo que no llega

Viernes, 17:58. La acompañante mira el reloj. Su turno terminaba a las 18:00. El paciente está tranquilo, concentrado en una película. Pero su compañera de relevo no aparece. Duda: ¿espera? ¿se va? ¿llama? Sabe

que acordaron “más o menos” el horario, pero ahora no está segura. Respira. Se queda.

Esta escena, que podría parecer un simple retraso logístico, pone en primer plano una dimensión estructural del dispositivo: el Acompañamiento no se sostiene de manera individual, sino como entramado de relevos. La decisión de quedarse —aunque no sea su “horario”— no responde a una ética del sacrificio, sino a una comprensión del lugar clínico que se habita. No se trata de disponibilidad infinita, sino de responsabilidad compartida. El paciente no es del acompañante; es del dispositivo. Y el dispositivo es de todos. Allí donde el otro no llega, no se improvisa: se sostiene.

Esta escena permite introducir un concepto central: la función se ejerce incluso cuando no se actúa. Decidir no abandonar no es una pasividad, es un acto clínico. Un modo de decir: “aquí estamos”. El encuadre no es solo la hora pautada, es la capacidad de sostener la presencia como garantía simbólica.

El paciente que ofrece un regalo

Al salir de la sesión de terapia, el paciente le entrega un pequeño paquete al acompañante. “Es una pavada, pero me acordé de vos.” El acompañante sonríe, pero se incomoda. No quiere herir al paciente, pero sabe que aceptar el regalo podría abrir un sentido que complique el vínculo.

Este tipo de escenas tensiona la dimensión afectiva del acompañamiento. ¿Qué se hace con lo que el paciente devuelve? ¿Cómo responder al gesto sin rechazar al sujeto? Aquí se juega algo más que la cortesía: se juega el encuadre. Aceptar un regalo, incluso uno menor, puede reconfigurar los lugares, habilitar una lectura del acompañante como figura de intimidad o de intercambio afectivo personal.

La escena convoca a una elaboración ética: el rechazo del regalo no es rechazo del paciente, sino resguardo del lazo. Lo que se cuida no es el objeto, sino el lugar desde el cual ese objeto circula. Nombrar la incomodidad, alojar la intención y, sobre todo, no decidir en soledad, permite transformar el gesto en material clínico.

El Acompañamiento trabaja sobre bordes difusos, pero requiere límites claros. Y esos límites no se sostienen con rigidez, sino con pensamiento clínico colectivo.

La noche y su insomnio

Una acompañante toma un turno nocturno. Viene de un día largo, muchos traslados, poco descanso. A las tres de la mañana, el paciente se despierta ansioso. Ella intenta calmarlo, pero está agotada. Cierra los ojos “solo un momento”. Cuando los abre, pasaron cuarenta minutos.

La noche tiene su propio estatuto clínico. El turno nocturno no es una guardia pasiva, es una escena de vigilancia simbólica. Dormir en ese contexto no es descansar: es desaparecer. Esta escena nos permite pensar la disponibilidad psíquica como condición del Acompañamiento. No se trata solo de estar presentes con el cuerpo, sino de que ese cuerpo esté en condiciones de sostener presencia.

Aceptar un turno sin estar disponible no es una falta individual: es una falla del dispositivo que no habilita la pregunta por el propio límite. Porque también se acompaña cuando se sabe decir que no. En una clínica centrada en la presencia, el cuidado del acompañante es parte del cuidado del paciente.

La opinión sobre el terapeuta

Durante el acompañamiento, el paciente expresa dudas sobre su analista. “No me entiende... siempre me dice lo mismo.” El acompañante asiente con empatía. Se le escapa un comentario: “Y... a veces pasa, hay que encontrar con quién te sentís cómodo.” El paciente lo mira con complicidad. En la próxima sesión, suspende su tratamiento.

Aquí, la escena se vuelve nítidamente estructural. El acompañante, con una frase mínima, desarma una cadena de transferencias que sostenía el trabajo terapéutico. El error no fue tener una opinión: fue expresarla en escena. El Acompañamiento, en tanto función, no opina sobre otros referentes clínicos. No se convierte en comentarista del trata-

miento. Porque hacerlo no solo implica una invasión de lugares, sino una fractura en el dispositivo.

No hay neutralidad posible, pero sí hay una posición ética que decide cuándo y dónde intervenir. Lo que el paciente dice sobre su terapeuta es material clínico. Pero lo que el acompañante hace con eso define si sostiene el encuadre o lo debilita. Y esa decisión no se toma en soledad: se conversa, se elabora, se piensa con otros.

El paciente quiere subirse al auto

Llueve. El paciente le pide al acompañante que lo acerque en su auto. “Es solo una cuadra, no da para mojarse.” El acompañante duda. La calle está vacía. El paciente insiste. Finalmente, accede. No pasa nada, pero algo en la escena queda torcido. La semana siguiente, el paciente vuelve a pedir lo mismo. Y suma: “¿Y si me llevás al centro?”

La escena del traslado pone en juego uno de los bordes más delicados: la confusión entre el lazo terapéutico y la ayuda personalizada. El acompañante no es un amigo, no es un familiar, no es un chofer. Es alguien que sostiene una función clínica en un marco específico. Cuando ese marco se desdibuja, el vínculo se vuelve ambivalente, cargado de fantasías y demandas difíciles de simbolizar.

Aquí, el límite no es una cuestión legal —aunque también lo sea—: es una decisión clínica. Porque lo que se habilita una vez, se transforma en expectativa. Y toda expectativa no alojada puede devenir reclamo.

El Acompañamiento no consiste en “hacer por el otro”, sino en estar con él en lo que puede, en lo que no puede, en lo que está en proceso de construir. Subir al paciente al auto puede parecer una solución, pero a veces, la clínica requiere transitar juntos la incomodidad de la lluvia.

Feriado nacional, clínica activa

El acompañante se despierta el viernes con un pensamiento relajado: “Hoy es feriado, seguro se suspende el acompañamiento.” Pero al mirar la agenda, lee: “Confirmar si se sostiene el dispositivo de hoy.” Duda. Cree que sería razonable descansar. No hubo indicación clara de suspensión. Finalmente decide escribir en el chat grupal del caso: “¿Hoy trabajamos?”

La respuesta del coordinador es inmediata: “Sí, por ahora no hubo indicación contraria de los tratantes”.

Esta escena introduce una pregunta crucial: ¿cuándo el Acompañamiento se interrumpe y quién lo decide? Lo que aquí se despliega es una discusión sobre la autonomía del profesional frente al dispositivo colectivo. Creer que un feriado suspende por sí mismo la clínica es imaginar que la práctica está regulada por el calendario social, cuando en verdad se rige por los tiempos del caso.

Desde una lógica psicoanalítica, el encuadre no es solo un acuerdo logístico, sino una condición de posibilidad de la transferencia. Es lo que permite que algo se aloje, que un lazo se construya, que la escena se sostenga. Alterarlo sin mediar lectura clínica —por ejemplo, suspender sin discutir— equivale a fracturar las coordenadas simbólicas sobre las que se apoya la función.

El Acompañamiento no se ordena por el deseo del acompañante, ni por su disponibilidad, sino por una construcción estratégica que se decide entre varios. Por eso, cada excepción debe pasar por el colectivo: porque no se trata de flexibilizar el encuadre, sino de pensar cuándo y cómo hacerlo.

El paciente no está, ¿entro igual?

El acompañante llega al domicilio y golpea la puerta. Atiende el hermano del paciente: “No está, fue a comprar algo. Pero pasá, esperalo adentro como siempre”. La familia lo reconoce, lo saluda con confianza. El acompañante duda. Agradece, pero se queda en el palier. Escribe al coordinador. Espera afuera.

A simple vista, esta escena parece una muestra de respeto o discreción. Pero en verdad aloja una cuestión más profunda: el modo en que se construye la posición del acompañante. Entrar al hogar sin el paciente es colocarse en un lugar ambiguo, es sostener una presencia fuera del lazo clínico. Es también cargar de sentido algo que parece insignificante.

Esta escena puede pensarse con la noción de función-sujeto: no se trata del sujeto que hace, sino de la función que se encarna en el momento en que se la ejerce. La casa del paciente no es un espacio

neutro; es una escena densa de vínculos, sentidos, asimetrías. Estar ahí sin él es habitar ese espacio por fuera de la lógica que justifica nuestra presencia.

En la práctica del Acompañamiento, cada decisión construye lugar. Esperar afuera no es falta de compromiso: es respeto por el límite. Es una forma de decir “estoy”, pero sin confundir los planos. Porque acompañar no es invadir ni pertenecer. Es estar ahí, con cuidado, desde una posición que no se toma, sino que se construye.

El mensaje que no basta

Terminó el acompañamiento. Algo le hizo ruido: el paciente se mostró más irritable de lo habitual, dijo cosas que antes no decía. El acompañante manda un mensaje en el grupo del caso: “Me pareció más desconectado hoy”. Después lo sube a la intranet. Nadie responde. Al día siguiente, el paciente tiene un episodio crítico.

Aquí se despliega un problema frecuente: confundir la transmisión con la comunicación. El mensaje escrito, por sí solo, no implica que el dispositivo haya tomado conocimiento. En la era de la hiperconectividad, el Acompañamiento clínico requiere decisiones sostenidas en presencia —aunque esa presencia sea remota—. Informar no es comunicar. Y comunicar no es compartir la carga clínica de lo que se vivió.

Esta escena invita a pensar una categoría fundamental: la urgencia como construcción subjetiva y colectiva. Lo que para un acompañante es “una percepción leve” puede ser, para el equipo, un indicio crítico. Pero eso solo puede pensarse si hay interlocutores reales, si hay quien reciba y elabore la inquietud. El acto clínico, entonces, no termina con el Acompañamiento: se completa en la red.

Desde esta perspectiva, el acompañante no trabaja solo, ni siquiera cuando está solo con el paciente. Lo que lo sostiene no es solo su formación, sino la existencia de un colectivo que escucha, que lee, que responde. El llamado, el encuentro, la reunión: esos son los lugares donde el Acompañamiento se vuelve clínico.

La sugerencia bienintencionada

Están por salir. El paciente se muestra reacio, cansado. La madre se acerca y sugiere: “¿Por qué no lo llevás un ratito a la plaza? Eso siempre le hace bien”. El acompañante lo mira. El paciente no había dicho nada. La actividad no estaba pautada. El acompañante responde: “Si te parece importante, lo podemos hablar con el coordinador”. La madre se incomoda. El paciente lo agradece.

Esta escena permite leer el modo en que el Acompañamiento se diferencia del lugar de la disponibilidad absoluta. Es frecuente que las familias depositen en el acompañante expectativas no dichas, fantasías de reparación, deseos de completud. También es frecuente que se pida “un plus”, algo que excede lo acordado. Responder a ese pedido —por más bienintencionado que sea— puede abrir un sentido peligroso: el de la plasticidad infinita del rol.

En esta escena se pone en juego algo esencial: el acompañante no está para responder a todas las demandas. Está para alojar, pensar, sostener y articular dentro de una estrategia clínica. Y esa estrategia no se define por amabilidad, sino por lectura. Derivar el pedido al coordinador no es lavarse las manos: es ejercer la función.

Podríamos leer esto también desde la lógica de la interdisciplina: cada profesional ocupa un lugar. Intercambiar roles, aunque sea en nombre de “hacerle bien al paciente”, puede volverse contraproducente. Porque el acompañamiento no es “estar disponible”, sino “estar disponible desde un lugar”. Y ese lugar necesita bordes.

La escena como brújula

Lo que este recorrido deja en claro es que cada escena, por mínima que sea, contiene una potencia clínica. No son meros imprevistos: son momentos donde se define el modo en que entendemos y habitamos nuestra función. Allí donde muchos ven gestos, nosotros leemos estructura. Donde aparece una decisión cotidiana, nosotros encontramos una pregunta ética.

El Acompañamiento Terapéutico como intentamos transmitirlo, es, en su núcleo, una práctica clínica entre varios. No porque haya muchas personas haciendo lo mismo, sino porque su sentido solo se construye en

red. Cada escena, cada duda, cada desborde, es una oportunidad para confirmar que acompañar no es actuar solo, sino decidir en común. Y que esa decisión compartida —sostenida por un dispositivo, por un equipo, por una lógica clínica— es la que permite que nuestra presencia sea algo más que una compañía: sea una función.

Lo clínico del Acompañamiento: tres movimientos para una práctica

A lo largo de los primeros tres módulos hemos recorrido el corazón clínico del modelo de Acompañamiento Terapéutico que proponemos. Se trata, ni más ni menos, que de dar cuenta de una forma de estar en la escena, una forma de intervenir, de implicarse y de elaborar lo que sucede cuando alguien acompaña —y es acompañado por la red— en el territorio del padecimiento.

En el primer módulo, propusimos las condiciones necesarias para la construcción de la escena clínica. Nos centramos en la posición desde la cual se participa, en los elementos que organizan un dispositivo, en los marcos simbólicos y materiales que lo sostienen. Lo que está en juego allí no es sólo el encuadre, sino la pregunta por el lugar que ocupamos como acompañantes en una intervención.

El segundo módulo desplazó la mirada hacia el acompañante mismo: ¿qué le pasa a quien acompaña? ¿Qué afectos se activan? ¿Qué resonancias se producen? ¿Qué riesgos implica implicarse? Allí, la reflexión se volvió más íntima, más encarnada. Acompañar, lo sabemos, no es solo hacer: es también ser afectado, dejarse tocar, trabajarse a sí mismo.

En el tercer módulo, nos abrimos a la dimensión colectiva. Porque una clínica entre varios no es solo la suma de miradas, sino una forma de construir sentido. Pensamos el caso como una elaboración compartida, una cartografía que se traza con otros. Esa construcción no solo permite intervenir mejor: también protege del agotamiento, de la omnipotencia, del aislamiento.

Con estos tres módulos delineamos las coordenadas clínicas fundamentales del modelo que proponemos. Son ellos los que sostienen la propuesta de este Acompañamiento entre varios, que no se agota en el hacer individual ni se apoya únicamente en el saber técnico, sino que se configura en el encuentro, en la implicación y en la elaboración conjunta de lo vivido.

La formación contempla, por supuesto, un cuarto módulo. Pero su objetivo no es ya profundizar sobre lo clínico, sino ampliar el campo: pensar la articulación del dispositivo con su contexto. Es allí donde se vuelve imprescindible abrir el análisis a los discursos que nos rodean: lo jurídico, lo institucional, lo administrativo, lo comunitario. Ese trabajo lo retomaremos más adelante, cuando nos adentremos en capítulos bajo la premisa “Entre discursos”.

Ahora, en cambio, abrimos otro recorrido. Nos proponemos pensar las condiciones necesarias para implementar un dispositivo de Acompañamiento Terapéutico. No ya cómo se acompaña, sino cómo se organiza, cómo se sostiene y qué hace falta —material, simbólica y políticamente— para que esa escena clínica pueda tener lugar.

Tercera Parte

LA IMPLEMENTACIÓN DEL DISPOSITIVO: CLÍNICA ENTRE VARIOS Y TRABAJO EN EQUIPO

INTRODUCCIÓN

La formación propuesta por el equipo Ágora, con sus distintos modelos y núcleos temáticos, no se limita a la transmisión de herramientas para la intervención. Lo que se enseña —o mejor dicho, lo que se pone a trabajar— es una forma de habitar la clínica, un modo singular de lectura y de posicionamiento ético en la escena del Acompañamiento. Cada módulo desarrollado hasta aquí, cada instancia formativa, ha buscado ofrecer coordenadas que permitan al acompañante no solo sostener su función, sino también problematizarla, reinventarla y vincularla con las complejidades del lazo social.

Sin embargo, toda práctica necesita condiciones que la sostengan. El Acompañamiento Terapéutico, en tanto práctica clínica singular, no puede desplegarse de manera aislada ni individual. Su eficacia, su potencia subjetivante y su capacidad de intervención dependen en gran medida del modo en que se implementa. Esto nos obliga a preguntarnos por la estructura que hace posible ese hacer con otros: ¿qué formas de organización lo contienen? ¿Qué funciones hacen al sostenimiento del lazo clínico entre acompañantes y acompañado? ¿Qué escenas se vuelven necesarias para procesar lo que allí acontece?

En los capítulos que siguen, nos adentramos en las condiciones de posibilidad del Acompañamiento Terapéutico como dispositivo clínico. Nos detendremos especialmente en tres pilares fundamentales: la construcción del equipo como entramado colectivo que aloja y potencia las intervenciones; la figura del coordinador, no solo como gestor, sino como operador clínico que habilita lecturas, sostiene el encuadre y promueve la articulación entre los actores; y la reunión de equipo, entendida como espacio privilegiado de elaboración, transmisión y producción de sentido. Estos tres pilares constituyen lo que llamamos “Clínica entre varios”.

El pasaje de la formación a la organización no es un cambio de registro, sino una continuidad lógica: no hay formación sin un colec-

tivo que la aloje, y no hay práctica clínica posible sin una arquitectura simbólica que la sustente. En esa clave, el dispositivo de Acompañamiento es una apuesta que requiere estructura, tiempo compartido y un lazo que cuide.

Capítulo 5

EL EQUIPO EN ACOMPAÑAMIENTO TERAPÉUTICO

El equipo como figura clínica y política en la historia del Acompañamiento Terapéutico

Hablar de equipo en Acompañamiento Terapéutico no es simplemente referirse a una modalidad de trabajo, sino a una apuesta ética, clínica y política que atraviesa, de maneras diversas, toda la historia del dispositivo. Desde los primeros textos que dieron forma al campo hasta los desarrollos contemporáneos, la figura del equipo aparece como condición de posibilidad para una práctica que, por su despliegue en los márgenes, necesita de entramados que la sostengan.

Este apartado propone un recorrido por las distintas maneras en que los textos iniciales del Acompañamiento Terapéutico abordaron, imaginaron o reclamaron lo colectivo. Más allá de los nombres propios o los formatos institucionales, buscamos rastrear cómo se fue tejiendo la noción de equipo: como lugar de elaboración clínica, como espacio de sostén, como estrategia frente a la precariedad, como condición de cuidado.

Retomar estas voces fundantes no implica una mirada nostálgica ni celebratoria, sino la necesidad de historizar las condiciones desde las que hoy seguimos pensando el Acompañamiento Terapéutico. En un tiempo marcado por la fragmentación, la urgencia y la burocratización, volver sobre la construcción del equipo como figura clínica nos permite recuperar la dimensión artesanal y colectiva de esta práctica, sostener su especificidad y proyectar su porvenir.

El lugar del Equipo en los textos fundacionales

Hay conceptos que, aunque centrales en una práctica, transitan largamente sin ser interrogados. Viven en el discurso, organizan modos de hacer, condicionan intervenciones y delimitan responsabilidades, pero lo hacen desde una supuesta obviedad que los protege de la problematización. El concepto de “equipo” en Acompañamiento Terapéutico parece ser uno de ellos. Constituye el corazón mismo de la práctica, estructura las formas de intervención, orienta las responsabilidades y sin embargo, pocas veces se lo define. Con mucha facilidad se lo da por sabido. Se lo nombra como si no hiciera falta detenerse a pensar de qué se trata, qué implica, qué consecuencias tiene.

Sin embargo, una revisión de los textos históricos del campo muestra que el concepto de equipo ha ido mutando, reorganizándose, tomando diferentes formas según los contextos sociales, institucionales y clínicos en los que se inscribía el Acompañamiento Terapéutico. Como sucede con todo campo en construcción, la producción teórica y editorial del Acompañamiento ha sido una forma de diagramar sus tensiones, de hacer visibles sus contradicciones y de fijar ciertos acuerdos. Los libros y artículos no solo reflejan lo que sucede en la práctica: también la instituyen, la orientan, la legitiman.

El primer texto publicado sobre Acompañamiento Terapéutico aparece en 1985 y lleva la firma de Susana Kuras de Mahuer y Silvia Resnizky. En “Acompañantes Terapéuticos y pacientes psicóticos”¹ se define por primera vez esta práctica como una intervención clínica que forma parte de un “abordaje múltiple” dentro de un equipo interdisciplinario. En esa propuesta inaugural, el equipo aparece como una estructura institucional preexistente, organizada para ofrecer respuestas terapéuticas integrales. El acompañante es uno más entre varios: un recurso terapéutico novedoso que se incorpora para ampliar las posibilidades de abordaje. Se trabaja bajo la lógica de un equipo conformado por profesionales con funciones interdependientes, aunque no simétricas. La figura del Acompañante Terapéutico es presentada entonces como una parte, subordinada a una estrategia clínica diseñada de antemano.

1. Kuras de Mauer, S., & Resnizky, S. (1985). *Acompañantes terapéuticos y pacientes psicóticos: manual introductorio a una estrategia clínica*. Buenos Aires: Trieb.

Hacia el final de ese mismo texto, las autoras abren la posibilidad de otra forma de implementación: aquella en la que el acompañante es convocado directamente por un terapeuta o incluso por la familia. Este tipo de conformación, más circunstancial, no institucionalizada, es mencionada de forma tangencial, sin ser desarrollada en profundidad. Se naturaliza que la relación entre acompañante y terapeuta mantendrá las mismas coordenadas del equipo institucional explicado anteriormente, pasando por alto las diferencias estructurales e ideológicas que existen entre una modalidad y otra.

Diez años después de la primera publicación sobre Acompañamiento Terapéutico, en 1994, aparece un segundo texto fundacional: “Acompañamiento Terapéutico. Aproximaciones a su conceptualización”², de Gabriel Pulice y Gustavo Rossi. Esta obra representa un giro significativo respecto de los planteos iniciales. Ya no se parte de una definición general de la actividad propia del acompañante, sino que se enfatiza que su sentido debe construirse en relación a cada tratamiento en particular. El concepto que atraviesa el libro es “la función” y esta no puede pensarse a priori, ni como una categoría fija: debe definirse según el contexto, el encuadre, la estrategia clínica y las particularidades del caso. En este enfoque, el acompañante aparece como un agente clínico cuya intervención se delimita puntualmente, en estrecha articulación con el profesional tratante.

Sin embargo, este mismo texto introduce una novedad fundamental: por primera vez se diferencian dos modalidades posibles de implementación del recurso. Por un lado, el acompañante terapéutico que trabaja en forma individual, autogestionando su práctica, articulando directamente con el terapeuta o profesional que indica la intervención. A este modelo lo denominan “acompañante terapéutico en forma individual”, y podría pensarse como una figura cercana al profesional liberal. Por otro lado, se menciona la existencia de lo que los autores denominan un “equipo de acompañantes terapéuticos”: un agrupamiento de varios acompañantes que funcionan colectivamente, con una lógica de trabajo organizada y propia, y que se articula como unidad con el profesional tratante.

En relación con esta segunda modalidad aparece, también por primera vez en una publicación, la figura del coordinador del dispositivo.

2. Pulice, G., & Rossi, G. (1994). *Acompañamiento terapéutico: aproximaciones a su conceptualización: presentación de material clínico*. Buenos Aires: Xavier Bóveda.

Se lo ubica como alguien necesario especialmente en Acompañamientos con una carga horaria intensa (por ejemplo, de 24 horas diarias), donde intervienen varios acompañantes que rotan por los distintos horarios para garantizar la asistencia. El coordinador es presentado como aquel que organiza aspectos logísticos del dispositivo, ordena horarios, planifica actividades, mantiene vínculo con el terapeuta, y en ocasiones también con la familia. Si bien aún no se distingue con claridad entre coordinación y supervisión, ya se advierte que esta figura cumple un rol articulador y sostenedor del funcionamiento del equipo, y que su existencia es crucial cuando el Acompañamiento se ejerce entre varios.

La modalidad del “equipo específico de Acompañamiento terapéutico” empieza así a consolidarse no solo como una forma organizativa posible, sino como una práctica ya instalada en el campo. Esto se evidencia de manera contundente en el Primer Congreso Nacional de Acompañamiento Terapéutico, realizado ese mismo año, en noviembre de 1994. En las publicaciones que surgen como compilación del congreso, vemos que la mayoría de las experiencias presentadas —ocho de quince— corresponden a dispositivos conformados por equipos de acompañantes. Es decir, más allá de la conceptualización teórica, la práctica ya venía construyéndose desde una lógica colectiva, entre varios, con funciones diferenciadas y necesidad de articulación interna.

Dentro de esas presentaciones, se destaca especialmente el trabajo de Guillermo Altomano y Silvia Azpillaga (Altomano, 1995), quienes aportan una reflexión precisa sobre la lógica del trabajo en equipo. Desde su perspectiva, el equipo no debe pensarse solo como una agrupación funcional, sino como una estructura que produce efectos subjetivantes. El paciente, al ingresar a ese entramado, accede a nuevas ofertas identificatorias, a relaciones múltiples, a un entrecruzamiento de miradas que habilita una resignificación del padecimiento. El valor clínico del equipo reside precisamente en ese “entre varios”.

En su texto, Altomano y Azpillaga también avanzan en la diferenciación entre las funciones de coordinación y supervisión. Aun cuando ambas funciones puedan estar ejercidas por la misma persona, insisten en la necesidad de pensar sus diferencias: la coordinación refiere a la organización interna del equipo, al sostenimiento logístico y vincular del dispositivo; mientras que la supervisión se define como una instancia clínica, orientada a la elaboración del caso, a la lectura de las transferencias, al análisis del lugar que cada acompañante ocupa en la trama

terapéutica. En conjunto, estas funciones permiten que el equipo no solo funcione, sino que pueda producir sentido, sostener su legalidad interna y ofrecerse como un dispositivo clínico potente.

En 2003, Kuras y Resnizky retoman su trabajo inicial y publican “Acompañamiento Terapéutico, actualización teórico-clínica”³. Allí, con una perspectiva más atravesada por el psicoanálisis, sostienen que el Acompañamiento no puede cumplirse en forma aislada, sino que siempre está inscripto en el seno de un equipo. Siguen pensando el equipo como un dispositivo de abordaje múltiple, institucional, pero comienzan a reconocer la figura del supervisor como necesaria. Se trata aún de una supervisión centrada en el acompañante como sujeto individual, con una mirada formativa y ética, pero que no termina de integrarse a la lógica del trabajo entre varios acompañantes en un mismo caso. De todos modos, en uno de los relatos clínicos incluidos en ese libro, se evidencia la existencia de un equipo específico con una coordinadora a cargo, que articula la relación entre el grupo de acompañantes y los otros profesionales del tratamiento. El texto explicita que este ordenamiento no solo favorece el abordaje clínico, sino que también protege el dispositivo de interferencias externas y permite un trabajo más consistente. A pesar de que las autoras mantienen una concepción centrada en el equipo interdisciplinario, el relato revela que la práctica misma exige asumir dinámicas propias del Acompañamiento entre varios, con un lugar específico para la coordinación.

Finalmente, en 2007, Gustavo Rossi publica “Acompañamiento Terapéutico, lo cotidiano, las redes y sus interlocutores”⁴, un libro que se propone dar cuenta de la práctica tal como se venía desarrollando en esos años. Con una escritura accesible, Rossi ofrece un panorama amplio del campo, deteniéndose en las formas concretas de intervención, en los actores implicados y en las lógicas de red que atraviesan al Acompañamiento. En ese texto, la figura del equipo específico de Acompañamiento Terapéutico aparece ya consolidada. Se delimitan claramente las funciones del coordinador, diferenciándolo de la supervisión, y se reconoce que el Acompañamiento, cuando es ejercido entre varios, exige una estructura que lo sostenga. El equipo deja de ser una

3. Kuras de Mauer, S., & Resnizky, S. (2003). *Acompañantes terapéuticos actualización teórico-clínica*. Letra viva.

4. Rossi, G. P. (2007). *Acompañamiento terapéutico: lo cotidiano, las redes y sus interlocutores*. Polemos

obviedad para convertirse en un dispositivo que necesita ser pensado, organizado y revisado.

Del acompañante autónomo al equipo específico

A esta altura ya existen, al menos, dos modos diferenciados de implementar el Acompañamiento Terapéutico. Por un lado, la figura del “acompañante autónomo”, convocado muchas veces al modo de un profesional liberal, quien se reconoce portador de un saber propio y, desde allí, se siente en condiciones de intervenir en las situaciones clínicas para las que es requerido. Su intervención se inscribe en una lógica de articulación directa con otros profesionales tratantes, intentando “hacer equipo” con ellos dentro de lo que habitualmente se denomina —no sin cierta liviandad— “equipo interdisciplinario”. Por otro lado, encontramos la modalidad del “equipo específico de Acompañamiento Terapéutico”: un agrupamiento de acompañantes que asumen colectivamente la responsabilidad de llevar adelante el dispositivo, organizando su práctica de forma compartida y sostenida en una dinámica interna propia. Desde ese lugar, el equipo se articula con el resto de los profesionales intervinientes, funcionando como un recurso más dentro del tratamiento, pero con identidad y estructura propias.

El crecimiento que ha experimentado el campo del Acompañamiento Terapéutico en los últimos años ha estado acompañado, en gran medida, por la expansión de la figura del acompañante autónomo. Esta expansión no es casual: se encuentra estrechamente ligada a la proliferación de cursos y tecnicaturas centrados en la construcción del rol, en la definición de obligaciones, incumbencias y capacidades profesionales, y en la preparación del acompañante como figura individual para el ejercicio responsable de la práctica.

Así, se consolidó un modelo formativo que privilegia tanto la autonomía del acompañante como su saber técnico, dejando por fuera las condiciones de su implementación. Sin embargo, si revisamos la historia de esta práctica, advertimos que gran parte de sus desarrollos más significativos —teóricos, clínicos y organizativos— han surgido al interior de equipos específicos de Acompañamiento.

Diferencias conceptuales entre modalidades

Es posible afirmar que ambas modalidades reconocen la necesidad de pensar el Acompañamiento dentro de un marco de trabajo conjunto, en el que la noción de equipo aparece como referencia insoslayable. Pero no se trata, en absoluto, del mismo concepto de equipo. Las diferencias entre uno y otro modelo no son solamente organizativas: implican distintas concepciones sobre la función, la posición subjetiva del acompañante, y el modo en que se produce lo clínico.

Llegados a este punto, puede resultar útil ordenar las diferencias entre las modalidades del Acompañamiento Terapéutico a partir de dos preguntas que, si bien parecen similares, abren caminos muy distintos: ¿qué lugar para el acompañante? o ¿qué lugar para el Acompañamiento?. La primera interroga la inserción del profesional desde una perspectiva individual, centrada en su habilitación técnica, en sus recursos subjetivos, en su posibilidad de ocupar un espacio clínico de intervención dentro de un tratamiento. La segunda, en cambio, desplaza el eje de la pregunta hacia una mirada estructural: no se trata ya del lugar de una persona, sino del lugar para un dispositivo. Esta reformulación nos obliga a pensar en términos colectivos: a interrogar cómo se organiza la intervención, cómo se articula con otros agentes de salud mental, qué tensiones emergen de ese entrecruzamiento de discursos y responsabilidades, y qué condiciones deben existir para que el Acompañamiento pueda operar como una práctica clínica situada y con efecto. Lo que se pone en juego, entonces, no es solo el rol del profesional, sino la arquitectura misma del dispositivo que habilita su intervención.

Condiciones clínicas para un dispositivo colectivo

Si somos varios ¿hay equipo? Las definiciones más generales podrían ayudarnos a trazar una primera delimitación. Un grupo —según su acepción más corriente— no requiere más que la presencia de varios individuos identificables. Puede haber grupo sin que exista un propósito común, una articulación funcional o una organización entre sus miembros. En cambio, un equipo es una forma específica de agrupamiento humano: se trata de personas que no solo comparten un objetivo, sino que interactúan, cooperan, debaten y piensan juntas, dentro de una

estructura organizada, capaz de coordinar sus diferencias en función de una meta común. Un equipo, a diferencia de un grupo, no se da por mera agregación: se construye.

Esa construcción implica una disposición activa de sus integrantes. Implica también un tiempo compartido, un conocimiento mutuo que permita tramitar los roces inevitables, las diferencias de criterio, las disonancias que surgen del trabajo conjunto. Sabemos que no es la calidad individual de cada integrante lo que garantiza la potencia de un equipo, sino la capacidad de poner en juego esas diferencias dentro de una estructura viva y organizada. En este sentido, el contacto sostenido, el ejercicio de la palabra compartida, el intercambio de perspectivas, son condiciones fundamentales para que el dispositivo funcione como tal. Solo así cada integrante puede devenir parte de un engranaje común, que no anula lo singular, pero lo hace operar dentro de una lógica de conjunto.

Sea cual sea la modalidad en la que un acompañante decide ejercer —como autónomo o como parte de un equipo específico—, no puede desentenderse de su inserción en un entramado clínico más amplio. En todo caso, siempre forma parte de una escena general, en la que están implicados el paciente, la familia, otros profesionales, e incluso aquellas presencias simbólicas que configuran los bordes de la intervención. Esa escena no es un fondo sobre el que el acompañante actúa: es el campo mismo del Acompañamiento. Y nadie —ni el paciente, ni la familia, ni los otros— puede ser considerado un obstáculo. Todos ellos son parte de lo que sucede.

Ahora bien, cuando el Acompañamiento se estructura en torno a un vínculo circunstancial entre un acompañante y un profesional tratante, se juega allí la necesidad de armar equipo, al menos entre dos. Es lo que suele llamarse, muchas veces con excesiva ligereza, un “equipo interdisciplinario”. Pero conformar un equipo no es simplemente coincidir en un caso. Para que ese lazo sea clínicamente eficaz, es necesario que el Acompañamiento sea parte de un diseño de tratamiento, que haya una estrategia compartida, y que el profesional tratante reconozca al menos los aportes del acompañante como parte del proceso. Aun cuando esas condiciones se cumplan —lo cual no es frecuente— persiste una dificultad que no puede soslayarse: la intervención, en la medida en que participa un solo acompañante, queda encapsulada en una sola figura. Todo lo que ocurre en la experiencia del Acompañamiento, todo lo que

se despliega en el vínculo, queda coagulado en el cuerpo del acompañante. Es sobre él que recae la responsabilidad de sostener el entramado clínico, y su eficacia dependerá tanto de su capacidad de lectura y maniobra como del respaldo simbólico que pueda recibir por parte del terapeuta. Porque, en la medida en que nos implicamos en la vida cotidiana de quienes acompañamos, y habitamos con ellos zonas de alta sensibilidad subjetiva, es esperable —casi inevitable— que emerjan tensiones. Y sin una estructura que aloje y reelabore esas tensiones, el Acompañamiento se vuelve una práctica aislada, frágil y expuesta.

El Equipo como unidad de cuidado clínico

Sostenemos que la forma más sólida de implementar el Acompañamiento Terapéutico es a través de un equipo específico, que cuente con estructura interna, funciones diferenciadas y lógicas de trabajo compartidas. En estos dispositivos, el asistido no se vincula con una única figura, sino que circula entre distintos acompañantes, cada uno con su estilo, su modo de presencia, su modo de hacer lazo. Esa diversidad relacional, lejos de dispersar el dispositivo, lo fortalece: protege al acompañante y protege al paciente, permitiendo que las tensiones que puedan surgir con uno puedan ser elaboradas por otros, dentro de una estructura clínica pensada para que eso suceda.

La diferencia estructural más clara con el modelo autónomo es que, en los equipos específicos, el lugar del acompañante está previamente construido y sostenido. No se inventa desde cero en cada intervención. Existe antes de que alguien lo ocupe. Está definido por el coordinador, quien no solo organiza los aspectos logísticos del dispositivo, sino que también resguarda la legalidad simbólica de la función. A lo largo del Acompañamiento, los diferentes profesionales asignados como acompañante circularán por ese lugar, asumiendo la función en momentos distintos, con sus diferencias transferenciales, pero dentro de una misma lógica de cuidado clínico. Lo que el paciente transita allí no es una serie de vínculos aislados, sino un entramado relacional con consistencia interna, que puede contener y resignificar.

Ese equipo se convierte en una unidad clínica con mecánica propia, capaz de articular con el profesional tratante, en la mejor de las situaciones, en clave interdisciplinaria. Y aun cuando esa articulación no

sea posible, el dispositivo puede sostenerse a partir de ciertos puntos nodales, permitiendo que el Acompañamiento opere de todas maneras. Esto no quiere decir que el Acompañamiento sea un tratamiento en sí mismo, pero sí que puede funcionar como sostén clínico significativo incluso cuando la estrategia general se debilita. Hay numerosos casos en los que, fuera de la indicación inicial y el encuadre general, el profesional tratante no sostiene una interlocución activa, y sin embargo, el Acompañamiento, en su modalidad colectiva, logra intervenir de manera eficaz.

Además, la logística propia del dispositivo colectivo permite alojar múltiples demandas sin que estas recaigan directamente sobre el acompañante. Las demandas de la familia, del psiquiatra, de la institución, pueden canalizarse hacia otras figuras —como el coordinador—, liberando al acompañante para que centre su escucha en la demanda del paciente. Esta estructura no solo ordena la práctica: también la protege. Permite trabajar sin quedar capturado por los múltiples tironeos que muchas veces se atraviesan en la cotidianeidad, que es la escena clínica.

¿Qué hace equipo a un equipo?

En Acompañamiento Terapéutico, cuando se habla de equipo, suele pensarse en la relación entre el acompañante autónomo y las otras disciplinas que intervienen en la escena clínica. Esta perspectiva, que ha sido ampliamente difundida, tiende a enfatizar la dimensión interdisciplinaria, muchas veces dejando en segundo plano la posibilidad —y la potencia— de construir equipos específicos de Acompañamiento Terapéutico. En estos casos, el equipo ya no es la articulación con otros saberes, sino una trama intersubjetiva entre profesionales que comparten una misma práctica, un mismo lenguaje y un modo de intervención común.

No toda agrupación es un equipo, y no todo grupo logra construir una lógica colectiva. Nos animamos a pensar que el equipo no es una estructura dada, sino un resultado: una experiencia que se percibe, que se siente, y que emerge del encuentro sostenido en el tiempo. No hay fórmulas fijas para su constitución; más bien, se trata de un proceso que se va armando en la práctica, en el roce cotidiano, en las preguntas compartidas, en los acuerdos y en las diferencias.

El equipo se configura como un espacio relacional, donde lo colectivo se pone en tensión con lo singular, y donde cada acompañante, aunque trabaje de forma individual con sus asistidos, puede sentirse parte de una construcción más amplia. Esa trama colectiva no solo contiene, sino que también confronta, habilita preguntas, sostiene la transferencia y vehiculiza la dimensión clínica del Acompañamiento.

La figura del coordinador, en este marco, no es un administrador ni un supervisor externo, sino quien sostiene los hilos del encuadre común. Coordinar es alojar el malestar del equipo, contener las tensiones propias de la práctica clínica y propiciar la elaboración colectiva. Es también asumir una posición que oscila entre facilitar el pensamiento compartido y habitar una diferencia que no se imponga como saber cerrado, sino que habilite la construcción común.

Las reuniones de equipo se vuelven nodales para esa experiencia: allí se alojan las disidencias, se confrontan las decisiones, se teje la práctica en diálogo. Un equipo no es un espacio sin conflictos; por el contrario, se define por su capacidad de habitar el desacuerdo, de construir desde el conflicto, de sostenerse incluso cuando el consenso no aparece de inmediato.

Desde nuestra experiencia, entendemos que un equipo solo puede construirse si sus integrantes se implican con el proyecto. Implicarse no es solo comprometerse con la tarea, sino también dejarse afectar por la mirada del otro, ceder ante una decisión colectiva, reconocer los propios límites y ponerlos en juego. Por eso, todo equipo genuino es también un ejercicio de descentramiento: cada integrante debe encontrar su lugar sin intentar hegemonizar el conjunto, y al mismo tiempo sostener con firmeza aquello que lo convoca.

En contextos donde las formas de trabajo tienden a la fragmentación, y donde el lazo profesional se debilita en favor de lógicas más utilitarias, construir equipo es una apuesta política. Implica generar condiciones para que cada quien pueda apropiarse de su práctica, sin delegar en otros la orientación clínica ni reducirse a ejecutar lo que se le demanda. Implica también construir un marco común desde el cual intervenir, con lugar para la diferencia y con vocación de encuentro.

En definitiva, entendemos que el equipo es siempre un devenir. Una posibilidad que se construye y se sostiene en tanto haya deseo de encuentro, voluntad de implicación y apertura a la transformación.

Capítulo 6

FUNDAMENTOS DE LA COORDINACIÓN EN ACOMPAÑAMIENTO TERAPÉUTICO

El ejercicio de la coordinación

Introducción

Entre los distintos ejes que fuimos elaborando a lo largo de los años en torno al Acompañamiento Terapéutico, uno de los que más trabajo conceptual y clínico nos exigió —y al que seguimos volviendo una y otra vez— es el de la coordinación. No se trata de una figura nueva, ni de una invención propia. Es una función que existía desde antes, pero que históricamente ha sido pensada, en muchos casos, desde una lógica puramente administrativa o funcional, desligada del espesor clínico que implica sostener un dispositivo.

Lo que aquí se presenta es un recorrido situado, una práctica que se fue armando en el hacer cotidiano y en la conversación con otros. No se trata de ofrecer un modelo cerrado, sino de compartir una construcción posible. Sabemos que no hay una única forma pensar la coordinación. Esta es apenas una experiencia, un modo entre otros. Pero creemos que en estas páginas puede leerse algo del aporte que el equipo Ágora ha buscado hacer al campo del Acompañamiento Terapéutico: pensar la coordinación como una función ética y clínica, encarnada en una práctica que habilita, escucha, contiene y transmite.

Entre bastidores: la trama silenciosa de la coordinación

La figura del coordinador en Acompañamiento Terapéutico suele quedar, en muchos discursos, reducida a una función operativa: se la asocia con la organización de horarios, el enlace entre profesionales, o la resolución de conflictos logísticos. Sin embargo, cuando se piensa al Acompañamiento como una práctica clínica situada, de orientación colectiva y con implicancias éticas, políticas e institucionales, la función de coordinación adquiere una densidad que desborda ampliamente lo administrativo. Coordinar no es simplemente gestionar. Es sostener un dispositivo.

Este capítulo se propone explorar en profundidad esa función: su dimensión clínica, su papel como terceridad simbólica, su responsabilidad en la construcción y sostenimiento del equipo, su lugar en la interlocución con las instituciones y en la lectura de la demanda. Desde la primera escucha que inaugura un Acompañamiento hasta las decisiones que permiten sostener su consistencia a lo largo del tiempo, el coordinador opera como un punto de anclaje: un lugar que organiza, pero también que escucha, que lee, que media y que representa.

A lo largo del desarrollo iremos diferenciando —sin disociar— las distintas capas de esta función: la logística como andamiaje necesario; la clínica como lectura, cuidado y orientación del lazo; la terceridad como posición estructurante; y la dimensión política e institucional como marco de legitimación y disputa. En todas ellas, la coordinación aparece como una práctica en sí misma, indispensable para que el Acompañamiento Terapéutico no pierda su potencia ni se diluya en la fragmentación.

La función de la coordinación en los equipos de Acompañamiento Terapéutico

En los dispositivos de Acompañamiento Terapéutico, donde la intervención se despliega en la vida cotidiana del acompañado y se apoya en un trabajo clínico distribuido entre varios agentes, la figura del coordinador emerge como pieza clave para sostener la dimensión colectiva del tratamiento. A diferencia de un modelo asistencial centrado en relaciones duales, el Acompañamiento Terapéutico encuentra en el equipo

su estructura fundamental. Pero este equipo no es una suma de intervenciones individuales: requiere una organización, una articulación simbólica y una orientación clínica sostenida en el tiempo. Allí, la coordinación no es sólo una función operativa, sino también una posición clínica e institucional que habilita, regula y preserva el dispositivo.

Un Acompañamiento Terapéutico no comienza cuando el acompañante cruza la puerta del domicilio o del dispositivo donde interviene. Comienza antes. Mucho antes. Comienza, de hecho, en ese primer llamado que suele llegar de forma inesperada, casi siempre urgido, muchas veces caótico. Una madre angustiada que no sabe cómo sostener más a su hijo. Un psiquiatra que percibe que algo en el tratamiento necesita apoyo en lo cotidiano. Una trabajadora social que, desde una obra social, intuye que se requiere presencia clínica allí donde las prácticas usuales no alcanzan. Ese primer contacto —telefónico, por mail o incluso por mensaje— inaugura el proceso clínico que nos ocupa, y es, de hecho, el primer momento donde se activa la función de la coordinación.

Lejos de tratarse de una tarea meramente administrativa o logística, la recepción de un pedido de Acompañamiento es ya una escena clínica. La escucha que allí se pone en juego es una escucha activa: interroga, articula, delimita. El coordinador, en su función, no responde mecánicamente a una demanda, sino que la lee, la interroga y la contextualiza. ¿Quién está llamando? ¿Desde dónde? ¿Qué representa en el entramado del paciente? ¿La solicitud surge como parte de una estrategia terapéutica o como último recurso ante una situación de crisis? Estas preguntas, lejos de ser formales, son el inicio de una operación clínica: permiten evaluar la pertinencia del dispositivo, su posible inserción en la red existente, y las condiciones para que efectivamente pueda llevarse a cabo.

Es esta una de las funciones iniciales —y estructurantes— del rol de coordinación. Releva las *Condiciones de acompañabilidad*, entendidas como el conjunto de factores clínicos, institucionales y logísticos que permiten evaluar si están dadas las condiciones necesarias para la implementación efectiva y sostenida del dispositivo de Acompañamiento Terapéutico. Es un momento clave, que no siempre se presenta con la solemnidad que merece.

Esta evaluación constituye una lectura compleja de la escena en la que se inserta la demanda, y requiere una posición ética y clínica por parte del coordinador. Releva las *Condiciones de acompañabilidad*

implica detenerse a mirar si hay un suelo donde pueda desplegarse la intervención.

El primer interrogante que orienta esta tarea es discernir si lo que se requiere —en función de la problemática subjetiva en juego, el contexto vincular y social del paciente, y lo que se espera de la intervención— es efectivamente un Acompañamiento Terapéutico. Este análisis no puede resolverse por la sola mención del dispositivo en una orden médica o en un pedido familiar. La demanda puede venir cargada de urgencia, de síntomas que desbordan, de escenas difíciles, pero no siempre eso implica que la respuesta indicada sea este dispositivo. Exige una lectura situada, que considere tanto la singularidad del padecimiento como la potencialidad del dispositivo para incidir sobre la trama en cuestión.

Una vez establecida la pertinencia del Acompañamiento, el siguiente paso es verificar si la demanda se inscribe en el marco de un tratamiento. Esto implica confirmar la existencia de un equipo tratante que no solo conozca la indicación del dispositivo, sino que esté en acuerdo con su implementación y dispuesto a articular con el mismo. Cuando no hay aún tratamiento —situación no infrecuente, especialmente en contextos de desborde o de externación institucional—, el coordinador tiene la tarea de orientar la propuesta en función de que se habilite un marco terapéutico. Es decir, que el Acompañamiento no se constituya como un recurso aislado o de contención circunstancial, sino que esté inserto en un proyecto clínico más amplio, capaz de alojar y sostener la intervención. La función del coordinador es ahí política y clínica a la vez: acompañar la construcción de un marco terapéutico que aloje el dispositivo antes de darle inicio.

Recuerdo una situación que ilustra bien este punto. Nos llamó la madre de Ezequiel, un joven de 17 años con un diagnóstico reciente de esquizofrenia. No había tratamiento aún, solo un alta reciente del hospital psiquiátrico y el pedido, más bien desesperado, de “alguien que lo acompañe, porque no podemos solos”. Durante la entrevista telefónica inicial, quedó claro que lo que pedían no era una suplencia familiar, ni una contención policializada, sino un lugar desde donde empezar a reconstruir una escena clínica. No había psicólogo, no había psiquiatra, no había dispositivos. Pero sí una disposición familiar que se sostenía con fuerza. A partir de allí, nuestra intervención como equipo fue triple: Explicar la necesidad de un marco terapéutico, acompañar a que contacten profesionales de referencia en la zona, una vez que vieron al paciente, contactar

desde la coordinación el nuevo equipo tratante, acordar las condiciones y los objetivos del dispositivo de Acompañamiento y luego habilitar el recurso para el paciente. En este sentido, lo clínico, lo logístico y lo institucional se entrelazaron desde el primer momento.

Además de estas consideraciones clínicas, el relevamiento de *Condiciones de acompañabilidad* requiere atender a aspectos concretos vinculados a la territorialidad y a la organización del dispositivo. ¿dónde se realizará el Acompañamiento? ¿En qué horarios? ¿La zona es accesible? ¿Es segura? ¿Hay medios de transporte viables? La zona geográfica donde se desarrollará el Acompañamiento debe ser accesible y segura para los profesionales. Esto no responde a una lógica de comodidad, sino a la necesidad de garantizar condiciones mínimas que posibiliten la presencia continuada del acompañante. En los casos en que la accesibilidad o la seguridad no estén dadas —por ejemplo, por cuestiones de distancia, disponibilidad de transporte o situaciones de violencia barrial—, es responsabilidad de la coordinación acordar con quien solicita el Acompañamiento las condiciones necesarias para habilitar la tarea (provisión de un remis, traslados seguros desde puntos de encuentro, coordinación de horarios diurnos, entre otros). No se trata de retraerse ante lo difícil, sino de pactar modos viables de estar.

El relevamiento de las *Condiciones de acompañabilidad* es, en definitiva, una lectura de posibilidad. Lejos de funcionar como un filtro excluyente, se trata de una operación clínica que busca abrir el campo de intervención bajo coordenadas que hagan viable el trabajo, sosteniendo al mismo tiempo la singularidad del caso y las condiciones concretas del acompañante. Es, en este punto, donde la función de coordinación pone en juego su potencia articuladora: tejer una red de viabilidad para que el Acompañamiento no solo sea posible, sino efectivo y éticamente sustentado.

En síntesis, evaluar las *Condiciones de acompañabilidad* es una praxis clínica compleja, donde el coordinador debe articular múltiples planos: el diagnóstico previo (si lo hay), la existencia o no de un equipo tratante, la claridad de la indicación, el consentimiento del paciente o, al menos, su inclusión simbólica en la escena del pedido. También se interroga la viabilidad material del dispositivo: horarios, distancias, posibilidades económicas, configuración familiar.

Una y otra vez, se ha señalado la importancia de este momento inaugural. Lejos de una mera entrevista de admisión, es el momento donde

comienza a desplegarse el dispositivo. El momento donde el coordinador, en soledad pero en nombre de un equipo, comienza a construir la posibilidad de intervención. Una posibilidad que, como todo en el campo clínico, siempre es tentativa, precaria y a construir, pero que requiere desde el inicio de una dirección clara.

Todo esto ocurre antes de que se haya asignado un acompañante. Es más: ocurre antes de que el Acompañamiento esté formalmente en marcha. Sin embargo, es ya una práctica clínica en sentido pleno. Esta etapa —a la que bien podríamos llamar “la fase previa”— define gran parte del tono, la estructura y las posibilidades de la intervención futura. Como en las primeras entrevistas de un psicoanálisis, se juega allí el encuadre, la posición subjetiva de los actores involucrados y la delimitación del campo de trabajo. Por eso decimos que el Acompañamiento no empieza con el at, sino con el coordinador. No se le da inicio con la presencia, sino con una escucha capaz de alojar el pedido, sin precipitarse a satisfacerlo.

Así, desde ese primer gesto clínico que es la escucha de la demanda, la función de coordinación comienza a trazar las coordenadas del dispositivo. Se trata de construir las condiciones simbólicas, materiales y afectivas para que el Acompañamiento sea posible. Es en esa trama donde el coordinador se vuelve una pieza estructurante, quien lejos de una figura jerárquica, se ubica como operador de sentido, mediador entre posiciones, sostén de la función. A partir de aquí, nos adentramos en las distintas dimensiones que esta función despliega a lo largo del tratamiento: su función organizadora, su lugar en la clínica, su rol como terceridad, su intervención en los lazos con la familia y el equipo tratante, y su incidencia en la economía subjetiva del dispositivo.

La organización del dispositivo: Funciones logísticas de la coordinación. El andamiaje previo a la clínica

Antes de que el Acompañamiento se ponga en marcha, luego de la “fase previa” pero antes incluso de que se produzca el primer encuentro entre acompañante y acompañado, se abre otro tiempo fundante del dispositivo que requiere un conjunto de tareas que, si bien no están teñidas aún por la dimensión clínica directa, resultan indispensables para su viabilidad. Se trata del momento en que el coordinador, una vez

recepcionada la demanda y valorada su pertinencia, pone en juego lo que podríamos denominar como las funciones logísticas de la coordinación.

Estas funciones constituyen el andamiaje estructural que hace posible el Acompañamiento. Implican un trabajo riguroso de organización que, aunque pueda parecer operativo o administrativo en la superficie, está profundamente ligado al sentido clínico y ético del dispositivo. No se trata simplemente de armar una grilla horaria, sino de tramar una estructura de presencia que, en su forma más elemental, permita a alguien ser acompañado.

En esta etapa, el coordinador dialoga con la familia y con el propio paciente, si es posible, para delimitar los ritmos de vida, los espacios de circulación, los intereses y restricciones. A la par, se comunica con el equipo tratante para comprender qué objetivos clínicos se esperan del Acompañamiento, cómo se articula con el resto del tratamiento y qué singularidades presenta el caso. Esta conversación, que muchas veces ocurre en tiempo real entre distintas fuentes de información, le permite al coordinador definir el encuadre inicial del dispositivo: cuántas horas se cubrirán, qué días, en qué franjas horarias, con qué acompañantes.

La convocatoria de los acompañantes, entonces, no es aleatoria. Se ajusta a la disponibilidad concreta de los profesionales, pero también —y sobre todo— a una lectura preliminar del caso, de su complejidad, de la transferencia posible y de la sostenibilidad del dispositivo en el tiempo. En este punto, la cantidad de acompañantes a convocar está directamente ligada a la cantidad de horas y bloques horarios a cubrir, pero también a una estrategia que no deje al paciente encerrado en una lógica dual, ni diluya el lazo con una rotación excesiva.

También se definen aquí las condiciones de trabajo: modo de pago, viáticos, criterios de cobertura de gastos. El coordinador funciona como mediador de estas condiciones, evitando que recaigan sobre los acompañantes cuestiones que podrían interferir en el lazo clínico o en la ética del dispositivo. Esta delimitación previa permite que el tratamiento se inicie en condiciones de mayor claridad y resguardo para todos los actores implicados.

Puede decirse que, en este primer tramo, el coordinador trabaja antes de la clínica, pero no fuera de ella. Porque si bien aún no se están leyendo escenas ni interviniendo sobre el padecimiento, se está construyendo la arquitectura simbólica y material que permitirá que algo así como un lazo clínico acontezca. Sin este trabajo silencioso y paciente, no habría

Acompañamiento posible. O, peor aún, lo que se produciría sería un Acompañamiento desorganizado, disperso, precario en su estructura, y por lo tanto, clínicamente inconsistente.

A medida que el dispositivo se pone en marcha y se asientan las relaciones entre el paciente y los acompañantes, comienza a desplegarse otra dimensión de la función del coordinador: la que implica una lectura del caso, una escucha del proceso, una intervención sobre el sentido clínico de lo que acontece. Es entonces cuando la coordinación transita de sus funciones logísticas hacia su fase plenamente clínica. Pero ese pasaje no es un corte. Es una transición que se sostiene, justamente, en la solidez del trabajo organizativo previo.

Si bien aquí hemos diferenciado una primera fase de funciones logísticas de la coordinación, esta distinción es útil solo a fines analíticos. En la práctica concreta de los equipos, ambas dimensiones —la logística y la clínica— conviven de manera permanente y se articulan en forma dialéctica a lo largo de todo el tratamiento. Habrá momentos donde la urgencia organizativa demande mayor energía —cambios de horario, reemplazos, conflictos familiares o cuestiones administrativas— y otros donde el foco esté puesto en la lectura clínica del caso, en la conducción del equipo o en la orientación de las intervenciones. Pero lo cierto es que no existe una coordinación “solo logística” ni otra “puramente clínica”. Toda intervención del coordinador —incluso aquella que parece meramente operativa— tiene efectos clínicos. Y, del mismo modo, toda decisión clínica debe traducirse en un modo de organizar la estructura del dispositivo. En ese movimiento constante entre sostener y pensar, entre gestionar y leer, se despliega el corazón mismo de la función de coordinación.

La dimensión clínica de la coordinación: la gestión del equipo y la lectura del dispositivo

La dimensión clínica de la coordinación tiene como uno de sus ámbitos de expresión, el modo en que se sostiene y gestiona la vida del equipo. Toda práctica compartida en torno al padecimiento psíquico moviliza —inevitablemente— afectos, identificaciones, fantasías. La convivencia con el padecimiento psíquico, con lo que desborda o desorganiza, no es neutral: toca a quienes acompañan, los atraviesa, los expone. El grupo de acompañantes, en tanto colectivo clínico, no está

exento de reproducir escenas que también circulan en los tratamientos: rivalidades sutiles o explícitas, proyecciones, posiciones subjetivas que tensionan el lazo entre colegas. En ese escenario, el coordinador sostiene una función delicada: centrar la tarea, contener el malestar, alojar los relatos del cotidiano —ese “anecdótico” que tantas veces opera como válvula de escape— sin perder de vista el marco clínico. Las rotaciones de horarios, los pedidos de cambio, los desacuerdos internos, encuentran en la figura del coordinador un lugar donde tramitarse y reorientarse. Porque si el equipo se fragmenta, si las diferencias no logran simbolizarse, el dispositivo se debilita. Y si el deseo de los acompañantes se apaga, también lo hace la potencia del Acompañamiento.

Por otro lado, la dimensión clínica de la coordinación se despliega en la mirada sobre la escena. Es una mirada distinta a la del acompañante, pero no externa al dispositivo. El coordinador no es un supervisor externo ni un mero organizador. Está implicado en el caso, forma parte del dispositivo, pero su posición le permite una distancia relativa que habilita una lectura del conjunto. Mientras el acompañante se sumerge en la cotidianidad del vínculo, en la inmediatez de lo que acontece —y muchas veces en la intensidad afectiva que eso implica—, el coordinador puede leer desde otro lugar: observa las escenas que se repiten, escucha las resonancias transferenciales, identifica los desplazamientos o estancamientos del proceso. Su función no es intervenir en el uno a uno, sino sostener la estructura que permite que ese uno a uno tenga sentido.

Esa mirada clínica se vuelve particularmente valiosa cuando se producen situaciones de ambigüedad, desborde o malestar entre los actores involucrados en el tratamiento. El coordinador funciona entonces como lugar de apelación, como punto de anclaje para los acompañantes, pero también como operador clínico capaz de intervenir simbólicamente en la escena. A veces para habilitar un cambio, otras para detener una deriva, siempre para sostener la consistencia del dispositivo.

En esa línea, podríamos decir que la coordinación sostiene una posición clínica de terceridad.

La función de terceridad: una posición que habilita lo simbólico

Dentro del entramado clínico de la coordinación, hay una función que resulta especialmente relevante por su carácter estructurante: la de terceridad. Lejos de ser una intervención ocasional o excepcional,

la terceridad del coordinador constituye una operación constante, que atraviesa toda la vida del dispositivo de Acompañamiento Terapéutico. Es, en cierto sentido, la condición de posibilidad para que el lazo clínico entre paciente y acompañantes no derive en una escena cerrada, especular y asfixiante.

Desde el psicoanálisis, sabemos que cuando una escena se sostiene exclusivamente en el eje imaginario —entre un yo y un otro, sin mediación simbólica— se corre el riesgo de la repetición estéril, la confrontación o la fusión. En el caso del Acompañamiento Terapéutico, esta lógica puede volverse especialmente densa, ya que se trata de una práctica que trabaja en lo cotidiano, que se mete en la vida misma, que transcurre en escenarios poco ritualizados. Allí, el acompañante queda expuesto no sólo al padecimiento del otro, sino también a sus exigencias, a sus rechazos, a sus afectos. Es decir, a ser ubicado como salvador o como enemigo, como hermano, madre, vigilante, obstáculo o ideal. En esas situaciones donde la escena tiende a cerrarse entre el paciente y el acompañante —ya sea por identificación, confrontación o pasaje al acto—, el coordinador introduce una referencia simbólica que permite desalojar lo imaginario y abrir la escena a otros sentidos. Introduce un tercero que no es “un otro más”, sino una posición simbólica que desalienta la cristalización de roles imaginarios. Se trata de una función estructurante: habilita una lectura compartida, sostiene la transferencia múltiple que todo dispositivo con varios agentes implica, y garantiza la circulación en el tratamiento.

Es un hecho que la clínica del AT se despliega, muchas veces, en un uno a uno que, si no está sostenido por una instancia tercera, puede derivar en zonas de tensión especular. Pensemos en una situación habitual: un paciente que se niega a tomar la medicación, y un acompañante que insiste desde la indicación médica. El no del paciente y el sí del acompañante giran sin salida. Si no hay una intervención que organice esa tensión, la escena corre el riesgo de degradarse en una disputa circular, donde ambos quedan atrapados. Si nadie más interviene, si no hay otro que escuche, lea y se haga cargo de esa tensión, la relación puede empantanarse en una rivalidad sin salida. La intervención del coordinador —que no siempre es directa— permite desplazar la lógica binaria hacia una dimensión simbólica: pone en palabras la escena, la ubica en el marco de una indicación, reubica al at en su función, y muchas veces puede incluso reinterpretar la negativa del

paciente como una producción subjetiva y no sólo como una resistencia. No se trata de garantizar la obediencia del paciente, sino de sostener condiciones para que el acompañante no se ubique como único portador de la indicación y, por ende, del fracaso. Es en este tipo de situaciones donde la clínica de la coordinación se vuelve más visible: cuando interviene para restituir un marco simbólico, para sostener una posición, para alojar una dificultad sin que se transforme en ruptura.

La terceridad también se vuelve fundamental cuando aparecen conflictos con la familia. En los Acompañamientos, es frecuente que las demandas familiares se entrecrucen con las del paciente, o con las del tratamiento, y que el acompañante quede en el medio. Muchas veces, quien coordina debe interceder para que esas exigencias no recaigan directamente sobre los acompañantes, y evitar que se activen escenas donde el at quede atrapado entre los deseos familiares y el cuidado del paciente. En esas ocasiones, se delimita qué corresponde al acompañante y qué no, qué se puede escuchar y qué debe tramitarse por otra vía. El coordinador funciona como mediador: escucha, aloja, traduce y delimita. Sabe que muchas de las demandas familiares —incluso las más razonables— pueden estar en tensión con los intereses del paciente, y que esa tensión no debe recaer sobre la figura del acompañante. Entonces interviene, no para anular la voz de la familia, sino para ponerla en diálogo con el marco clínico que orienta la intervención. La coordinación aloja esas tensiones, las traduce en términos clínicos y las articula a una estrategia. De este modo, se evita que el acompañante sea absorbido por roles que no le corresponden, y se protege la integridad clínica del dispositivo.

Otro escenario habitual en el que la función de terceridad se hace visible es la dinámica interna del equipo. Los dispositivos de AT implican siempre una multiplicidad de actores. La transferencia, entonces, no se deposita de forma homogénea. Hay acompañantes más convocados, otros más rechazados, hay vínculos más fluidos, otros más complejos. Aparecen transferencias positivas y negativas, idealizaciones, desplazamientos, incluso rechazos. El coordinador, en su función de terceridad, no busca forzar una homogeneidad ni eliminar las diferencias transferenciales, sino justamente habilitar su lectura. Escucha lo que se juega en cada vínculo, sostiene la función de cada at, y protege al equipo de la fragmentación que puede surgir cuando esas diferencias no encuentran marco simbólico. De este modo, evita la expulsión impulsiva y permite sostener la continuidad del dispositivo.

Finalmente, también ante el equipo tratante la terceridad cumple un papel clínico y estructurante. Busca garantizar una lógica común: que las indicaciones clínicas lleguen a todos los acompañantes del equipo del mismo modo, que circulen de manera clara y unificada, que la lectura del caso no se fragmente en relatos inconexos. Es habitual que las indicaciones lleguen desordenadas, con información parcial, o incluso contradictoria. El coordinador organiza esa información, la distribuye, la resignifica. No traduce mecánicamente, sino que orienta: toma lo que llega de los otros profesionales y lo convierte en una lógica común, en un encuadre que los acompañantes puedan sostener. Sin esa función, el dispositivo se vuelve errático, cada acompañante opera según su interpretación, y se pierde la dirección del tratamiento. Esta tarea, a veces invisibilizada, es fundamental para que el Acompañamiento no se transforme en un archipiélago de escenas aisladas, sino en una práctica con continuidad, orientación y sentido. Los informes se estandarizan, las intervenciones se enmarcan, y se mantiene una lógica clínica común que no aplasta las diferencias de estilo, pero evita la dispersión sin sentido.

En todos estos planos —con el paciente, con la familia, con los acompañantes, con el equipo tratante—, la función de terceridad no se define solo por su lugar en el dispositivo, sino por lo que logra operar simbólicamente. El coordinador no es un observador externo: es parte del dispositivo, pero en una posición que habilita el movimiento, que introduce diferencia, que sostiene una lectura. Es un tercero que no se impone, sino que se hace lugar. Que no ordena desde arriba, sino que organiza desde una posición ética, clínica y política.

En este sentido, podríamos decir que la terceridad del coordinador no es un lujo, ni una forma de control, ni una delegación técnica. Es una necesidad estructural de todo Acompañamiento que se piense como práctica clínica con orientación colectiva. Sin esa terceridad, el dispositivo corre el riesgo de replegarse en lógicas binarias, fragmentarse o derivar en intervenciones meramente asistenciales.

La función política e institucional de la coordinación

Hablar de la función política e institucional del coordinador en Acompañamiento Terapéutico implica salir del dispositivo en su microescala —la relación paciente-acompañante-coordinador— y situarlo en

el entramado más amplio en el que se inscribe: el sistema de salud, las políticas públicas, las lógicas institucionales, los marcos legales, los discursos dominantes sobre el padecimiento y la intervención. Porque, como sabemos, ningún tratamiento se realiza en el vacío. Y mucho menos un Acompañamiento, que por su propia estructura se despliega en territorios compartidos, entre familias, profesionales, escuelas, hospitales, juzgados, obras sociales.

El coordinador, en tanto figura que representa al dispositivo ante esos otros actores, ocupa un lugar político clave. Es quien responde por el equipo ante la familia y ante el sistema de salud; es quien argumenta la pertinencia del dispositivo cuando es requerido por una obra social, quien inscribe el Acompañamiento dentro de un proyecto clínico más amplio cuando hay que rendir cuentas ante un juzgado o una auditoría. Esta función de representación no es menor. Requiere una lectura institucional fina, una capacidad de traducción entre lenguajes (clínico, jurídico, administrativo), y una posición ética clara: no ceder en los fundamentos del dispositivo, pero saber negociar sus formas en contextos donde muchas veces prima la lógica del control o la desconfianza.

Por eso decimos que el coordinador no es sólo un organizador interno del equipo, sino también un interlocutor institucional. Y esa interlocución está atravesada por disputas de sentido. Porque el Acompañamiento Terapéutico, cuando se sostiene en su especificidad clínica y en su perspectiva de derechos, desborda los marcos tradicionales. No es terapia en consultorio, pero tampoco es cuidado domiciliario. No es asistencia ni simple compañía. Es una práctica que desarma binarismos, que entra en zonas grises, que propone un tipo de presencia no controlada, no medicalizada, no normalizadora. Esa ambigüedad, que es su potencia, es también lo que muchas instituciones no saben cómo alojar.

El coordinador, entonces, debe sostener la legitimidad del dispositivo en esos escenarios. Argumentar por qué se necesitan varios acompañantes, por qué se trabaja en equipo, por qué no se puede garantizar “resultados” en términos de eficiencia, pero sí se puede construir un proceso sostenido en la singularidad. Debe defender las condiciones mínimas de trabajo digno para los acompañantes, evitar que se impongan criterios de control externo que atenten contra la clínica, y, en algunos casos, incluso rechazar intervenciones que se pretendan “acompañamientos” pero que sólo replican lógicas de vigilancia o contención sin proyecto terapéutico.

A su vez, la función política del coordinador se juega también hacia adentro del equipo. El modo en que se organiza el trabajo, la distribución de los horarios, el reconocimiento de las tareas, la conducción de las reuniones, la gestión de los conflictos, son también escenarios donde se decide qué equipo se quiere construir. Un coordinador que habilita la palabra de los acompañantes, que escucha las tensiones sin deslegitimárlas, que no se posiciona como autoridad vertical sino como referente ético y clínico, está ya haciendo política. Está construyendo un equipo como espacio de trabajo colectivo, en oposición a una mera yuxtaposición de funciones.

Por último, la función política se entrelaza con la historia más amplia del Acompañamiento Terapéutico como práctica surgida desde los márgenes, con una fuerte impronta crítica frente al encierro, la exclusión y el desamparo. El coordinador, en tanto figura que representa y organiza, no puede desentenderse de esa historia. Su función no es sólo clínica o administrativa: es también sostener la orientación de una práctica que se posiciona a favor de la vida en la comunidad, de la construcción de lazo, de la desmanicomialización y de una clínica que no se rinde al formato institucional hegemónico. Incluso cuando —y sobre todo cuando— trabaja dentro de las instituciones.

En este sentido, cada decisión que toma el coordinador es también una apuesta política. Desde cómo organiza una rotación hasta cómo responde a una demanda externa. Desde cómo habilita el debate clínico hasta cómo redacta un informe. La coordinación, cuando no se limita a gestionar sino que se asume como función ética, clínica e institucional, es una de las garantías de que el Acompañamiento Terapéutico no pierda su potencia subversiva, su orientación subjetivante, su fuerza transformadora.

A modo de cierre: coordinar es sostener un dispositivo con orientación clínica, política y colectiva

A lo largo de este capítulo, nos propusimos desarmar la idea, demasiado extendida, de que la coordinación es una función auxiliar, meramente organizativa, o una tarea de gestión que sucede “al margen” de la clínica. Por el contrario, mostramos cómo en el Acompañamiento Terapéutico —cuando se lo concibe como una práctica colectiva con orienta-

ción ética— la coordinación es una función central, sin la cual el dispositivo pierde espesor simbólico, coherencia clínica y legitimidad institucional.

Desde el primer llamado en que una demanda se expresa, el coordinador comienza a intervenir. Lo hace con una escucha atenta, que no se limita a recepcionar datos, sino que comienza a construir un encuadre. Define disponibilidad, compatibiliza horarios, conversa con los tratantes, elige perfiles de acompañantes. En esta etapa, las funciones logísticas no son accesorias: son el andamiaje que permite alojar la singularidad de un sujeto dentro de una estructura que haga posible el tratamiento.

Pero el trabajo del coordinador no se reduce a ese momento inicial. A medida que el Acompañamiento avanza, la función de coordinación se despliega también en su dimensión clínica: sosteniendo el lazo, orientando las intervenciones, alojando el malestar de los acompañantes, escuchando las escenas repetidas, evitando los efectos de clausura que se producen cuando no hay una terceridad que habilite la circulación simbólica. Allí, el coordinador opera como un tercero estructurante, capaz de abrir la escena tanto en el vínculo entre paciente y acompañante como en los otros lazos del dispositivo: con la familia, con el equipo tratante, con el propio grupo de acompañantes.

En todos estos niveles, coordinar implica leer, escuchar, intervenir, sostener. Y también resistir: resistir la lógica de la eficiencia, del control, del individualismo que tantas veces las instituciones intentan imponer al Acompañamiento Terapéutico. Por eso decimos que la función de coordinación no es solamente clínica, sino también política e institucional. Es quien representa al equipo ante las instituciones, quien disputa sentidos, quien legitima el dispositivo cuando es cuestionado, quien defiende condiciones dignas de trabajo y quien articula una práctica profesional con una orientación ética clara: a favor del lazo, de la comunidad, de la posibilidad de construir otras formas de tratamiento.

Coordinar, entonces, es mucho más que organizar: es sostener una trama, habitar un lugar de responsabilidad simbólica, mediar entre discursos, alojar tensiones, cuidar al equipo, y al mismo tiempo mantener viva la orientación clínica del dispositivo.

Por todo esto, en los equipos que se piensan como tales —no como sumatoria de trabajadores independientes, sino como colectivos clínicos con un proyecto común— la coordinación no es un accesorio, ni un lujo. Es una necesidad estructural. Una posición clínica, política y ética que,

cuando está bien sostenida, se vuelve invisible: porque hace que todo funcione, que cada uno pueda ocupar su lugar, que el dispositivo tenga dirección. Pero cuya ausencia o mal ejercicio, por el contrario, desorganiza, fragmenta y, muchas veces, deslegitima todo el trabajo clínico realizado.

Coordinar, en suma, es cuidar que el Acompañamiento Terapéutico pueda ser lo que promete: una práctica de presencia encarnada, una apuesta por el lazo, una intervención situada en lo real del padecimiento, sostenida por un equipo, y orientada por el deseo de que algo pueda transformarse.

Capítulo 7

LA EXPERIENCIA DE COORDINACIÓN

Introducción al caso J

Coordenadas clínicas de una función sostenida a distancia

Hay experiencias clínicas que, lejos de confirmar los esquemas conocidos, los tensan hasta sus bordes más frágiles. El caso de J, relatado por Rodrigo Santillán, no solo pone en escena los desafíos de acompañar un tratamiento atravesado por una construcción delirante compleja, sino que permite pensar con claridad quirúrgica los límites y potencias de la coordinación como función clínica en el Acompañamiento Terapéutico.

A lo largo de más de ocho años, y con más de sesenta acompañantes implicados, lo que se sostiene —paradójicamente— no es una presencia estable, sino una lógica de funcionamiento: una función acompañante que se encarna en el recambio constante, y una función de coordinación que, a condición de mantener una distancia simbólica, se vuelve tolerable para el paciente y estructurante para el dispositivo.

En un contexto donde cualquier intento de normativización corre el riesgo de volverse persecutorio, la coordinación aparece como el único punto de constancia. Una presencia simbólica cuidadosamente distanciada, mediada por otros (una hermana, un at, un “jefe supremo”), que permite al paciente sostener su armado subjetivo sin clausurar el vínculo terapéutico. Es J quien impone las reglas del lazo, y es el dispositivo el que se deja enseñar por esa lógica, sin resignar por eso su orientación clínica.

Este testimonio no narra un caso exitoso en los términos habituales. No hay resolución, ni integración social, ni estabilización convencional. Lo que hay es una invención: una pragmática del lazo, una ingeniería fina de funciones separadas de las personas, un dispositivo que se

acomoda sin ceder su orientación. En esta arquitectura inestable pero eficaz, la coordinación se vuelve posible porque sabe retirarse. Y es ese gesto —el de no ocupar todo el lugar del Otro, el de sostenerse incluso en el yerro, el de encarnar una función más que una figura— el que permite alojar lo que de otro modo no tendría lugar.

Sobre la función Coordinación y la función acompañante en un caso de esquizofrenia

Rodrigo Santillán

J es un paciente de cincuenta y tantos. Su psicosis se ha desencadenado a temprana edad y ha transitado por distintas institucionalizaciones, la última de las cuales aconteció poco mas de un año antes de que comenzáramos el Acompañamiento; pasando luego por un Hospital de Día hasta que cuestiones burocráticas fuerzan un alta temprana, y J se va aislando cada vez más, hasta casi no salir de su domicilio.

A partir de entonces el tratamiento psiquiátrico no termina de establecerse, a J no parece interesarle; él tiene “su tratamiento”. En un intento de restituir un mundo en el que él pueda tener un lugar, va consolidándose un delirio que, pese a ciertas variaciones en el contenido, permanece estable en su estructura, “hay que hacer lo que se debe y no lo que se quiere”. Esta fórmula lo enlaza al mundo de un modo particular, ya que por momentos le exige sacrificios importantes acordes a la gran responsabilidad asignada: “salvar al mundo”.

Dentro de las voces que le hablan y hacen tantos milagros en él, hay personajes engañosos que le hacen o pueden hacer cosas dañinas. Las amenazas son muchas, y va encerrándose en su casa cada vez más frente a los posibles atentados que misteriosas máquinas podrían perpetrarle. Sobre todo en el afuera. Este replegamiento viene también alimentado por infructuosos intentos de otra época en compartir las revelaciones adquiridas, la verdad de un mundo sin sufrimiento. En esos tiempos, por ejemplo, imprimió y repartió folletos sobre lo terrible de comer carne (cadáveres decía) y las terribles consecuencias que esto traía. Pero no le era posible encontrar el eco acorde a sus verdades, armar una causa común, por lo que parece haber decidido salvar al mundo solitariamente.

En el inicio, El límite- la regulación

Comenzamos este Acompañamiento solicitado por la hermana del J, M, luego de un episodio de descompensación clínica que padece J. una médica le dijo a M que “ya no podía estar solo”, frase que para M fue una sentencia. Inicialmente una vez por semana hasta que luego por la gestión de M se logra instalar un esquema de 12 horas diarias todos los días de la semana, reemplazando a un equipo de cuidadores domiciliarios que la obra social había contratado, pero que reclusos en la pequeña cocina del pequeño monoambiente, pasaban 12 horas por día leyendo unas revistas viejas para pasar el tiempo.

Comenzamos el Acompañamiento con este panorama: J pasa el día recostado o sentado en su cama, inmerso en su mundo poblado de fenómenos alucinatorios, interceptaciones del pensamiento, manierismos etc.; dignos de un manual de psiquiatría. Es un mundo con reglas que no conocemos ni quiere compartir. Los ats se limitan a estar, a participar de algunos ceremoniales extraños que J exige y no explica. Eso que a él se le impone, lo impone a su vez a sus acompañantes.

J toma medicación psiquiátrica y clínica, indicada alguna vez por algún psiquiatra, pero las cantidades las maneja a discreción, consiguiendo recetas de algún psiquiatra de turno y ocultando la toma de la medicación a la injerencia del Acompañamiento. No permite cambio alguno en su esquema y es evidente el exceso de benzodiacepinas que ingiere.

El tipo de alimentación y la cantidad de líquido que bebe son preocupantes, incluso para la salud de los acompañantes, que se ven compelidos a compartir la comida ya que es uno de los pocos momentos donde le es permitido a J interaccionar con los mismos; por fuera de esto se encuentra ocupado, en actividades reservadas.

Ante este cuadro de situación se vuelve imperioso cierto ordenamiento de los aspectos regulatorios de su vida. En primera lugar se apuntó al establecimiento de una instancia de tratamiento más clara y con la cual poder dialogar. Es así como luego de varios intentos con distintos psiquiatras se logrará que J acceda ir con un psiquiatra que ya lo atendió en algún momento.

Dentro de los recursos de que dispone J logra armar un personaje para el mundo del afuera de su casa. Sabe que sus actividades secretas no son compatibles con el mundo que le rodea, sabe también qué le

conviene decir, o mejor no decir, aunque a veces ese personaje no alcance para contener los fenómenos que lo habitan, pero hace un gran esfuerzo acorde a la necesidad de tal o cual tarea externa, y la consulta con el psiquiatra no es la excepción.

Luego de varios encuentros J les pide a los ats que ingresen a las sesiones, parece necesitar una especie de escudo protector frente a ese encuentro. Buscará también el asentimiento del acompañante cuando le sea solicitado dar cuenta de lo que hacía en su día a día, realizando un estratégico y a veces pueril dibujo de actividades que realizaba con sus ats (ejemplo de esto es que se bajara del taxi y corriera 20 metros hasta llegar a la puerta del consultorio y al relatar las actividades de la semana dijera, mientras miraba a su compañera de carreras, que salían a correr). Esta verdad a medias permitía al at un lazo posible, incluso fue desembocando en el armado previo de un texto a ser relatado en sus sesiones. El at le preguntaba antes de ingresar “que hicimos en la semana” y juntos armaban esa verdad a medias.

En las comunicaciones con el psiquiatra de estos aspectos que nos preocupaban de J y que no aparecían en el territorio de las sesiones, nos refiere que necesitaba que sea el acompañante quien denuncie las mismas, ya que en las sesiones el acompañante “no decía nada” y J no le comentaba ni quería hablar con él de estas cuestiones.

En un momento y ante las dificultades que representaban estos aspectos desregulados: el incremento de fenómenos alucinatorios, el aislamiento, como así también algunos pedidos extravagantes que nos interrogaba respecto a una tarea terapéutica posible (como estar acostados en el piso con la corriente de la casa desconectada y a oscuras, a una distancia equidistante de las llaves de luz que emitían rayos peligrosos) nos vimos en la necesidad de acceder al pedido del psiquiatra. Pero no accedimos a que sea el acompañante quien comente nuestra preocupación, sino que sea el coordinador en el marco de reuniones entre los tratantes, el paciente y el familiar.

Tal como pensamos la función de la coordinación, tenía que lidiar con las diversas demandas para así permitir al acompañante continuar con un vínculo amistoso, y no horadar esta función de escudo de la que J parecía servirse. Entonces fue la coordinación quien a la distancia necesaria de algunas reuniones cada tanto, y cargando sobre si cierta regulación que considerábamos necesaria, planteamos en ese espacio nuestra preocupación.

El riesgo evidente era que el coordinador se transformase en un Otro intrusivo del que la literatura psicoanalítica nos advierte para con la psicosis; pero ante la encrucijada, que fuera el coordinador nos parecía que permitía al acompañante continuar en la función que J les asignaba (J se llamaba el salvador, o el mas santo de todos los santos en algún otro momento; en una ocasión que algún at le preguntó para que estábamos nosotros, dijo que éramos “sus ángeles guardianes”), y si... para J nuestra presencia significaba que no lo internarían, y como dijo alguna vez, si lo internaban era el fin del mundo.

A esas alturas J pasaba gran parte del día recostado en una cama frente al acompañante, a veces durmiendo, pero generalmente “trabajando” en misteriosas actividades, ya sea pidiendo por la paz, interconectado a distancia con otras personas con quienes dialogaba, o haciendo movimientos para calibrarse con la “machine”, (una especie de computadora del tamaño de dos habitaciones creada por Jesús según dijo, y con la cual mantenía cierto equilibrio necesario al mundo). Pero básicamente nuestras propuestas de actividades o dialogo eran cordialmente rechazadas, salvo en alguna comida o merienda ocasional. J parecía no disponer de ese tiempo, tenía que hacer lo que le decían, incluso cuándo y en qué cantidad de tiempo ir al baño.

En dicha reunión, en algún momento de mi pequeño relato, digo que nos preocupaba la gran cantidad de tiempo que J pasaba acostado durmiendo, a lo que J interviene como aquel que se siente difamado corrigiéndome “estoy recostado, no durmiendo”. Semejaste difamación tendrá sus consecuencias, poniendo una distancia con la coordinación que parecía insalvable a partir de entonces.

Este camino elegido tal vez fuera necesario, pero seguramente errado en su forma. No me refiero a la “difamación” solamente, sino que nuestra preocupación forzaba una cercanía que quebrantaba una distancia con la coordinación que parecía serle necesaria.

Los acompañantes con J, la hermana con el coordinador

Empecé a entender que para J el coordinador es un otro que él mantiene a una distancia que le permite continuar con un vínculo posible. En este sentido generalmente no estaba disponible cuando intentaba comunicarme con él y utilizaba a su hermana o a alguno de

sus acompañantes para comunicarme sus decisiones respecto a quien podía acompañarlo y quien ya no; o también para pedir que se fueran antes ya que estaba lloviendo o era riesgoso si permanecían.

J propone la distancia que necesita. En este sentido ha sucedido que al no querer que vaya una acompañante al día siguiente le dice a la at que lo acompaña que me diga como cosa de ella que vaya tal acompañante, y al preguntarle porque no se lo decía directamente al coordinador dirá “no quiero que piense que yo le digo lo que tiene que hacer”.

M es la hermana de J, al inicio del Acompañamiento vive en otro departamento del mismo edificio y trabaja en una oficina de secretaria. Para ella lo que le pasa a J transita por explicaciones de las más diversas y extravagantes, justificando todo aquello que padece J. Ha tomado a su cargo a su hermano y su misión es ser su “curadora”, al punto de descuidar su trabajo hasta perderlo, e irse a vivir con su hermano al monoambiente donde vivía este, sometién dose a las exigencias más locas de J respecto a lo que puede o no hacerse en la casa.

Esta proximidad propia de una locura de a dos (*folie a deux*) parece profundizar el malestar de ambos. Aunque J soporta la vecindad de M, esta última va adquiriendo características maliciosas. Denuncia con razón el doble discurso de M, y las mentiras que su gozosa posición sostiene, ya que si bien denuncia a escondidas las locuras de J y exigía al Acompañamiento que intercediera al respecto, también se sometía voluntariamente a los extraños rituales que J requería a quienes estaban con él en su domicilio.

Las exigencias de M respecto a las actividades, controles médicos y varios etcéteras que J debería realizar, se sostienen en una idealización de las capacidades extraordinarias, tanto deportivas como intelectuales, que le adjudica; pero distan mucho de las posibilidades de J. La desazón que le provoca el padecimiento de J se traduce en una posición querellante hacia los tratantes. Nos responsabiliza de las dificultades sociales de J y de su reticencia por realizar lo que ella considera necesario para su salud según la “ley” establece. Amenaza constantemente con recursos judiciales que atentan contra los recursos terapéuticos de los que sí se sirve J. En varias oportunidades le propone a J cambiar de equipo de ats, de médicos etc, y es J quien dirá que no, aun cuando por momentos se le vuelva intrusivo la presencia de los ats, e incluso la coordinación, es él el que sostiene su tratamiento.

M es su “curadora”, y la impotencia por no poder “curar” a su hermano la enferma; al punto de deteriorarse su salud, su situación económica y hasta cultural. Se siente obligada a estar con él. En esta situación ambos parecen enloquecer cada vez más.

Nuevamente es J quien nos muestra el camino de un Acompañamiento posible, pidiéndole a M que se encargue de sus asuntos con la coordinación. Es así como las comunicaciones constantes con M se transforman en reuniones entre el coordinador y M, en las que podrá ir manifestando todas sus disconformidades con el equipo, con los psiquiatras, la obra social etc. La función de la coordinación ocupará el lugar de alojar sus peticiones y teorías sobre el malestar de J, intentando consensuar algunas posibles estrategias en las que pueda incluirse, y direccionándola hacia un afuera de su aislamiento enfermizo con J.

La intervención se sostiene en la distancia que J sabe que necesita para un vínculo no tan intrusivo, tanto con M como con la coordinación. Los efectos son varios, M retoma alguna de sus actividades sociales, permitiendo al at sacarse un poco de encima la marca personal que M les imprime y que dificulta la tranquila presencia del at que J necesita; habilitando un decir de J que de otro modo es obturado. Ejemplos de esto es que J compartiera alguna breve actividad o dialogo con el at, y que cuando escuchaba que llegaba M interrumpiera y se zambullera en la cama pidiendo silencio.

La sexualización de los vínculos

La presencia del at ha tenido distintos matices afectivos para J, los motivos por los que necesita de un recambio constante de acompañantes son diversos: “tiene ojos de demonio”, “el novio me dice que está celoso”, “todo lo que toca lo contamina”, “cuando estaba hizo tal o cual cosa y yo vomite”, “me dicen que es mala persona”, “sacó la lengua como una serpiente y toco mi vaso”, “su nombre no está bendecido”. O más generales como ser que “EEUU nos iba a invadir” etc., etc.

Los intentos por problematizar estos postulados, apelando al buen vínculo que tenía con tal o cual at eran infructuosos. Nuestra intención era que J pudiera tensionar esa obediencia acérrima a lo que “le decían” esas voces, ya que él mismo sostenía que a veces eran “engañosas”, que había infiltrados que podían querer hacerle mal.

Inicialmente desde la coordinación me resistía a desarmar y rearmar el equipo constantemente, intentando convocar alguna legalidad (indicación de su tratante, del juzgado etc.) que compitiera con la autoridad de sus voces (ya que no siempre él estaba de acuerdo con quien tenía que irse, decía que le gustaría que siguiera tal o cual pero que “no se podía”). A lo sumo aceptaba que permaneciera un tiempo con los recaudos necesarios (no tocar las cosas, no comer con él etc.), pero solo incomodaban aún más su situación y nos confirmaba cada vez lo ineficaz de insistir, por tal o cual acompañante, ante esta inamovible posición.

Es así como dejamos de insistir, entendiendo que la función del acompañante podía permanecer más allá de quien la encarnara cada vez. Podríamos decir que la función acompañante se sostenía en tanto se lograba independizar de quien la encarnara, lo que permitía a J sostener un lazo social posible, aunque implicara que quien la habite lo hiciera temporalmente.

En este contexto el acompañante será aquel con quien vaya pudiendo compartir cada vez más cosas, incluso de su mundo interior. Es así como en distintos momentos el at se prestará a compartir prácticas que se le vuelven necesarias a J: la lectura de una oración que inventa, pedir por la paz, no llevar determinados colores a su casa, no usar palabras en otros idiomas, etc.

Estas actividades van incluyendo al acompañante pero respetando su limitación, la del acompañante, respecto del entendimiento como de su hacer (el at podía acompañarlo en algunas prácticas siempre y cuando se respetaran ciertos límites. Sostener la distancia entre respetar su delirio y delirar con él). Una función que se va delimitando y de la cual va haciendo uso, delineando un modo de lazo que permite cierta convivencia posible. Pero por otro lado esa presencia en su cotidiano, aunque reducida a su mínima expresión (ya que cada at iban una o dos veces por semana como máximo, lo que implicaba un equipo de al menos 10 personas para cubrir los horarios) se tornaba amenazante más tarde o más temprano, requiriendo el recambio constante de acompañantes al dispositivo.

A modo de conclusión un nuevo inicio: la función acompañante y la función coordinación

Varias preguntas surgen de este caso como de otros:

¿Que hace al Acompañamiento permanecer cuando otras instancias de tratamiento van rotando? , En J han desfilado innumerables tratantes, como dirá Freud respecto de Schreber, “procuran defenderse de una sexualización así de sus investiduras pulsionales sociales”, los vínculos se le sexualizan y adquieren características que finalmente transitan algún tipo de amenaza a su ser.

¿Por qué entonces ha mantenido la coordinación incluso a pesar de las situaciones relatadas? Es en este punto donde pienso que J ha sabido inventar una función, aquella que le permite mantener la distancia necesaria para poder sostenerla, y que la coordinación, pese a sus yerros, ha podido escuchar y ubicarse en función de esa distancia.

J marca el camino de un Acompañamiento posible, de un vínculo posible de ser tolerado por él, a condición de un recambio constante de las personas que encarnan dicha función. 60 acompañantes para 1 Acompañamiento parecería decirnos algo de lo que no termina de funcionar, y sin embargo entendemos que nos habla de lo que si funciona. Funciona a condición de no superponer persona con función, una función que podrá ser encarnada por varios, muchos, y aun así seguir siendo una función.

Este desdoblamiento del Otro le permite mantener un vínculo posible; un desdoblamiento entre la persona y la función en los acompañantes por un lado, y por otro una distancia con la persona que ocupa la coordinación, para mantener a resguardo dicha función.

* * *

Introducción al caso de D: coordenadas clínicas de una función sostenida en el cuerpo

En muchos dispositivos de Acompañamiento Terapéutico, la figura del coordinador se sostiene en una modalidad de trabajo telefónica, operando a distancia de la escena cotidiana que transitan acompañantes y pacientes. Sin embargo, hay casos en los que la singularidad de una demanda interpela ese encuadre y requiere otras formas de presencia. El caso que sigue —presentado por Laura Marcela Ramírez Montoya— es uno de ellos.

Cuando D, un paciente con diagnóstico de psicosis, convoca a la coordinadora a una entrevista de admisión en su domicilio, no solo desacomoda el modo habitual de iniciar un Acompañamiento, sino que inaugura una escena que será luego sostenida como parte constitutiva del dispositivo. En este contexto, la coordinación adquiere una dimensión encarnada: no ya como voz a la distancia, sino como cuerpo que se ofrece al encuentro y como función que aloja la lógica del paciente desde una posición disponible, pero no indiferenciada.

Lejos de desmentir el marco telefónico habitual, esta experiencia lo complejiza. La presencialidad no anula la distancia, sino que se vuelve herramienta clínica cuando se articula a una posición ética y al deseo de construir un lazo posible. A lo largo de los seis años de tratamiento, el trabajo de coordinación se transforma en un sostén delicado para el armado de un Acompañamiento que no responde solo a la urgencia o a la indicación externa, sino que se va desplegando como invención compartida entre el paciente, sus acompañantes y quien coordina.

El texto que presentamos no solo narra ese recorrido, sino que lo articula teóricamente desde una lectura lacaniana que pone en primer plano la operación del deseo del analista, la construcción de una solución sintomática y el valor clínico de la escritura como forma de lazo. En un caso en el que la amenaza del Otro impone condiciones complejas para el encuentro, la coordinación logra sostenerse como un lugar tercero, vaciado de imposición, pero habitado por una escucha que orienta. Lo que allí se escribe no es solo una serie de mails, sino un modo de anclaje en el mundo: una transferencia que, alojada con rigor, habilita una invención subjetiva posible.

Escribir un lugar

Laura Ramírez Montoya

Introducción

El presente escrito pretende formalizar, a partir de una lectura psicoanalítica, el trabajo realizado desde la función de la coordinación a lo largo de seis años de tratamiento en un dispositivo de Acompañamiento Terapéutico, para cuyo propósito se intentará dar cuenta de cómo la coordinación puede ser encarnada desde una posición analítica y de cuáles son los efectos clínicos de las intervenciones que de allí se desprenden.

En ese sentido, se propone un recorrido de articulación teórica de la operación del deseo del analista en este dispositivo de Salud Mental y su función como soporte en la invención de la solución sintomática en un caso de psicosis.

Presentación del caso. Generalidades clínicas

D es un paciente de 36 años, vive con su madre y está diagnosticado con esquizofrenia paranoide desde los 15 años, momento en el que tuvo su primer brote psicótico bajo la coyuntura de la separación de sus padres y la desestabilización psicótica de su madre producto de dicha ruptura. Ha tenido varias internaciones, algunas de ellas motivadas por cuadros caracterizados por alucinaciones cenestésicas, visuales y auditivas, con conductas de desinhibición sexual, y otras, por estados agudos de perplejidad. En dos ocasiones intentó asistir al Hospital de Día, pero no toleró la presencia de los otros ni la dinámica grupal, aún así refiere que le gustaría tener amigos “para hablar”. Quiere vincularse pero no puede, algo se lo dificulta.

Las ideas delirantes de tinte paranoide están siempre presentes, en ocasiones lo llevan al aislamiento y a permanecer en casa con las persianas bajas, la puerta con doble cerradura y con una estatua gigante de la virgen puesta en la puerta de entrada como medida de protección. Hay cámaras en la cocina y el living, las cuales permanecen encendidas

en señal de alerta. Los otros lo vigilan, lo acechan, quieren hacerle mal. Aún así, no se trata de un lazo cortado, ni suspendido, en su delirio se las arregla para estar en relación a un Otro.

Acerca del Acompañamiento Terapéutico

A inicios del 2018, D y su madre estaban en la búsqueda de un equipo de Acompañamiento Terapéutico (AT). Venían de 10 años de cambios continuos en todo el equipo de tratamiento, los cuales habían sido realizados con cierta metonimia, cada cambio se presentaba como una expulsión y la salida de uno era rápidamente sustituida por el ingreso de otro, sin dejar espacio a la posibilidad de indagar y trabajar sobre lo allí sucedido, dejando claro que su decisión era irrevocable y no podía dar a conocer sus razones. En este contexto llegan al Equipo Agora, donde me desempeñaba como coordinadora de equipos de AT, función que tiene la característica de operar principalmente de forma telefónica, en tanto los encuentros presenciales transcurren con los acompañantes.

En nuestra primera comunicación, D me citó en su casa para conocerme y en el transcurso de la reunión me avisó que me estaba realizando una entrevista de admisión y él decidiría si me aceptaba como parte de su equipo tratante. Fui admitida. Me presentó por escrito su plan de trabajo para el AT, dejando constancia sobre sus intereses (trabajo misionero, visitar iglesias y hacer producciones intelectuales sobre historia argentina). Respondí con interés a su pedido y le solicité detalles sobre dichas actividades, con la finalidad de poder acompañarlo de una mejor forma, me pidió tomar nota sobre sus respuestas, argumentando que no estaban escritas en los documentos impresos que me había entregado y que también incluían su esquema farmacológico y su historial médico. Así lo hice.

Tomé nota también sobre el perfil de AT que solicitó y debido a los estrictos y extensos requisitos del mismo, le propuse sostener la dinámica de las entrevistas de admisión, con la posibilidad de evaluar cómo se sentía en los primeros encuentros y de acuerdo a eso decidir si la acompañante ingresaba o no a su equipo. Dicha modalidad se sostuvo a lo largo de todo el tratamiento.

Durante los primeros años, las expulsiones de acompañantes sin posibilidad de mediación desde la coordinación, fueron recurrentes. Algo

lo amenazaba y le era imprescindible ponerse a salvo. En cada expulsión, yo alojaba y respetaba su decisión y a la vez decía algo sobre la misma, señalando que parecía que algo lo había hecho sentir incómodo, que algún comentario había sido desafortunado, que tal vez la acompañante no había entendido su pedido o no se había dado cuenta de su imprudencia. Así se fue construyendo un tiempo de palabra, en el que se fue instalando el lugar de la coordinación como una función de mediación, que a la vez que introducía una distancia a la cercanía ominosa del Otro, introducía una barradura que operaba restando algo de lo enigmático de la AT.

Con el tiempo, la expulsión dejó de ser el único modo de respuesta posible de D frente al malestar, llegando incluso a poder preguntarle a las acompañantes acerca de sus intenciones respecto a algún comentario o situación sospechosa, dejando claro que si se corroboraba lo que pensaba, no podrían seguir haciendo parte de su tratamiento. Si bien muchas veces la respuesta lo tranquilizaba, otras veces ésta no le resultaba suficiente y necesitaba preguntar una y otra vez “para sacarse la duda”.

La errancia

En una ocasión, D se comunicó para avisarme que se había olvidado de tomar la medicación en horario, me llamó para tomarla conmigo en la línea. Una vez finalizado el llamado, volvió a llamarme varias veces de forma consecutiva para verificar si había tomado la medicación, y debido a que mi respuesta no tenía efecto de inscripción, le propuse enviarme por mensaje de texto el horario de la toma y la dosis correspondiente. Me envió un mail, solicitando una respuesta por escrito y una vez que la recibió cesaron sus llamadas.

A partir de ese momento, empezó a enviarme mails informando sobre cuestiones significativas de su día: cambios de horario, modificaciones en el plan farmacológico o los resultados mensuales del hemograma y, de a poco, comenzó a enviarme “información de interés general” sobre fechas patrias y hechos históricos del país, argumentando que debido a mi extranjería era importante que yo estuviera bien informada. En una de mis respuestas a sus mails, le agradecí por la rigurosidad en la información y señalé que la historia era algo que al parecer le interesaba mucho y que transmitía con facilidad y claridad.

Los mails sobre historia empezaron a hacerse frecuentes y se fueron sumando nuevos destinatarios. Armó una extensa lista de contactos y a su vez sus escritos comenzaron a tener una estructura cronológica informativa. Empezó a tomar clases de historia de forma particular e incluyó en la firma de cada mail el atributo de *El Historiador*.

Articulación teórico clínica

a. El acecho del Otro

Una de las primeras dificultades con las que nos encontramos al inicio del tratamiento en este dispositivo de Acompañamiento Terapéutico, tuvo que ver con la expulsión reiterada y precipitada de los acompañantes y, que sin poder ubicar los motivos, cada expulsión denotaba un estado de urgencia y la solución posible que D encontró como recurso para ponerse a salvo cuando algo del Otro –peligroso, amenazante y siempre al acecho– se hacía presente. ¿No es acaso absurdo pedirle a alguien tiempo y palabras para dar cuenta de una decisión, cuando siente que su vida está en riesgo?

Una de las primeras maniobras de intervención constituyó en disponer la función de la coordinación como instancia mediadora entre D y ese Otro, ofreciéndole ocuparme yo de realizar el cambio de acompañante para que él pudiera descansar. Fue necesario alojar su pedido, acompañar su decisión y en un segundo tiempo poder empezar a introducir una pregunta, construir a partir de fragmentos una respuesta e incluso prestar alguna palabra si así se requería.

La coordinación es una figura clínica y en tanto tal es necesario que sea maleable, que se pueda dejar tomar por las características a las que un dispositivo convoca para responder al lugar que cada paciente requiere. Es así que “la transferencia en la psicosis puede constituirse como un lugar privilegiado para tratar aquello que vuelve insoportable las relaciones sociales” (Alcuaz, 2021, p. 145).

Escuchar los límites de D y rectificar mi posición fue necesario cada vez que mis preguntas fueron inoportunas o lo incomodaron, y así mismo, fue imprescindible alojar y habilitar algunas de sus preguntas sobre mí, en momentos en los cuales mi presencia se le hacía enigmática. Sus intereses giraban en torno a mi nacionalidad, los motivos

de mi migración, mi formación y mi trabajo. La apuesta siempre fue constituir una alternativa diferente a ese Otro inaccesible, autoritario y que lo somete, con la finalidad de hacer posible un vínculo menos martirizador.

b. Deseo del analista en la función de la coordinación

Pensar la función de la coordinación desde una lógica clínica cercana a la función del analista, implica pensar en la posición desde la cual alguien se dispone al encuentro con un paciente y el lugar desde el cual escucha, aloja una demanda o interviene. No se trata de ocupar el lugar del analista en sentido estricto, sino de asumir una posición que, al no saturar la escena con sentido previo, permite que el otro construya una vía singular de relación con el mundo. Se trata de una presencia que no se impone, que no busca dirigir ni corregir, sino que se sostiene desde una disponibilidad ética, que consiste en hacerle lugar a la dignidad de la palabra del sujeto, en eso consiste el deseo del analista.

El encuentro inicial con D puso las cartas sobre la mesa y fue necesario partir de allí leyendo los lugares por los cuales él indicaba no ir. La entrevista de admisión, el plan de trabajo, las indicaciones respecto a tomar nota sobre sus pedidos y los antecedentes acerca de lo insopportable y amenazante de la presencia de ese Otro siempre al acecho, orientaron la posición analítica en la función de la coordinación, como ese lugar vacío, en reserva y a su vez disponible para que fuera él quien lo llenara con su propio contenido. Me dispuse como hoja en blanco para que allí deviniera un único texto, el suyo: sus silencios y soluciones, sus pedidos y condiciones, su decir y su escritura.

“El objeto analista es asombrosamente versátil, disponible y multifuncional” (Miller, 1999, p.10) y disponerse como tal requiere no querer nada a priori ni pretender el bien común, todo lo contrario, implica acompañar la construcción sintomática del sujeto, leerla y muchas veces hacerla saber, indicando el camino por donde seguir. Para D, la respuesta al mail que nombraba su interés por la historia y su transmisión tuvo efecto de orientación, señaló un camino y la posibilidad de hablarle a otros —de enlazarse— desde un nuevo lugar: el que enseña. Su interés por la historia estaba escrito desde un comienzo en su plan de trabajo y también allí la escritura estaba dispuesta como recurso.

¿Es posible pensar la escritura como una solución sintomática? ¿De qué se trata la invención?

c. Efectos analíticos: la escritura como anclaje e invención

Hay efectos analíticos cuando hay deseo del analista, cuando aquel que como objeto nómada favorece la instalación móvil del psicoanálisis en contextos por fuera del consultorio, posibilitando la creación de espacios inéditos.

Inicialmente para D la escritura surgió como un recurso para decir, para que no se perdiera lo dicho, luego hubo un primer movimiento en el cual se constituyó como un punto de anclaje para resguardarse de la errancia, como un punto de partida y a la vez un punto de retorno en caso de extravío. En un segundo movimiento y orientada por la historia, la escritura devino como transmisión de un saber. D quería tener amigos para “poder hablar” y vía mail encontró el modo de hablarle a alguien y enmarcar allí la función de transmitir.

La transmisión implica a un Otro a quien dirigirle el mensaje y la construcción de ese Otro y de esos otros requiere de la invención de una relación, es en ese sentido que “las invenciones paranoicas recaen esencialmente sobre el lazo social” (Miller, 2007, p.7), y en este punto, la relación a quien esté en posición analítica representa un soporte que ayuda a la construcción de dicha invención, teniendo como brújula cuál es el modo de lazo posible que al paciente le permitirá aliviar el dolor de su existencia. Se requiere entonces del deseo del analista como ese lugar vacío y vaciado de lo propio para acompañar al psicótico al encuentro de su solución singular (Alcuaz, 2021, p.79 y 144).

La escritura en tanto solución sintomática constituye para D el nexo con el mundo, la posibilidad de inventar otros sociales a los cuales poder dirigirse a partir de un nombre: El Historiador. Nombre que le otorga una posición de trabajo, en tanto le implica jornadas de lectura, investigación y producción de textos propios, y que a su vez, le permite circular por lugares distintos al de ser el objeto de goce del Otro.

d. Para concluir

Si bien el Acompañamiento Terapéutico es un dispositivo de atención ambulatoria que se caracteriza por ser una práctica que está inmersa en la vida cotidiana, es posible situar que hubo efectos analíticos que posibilitaron un tratamiento de la otredad y la invención de una solución sintomática que porta la marca de lo propio.

La coordinación como función mediadora, vacía y disponible, permitió alojar y devenir la singularidad del paciente, operando incluso como punto de orientación respecto al camino por donde continuar construyendo el modo posible de hablarle a otros. Es allí que puede pensarse entonces la operación del deseo del analista en este dispositivo y su función de sostén para admitir y autorizar la producción de nuevos sentidos.

* * *

20 años de coordinación. Una experiencia desde el equipo Ágora

Ezequiel Urribarri
Maximiliano Peverelli

Este texto tiene como punto de partida una serie de reflexiones que Ezequiel Urribarri presentó en el año 2015, durante el Congreso Nacional de Acompañamiento Terapéutico organizado por AATRA. Aquella intervención sembró preguntas que quedaron resonando, y que hoy, años después, retomamos entre los dos, desde la experiencia acumulada, la práctica compartida y la persistencia de una misma apuesta. Lo que sigue es el resultado de ese trabajo: una escritura situada, pensada a varias voces, que busca alojar la complejidad de la función de coordinación sin reducirla a una definición cerrada.

Más que un texto sobre cómo coordinar, es una forma de testimoniar qué sucede cuando la coordinación se vuelve una práctica encarnada, colectiva, sostenida en la trama viva de los vínculos.

Lejos de presentar una receta aplicable, lo que aquí se intenta es dar cuenta de un modo de abordaje que fue tomando forma en la práctica, en el entretejido de escenas clínicas, encuentros de equipo y conversaciones que permitieron construir un saber situado. La coordinación, tal como se despliega en Ágora, se inscribe en un entramado complejo. No se trata de un rol unívoco ni de una función que pueda delimitarse de una vez y para siempre. Por el contrario, se configura como un punto de cruce entre múltiples actores implicados en cada tratamiento. Es, a la vez, lugar de resonancia de las distintas demandas que emergen; espacio de terceridad que habilita nuevas perspectivas de abordaje según quiénes participen del dispositivo; y también ámbito privilegiado para hacer circular la palabra entre los acompañantes, propiciando la construcción colectiva de sentido.

Estos distintos planos de la coordinación —que podrían pensarse como funciones, posiciones o escenas— no se presentan de forma aislada ni secuencial. Más bien, tienden a emerger simultáneamente, superponiéndose y convocando a la coordinación a una constante tarea de lectura, discriminación y decisión. Es precisamente en esa simultaneidad donde se aloja una de sus mayores dificultades, pero también su riqueza.

En esta tensión —entre la multiplicidad de lo que se espera, lo que se necesita y lo que efectivamente se puede— se vuelve imprescindible

detenerse a pensar la demanda misma de coordinación. ¿Qué se espera de quien coordina? ¿Desde dónde se dirige la palabra? ¿Qué escucha se espera? ¿Qué lugar se construye para que algo de lo común pueda sostenerse?

Este texto se propone, entonces, como un intento de pensar esos interrogantes desde una experiencia concreta, con la convicción de que narrar lo vivido puede abrir camino para seguir elaborando colectivamente la práctica de la coordinación en Acompañamiento Terapéutico.

Un poco de historia

Desde los inicios del equipo Ágora —incluso antes de adoptar ese nombre— la coordinación fue uno de los pilares sobre los que se sostuvo nuestra forma de hacer Acompañamiento. A lo largo del tiempo, esta función no fue pensada siempre del mismo modo: el concepto de coordinación, así como ciertas reglas que organizaban los dispositivos, fueron transformándose al calor de la práctica.

Sin embargo, hay algo que nunca cambió en nuestra experiencia: la estructura mínima que consideramos necesaria para que exista un Acompañamiento Terapéutico. Siempre pensamos esta práctica como una conjunción de tres elementos: el acompañante en el campo, una coordinación y un espacio compartido para pensar la experiencia. Esa tríada —acompañante, coordinación y espacio de reunión— ha sido, y sigue siendo, la base desde la que entendemos la potencia del dispositivo. En la perspectiva que proponemos, no hay Acompañamiento Terapéutico posible sin este entramado.

Durante los primeros años, el rol del coordinador era más acotado: su función principal era la de reunir a los acompañantes en un espacio común donde pudieran conversar sobre cómo venía el tratamiento, intercambiar impresiones, compartir obstáculos. También era quien recibía las demandas iniciales de Acompañamiento y ayudaba a darles forma como dispositivo, en una suerte de función de admisión.

Pero con el correr del tiempo —y también con la expansión del equipo y la aparición de los teléfonos móviles como herramienta cotidiana— esa figura empezó a adquirir nuevas responsabilidades. Ya no alcanzaba con coordinar un espacio de reunión: el coordinador se volvía interlocutor cotidiano de los acompañantes, de las familias, de los profesionales tratantes. El desafío fue, entonces, no quedar atrapado en una

función meramente informativa, sino sostenerse como alguien que organiza, que orienta, que ayuda a dar sentido. El lugar que ocupaba en la circulación de la información (cambios de horarios, modificaciones en la medicación, pedidos de la familia, alteraciones en la escena del Acompañamiento) lo colocaba en una posición estratégica que requería una lectura clínica y no solo operativa.

Una práctica que se fue haciendo

Breve recorrido histórico por la función de coordinación en Ágora

Ágora siempre se caracterizó por una fuerte inercia a pensar lo que hacíamos. Ese pensar no se limitaba a la escena del Acompañamiento, sino que incluía también las condiciones que lo hacían posible: el armado del dispositivo, el tipo de coordinación, la función de los espacios de reunión. Así, aunque cambiamos estrategias y formas, nunca dejamos de sostener la coordinación como una función imprescindible. Esa coordinación no es, ni fue nunca, meramente administrativa.

En la etapa inicial del armado de un tratamiento, el coordinador cumple una función clave: es quien realiza la admisión, quien releva las condiciones necesarias para implementar el dispositivo, quien elige — en función de su lectura del caso y la disponibilidad del equipo— a los acompañantes que van a intervenir. Una vez conformado el equipo de trabajo, salvo que surja alguna urgencia o modificación sustancial, el coordinador se retira de la organización de los horarios específicos. No se trata de supervisar cada paso, sino de generar las condiciones para que el dispositivo se sostenga en su andar.

En los primeros tiempos, cuando éramos más jóvenes y todavía ensayábamos nuestras primeras formas de organización, establecimos una regla que nos marcó: los coordinadores no debían conocer personalmente a los pacientes. La comunicación debía ser exclusivamente telefónica. Recuerdo que solíamos definir la coordinación como “una voz al teléfono”.

Esa decisión —no del todo explícita ni del todo consciente— respondía, en el fondo, a una incomodidad que aún no sabíamos nombrar: muchos de los pacientes con los que trabajábamos eran mayores que nosotros, y no nos veíamos en condiciones de asumir con ellos una función de regulación o de sostén. Intuíamos que si nos presen-

tábamos, si nos hacíamos visibles, se abría una vertiente imaginaria que podía dificultar la función. La regla venía, en definitiva, a protegernos de nuestro propio fantasma: el temor a no estar a la altura, a ser desbordados por una escena que aún no sabíamos cómo habitar.

Con el tiempo, en el marco de las reuniones generales, alguien se animó a cuestionarla. Aquello que en su momento había sido una respuesta eficaz comenzó a mostrar sus límites. Nos tocó entonces revisar la dinámica, volver a pensar desde otro lugar lo que dábamos por resuelto. Pero lejos de invalidarla, esa revisión nos permitió reconocer su valor: no fue un error. Fue una decisión que nos sirvió, y mucho, para empezar a estructurar la función.

Desde esa distancia inicial —protegida, sí, pero también pensante— comenzamos a delimitar un lugar de coordinación que no se confundiera ni con la intervención directa ni con la gestión puramente logística. Empezamos a preguntarnos, entonces, cuándo interviene un coordinador, y cuándo no. Cómo puede sostener a los acompañantes sin sobreexponerse. Cómo articular con los pedidos que llegan desde afuera del dispositivo —familiares, instituciones, profesionales— sin diluir el encuadre ni perder de vista la dirección clínica.

Así se fue configurando, con el tiempo, lo que empezamos a llamar nuestro “modo clásico de coordinación”. Un modo que no nació de una teoría previa, sino de la experiencia compartida, de la necesidad de encontrar formas viables y éticas de sostener el lazo clínico en medio de la complejidad de lo real.

El “modo clásico” de coordinación.

Una legalidad externa que sostiene el lazo

A medida que el equipo fue creciendo y la complejidad de los tratamientos aumentaba, nos vimos en la necesidad de pensar con más precisión cuál era el lugar de la coordinación. No alcanzaba con una figura que cumpliera funciones administrativas ni con alguien que simplemente transmitiera mensajes de un lado a otro. La coordinación debía transformarse en una función clínica, capaz de organizar y estructurar el dispositivo en su conjunto.

Fue en ese momento que comenzamos a hablar, de manera más o menos tácita, de un “modo clásico” de coordinación. En este modelo, la

coordinación asumía un lugar privilegiado en la circulación de la información. Su tarea no era solo reunir los datos, sino transformarlos en sentido, evitando que las múltiples voces que atraviesan el dispositivo —familias, profesionales tratantes, instituciones— generen contradicciones que desorganicen el trabajo clínico.

Uno de los efectos más importantes de esa centralización fue la posibilidad de introducir una pausa, una distancia, una dimensión temporo-espacial que permitiera pensar los cambios antes de implementarlos. Frente a una modificación en el horario, una indicación médica, o un pedido urgente por parte de la familia, el acompañante ya no quedaba solo en el momento de responder. La presencia de una coordinación —no necesariamente en acto, sino como una legalidad externa al dispositivo— ofrecía un punto de apoyo desde donde sostener el encuadre.

Ese punto de apoyo resultaba fundamental para preservar al acompañante de quedar atrapado en una escena especular, sobre todo en vínculos muy demandantes o desiguales, como puede ser la relación con la madre de un paciente cuando es el acompañante quien va todos los días a su casa. La coordinación, en este sentido, no solo ordena, sino que autoriza: habilita un espacio para pensar antes de actuar, resguarda la posición del AT y contribuye a mantener la ética del dispositivo.

Este proceso nos llevó a una nueva comprensión: la coordinación no es simplemente una persona, sino una función que puede estar encarnada de diversas maneras. A veces es el propio coordinador quien interviene; otras veces es el acompañante quien, al nombrar a la coordinación, la introduce como tercera en la escena. Incluso puede suceder que esa referencia esté tan internalizada que opere sin que el coordinador lo sepa. La coordinación, en su forma más elaborada, se vuelve un elemento estructural del dispositivo, más allá de su manifestación concreta.

Llegados a este punto, se vuelve claro que la coordinación en Acompañamiento Terapéutico no puede reducirse a un nombre propio, a una función delegada o a una posición fija dentro de un organigrama. Lo que hace a la coordinación no es su formalización, sino su capacidad de operar allí donde se la convoca, allí donde se la nombra, allí donde se la encarna.

En más de una oportunidad hemos podido verificar que puede haber coordinación incluso en ausencia del coordinador. Esto sucede, por ejemplo, cuando es el propio acompañante quien, frente a una situación de tensión o ambigüedad, introduce una palabra que organiza, un

gesto que sostiene el encuadre, una decisión que resguarda la legalidad del tratamiento. No se trata de una autonomía desregulada ni de una sustitución del rol, sino del despliegue clínico de una función que fue apropiada, pensada, trabajada colectivamente.

En estos casos, podríamos decir que la coordinación aparece como una presencia sin cuerpo, una función que ha sido internalizada y que puede ser invocada —o incluso actuada— sin necesidad de que su referente esté en la escena. El acompañante, al sostener el lazo, al no responder inmediatamente a una demanda impulsiva, al nombrar la necesidad de consultar, está introduciendo algo del orden de la coordinación.

Este fenómeno no debe confundirse con la desresponsabilización del coordinador, ni con una delegación informal de tareas. Al contrario: habla de un proceso de transmisión, de una ética compartida, de una construcción colectiva en la que los roles se interpelan mutuamente y se sostienen en una trama más amplia. Una trama donde las palabras no son órdenes, sino marcas de un estilo, de una apuesta, de una forma de estar con otros.

Quizás esta sea una de las formas más potentes y menos visibles de la coordinación: cuando deja de ser una voz que organiza desde afuera para volverse una lógica que habita el dispositivo, una legalidad encarnada que permite hacer lugar a lo singular sin perder de vista lo común. Allí, donde cada acompañante puede encontrar un modo de actuar sin salirse de la función, donde cada intervención contiene algo de lo colectivo aunque se realice en soledad, es donde la coordinación demuestra su verdadero alcance.

Porque la coordinación, en definitiva, no es tanto una posición como una práctica. Una práctica que se activa en el decir, que se encarna en los actos, que se sostiene en los vínculos. Una práctica que, cuando logra ser apropiada por quienes acompañan, muestra que el lazo clínico no depende de jerarquías, sino de la potencia de lo compartido.

Con el tiempo, fuimos reconociendo distintas modalidades de intervención de la coordinación, que hoy constituyen lo que denominamos nuestro “modo clásico”:

Con los acompañantes terapéuticos:

- En las reuniones de equipo, donde el coordinador cumple una función semejante a la de un coordinador de grupo: se trabaja con

el material clínico, pero también con las resonancias, los males-tares y la dinámica subjetiva de los acompañantes.

- En el campo clínico, como referencia tercera que introduce una legalidad externa y una dimensión temporo-espacial que permite descomprimir situaciones complejas.
- En intervenciones directas sobre el Acompañamiento, cuando la situación lo requiere, para sostener decisiones o encuadres en tiempo real.

Con las familias:

- Acompañando y sosteniendo las demandas sin romper el encuadre del tratamiento, funcionando como mediador y filtro que evita el desborde o la confusión de roles.

Con los profesionales tratantes:

- Redireccionando informaciones y situaciones que resulten importantes para el curso del tratamiento, resguardando el lugar del Acompañamiento Terapéutico y garantizando la coherencia del dispositivo.

Este modelo, construido desde la experiencia y atravesado por múltiples reformulaciones, se sostiene en la idea de que el Acompañamiento Terapéutico no se agota en el vínculo entre el acompañante y la persona acompañada. Es en el lazo con otros —coordinadores, equipos, espacios compartidos— donde se juega gran parte de su potencia.

El viraje de la coordinación. Cuando la función excede el dispositivo

Las formas que fue tomando la coordinación en nuestra práctica no son estáticas ni definitivas. Muy por el contrario, lo que denominamos como “modo clásico” de coordinación fue también, con el tiempo, atravesado por nuevos desafíos, nuevas escenas y nuevas exigencias clínicas que nos llevaron a revisar lo ya dicho y a reconfigurar el lugar desde el que intervenimos.

Una de las preguntas que comenzamos a hacernos en este nuevo momento fue: ¿hasta dónde llega la función de la coordinación? ¿Qué sucede cuando los acompañantes, por cercanía, por sostén, por conti-

nidad, quedan más cerca del paciente que el propio equipo tratante? ¿Qué lugar pasa a ocupar entonces la coordinación?

En la práctica cotidiana no son pocas las situaciones en las que el Acompañamiento Terapéutico deja de ser solo un “recurso complementario” para transformarse, de hecho, en el núcleo activo del tratamiento. Lejos de que esto sea un objetivo deseado o buscado, lo cierto es que muchas veces ese lugar se impone. Cuando no hay otros espacios de escucha disponibles, cuando los profesionales tratantes se encuentran distantes o ausentes, cuando la urgencia del padecimiento requiere intervenciones sostenidas, el acompañante y la coordinación quedan en la primera línea. Hacerse cargo de esa escena no implica desecharla, sino poder leer lo que está ocurriendo, reubicar las coordenadas y construir, allí donde no hay, un punto de salida.

En este viraje, la coordinación se convierte en una especie de brújula: no solo orienta al equipo de acompañantes, sino que, en muchos casos, termina sosteniendo la dirección misma del tratamiento. Afirmar esto no es sin riesgo, lo sabemos. Pero quienes llevamos años en esta práctica también sabemos que ese lugar —cuando aparece— no puede ser negado ni desestimado. Al contrario, requiere ser pensado, asumido, elaborado.

En este punto, se vuelve indispensable interrogar la propia demanda de coordinación. ¿Qué se espera de quien coordina? ¿Qué se le deposita? ¿Desde dónde se construye su autoridad? Si en un comienzo la coordinación aparecía como una figura externa que organizaba y sostenía, hoy se presenta también como un actor clínico central, situado en el corazón mismo del dispositivo.

Y sin embargo, sigue siendo un afuera. La coordinación escucha lo que los acompañantes dicen, sostiene la multiplicidad de versiones, recoge las resonancias. Está en el centro del dispositivo, pero sin confundirse con él. Tal vez podamos pensarla, como alguna vez lo nombramos, en términos de una extimidad: ni dentro ni fuera, pero absolutamente implicada. Ese lugar vacilante, que bordea la escena sin ocuparla del todo, es también lo que le permite funcionar como punto de anclaje, como legalidad externa, como otro que da lugar.

La coordinación, en este sentido, no es solo una función de articulación. Es también un dispositivo en sí mismo, una forma de alojar lo múltiple, de sostener lo que no se cierra, de hacerse cargo de lo que excede.

Entre la angustia y la función. La demanda del acompañante como materia clínica de la coordinación

Uno de los malestares más frecuentes que emergen en la práctica de la coordinación hoy tiene que ver con el desfasaje que se ha ido instalando entre quienes sostienen la función de coordinación y quienes encarnan el Acompañamiento en el campo. Esa brecha, a veces silenciosa, otras veces ruidosa, no es solo una diferencia de roles, sino una tensión clínica que atraviesa al dispositivo y pone en juego su estabilidad.

No es raro que los coordinadores se enfrenten a pedidos de los acompañantes que, a primera vista, resultan inviables dentro del marco del tratamiento. Sin embargo, muchas veces esos pedidos —por más extravagantes o poco oportunos que parezcan— encierran una necesidad subjetiva urgente, una forma de decir “no puedo más”, “necesito ayuda”, “esto me está desbordando”. Allí donde el acompañante deja de hablar desde su función para hablar desde su malestar, lo que se pone en juego no es el tratamiento en sí mismo, sino la posibilidad de seguir sosteniéndolo.

En esas escenas, el coordinador queda atrapado en una encrucijada: si responde afirmativamente al pedido, corre el riesgo de quebrar el encuadre; si lo rechaza de plano, puede empujar al acompañante a una renuncia súbita, al hartazgo, al “mandar todo al carajo”. En muchos casos, la respuesta del coordinador se vuelve ambigua: acepta el pedido “no conforme”, con la única intención de sostener algo que no se termine de desmoronar.

Uno de los grandes desafíos de esta función es poder leer lo que allí se está demandando, incluso cuando no hay una demanda formulada. Cuando el acompañante llama para pedir que se contacte a la madre del paciente —no porque el tratamiento lo requiera, sino porque está saturado y necesita saber si va a poder irse a tiempo—, la respuesta no puede limitarse a una explicación didáctica sobre por qué eso “no corresponde”. Esa respuesta técnica no es escuchada, porque lo que se impone es una urgencia subjetiva que no se calma con razonamientos. En ese momento, el acompañante no habla como AT, habla como persona excedida por una escena que lo sobrepasa.

Allí, el coordinador puede ofuscarse, puede cuestionar la supuesta inexperiencia o negligencia del acompañante, pero también —si logra sostener su función— puede leer ese pedido como lo que es: un llamado, una forma de demanda que necesita ser elaborada. La intervención no

consiste en hacer lo que se pide, ni en desautorizarlo brutalmente, sino en alojar ese pedido, traducirlo, y reubicarlo en los términos del dispositivo.

“Vos me estás pidiendo que llame a la madre porque...”, podría decir el coordinador, abriendo así la posibilidad de poner en palabras lo que está en juego. Porque no se trata ya de saber si la madre llegará o no a horario —algo que, en verdad, nadie puede saber hasta que suceda—, sino de leer que detrás de ese pedido hay una necesidad de sostén, una dificultad para seguir, una demanda de coordinación que aún no ha encontrado forma.

Convertir un pedido en una demanda, inscribirlo en el lazo, darle un marco, es uno de los modos más potentes que tiene la coordinación de intervenir. No se trata de apaciguar la angustia del acompañante a cualquier costo, ni de negarla, sino de construir —con él, con el equipo— las condiciones para que esa angustia no lo saque de la función. A veces, la intervención más clínica del coordinador no se dirige al paciente, sino al propio acompañante.

Capítulo 8

LA CLÍNICA ENTRE VARIOS

La Clínica entre varios: Fundamento y estructura

Del acompañamiento individual a la práctica entre varios

Ya en el Primer Congreso de Acompañamiento Terapéutico, en 1985, Guillermo Altomano señalaba que el Acompañamiento es una misma función, pero ejercida entre varias personas. Esa advertencia temprana no fue una consigna técnica, sino la descripción de una práctica que nació al calor de las experiencias concretas. La idea, que en aquel momento aparecía incipientemente como una constatación práctica, fue consolidándose a lo largo de los años hasta volverse una marca distintiva del dispositivo cuando se lo piensa como trabajo de equipo. Lo que llamamos “clínica entre varios” no es simplemente una estrategia de reparto de tareas, sino un modo específico de concebir la práctica: como un entramado colectivo que produce efectos clínicos en su conjunto, más allá de la singularidad de cada intervención.

No fue un concepto nacido en los márgenes. En las primeras publicaciones significativas del campo —desde los libros de Kuras y Resnisky hasta los textos de Pulice, Rossi o Delgado—, la práctica entre varios ya estaba presente, aunque no siempre nominada con claridad. En el capítulo que Osvaldo Delgado publica en el libro de Gustavo Rossi “Acompañamiento Terapéutico. Lo cotidiano, las redes y sus interlocutores”⁵, se introduce la idea de una “clínica entre varios” como posibilidad para alojar la transferencia multiplicada en un dispositivo abierto, extendido a la vida cotidiana, y donde el acompañante tiene un rol privilegiado como agente de articulación con lo público, con el otro social.

5. Rossi, G. P. (2007). *Acompañamiento terapéutico: lo cotidiano, las redes y sus interlocutores*. Polemos.

Sin embargo, fue en una ponencia del mismo Delgado, ya fuera del libro, donde escuchamos por primera vez ese concepto con la contundencia que nos permitió capturarlo. Más adelante, gracias al Lic. Nicolás Isla —coordinador de coordinadores en el equipo Ágora— esa expresión volvió a resonar, esta vez con una claridad tal que nos permitió reconocer en ella una definición precisa de lo que veníamos haciendo: una clínica desplegada por varios.

Condiciones estructurales para una clínica entre varios

En rigor, la formulación original del concepto que adoptamos proviene de Antonio Di Ciaccia, quien lo utilizó en referencia a una experiencia institucional de 1974 con pacientes graves, en la que diferentes disciplinas intervenían vaciadas de su saber técnico, priorizando la dimensión vincular y la elaboración colectiva de un saber común. Lo que Di Ciaccia llamó “práctica entre varios”, nosotros lo resignificamos en el terreno del Acompañamiento como “clínica entre varios”, porque no se trata solo de acompañar, sino de alojar en ese Acompañamiento una apuesta clínica.

En este modelo, el primer dato fundamental es que el Acompañamiento no puede ser ejercido por una sola persona. Requiere, al menos, dos profesionales intervinientes. No se trata de una superposición cuantitativa, sino de una condición estructural: la pluralidad de presencias no solo permite cubrir la carga horaria o responder a las particularidades del caso, sino que introduce variaciones clínicas fundamentales. Ese mínimo umbral inaugura una lógica de intercambiabilidad, en la que diferentes modos de relación, diferentes formas de estar con el paciente, se articulan como parte del tratamiento. Cada acompañante, en su relación con el paciente, construye un modo vincular singular, resultado de su propio posicionamiento subjetivo y del modo en que es alojado transferencialmente. No se trata de suplencias funcionales. Se trata de que cada profesional puede ser convocado no solo por su disponibilidad horaria, sino por los efectos clínicos que produce su presencia. Lo que cada uno construye con el paciente no es reemplazable, pero sí es articulable. El dispositivo se vuelve así capaz de alojar lo que no cierra, lo que se tensiona, lo que escapa a un solo modo de estar. Frente a esta diversidad, la coordinación de presencias y ausencias se vuelve

un recurso clínico. Se puede intervenir no solo con lo que se dice o se hace, sino también con quién está y quién no está, con qué acompañante se presenta en determinado momento del tratamiento. Lejos de entender la intercambiabilidad de los miembros como una cuestión meramente logística, la clínica entre varios convierte esa dinámica en una herramienta de lectura y de acción, en función de los movimientos subjetivos del paciente.

La reunión de equipo como escena clínica

El segundo pilar de este modelo clínico es la reunión de equipo. Lejos de una instancia meramente informativa o administrativa, la reunión opera como lugar de producción de saber clínico. Allí se recogen las narrativas parciales de cada profesional, se las pone en tensión, se las articula. Lo que se construye es un texto colectivo, una escritura en proceso que solo puede emerger en la confrontación respetuosa de las diferencias. En este espacio, cada profesional se ve interpelado a desprenderse de la ilusión de un saber total y a alojar el vacío que el caso impone. Ese movimiento es lo que permite una verdadera elaboración clínica. Solo en el marco de esa reunión, el discurso sobre el paciente se vuelve una palabra responsable, capaz de devenir acto. Por eso, todo lo que se enuncia por fuera de ese espacio puede tener efectos, pero carece de valor clínico si no es puesto en juego allí, en ese punto colectivo de elaboración.

El rol del coordinador: sostener la legalidad del dispositivo

El tercer eje fundamental es la figura del coordinador. No se trata de un jefe, ni de un experto. No es un supervisor ni un administrador. El coordinador no se ubica en una posición de saber, sino en sostener un lugar que habilite al resto. Es quien garantiza que la práctica colectiva no se diluya, quien preserva el vacío de saber como condición para que el discurso del Acompañamiento no se cierre sobre certezas. Es quien sostiene la estructura del dispositivo, quien organiza los tiempos, gestiona los intercambios, cuida los límites. Su posición no está fuera del dispositivo, pero tampoco del todo dentro: ocupa un lugar excéntrico,

que le permite intervenir sin absorber la escena. Es él quien garantiza que las funciones estén claras, que las tensiones encuentren cauce, que el Acompañamiento pueda sostener su especificidad sin desdibujarse. Su tarea no es intervenir en el lazo con el paciente, sino hacer posible que ese lazo se constituya clínicamente. Al organizar el dispositivo desde sus fundamentos, el coordinador instala simbólicamente un lugar que luego será encarnado, de manera alternada, por los acompañantes que participan.

Una ética situada en lo común

La clínica entre varios se constituye, entonces, como una modalidad específica de intervención, especialmente adecuada para abordar situaciones de padecimiento subjetivo en tratamientos de encuadre abierto. Si bien requiere ciertos elementos estructurales mínimos —al menos dos acompañantes, una coordinación clara y reuniones de equipo periódicas— su verdadera potencia clínica se evidencia en la multiplicidad de vínculos transferenciales que se organizan. Cada intervención se sostiene en un dispositivo colectivo, que puede gestionar sus tensiones y redistribuir sus lugares en función de lo que el caso requiera. En este sentido, deja de ser una suma de intervenciones individuales y se convierte en un cuerpo colectivo que escucha, que elabora, que se organiza para acompañar. Y que, en ese movimiento, también se transforma.

Así concebida, la clínica entre varios no es simplemente una organización eficaz del trabajo, ni una sumatoria de intervenciones. Es una forma específica de alojar el padecimiento subjetivo en la vida cotidiana. Un modo de construir, entre varios, las coordenadas que permitan al paciente ensayar nuevos modos de estar en el mundo.

En esta lógica, la integración social deja de pensarse como un objetivo explícito del acompañante, y pasa a entenderse como un movimiento que el propio sujeto realiza cuando encuentra las condiciones que lo habilitan a circular. La tarea del equipo es construir ese mundo relacional que pueda alojar la diferencia, que no clause la posibilidad del lazo ni fije identidades, sino que sostenga una escena viva, capaz de abrir tiempo y espacio para el encuentro.

En definitiva, la clínica entre varios no es solo un modo de trabajo: es una ética de la práctica. Una ética que se sostiene en la renuncia a

las certezas, en la disponibilidad para escuchar al otro y en la apuesta decidida por lo común. Allí donde el padecimiento tiende a aislar, a clausurar, a dejar sin palabras, el Acompañamiento —cuando es verdaderamente clínico— se ofrece como un trabajo de reanudación del lazo.

Tal vez por eso, más que técnica o procedimiento, el Acompañamiento Terapéutico sea, en su núcleo más íntimo, una forma de presencia. Y si esa presencia puede operar como sostén, como impulso, como borde o como descanso, es porque nunca se ofrece sola, sino sostenida por otros.

Cuarta parte

ÁMBITOS DE INSERCIÓN Y EXPERIENCIAS DEL CAMPO AT

Capítulo 9

TERRITORIOS DEL ACOMPANAMIENTO TERAPÉUTICO

DIÁLOGOS, TENSIONES Y PRÁCTICAS SITUADAS

La articulación con otros campos para pensar el Acompañamiento

Venimos de pensar el Acompañamiento en su dimensión más íntima: la del encuentro uno a uno, sostenido por la implicación subjetiva y el trabajo colectivo que lo enmarca. Pero ese gesto —el de acompañar— se despliega también en territorios diversos, donde la escena se ensancha, donde otras instituciones, otros discursos, otros cuerpos entran en juego.

Si algo ha caracterizado al Acompañamiento Terapéutico ha sido su capacidad de mantenerse abierto, en tensión, en cruce. No hay un único marco que lo agote ni una sola tradición que lo reclame como propio. El Acompañamiento se construye —y se transforma— en diálogo con otros discursos: los que lo disputan, los que lo enriquecen, los que lo tensionan.

Articular con otras miradas es una necesidad ética y política. Pero no se trata de disolver las diferencias ni de buscar síntesis forzadas. Por el contrario, el desafío es sostener el diálogo en la diferencia, sin perder el norte clínico ni la implicación subjetiva que nos convoca.

Este apartado nos invita a recorrer algunas de las tramas discursivas que atraviesan, rodean o interpelan al Acompañamiento Terapéutico. Recorridos que no llegan a ilustrar una teoría, pero construyen escenas que nos invitan a repensar la función, conscientes de que cada una de ellas lleva consigo una lógica, una lengua, una política del cuidado. Nos proponemos abrir el campo sin perder el centro: esa práctica situada que, aunque nacida al margen, hoy exige ser pensada en relación con las tramas más amplias que configuran lo común.

* * *

Notas preliminares al dispositivo de AT Grupal

Las internaciones psiquiátricas de niños, niñas y adolescentes presentan, desde hace décadas, un serio problema clínico, ético y social. Aunque legalmente se admite su excepcionalidad, en la práctica son muchas las instituciones que alojan a pacientes menores de edad sin las adecuaciones necesarias para garantizar condiciones mínimas de resguardo. En la mayoría de los casos, los dispositivos de internación se encuentran estructurados bajo lógicas pensadas para adultos, tanto en sus espacios físicos como en sus prácticas asistenciales. En ese marco, la internación de un niño o adolescente no solo expone la gravedad del padecimiento subjetivo que motivó la indicación, sino que añade una segunda capa de vulnerabilidad: la de ser alojado en un entorno que no fue pensado para él.

Esta doble vulnerabilidad se manifiesta, sobre todo, en el tipo de convivencia que se propicia. El simple hecho de compartir pasillos, salas comunes o rutinas institucionales con adultos en estado de crisis aguda supone un riesgo que excede lo clínico y alcanza el plano de lo subjetivo, lo vincular y lo ético. En muchos casos, la estrategia institucional para paliar esta situación ha sido permitir —e incluso exigir— la permanencia de un familiar o adulto referente dentro de la internación, con la expectativa de que esa figura funcione como sostén y resguardo. Sin embargo, esta modalidad ha generado en la práctica numerosos efectos no deseados: desde la circulación de familiares en los espacios comunes sin formación clínica ni orientación terapéutica, hasta tensiones propias de convivencias prolongadas en situaciones límite, muchas veces atravesadas por conflictos familiares no elaborados.

En este contexto, la institución en la que se inscribe esta experiencia tomó una decisión significativa: crear un espacio específico, separado de las áreas de internación de adultos, destinado exclusivamente a niños, niñas y adolescentes. Este gesto no fue solo una reconfiguración arquitectónica o funcional; implicó un posicionamiento ético respecto a cómo alojar a los y las adolescentes en situación de internación, reconociendo su particularidad, su etapa vital, sus modos de expresión y sus necesidades específicas. Se organizaron actividades acordes a sus intereses, se reguló su circulación para evitar el contacto con pacientes adultos, y se pensó un modo de atención que no los reduzca al síntoma ni a la peligrosidad, sino que los ubique como sujetos de deseo, en tránsito por una etapa compleja y vital.

En ese marco, y como parte de una búsqueda institucional que lleva más de quince años de elaboración continua, se introduce el dispositivo de Acompañamiento Terapéutico grupal como una pieza clínica fundamental. El desafío era, y sigue siendo, enorme: ¿cómo introducir un recurso cuya potencia reside en la cercanía, en la cotidianeidad, en el cuerpo presente, en una institución organizada muchas veces por la distancia, el protocolo y la regulación? ¿Cómo sostener un modo de estar que no vigila ni dirige, sino que escucha, acompaña y trama lazo?

Este capítulo da cuenta de esa experiencia. Una experiencia que, con sus tensiones, sus avances y sus límites, construye día a día una escena distinta: una escena donde el acompañamiento no es un lujo ni un accesorio, sino una apuesta política por alojar el sufrimiento sin reprimir la diferencia; por sostener la grupalidad sin perder de vista la singularidad; por hacer del lazo no solo un modo de intervención, sino una brújula clínica en un terreno siempre desafiante.

Acompañamiento Terapéutico Grupal en el marco de una internación psiquiátrica para niños, niñas y adolescentes

Maximiliano Peverelli

Analía López

Vanessa Carballo

Introducción: una escena grupal en tensión

El Acompañamiento Terapéutico Grupal, en contexto de internación, no es una mera adaptación del dispositivo uno a uno a una escena compartida. Es otra cosa. Supone una práctica específica, tejida en la frontera entre la singularidad del padecimiento subjetivo y el espacio común de la convivencia. Y es, en ese entre, donde se vuelve necesario pensar qué hace el Acompañamiento cuando lo que está en juego es el abordaje de un grupo.

Este capítulo surge de una experiencia concreta, sostenida en el tiempo, que se inscribe dentro de un dispositivo de Acompañamiento Terapéutico Grupal a adolescentes en situación de internación en salud mental. Una escena compleja, donde se cruzan adolescencias desbor-

dadas, institucionalizaciones marcadas por lógicas aún custodiales, y equipos clínicos que ensayan día a día formas posibles de alojar lo insoportable. Allí, el Acompañamiento se constituye como actor clínico, capaz de interrumpir el automatismo institucional para producir escenas de subjetivación.

Ahora bien, esta experiencia clínica no ocurre en un marco propio, sino en el seno de una institución de salud mental con historia, normas, regulaciones y dispositivos ya establecidos. El equipo de acompañantes terapéuticos se incorpora como recurso externo, convocado a habitar un adentro que no le pertenece, y que muchas veces le es ajeno en su lógica. Esa inclusión implica necesariamente un trabajo de lectura institucional: reconocer sus coordenadas, incorporarlas, respetarlas y tensionarlas cuando se vuelven obturadoras del lazo.

La escena cotidiana del dispositivo se teje, en gran medida, en los intersticios de la internación: aquellos tiempos muertos, entre actividad y actividad, entre taller y entrevista, donde no hay propuesta terapéutica formal. Es ahí donde el equipo de AT despliega su intervención, armando un espacio grupal que no sustituye a los tratamientos, pero que los acompaña, los bordea. Apuesta a sostener una presencia que permita habitar la espera, tramitar el malestar, construir un lazo posible.

En ese sentido, la presencia del dispositivo externo no solo amplía el campo clínico, también lo interroga. Su mera existencia introduce una variación en la rutina institucional, plantea nuevas preguntas sobre el lazo, sobre la singularidad, sobre los modos posibles de habitar una internación. Pero esa inclusión no es sin fricciones: requiere construir legitimidad, sostener la escucha institucional, negociar sentidos. El AT se sostiene en esa tensión, sin renunciar a su especificidad, pero sabiendo que toda intervención se juega dentro de un entramado más amplio que la excede.

A lo largo de este capítulo, nos proponemos recuperar esa experiencia concreta para extraer de ella algunas coordenadas clínicas, organizacionales y políticas que permitan pensar el Acompañamiento Terapéutico Grupal como una práctica situada, potente y en tensión permanente con el contexto que la aloja. Porque si hay algo que caracteriza a este dispositivo es justamente eso: el modo en que se dispone a alojar lo inclasificable, lo que no encaja, lo que desborda.

El dispositivo grupal: no es uno, ni son todos

Este dispositivo al que hacemos referencia no parte de la idea de reunir adolescentes en una sala y esperar que ocurra algo. Por el contrario, se trata de construir, cada día, un espacio clínico singular, capaz de sostener la complejidad que emerge cuando se pone a convivir lo que aún no tiene forma, lo que no logra decirse, lo que se manifiesta como acto o como puro malestar. Este armado no se apoya en la homogeneización del grupo, ni en el ideal de comunidad terapéutica, sino en la posibilidad de alojar diferencias, ritmos y modos de estar que no siempre encuentran lugar en otras escenas institucionales.

El Acompañamiento Grupal, en este contexto, se desmarca de la lógica del “grupo terapéutico” clásico, estructurado por consignas, técnicas o metas compartidas. En este dispositivo, el grupo es más bien una escena en tensión: dinámica, cambiante, a veces caótica, donde lo que se pone en juego es la posibilidad de habitar un espacio con otros sin que eso implique perder la singularidad. En ese sentido, se trata de sostener un entramado flexible que permita que algo circule, que algo del orden de lo vincular se ponga en marcha.

Lo grupal, aquí, es un trabajo artesanal, sostenido por acompañantes que no solo están con los adolescentes, sino que intervienen activamente en la escena: regulan, median, observan, traducen, hacen lugar a lo que no tiene lugar. Esa tarea clínica se sostiene desde una posición que no busca interpretar, encuadrar o contener en el sentido tradicional del término, sino que habilita, acompaña, hace lazo. La grupalidad se juega tanto en la posibilidad de que los adolescentes se miren, se escuchen, se afecten, como en el modo en que los acompañantes se disponen a estar presentes sin invadir, ordenando pero sin capturar.

La dinámica del grupo se va configurando en tiempo real, a partir de los movimientos que el propio devenir de la internación impone: ingresos, altas, crisis, silencios. Nada se mantiene fijo demasiado tiempo. Lo grupal, en este dispositivo, no es una estructura cerrada, sino una forma de disponibilidad: se trata de estar ahí, cuando la escena lo demande, con otros, entre varios. Y ese “entre” es clave: es en ese espacio intermedio donde muchas veces algo logra aparecer, donde lo que parecía acto puro se transforma en palabra, donde lo que era aislamiento se vuelve roce, mirada, gesto compartido.

Por eso decimos que el Acompañamiento Terapéutico Grupal no es uno —no hay una escena individual que pueda sostenerse por fuera del entramado común—, pero tampoco son todos —no se disuelve la singularidad en la lógica del conjunto—. La apuesta es a una coexistencia clínica, en la que cada quien puede hacer un recorrido en presencia de otros, sin ser forzado a adherir, pero sabiendo que no está solo.

La coordinación del grupo no se impone desde una lógica jerárquica. Se construye desde la escucha, desde la lectura clínica y desde la sensibilidad para detectar cuándo es posible abrir un espacio, cuándo es mejor esperar, cuándo intervenir y cuándo simplemente estar. En cada uno de esos movimientos, el equipo de acompañantes actúa como un cuerpo colectivo, sostenido por la reunión, la conversación clínica, la supervisión entre pares y el aprendizaje constante que impone lo real de la escena.

La grupalidad no está dada. Se produce. Y en esa producción, los acompañantes se vuelven piezas clave para la emergencia de un grupo que no aplaste, que no expulse, que no repita las violencias que muchas veces trajeron a esos adolescentes hasta allí. Un grupo que se permita ser, también, espacio de invención.

Adolescencias des-sujetadas: del acto al texto

Trabajar con adolescentes en contexto de internación en salud mental nos enfrenta, una y otra vez, a formas radicales del malestar. En muchos casos, ese malestar no encuentra palabra, no se inscribe en una narrativa ni se deja alojar en un discurso. Se presenta como ruptura, como irrupción, como acto. Cortes, ingestas, intentos de suicidio, crisis abruptas: gestos donde el cuerpo toma la palabra allí donde el lenguaje no alcanza, donde el dolor psíquico se expulsa en forma de acto porque no ha podido tramitarse simbólicamente.

Estas escenas no se explican desde un déficit o una falla individual. Más bien, son la marca de una fragilidad estructural del lazo social que, en la adolescencia, se vuelve insoportable. Años en los que lo infantil se derrumba sin que lo adulto se haya constituido; en los que la identidad tambalea y los referentes se desdibujan; en los que la sexualidad irrumpe sin nombre, cargada de intensidades difíciles de ordenar. La adolescencia es, por sí misma, una experiencia de límite. Pero cuando ese límite no encuentra borde simbólico, lo tanático puede ocupar la escena.

No hablamos solo de adolescentes en riesgo. Hablamos de adolescencias des-sujetadas: subjetividades sin anclaje, a la intemperie de la trama simbólica que permite sostenerse en el mundo. Chicos y chicas sin puntos de identificación estables, sin palabras que les devuelvan una imagen soportable de sí, sin adultos que habiliten un deseo. Y muchas veces, también, sin instituciones que escuchen, que apuesten.

Es en ese vacío donde el dispositivo de Acompañamiento Terapéutico Grupal se vuelve un recurso clínico singular. Porque no exige que el adolescente hable, pero le ofrece una escena donde eso puede suceder. Porque no pretende interpretar de inmediato el acto, pero lo aloja, lo pausa, lo rodea. Porque no pide sentido, pero construye condiciones para que, alguna vez, algo del sentido pueda advenir.

El grupo, en estos contextos, opera como campo de resonancia. No se trata de forzar identificaciones o de imponer relatos colectivos, sino de sostener una presencia entre otros, de habitar un espacio donde la palabra circule como posibilidad. Incluso cuando no se habla, incluso cuando todo se encarna en el gesto, en la mirada, en el silencio denso, la presencia del equipo y de los pares introduce un otro que puede alojar, preguntar, acompañar.

Cuando falta texto, el cuerpo actúa. Pero cuando hay alguien dispuesto a leer ese acto, a no rechazarlo, a no reducirlo a una conducta disruptiva o a un síntoma a controlar, entonces el acto puede empezar a devenir palabra. No es un pasaje garantizado, no es inmediato, y muchas veces ni siquiera es lineal. Pero es una posibilidad. Y esa posibilidad ya es clínica.

Dice Viviana Vangieri, en el marco de su trabajo con adolescentes en situación de riesgo, que “lo que urge es un acto que acompañe al sujeto a ubicarse en un encadenamiento que se ha caído, caído de la cadena significativa”¹ (Vangieri, 2023). En esa línea, el Acompañamiento Terapéutico Grupal no se ofrece como sustituto del encadenamiento perdido, sino como presencia que posibilita, con paciencia y cuidado, que ese encadenamiento vuelva a tejerse. Que el adolescente no quede aislado en su acto, que lo que se dice con el cuerpo encuentre, alguna vez, otra vía.

Por eso, frente al acto, el dispositivo no responde con control ni con castigo. Responde con escucha, con escena, con compañía. Se instala

1. Vangieri, Bibiana. (2023) Clase 8 de la *Diplomatura en Adolescencias en situaciones de riesgo. Autolesiones y suicidios. Intervenciones desde las instituciones*. AASM. Buenos Aires, Argentina

como un espacio donde se puede llorar, enojarse, preguntar, repetir, callar, sin que eso implique exclusión. Y donde cada pequeño gesto —una mirada, una intervención, una silla corrida, una pregunta al pasar— puede ser la punta de un hilo que permita reconstruir algo del tejido roto.

La clínica con adolescentes en internación no puede prescindir de este trabajo con el acto. Pero tampoco debe resignarse a él. La apuesta es siempre al lazo, a la palabra, a que algo se inscriba. Y en ese punto, el Acompañamiento Grupal no es sólo un recurso, es una forma de resistencia: una política del cuidado, una práctica que insiste en que cada quien merece ser alojado en su diferencia, incluso —y sobre todo— cuando no tiene aún las palabras para nombrarla.

Clínica entre varios: del acompañante al equipo

Si algo distingue al dispositivo de Acompañamiento Terapéutico Grupal en contexto de internación es que la figura del acompañante no se recorta como agente aislado, sino como parte de un entramado clínico construido entre varios. No hay aquí intervenciones individuales desligadas del colectivo, ni decisiones que se tomen por fuera de una conversación sostenida en el tiempo. La clínica se trama como una experiencia común, donde cada acompañante actúa en la escena sostenido por un nosotros.

Este “entre varios” no es un lema. Es una práctica. Cada guardia se organiza en torno a microequipos de 3 acompañantes que, más allá de su función operativa, encarnan un modo de estar y de hacer que solo cobra sentido si se comparte, si se discute, si se revisa. La intervención del acompañante, entonces, no responde únicamente a su percepción singular, sino que se inscribe en un dispositivo que promueve la circulación de la palabra entre los acompañantes tanto como entre los pacientes. El equipo se vuelve una instancia de validación, de resonancia y de soporte clínico.

En ese sentido, el acompañante no lleva solo su escucha: lleva también la escucha de otros. La escena con los adolescentes no está sostenida solo por su presencia, sino por un trabajo previo de elaboración colectiva —en reuniones, en intercambios informales, en la construcción paulatina de criterios comunes— que le permite inter-

venir con el respaldo de una mirada compartida. Lo que se habilita en la guardia no es un acompañante suelto improvisando en el terreno, sino un equipo que, a través de cada uno de sus miembros, actúa como cuerpo clínico.

Las reuniones semanales cumplen en este punto una función vital. Son el espacio donde se elaboran las escenas vividas, donde se tensionan decisiones, donde se reconstruye el clima de los vínculos entre los adolescentes, y también donde se tramitan los efectos que el trabajo produce en los propios acompañantes. Se construye allí una narrativa que no apunta a cerrar sentidos, sino a abrir preguntas, a dejarse afectar por lo que cada intervención ha movilizado, a pensar con otros lo que muchas veces resulta demasiado complejo o doloroso para ser pensado en soledad.

Esta clínica entre varios no excluye las diferencias. Al contrario: las diferencias es parte constitutiva del dispositivo. No todos los acompañantes intervienen igual, no todos leen del mismo modo, no todos afectan y se afectan del mismo modo. Pero esa diversidad, lejos de ser un obstáculo, se vuelve potencia en tanto se pone al trabajo. No se trata de homogeneizar estilos ni de silenciar matices, sino de que esas diferencias dialoguen, se tensionen, produzcan algo más. Que la escena no se cierre en una sola lectura, sino que se enriquezca en la conversación clínica que el equipo sostiene.

Además, la circulación de los acompañantes —el modo en que se relevan, se intercalan, se sustituyen entre guardias— introduce una dinámica que impide que el vínculo se estanque o se rigidice. El relevo no es solo una cuestión logística: es también una intervención clínica. Permite descomprimir escenas, abrir otros modos de vínculo, introducir variaciones que muchas veces habilitan la palabra allí donde estaba obturada. La discontinuidad, lejos de ser un problema, puede volverse aliada cuando se trabaja desde una lógica colectiva.

La clínica entre varios también implica la posibilidad de alojar los efectos subjetivos del trabajo para los propios profesionales. El Acompañamiento en internación con adolescentes no es neutro: conmueve, sacude, deja marcas. El equipo, entonces, no solo sostiene la escena con los pacientes: también se cuida a sí mismo. En la medida en que hay palabras para nombrar lo que duele, para compartir lo que angustia, para pensar lo que desborda, el dispositivo se protege de caer en el automatismo o en la desubjetivación.

En definitiva, lo que el dispositivo propone no es solo un trabajo con varios adolescentes, sino un modo de hacer clínica entre varios adultos. Una práctica que no se sostiene en la supuesta pericia individual, sino en la construcción compartida de un saber situado. Una ética del estar con otros que se juega tanto en la escena grupal como en el modo en que se organiza el propio equipo.

Intervención en la escena: hospitalidad y bordes

El ingreso de un adolescente a un dispositivo de internación en salud mental representa, muchas veces, un momento de ruptura. No solo por el alejamiento físico de su entorno habitual —familia, escuela, amigos—, sino porque también se trata de una suspensión abrupta de las coordenadas simbólicas que organizaban su mundo. En este contexto, el Acompañamiento Terapéutico Grupal ofrece una escena posible de llegada, una forma de bienvenida que no anula el extrañamiento, pero que se ofrece como borde hospitalario.

Decimos borde, y no límite estricto, porque la función que el acompañante encarna no es la de controlar o normativizar. Es la de ofrecer un umbral, una zona transicional entre lo ajeno y lo propio, entre el encierro institucional y el afuera que quedó suspendido. Cuando decimos que un adolescente “ingresa de la mano de un acompañante terapéutico”, no hablamos solo de una metáfora clínica: aludimos a un gesto concreto, ético y político. La mano tendida es la forma mínima de una hospitalidad que no impone, que no fuerza, pero que sostiene.

Esa escena de recepción no se agota en el primer día. Es una práctica sostenida en el tiempo, que implica leer los modos de estar de cada quien, su disponibilidad al lazo, sus formas de retraimiento o de exceso, sus rituales, sus silencios. El acompañante escucha con el cuerpo, interviene en la respiración del grupo, regula sin imponer. A veces interrumpe; otras, apenas roza la escena con una pregunta o una mirada. Lo importante es que no abandona el borde: se ubica allí donde puede alojar con disposición a acompañar.

En este punto, la escena grupal exige un cálculo clínico permanente. No se trata de permitir todo en nombre de la espontaneidad, ni de disciplinar en nombre del orden. Se trata de discernir cuándo una conducta es expresión de un malestar que necesita encontrar su forma, y cuándo

pone en riesgo el armado grupal. En ocasiones, una intervención puede consistir en contener a alguien que se desborda; en otras, en interpelar a quien se retrae. El acompañante lee la escena y actúa desde una posición de presencia clínica.

La hospitalidad que el dispositivo propone no es ingenua. Sabe que el grupo puede ser tanto espacio de sostén como escenario de nuevos rechazos. Por eso se interviene con cuidado, con atención a los movimientos singulares y a las resonancias colectivas. Una conducta disruptiva puede suscitar miedo, rechazo, identificación, burla o conmoción entre los demás adolescentes. El trabajo del equipo es también intervenir sobre esas resonancias, para evitar que se repita la lógica del aislamiento o la exclusión.

El acompañamiento en escena no es solo entre acompañante terapéutico y paciente. Lo que se produce, muchas veces, es una red vincular que habilita otras formas de estar. Es frecuente que un adolescente en crisis encuentre más regulación en un gesto espontáneo de un par —un abrazo, una mirada, una imitación empática— que en la palabra adulta. El dispositivo se abre también a eso: a la posibilidad de que el lazo no se organice jerárquicamente, sino que circule, que se desplace, que encuentre otras rutas.

En ese sentido, el equipo de ATs no solo interviene en el grupo, sino que lo produce. Lo constituye como escena clínica y lo cuida como trama posible. No hay garantía de que siempre funcione, ni de que el lazo se sostenga sin tensiones. Pero hay una insistencia: cada día, cada guardia, cada escena, es una nueva ocasión para relanzar la apuesta. Para decir, con la presencia, con el cuerpo y con la escucha: “hay lugar para vos, aún en el desborde”.

El Acompañamiento Terapéutico Grupal se hace fuerte en esa posición intermedia: entre la rigidez de la norma institucional y el caos que puede advenir cuando no hay bordes. Ni neutralidad pasiva ni control disciplinario. Un modo de estar que implica disponibilidad, atención, sensibilidad, y también firmeza clínica. Porque si hay hospitalidad, es precisamente porque hay bordes. Y si hay bordes, es para que lo que llega —por más extraño, desorganizado o doloroso que sea— tenga un lugar donde aterrizar sin caer al vacío.

El grupo como regulador: escenas clínicas

Uno de los aspectos más potentes del dispositivo de Acompañamiento Terapéutico Grupal en internación es la posibilidad de que el grupo mismo opere como agente clínico, como regulador subjetivo. En un contexto donde muchas veces la palabra está ausente o resulta insuficiente, el lazo con los otros —los pares, los acompañantes— se vuelve una herramienta vital para habilitar tramitaciones, contener actos, y también permitir que algo del deseo se diga sin necesidad de ser formulado explícitamente.

No es casual que muchas escenas clínicas destacadas dentro del dispositivo sean aquellas donde la intervención más significativa no vino del adulto, sino de un par. Una paciente que gira alrededor de una silla como parte de sus rituales encuentra, para su sorpresa, que otra adolescente, sin que nadie lo sugiera, replica ese gesto y se suma a la escena. No lo hace para burlarse, sino para acercarse, para decir con el cuerpo: “entiendo algo de lo que estás haciendo, y no te dejo sola”. Esa intervención no se planificó, no se pautó en una reunión: emergió de la sensibilidad grupal, de la disponibilidad de una joven a mirar y a implicarse en el mundo del otro.

En otro momento, un paciente que atraviesa una crisis de enojo recibe múltiples intervenciones verbales de los adultos, sin resultado. La tensión crece. Hasta que otra adolescente se acerca y, sin mediar palabra, lo abraza. Y es ese gesto, inesperado, el que opera la transformación de la escena: el otro se deja abrazar, baja la intensidad, aparece una pausa. Ahí donde las palabras no alcanzaban, el cuerpo del otro sostuvo.

El grupo no es siempre ese lugar de regulación espontánea. También puede ser un espacio de contagio, de escalada, de desborde. Por eso, el trabajo del equipo de acompañantes es tan delicado: debe saber cuándo confiar en la dinámica entre pares, cuándo intervenir para prevenir un deterioro, y cuándo propiciar que ciertas experiencias colectivas tengan lugar. No hay fórmulas. Cada escena exige una lectura clínica precisa, una disposición a actuar sin certezas.

El grupo regula cuando es posible constituir una escena común, un nosotros donde cada uno pueda implicarse sin ser devorado. Esa implicación no requiere hablar ni exponerse. A veces se da en un juego compartido, en una película que se mira juntos, en el tiempo libre sin pauta, en

la espera compartida. En esos momentos, los adolescentes se enlazan, se observan, se escuchan, a veces sin hablar. Y en ese entre, empieza a surgir algo que estaba obturado: preguntas, angustias, proyectos, recuerdos, palabras nuevas.

La intervención del acompañante no es reemplazada por la fuerza del grupo. Por el contrario, es su presencia la que habilita al grupo a volverse continente. La tarea clínica consiste en hacer lugar para que eso ocurra, sin forzarlo. En sostener los hilos de una trama que se rehace a cada instante, y que puede romperse fácilmente si no se la cuida. Por eso, lo que el equipo construye no es solo una dinámica grupal, sino una disposición clínica que acompaña, que regula y que habilita.

El efecto regulador del grupo también se juega en los tiempos. No solo se trata de intervenir en una escena puntual, sino de sostener una cotidianeidad donde cada quien se sienta incluido en una rutina que lo tiene en cuenta. Los horarios de comida, los talleres, las visitas, las pausas: todo eso forma parte de una temporalidad que organiza, que ofrece anticipación y previsibilidad. En esa temporalidad compartida, el grupo encuentra un ritmo, y cada adolescente puede ir tramitando su propia posición en relación a los otros.

Cuando se trabaja desde la perspectiva del lazo, cada escena clínica se vuelve una oportunidad. Una crisis no es solo un episodio a resolver; es una ocasión para tejer sentidos. Un gesto agresivo no es solo una amenaza; puede ser leído como un pedido de inscripción. Un silencio tenso no es solo ausencia de palabra; puede ser el tiempo previo a que algo se diga. Y el grupo, cuando está sostenido, puede operar como soporte de esas escenas.

En ese sentido, el dispositivo no se limita a observar lo que pasa: lo produce. Produce condiciones para que lo que pasa se vuelva legible, tramitable, transformable. Y cuando eso ocurre, el grupo deja de ser solo un conjunto de individuos compartiendo un espacio, para volverse una red viva, capaz de sostener a cada uno sin aplastarlo.

El afuera como horizonte: alta, palabra y proyecto

La internación en salud mental representa, para muchos adolescentes, una experiencia ambigua: por un lado, puede ser un tiempo de cierta pausa del malestar, una interrupción del circuito de actos o

violencias en las que estaban atrapados; por otro, es también vivida como encierro, como suspensión de la vida, como un tiempo incierto y sin garantías. En esa tensión, el dispositivo de Acompañamiento Terapéutico Grupal se posiciona no solo para sostener el presente de la internación, sino también para volver pensable el futuro, para anudar algo de esa experiencia al horizonte del alta, a un afuera que no quede clausurado por el encierro.

El Acompañamiento no promete salidas rápidas ni alienta fantasías de resolución mágica. Pero está ahí, disponible, para alojar las preguntas que emergen: ¿cuánto tiempo voy a estar acá?, ¿cuándo me voy?, ¿qué pasa si no salgo nunca más? Preguntas que no siempre buscan una respuesta literal, sino un espacio donde decirse, donde ser escuchadas. Frente a esas inquietudes, el equipo no apura ni desvía: habilita el tiempo del decir, sostiene la escena, y cuando es necesario, señala —con palabras y con gestos— que el alta no es un mito, sino una posibilidad real.

El proceso de externación no es una fecha en el calendario. Es un movimiento subjetivo que comienza mucho antes de que el adolescente abandone la institución. A medida que la internación avanza, y en la medida en que se sostiene una red vincular y una rutina posible, empiezan a aparecer signos de ese movimiento: deseos de salir, recuerdos del afuera, proyectos incipientes, curiosidades. El equipo de acompañantes escucha y amplifica esos signos, los hace circular, los enlaza con el presente para que no queden suspendidos como ideal inalcanzable.

Las pequeñas instancias de salida —salidas cortas, visitas al hogar, permisos de fin de semana— son hitos que el grupo acompaña y comenta. Se vuelven parte de la trama grupal. Así, el alta deja de ser un acto individual y aislado, y se transforma en una experiencia compartida, anticipada por todos. Cada egreso modifica al grupo: genera angustias, reacomodamientos, preguntas. Y el equipo se dispone a escuchar esos movimientos, sin negarlos, sin evitar el duelo que implica la pérdida de un otro con el que se había construido un lazo.

En ese tránsito, el Acompañamiento también cumple una función de traducción: ayuda a transformar lo vivido durante la internación en relato, en experiencia que pueda ser significada. No se trata de enumerar logros, ni de cerrar el proceso con un balance positivo. Se trata de poder historizar algo de lo vivido, de construir una narrativa que habilite una continuidad entre el adentro y el afuera. Que el adolescente no salga

como quien despierta de un paréntesis, sino como quien ha transitado un tiempo con sentido, por más fragmentario o complejo que haya sido.

En muchas ocasiones, los adolescentes encuentran en el grupo un espacio para proyectar. No en el sentido de planear objetivos grandilocuentes, sino en el gesto mínimo de anticipar algo: volver a la escuela, visitar a un familiar, escribir, dibujar, escuchar música con alguien. El equipo de acompañantes no propone esos proyectos, pero está atento a ellos. Los celebra, los nombra, los sostiene. Porque cada deseo que logra decirse en voz alta, en el contexto de una internación, es una apuesta a la vida, una inscripción en el porvenir.

Incluso cuando no hay una fecha definida, incluso cuando la externación se demora, el equipo mantiene presente esa perspectiva como horizonte. El afuera existe. Lo que se vive en la internación no agota la biografía. El padecimiento no es todo. Esa insistencia —a veces silenciosa, a veces explícita— es una forma de resistir lo difícil del encierro, de sostener la dimensión temporal de la subjetividad, de afirmar que el sujeto no se reduce a su síntoma, ni a su diagnóstico, ni a su conducta actual.

Así, el Acompañamiento Terapéutico Grupal, cuando aloja el deseo de salida, de continuidad, de vida, se transforma en un lugar de pasaje. Una clínica del mientras tanto, pero también del después. Porque incluso en los contextos más restrictivos, siempre se puede ofrecer una puerta entreabierta hacia otro tiempo posible.

Conclusión: el AT grupal como política del lazo

Pensar el Acompañamiento Terapéutico Grupal en contexto de internación es afirmar que incluso en los márgenes, en los intersticios de la clínica, en los tiempos muertos de la internación psiquiátrica, es posible sostener una escena que habilite el lazo.

Lo grupal no se juega aquí como formato técnico ni como técnica terapéutica convencional. Es una posición. Una apuesta por construir comunidad incluso entre fragmentos, por armar trama allí donde predomina la disgregación, por escuchar lo que no encuentra palabras y sostener lo que se dice con el cuerpo. En este sentido, el dispositivo no solo acompaña. Actúa. Interviene en la escena institucional, la modifica, produce nuevas formas de estar juntos que no estaban previstas.

Que este dispositivo se construya desde un equipo externo, que se inscriba como recurso adicional en una institución ya organizada, no es un detalle menor. Implica moverse en tensión permanente entre el deseo de sostener una práctica singular y la necesidad de operar en un espacio regulado por otras lógicas. Requiere una lectura política de lo institucional, una sensibilidad para no quedar atrapado en la lógica de la excepción, y una firmeza clínica para sostener lo específico del Acompañamiento sin quedar subsumido en la lógica de la asistencia tradicional.

Frente al riesgo de la homogeneización —el “para todos lo mismo” que requieren las internaciones psiquiátricas— el dispositivo de AT propone una práctica artesanal. Una construcción paciente, situada, que se rehace en cada escena, en cada guardia, en cada gesto. No se trata de resistir por fuera, sino de insistir por dentro: abrir espacios de diferencia en el interior mismo del dispositivo cerrado, sostener la singularidad sin dejar de cuidar al colectivo, mantener viva la pregunta por el sujeto aún cuando todo invite a mantener el control y hacer cumplir las reglas.

Por eso decimos que el Acompañamiento Terapéutico Grupal, tal como se despliega en esta experiencia, es una política del lazo. Porque no trabaja solo con el síntoma, sino con las condiciones de posibilidad de una subjetivación. Porque no interviene desde un lugar de saber cerrado, sino desde una posición de apertura y disponibilidad. Porque no ofrece respuestas acabadas, sino una presencia sostenida que permite que algo se diga, se construya, se enlace.

En tiempos donde lo comunitario se fragiliza, donde el cuidado se burocratiza y el dolor se aísla, el dispositivo que aquí se presenta insiste: hay otra forma de estar con otros. Una forma que no niega el padecimiento, pero no lo reduce al diagnóstico. Una forma que no sustituye los tratamientos, pero los complejiza. Una forma que no espera a que el sujeto “se acomode”, sino que se acomoda a su tiempo, a su modo, a su ritmo.

Una forma, en definitiva, que hace del lazo no solo un medio, sino un fin en sí mismo.

* * *

El Acompañamiento Terapéutico en su dimensión uno a uno y sus distintos ámbitos de inserción

Hemos repetido en reiteradas ocasiones que el Acompañamiento Terapéutico, como intervención individual, es un dispositivo caracterizado por su inclusión en la cotidianeidad de la persona asistida. Esa es su marca registrada. Se trata de un agente ligado a la salud mental que se acerca a la problemática del individuo y comparte con él su día a día, con una presencia efectiva, donde y cuando las cosas suceden. Este aspecto concreto y definitorio de la identidad del Acompañamiento Terapéutico es crucial para comprender la exigencia de adaptación que requiere su implementación. Lo que ofrece el recurso en última instancia es un modo relacional particular, caracterizado por su posicionamiento clínico, con disposición a alojar la propuesta vincular que proponga el acompañado.

Los abordajes terapéuticos tradicionales asumen un conocimiento particular y convocan, a la hora de implementar su intervención, a la construcción de un espacio organizado según las coordenadas de su propuesta. En cambio, el Acompañamiento Terapéutico no sigue esa linealidad. Su condición de existencia se ajusta y adapta a las coordenadas propuestas por la cotidianeidad a la que se enfrenta. En estas condiciones singulares, el acompañante busca su lugar en el entramado de relaciones que rodean al paciente. Este es un desafío poco valorado en la práctica del Acompañamiento Terapéutico, ya que no es posible anticipar las coordenadas de cada encuentro. Lo cotidiano y el contexto se convierten en parte de nuestra escena, condicionando tanto el lugar desde donde intervenimos como las posibles intervenciones del acompañante.

Es una realidad que el Acompañamiento Terapéutico ha crecido significativamente en los últimos años. No solo hay una mayor demanda de acompañantes, sino que esta demanda se ha vuelto más variada y diversa. Es un hecho que las solicitudes de Acompañamiento provienen a menudo de ámbitos completamente ajenos a la perspectiva clínica que dio origen a esta función.

Probablemente, esta capacidad particular del Acompañamiento Terapéutico para adaptarse al entorno es una de las razones por las que se han multiplicado los ámbitos de inserción de este recurso. En la vida de los sujetos suceden cosas y, cuando se considera necesaria una inter-

vención in situ, cuando se necesita un agente que participe e intervenga desde la misma escena para modificar sus coordenadas, este agente lleva el nombre de Acompañamiento Terapéutico.

En tales ocasiones, hay que tener en cuenta que estos campos de intervención, cada ámbito en el que nos estamos incluyendo, cargan cada uno con su propio andamiaje de significaciones, y estas no siempre coinciden con el criterio o las coordenadas que dan fundamento a un Acompañamiento Terapéutico tradicional.

Cuando se articulan los discursos, cuando se convoca un Acompañamiento Terapéutico desde un campo discursivo distinto al clínico, los discursos tensionan, se potencian, se anulan, se confunden... En el mejor de los casos dichas tensiones son el caldo de cultivo para una significación novedosa. Sin embargo, entendiendo que quienes encarnan los discursos son sujetos singulares, atravesados por esta misma disputa de sentidos, incluso en ocasiones con cierto espíritu corporativo, es fácil visualizar porque se hace difícil la articulación. En otras palabras, es habitual que la solicitud de Acompañamiento tenga sentido solo en la lógica discursiva en la que fue considerada y que no responda en su estructura a una demanda genuina de Acompañamiento Terapéutico en términos clínicos.

Podemos organizar, y de hecho se organizan Acompañamientos Terapéuticos en estos ámbitos diversos. El punto es que frente a esta realidad, si decidimos prestarnos a dicha articulación discursiva, resulta ineludible ejecutar un acto de traducción que al menos opere sobre nosotros mismos. No podemos pedir que quien solicita un Acompañamiento Terapéutico entienda el sentido ético y político de nuestra práctica, que la solicitud de Acompañamiento se organice con nuestro propio esquema de significaciones, que la demanda llegue articulada bajo las mismas coordenadas clínicas que conforman nuestra identidad. Al mismo tiempo, no tendría ningún sentido confrontar con quien solicita el recurso. Por el tipo de función que cumplimos, al habitar la cotidianidad, la solicitud suele venir asociada a ciertos actos concretos que le dan fundamento. El Acompañamiento se pide para algo... La apuesta es caminar por el sendero planteado en la solicitud sin perder nuestra esencia. Se puede cumplir con cierta indicación precisa que se nos allá dado, solo que la intervención no puede limitarse a ello.

Creemos que es un paso importante que se convoque el recurso Acompañamiento Terapéutico para ser implementado en ámbitos no tradicionales. Da cuenta de la potencialidad de la función... El punto es que

hay que tomarlo con responsabilidad y garantizar con criterio profesional, con elaboración clínica, la coherencia y el sentido de nuestra intervención. El compromiso es poner trabajar la solicitud de Acompañamiento para construir allí una demanda de Acompañamiento Terapéutico, y con ello un caso clínico.

En esta expansión que ha tenido el Acompañamiento Terapéutico podemos encontrar cuatro grandes campos de inserción

- El campo jurídico
- El campo de la educación
- El campo Institucional Sanitario
- El campo clínico domiciliario

Es evidente que se podría ampliar este listado, e incluso se podría hilar más fino dentro de cada uno de los campos enunciados. Sin embargo, entiendo que en estos cuatro grandes ámbitos encontramos los cuatro discursos más potentes, más influyentes con los que articula el Acompañamiento Terapéutico como práctica. No agota el mapa posible de intervenciones, pero permite situar con claridad las tensiones, desafíos y oportunidades que emergen cuando el dispositivo se despliega en los distintos territorios.

El campo jurídico

Pensar el campo jurídico es tomar en consideración cómo una sociedad se da a sí misma una organización, una forma. No hay derecho sin comunidad, ni comunidad sin conflicto. El derecho no aparece para suprimir el desacuerdo, sino para establecer un marco dentro del cual ese desacuerdo no destruya el lazo social. Desde esta perspectiva, el derecho no es solo una tecnología de control ni un instrumento Estatal: es una forma simbólica de tramitar la vida en común.

El derecho, en su mejor expresión, opera como un espacio de interdicción y garantía: interdicción de la violencia arbitraria, del uso unilateral de la fuerza, del abuso de poder; garantía de los derechos más elementales, de la posibilidad de vivir con otros sin ser arrasado por ellos. En ese sentido, la ley no es solamente un límite, sino también una promesa de que hay un marco al que todos –al menos en el plano simbólico– estamos igualmente sometidos.

Esa igualdad, sabemos, es siempre una construcción imperfecta. El derecho no escapa a las relaciones de poder, ni está exento de sesgos, exclusiones y mecanismos de reproducción de privilegios. Pero incluso en su dimensión más ideológica, el campo jurídico produce efectos de subjetivación y de reconocimiento. Cuando un sujeto logra nombrar un padecimiento como injusticia, cuando puede reclamar un derecho, cuando puede apelar a una figura jurídica para proteger su integridad, algo de lo común se pone en juego.

En sociedades marcadas por la desigualdad estructural, el derecho se vuelve un terreno de disputa. Disputa por la palabra válida, por el estatuto del sufrimiento, por el acceso a los recursos simbólicos que permiten nombrar una situación como legítima o ilegítima. En este punto, el derecho es también una forma de lenguaje, y como todo lenguaje, tiene reglas, exclusiones y condiciones de posibilidad.

Sin embargo, a pesar de esa restricción, el campo jurídico ha sido históricamente una plataforma clave para la ampliación de derechos y la conquista de dignidades. Los movimientos feministas, los colectivos de personas con discapacidad, los trabajadores organizados, los pueblos originarios: todos han encontrado en el lenguaje jurídico una herramienta para disputar su lugar en el mundo.

En este sentido, lo jurídico no es simplemente un campo técnico, sino un espacio político de sentido, donde se juegan los modos en que una sociedad decide reconocer al otro, alojar la diferencia, distribuir los bienes comunes. Si el derecho puede ser una trampa, también puede ser una apertura. Si puede cristalizar el orden existente, también puede ser un vector de transformación.

Para quienes intervenimos en el campo clínico, especialmente en prácticas como el Acompañamiento Terapéutico, es clave no romantizar ni demonizar el derecho, sino leerlo en su ambivalencia. Comprender que en su marco se organizan muchas de las condiciones de existencia de las personas con las que trabajamos: su acceso a la salud, a un ingreso, a una vivienda, a la libertad. Pero también comprender que el derecho no agota la dimensión del padecimiento, ni siempre está a la altura del sufrimiento subjetivo.

El campo jurídico ocupa un lugar privilegiado, no sólo por la centralidad simbólica que detenta en la vida social, sino por su capacidad de producir efectos materiales directos en la vida de las personas. Su peso específico en el orden social es innegable.

No podemos eludir que el peso que dicho discurso porta, también empodera a los agentes judiciales advertidos del lugar que les toca ocupar en la representación social de su función. Desde esta posición de autoridad, los agentes judiciales –jueces, defensores, curadores, equipos técnicos– no solo aplican normas, sino que también producen sentido. Administran recursos, definen necesidades, delimitan responsabilidades. Y entre esos recursos, cada vez con más frecuencia, convocan al Acompañamiento Terapéutico. Ahora bien, la lógica que organiza esta convocatoria no siempre se funda en una demanda clínica. Muchas veces responde a la necesidad de “resolver algo”: garantizar una salida, sostener una rutina, supervisar una situación.

Pensemos una primera viñeta:

Una persona lleva más de quince años internada en el Hospital Moyano. Desde la Defensoría Pública Curaduría se solicita un acompañante para que la persona pueda salir a tomar un café una vez por semana. La intención es clara y comprensible: ofrecer una experiencia distinta, romper con la lógica del encierro, generar algún grado de apertura al lazo social.

El agente judicial comprende que el alto grado de institucionalización es un factor complejo en la vida de esa persona, incluso que opera de modo iatrogénico promoviendo su aplanamiento subjetivo. Sabe que la institucionalización prolongada ha tenido efectos devastadores y que es necesario ofrecer alternativas. Su modo de aportar a la situación se construye bajo las coordenadas del sentido común. “Que salga de la institución”. Entiende que es su derecho que esa salida sea contemplada, que debe ser financiada por su seguro de salud o por el Estado mismo. Lo que no siempre se considera –y no tiene por qué ser así– es que la verdadera marca de la institucionalización no reside únicamente en los muros físicos, sino en las coordenadas vinculares que ese encierro reproduce.

Una salida semanal a una cafetería puede resultar placentera. Pero si no se articula con una estrategia terapéutica más amplia, si no se inscribe en una construcción clínica con el paciente, si no se aloja la posibilidad de decir sobre esa experiencia, el riesgo es que la intervención quede reducida a una acción asistencial o, peor aún, a una confirmación del lugar de objeto que históricamente ha habitado esa persona.

Ante esta escena, el Acompañante queda entre dos riesgos simétricos: oponerse directamente a la indicación –lo que probablemente lleve a su remoción–, o ejecutarla sin cuestionamiento, transformándose en agente de la cronificación.

Lo que habilita una salida ética y clínica es otra cosa: alojar la solicitud sin perder la brújula del dispositivo, comenzar a entablar el vínculo terapéutico con el acompañado, armar lazo con el agente judicial y con los tratantes del paciente y desde allí generar una indicación más acorde al trabajo terapéutico. El desafío es transformar una indicación literal en una intervención clínica.

Otra viñeta:

Una Defensora Pública Curadora solicita que el acompañante administre una suma mensual de dinero, destinada a la compra de objetos personales y alimentos que mejoren la calidad de vida de su representado.

No hay duda que cualquier avance en este sentido es en beneficio de la persona. La intención es legítima y valiosa. El Curador promueve un uso del dinero a favor de la persona involucrada. Se busca ampliar las posibilidades de elección, dignificar el cotidiano, incluir el deseo en lo mínimo: elegir una pasta de dientes, una golosina, un desodorante. Tal como venimos diciendo, es lógico que el pedido surja por parte del agente Judicial en las coordenadas que hacen a su propio discurso. Sin embargo, la indicación omite –porque no está pensada desde ese registro– el impacto transferencial que puede implicar que el acompañante se convierta en quien “da”, en el gestor de ese dinero, en el mediador del acceso al goce.

Aquí también, lo relevante no es negar la indicación, sino leerla, alojarla, y trabajarla. Es posible que esa función pueda ser sostenida por el acompañante, pero solo si se la inscribe en una estrategia clínica clara, que mantenga en tensión su efecto simbólico y evite desdibujar los lugares subjetivos. De lo contrario, la función terapéutica queda colonizada por una lógica asistencial que anula su potencia transformadora.

El campo jurídico, con su fuerza normativa y su eficacia material, puede ser un aliado decisivo en la construcción de derechos. Pero también es un discurso que, al organizar las intervenciones desde la

lógica de la resolución, puede reducir la complejidad clínica a un acto administrativo. Allí radica una de las tareas fundamentales del Acompañamiento Terapéutico: ejercer una lectura propia, sostener su marco de referencia, y transformar cada solicitud en una escena de intervención subjetivante.

¿Es viable llevarlo a cabo? Probablemente sí, pero solo a condición de comprometerse a un ejercicio de problematización, y en todo caso mantener en tensión las implicancias transferenciales de nuestra presencia, la proyección a futuro de esa intervención, el aporte que puede significar el recurso en términos clínicos para ese sujeto. En última instancia, la clínica son apuestas sostenidas en una reflexión basada en coordenadas propias del discurso clínico. Ejercer esa lectura es nuestra responsabilidad.

También vale considerar si efectivamente ese pedido debió ser dirigido a un Acompañante Terapéutico. Que la intervención se dé en la cotidianeidad del acompañado no es, por sí sola, garantía de que se trate de Acompañamiento Terapéutico. Lo que define la especificidad del dispositivo es su fundamento clínico, su orientación ética y su inscripción en un campo de lectura que no se limite a responder al mandato externo, sino que se sostenga en una apuesta por la subjetividad.

El campo de la educación

La escuela, aun con todas sus contradicciones, sigue siendo uno de los espacios más potentes que una sociedad ha inventado para encontrarse, para pensarse a sí misma, para proyectar futuro. No es –ni debe ser– solo un lugar de instrucción, sino un territorio donde se disputan sentidos, se producen subjetividades y se habilitan (o se clausuran) horizontes de posibilidad.

Desde una perspectiva social y crítica de la educación, como la que propone Paulo Freire, la escuela no puede ser entendida como una institución neutra. Su práctica está cargada de ideología, de relaciones de poder, de concepciones implícitas sobre el saber, la infancia, la normalidad, el progreso. Pero a la vez, es en ese mismo entramado donde se abre la oportunidad de una pedagogía transformadora: una pedagogía que no reproduzca el orden existente, sino que lo interpele, lo cuestione, lo incomode.

La educación, en este marco, no se limita a transmitir contenidos. Es siempre un acto político, un encuentro entre sujetos que se reconocen como inacabados, como aprendices mutuos.

En un contexto marcado por la fragmentación social, la desigualdad estructural y la mercantilización de los vínculos, la escuela es también uno de los pocos espacios donde lo común aún tiene lugar. Allí donde todo empuja al individualismo, la lógica escolar –con sus rituales, sus reglas, sus tiempos compartidos– sigue proponiendo algo que se construye entre muchos. Esa dimensión colectiva, cuando no se vuelve autoritaria ni homogénea, puede ser profundamente democratizadora.

Claro que esto no ocurre automáticamente. La escuela puede ser también reproductora de exclusión, de estigmas, de violencias silenciosas. Pero esa posibilidad no debe llevarnos a renunciar a ella. Muy por el contrario: debe empujarnos a radicalizar su sentido público, su vocación igualitaria, su potencia como espacio de subjetivación.

Porque la escuela no solo forma ciudadanos: forma sensibilidad social. Introduce a los niños y jóvenes en un lenguaje común, en una historia colectiva, en un horizonte compartido. Cuando lo hace desde una pedagogía de la escucha, desde una ética del cuidado, desde una práctica que no humilla sino que habilita, se vuelve un lugar donde puede comenzar una existencia más digna.

Y ese es, quizás, su mayor aporte a la vida en sociedad: proponer la idea de que todos tenemos algo para decir, algo para enseñar, algo que aprender juntos. En tiempos donde la palabra se degrada, donde el lazo se rompe, donde el otro aparece cada vez más como amenaza, la escuela puede ser ese espacio que insiste con ternura en la posibilidad de un nosotros.

Sin embargo, ese valor no debe ocultar que también es una maquinaria institucional con efectos muchas veces excluyentes. Produce subjetividades que se ajustan a un ideal de alumno: previsible, atento, productivo. Y cuando ese molde no se alcanza, el sujeto queda marcado como problema.

La escuela, entonces, no es solamente una promesa: es también un límite. Su estructura puede albergar proyectos emancipadores o reforzar la lógica del castigo. Puede habilitar una palabra o convertirla en síntoma. Puede formar lazos o cristalizar jerarquías. No es un espacio vacío que espera ser llenado de sentido, sino un territorio ya saturado, donde intervenir exige lectura, cuidado y decisión política.

Por todo esto, el campo educativo es uno de los territorios más fértiles

para pensar los desafíos y las potencialidades del Acompañamiento Terapéutico. Se trata de un ámbito atravesado por múltiples tensiones, donde se cruzan políticas públicas, marcos normativos, proyectos pedagógicos institucionales, historias singulares de aprendizaje, trayectorias interrumpidas, diagnósticos que etiquetan, y prácticas que –con mayor o menor conciencia– producen inclusión o exclusión.

La escuela, como institución moderna, no es simplemente un espacio de transmisión de saberes. Es también –y quizás sobre todo– una maquinaria de producción de subjetividades. A través de su organización del tiempo, del espacio, de los cuerpos, de los discursos y de las jerarquías, la escuela inscribe formas específicas de estar, de hablar, de comportarse y de significarse. La escuela no solo educa: moldea.

Algunas de las características más relevantes de esa producción subjetiva son:

- **Normalización del comportamiento:** La escuela produce subjetividades ajustadas a un ideal de alumno: atento, silencioso, obediente, progresivo, previsible. Quien se desvía de esa norma, es nombrado como “disruptivo”, “inmaduro”, “violento” o “inadaptado”. La subjetividad escolarizada es, en gran medida, una subjetividad normalizada.
- **Centralidad de la evaluación:** La escuela estructura su vínculo con los sujetos en torno a la evaluación. Se evalúa el rendimiento, la conducta, la participación. Esta lógica instala un modo de subjetivación ligado al deber-ser y a la mirada del Otro como agente de validación o exclusión.
- **Homogeneización de trayectorias:** La escolarización tiende a homogeneizar: se espera que todos aprendan lo mismo, al mismo tiempo y del mismo modo. Las diferencias subjetivas son rápidamente transformadas en déficit, patologizadas o externalizadas.
- **Producción de subjetividades escolarizadas:** La escuela no solo educa, también produce modos de estar en el mundo: subjetividades que temen al error, que buscan agradar, que internalizan jerarquías, que se autoevalúan, que reproducen los mandatos del sistema educativo incluso fuera de él.
- **Negación estructural del conflicto:** El conflicto suele ser leído como fracaso institucional. Hay una tendencia a negarlo, suprimirlo o derivarlo.

Como ya mencionamos, el discurso educativo tiene la potencia de convocar lo común, lo colectivo, lo que se organiza en torno a una idea de ciudadanía, de comunidad de aprendizaje. Pero también se ve condicionado por lógicas normalizadoras, exigencias de rendimiento y expectativas que no siempre contemplan la singularidad.

Proponemos que las características mencionadas no sean leídas de modo fatalista, sino como puntos de partida para pensar intervenciones que habiliten otras formas de presencia, de lazo y de inscripción subjetiva. El Acompañamiento Terapéutico, en tanto dispositivo que no pretende adaptar sino alojar, puede operar como una cuña en esas lógicas, abriendo preguntas allí donde se buscaba ajuste.

En este entramado complejo, la inclusión de un Acompañamiento Terapéutico suele tener como punto de partida una dificultad: un niño, niña o adolescente que no logra sostener su recorrido escolar del modo esperado. Dicha solicitud suele estar mediada por el requerimiento de la escuela, de la familia o de un equipo clínico, y organizada bajo la lógica de “contener”, “ordenar” o “evitar conductas disruptivas”. En muchos casos, se espera del acompañante que actúe como una suerte de mediador conductual o de “sombra” que facilite la adaptación del sujeto a los ritmos escolares.

Es habitual que en algunas escuelas se viva la irrupción del síntoma como una amenaza a su funcionamiento. Se trata de una presencia disruptiva que pone en tensión la pretendida linealidad del proceso educativo. El problema de conducta irrumpe allí donde se esperaba homogeneidad, continuidad, éxito académico. Frente a esta escena, muchas instituciones tienden a leer el problema en términos de “desajuste” individual, lo que habilita la delegación del conflicto en un tercero. La solicitud de un Acompañante no siempre surge como parte de una estrategia integradora, sino como un modo de externalizar el conflicto: un gesto que permite “marcar” el problema, encapsularlo y restituir una apariencia de normalidad.

En esta operación, el Acompañamiento funciona muchas veces como un recurso que permite a la escuela correrse de la responsabilidad institucional que le cabe en la producción de inclusión. Se trata de una forma de nombrar la diferencia para luego encapsularla en un dispositivo, dejando intacta la lógica que produjo el rechazo. El acompañante se vuelve entonces la figura que “contiene”, “acomoda” o “sostiene”, allí donde la escuela ha perdido capacidad de conten-

ción. El síntoma queda así aislado en un cuerpo, y el lazo social que lo produce se invisibiliza. De este modo, el Acompañamiento se constituye en un anhelo de integración escolar que opera redoblando las condiciones de exclusión.

Tal como sucede en otros ámbitos de inserción, estas solicitudes no siempre llegan con un encuadre clínico claro. El riesgo es que el Acompañante se vea atrapado en una función de control, ajena a los fundamentos de su práctica. Sin embargo, también aquí se abre la posibilidad de construir demanda, de alojar el motivo de consulta y comenzar un trabajo que introduzca una lectura subjetivante.

Tomemos una viñeta:

se solicita un acompañante para un niño de 8 años que “no se queda quieto en clase”, “interrumpe a los docentes” y “molesta a sus compañeros”. Se espera que el Acompañante logre que el niño permanezca sentado, que no interrumpa y que “se comporte como los demás”.

Si bien el pedido puede sonar reduccionista, y de hecho lo es, sería erróneo desecharlo sin más. La clave está en no quedar atrapados por la literalidad de la solicitud, sino en alojarla, construir un vínculo con el niño, leer las escenas que se presentan en la escuela y en el cuerpo docente, y habilitar con el niño –y con los adultos implicados– otros modos posibles de estar. Quizás, con el tiempo, esa presencia permita introducir una pregunta por el malestar que se actúa, por la función que tiene ese “interrumpir”, por el lugar que ocupa ese niño en la trama escolar.

El Acompañante puede entonces operar como un punto de apoyo subjetivo, como una presencia que permite leer lo que pasa más allá del síntoma, que ofrece una interlocución sostenida, que habilita una narrativa propia del sujeto en el campo escolar. Y esto, claro está, exige una lectura clínica, no pedagógica, ni meramente adaptativa. La intervención se inscribe en un territorio ajeno, con reglas propias, en el que es necesario construir una escena de trabajo sin disputar la autoridad pedagógica, pero sin ceder en la lectura del malestar.

La articulación con los docentes y el equipo institucional es clave. No se trata de confrontar con la lógica escolar, ni disputar la construcción de verdad respecto del problema en cuestión, sino de sostener nuestra posición clínica en el marco de una intervención que habita ese otro

discurso. Se trata de intervenir sin diluirse, de sostener la pregunta por el sujeto incluso cuando el contexto empuja a responder por la conducta.

Es crucial comprender que la presencia de un Acompañante Terapéutico introduce inevitablemente una mirada externa en el seno de la escuela. Se trata de un agente ajeno a la dinámica institucional, que porta consigo otra lectura, otro modo de estar y de intervenir. En ese sentido, es lógico —y esperable— que surjan resistencias por parte de la escuela. No se trata de simples obstáculos administrativos o malentendidos; en muchos casos, se trata de una defensa frente a lo que se percibe como una intromisión en los modos instituidos de hacer escuela.

Por eso, el ingreso del acompañante en la escuela no puede ser una decisión unilateral ni improvisada: requiere de una estrategia compartida, de una elaboración conjunta que convoque al equipo de Acompañamiento y a los actores institucionales. Solo en ese entramado de diálogo y articulación es posible construir una intervención que no refuerce el aislamiento, sino que habilite verdaderamente un lugar para la diferencia. No se trata de que la escuela entienda y abraze de inmediato la lógica del dispositivo, sino de construir un puente donde las diferencias puedan alojarse, pensarse y, con un poco de optimismo, enriquecerse mutuamente.

En el mejor de los casos, el Acompañamiento no solo transforma la experiencia escolar del niño o adolescente acompañado, sino que también modifica, aunque sea levemente, la mirada de la institución. Permite instalar otra lógica, abrir grietas, habilitar espacios donde la diferencia no sea leída como déficit, sino como singularidad.

El campo institucional sanitario

El campo institucional sanitario —hospitales generales, neuropsiquiátricos, centros de salud mental— constituye uno de los territorios más densos y complejos en los que el Acompañamiento Terapéutico ha comenzado a tener presencia. Se trata de espacios donde los discursos sobre la salud y el sufrimiento han sido históricamente hegemonizados por el modelo médico, con su lógica de diagnóstico, prescripción y control. Allí, el padecimiento subjetivo suele ser leído a través del prisma de la organicidad, del síntoma observable, del cuerpo que responde o no al tratamiento.

La institución sanitaria no es solo un espacio físico ni un conjunto de servicios: es una forma particular de organizar el saber, el poder y la intervención sobre el padecimiento. Está atravesada por normativas, protocolos, jerarquías y lenguajes que delimitan qué se considera clínico, qué es una urgencia, qué debe hacerse y quién puede decir. En ese entramado denso, el ingreso del Acompañamiento Terapéutico no puede más que producir desplazamientos, preguntas, a veces resistencias, y otras veces, transformaciones.

Nos proponemos aquí recorrer dos formas diferenciadas pero complementarias de inserción del Acompañante en el ámbito institucional sanitario: Una primera, más incipiente pero creciente, es su incorporación como parte del staff clínico de una institución de salud, con los desafíos que implica construir lugar y legitimidad en una estructura ya instituida; Por el otro lado, una segunda, más habitual, es su convocatoria como recurso externo, en general para abordar situaciones agudas donde se percibe que el dispositivo institucional no alcanza.

En ambos casos, lo que está en juego no es solo una función, sino una apuesta por una clínica que no se limite a administrar síntomas, sino que insista en alojar la palabra del sujeto. El desafío es sostener la especificidad del dispositivo sin perder capacidad de articulación, en otras palabras, hacer lugar sin confrontar.

a. El acompañante que se incorpora al staff: construir lugar en lo ya instituido

Cuando el acompañante se incorpora al equipo institucional como parte de su staff, comienza a formar parte de una red de relaciones ya constituida, con reglas explícitas y también implícitas sobre quién puede decir, quien puede decidir y quien puede actuar. El hospital —como bien lo describe Erving Goffman en sus estudios sobre instituciones totales— organiza no solo la circulación de los cuerpos, sino también de las palabras y de los lugares de saber. De este modo, el Acompañante irrumpe en una escena donde los roles están fuertemente reglados y los lugares jerarquizados por título, antigüedad o especialidad. La lógica del hospital —con su rigidez horaria, su protocolo de partes, su verticalidad decisional— muchas veces choca con el modo clínico, situado y vincular que el Acompañamiento propone.

En ese entramado, la figura del acompañante no siempre encuentra reconocimiento inmediato. Mas bien suele generar desconcierto. Se lo incorpora, pero no siempre se sabe bien qué se espera de él. ¿Es un auxiliar? ¿Un técnico en vínculo? ¿Un operador comunitario? ¿Un agente de control?

En línea con este desconcierto, el Acompañamiento en el marco institucional se expone a un doble riesgo: por un lado, que se lo reduzca a una función de sostén meramente asistencial, borrando la dimensión clínica de su tarea; por otro, que se le exija responder a las mismas lógicas de control y objetivación del padecimiento que muchas veces el Acompañamiento viene a cuestionar. En razón de ello, podemos advertir que sostener una práctica con coordenadas clínicas propias dentro del dispositivo institucional exige, no solo trabajo clínico sino una decisión política contundente.

Partimos de la base que no cualquier institución propone el ingreso de un acompañante como parte del staff. Esa decisión se inscribe en el seno de una dinámica institucional con historia, con densidad ideológica y proyección política. No se trata de agregar una figura más al equipo: se trata de inscribir una función en un entramado simbólico denso, ya instituido, que a su vez modula qué lugar se le habilita a esa figura y que vínculo se espera para con los otros discursos que abordan el padecimiento.

La inclusión del acompañante en estas circunstancias implica una doble operación: por un lado, la incorporación a una cultura institucional por parte del profesional —en la lectura y el respeto por los códigos, por los tiempos y los modos de habitar—, y por otro lado, en el mejor de los casos, en un futuro próximo, la posibilidad de que la práctica del Acompañamiento llegue a incidir en las respuestas institucionales, aportando a la construcción cultural de la institución misma.

Mas allá de las circunstancias de su inclusión, sabemos que no basta con estar nombrado: la habilitación institucional de la función del AT es un proceso que se construye. Supone trabajo lento, persistente, articulado con los equipos de planta. Hay que dar un tiempo para que se genere un lugar, y para ello es necesario generar lazos con médicos, psicólogos, enfermeros, trabajadores sociales antes de pretender reconocimiento y legitimación. No se trata solo de hacerse conocer, sino de construir confianza en el hacer: mostrar en acto, con tiempo y presencia, que la intervención del Acompañante no duplica funciones ni invade lugares, sino que aporta una lectura y una presencia que el equipo necesita.

Viñeta 1 – El que llega al equipo

Ana es Acompañante Terapéutica y acaba de ser incorporada al equipo de salud mental de un hospital general. Su tarea: trabajar proyectos de externación de pacientes con cuadros psicóticos estabilizados que permanecen internados por falta de red. En su primera semana, nadie le habla demasiado. Un psiquiatra le dice: “vos fijate qué podés hacer”, y una trabajadora social le pasa una lista de “casos complicados”. Ana decide empezar por escuchar. Recorre la sala, se sienta junto a las camas, conversa con los pacientes, toma nota de lo que ve y escucha. Después de un mes, comparte su primera devolución en ateneo: propone una salida gradual para un paciente que lleva dos años sin pisar la calle. El equipo la escucha. Es un gesto mínimo, pero marca el inicio de un reconocimiento.

b. El acompañante que viene de afuera: intervenir sin pertenecer

La segunda modalidad de ingreso del Acompañamiento Terapéutico al campo institucional sanitario se produce cuando un equipo solicita el recurso de manera externa, por fuera del staff. Suele tratarse de situaciones que desbordan las posibilidades del dispositivo institucional: pacientes con múltiples internaciones, con conductas disruptivas, con dificultades para sostener un alta o con trayectorias clínicas que exceden los marcos habituales de abordaje. En estos escenarios, se convoca al acompañante como figura singular, en general con una lógica focal y temporal, con la expectativa de que pueda sostener una intervención más personalizada.

La inclusión del acompañante en estas situaciones permite abrir una dimensión de presencia continua y específica, no sujeta a la rotación de profesionales, ni a los tiempos rígidos de la institución. Su inscripción en el campo cotidiano del paciente lo convierte, muchas veces, en un agente privilegiado para captar derivas clínicas que permanecen invisibles en el contexto hospitalario. Su mirada, anclada en la cotidianeidad y en la singularidad del vínculo, permite leer la escena desde coordenadas que otras prácticas no alcanzan

En estos dispositivos, la función del coordinador clínico del equipo de Acompañamiento Terapéutico es clave. Su tarea excede con mucho

la dimensión organizativa: se convierte en una figura de mediación entre discursos, que ordena el sentido de la intervención, acompaña el ingreso del acompañante al terreno clínico e introduce una trama de interlocución con el equipo tratante. Allí donde el Acompañante puede ser vivido como un cuerpo extraño —alguien que “viene de afuera”, que observa, que interviene sin pertenecer del todo—, surge el coordinador como el soporte de una presencia simbólica que amortigua las fantasías persecutorias, traduce expectativas, contextualiza los pedidos y resguarda al profesional de quedar atrapado en escenas de exclusión o enfrentamiento.

No se trata de una dificultad menor: el ingreso externo del acompañante suele activarse sobre una escena cargada, donde algo del malestar ya desborda. En ese contexto, la presencia del acompañante puede resultar incómoda. No pertenece del todo, pero interviene. No es del equipo, pero está en la escena. Porta una lectura clínica, pero sin legitimidad institucional plena. En muchos sentidos, el acompañante que ingresa desde afuera ocupa un lugar fronterizo, de borde. Ese lugar, sin embargo, puede volverse fértil. No necesariamente debe resolverse en una tensión. Cuando el vínculo con el paciente se trabaja también como lazo con el equipo; cuando la intervención no se inscribe solo en el eje uno a uno, sino que se articula en un entramado clínico; cuando se logra establecer una interlocución genuina con los otros profesionales intervinientes, el Acompañamiento deja de ser un recurso aislado y se transforma en una práctica que amplía las condiciones de posibilidad del dispositivo institucional.

Claro que esto no ocurre de inmediato. La articulación entre la lógica del Acompañamiento y la lógica institucional requiere tiempo, paciencia, disposición y presencia clínica. No se trata de conquistar un lugar, ni de imponer una mirada. Se trata de alojar la escena tal como es, sin renunciar a la especificidad del dispositivo. Allí donde se logra sostener esa doble inscripción —respetuosa del otro pero anclada en el propio marco clínico—, la presencia del Acompañante comienza a hacer lazo.

Viñeta 2 – El que viene de afuera

A Martín, paciente con diagnóstico de trastorno bipolar, se le indica Acompañamiento Terapéutico luego de varios episodios de descompen-

sación con internación. La médica psiquiatra del hospital monovalente solicita el recurso, pero en la primera reunión con el Acompañante expresa dudas: “No sé si va a servir, él no escucha a nadie”. El coordinador del equipo de AT toma la palabra: explica el encuadre, la lógica del dispositivo, aclara expectativas. Durante las primeras semanas, acompaña de cerca el vínculo entre el profesional y la médica. Al cabo de un mes, el vínculo entre el Acompañante y Martín empieza a tomar forma. La médica comienza a pedir devoluciones clínicas. Ya no es un cuerpo extraño: es un interlocutor.

En síntesis, ambas formas de ingreso al campo institucional —como parte del staff o como recurso externo— comparten un mismo desafío: que la práctica no sea absorbida por la lógica asistencial ni diluida en sus fundamentos clínicos. Que el acompañante no quede atrapado en el mandato de “hacer algo” sin poder decir nada.

El Acompañamiento, en este marco, no puede ser neutral. Su práctica implica tomar posición. No se trata de confrontar con las instituciones, ni de adaptarse sin resto, sino de sostener un posicionamiento clínico que haga lugar a la palabra del sujeto, que introduzca tiempo allí donde todo empuja a la urgencia, que habilite otra lectura allí donde solo se espera resolución.

No siempre será posible. Pero allí donde se pueda abrir una pregunta, donde el vínculo no se reduzca a la ejecución de tareas, donde el Acompañante pueda sostener su presencia sin invisibilizarse ni confrontar, se estará dando un paso más en la construcción de una clínica más humana, más situada, más abierta a la complejidad de lo singular.

Algunos desarrollos sobre un campo que le es propio: el campo clínico - domiciliario

El Acompañamiento clínico domiciliario es quizás el ámbito que más se aproxima al dispositivo fundacional del Acompañamiento Terapéutico. Desde sus orígenes, esta práctica se propuso como una forma de intervención situada, sostenida en la cotidianeidad del paciente, y comprometida con el lazo social. El hogar, con su densidad simbólica, sus rutinas, sus vínculos y sus marcas históricas, se convierte en escenario privilegiado para la clínica del Acompañamiento Terapéutico.

Allí donde otros dispositivos encuentran límites estructurales o institucionales, el Acompañamiento puede alojarse con flexibilidad, pero también con la exigencia de construir en acto las condiciones mínimas de un trabajo clínico. La casa –territorio íntimo, cargado de historia, de vínculos, de repeticiones y de silencios– se transforma en escena de intervención.

Algunas características relevantes del hogar son:

- **Espacio íntimo y privado, cargado de significación:** El domicilio es un territorio simbólicamente denso. No hablamos del lugar físico, sino de un espacio en el que se organiza la vida cotidiana, los vínculos familiares y las rutinas subjetivas. Se despliega una intimidad cargada de historia, afectos y conflictos, lo que lo diferencia radicalmente de los ámbitos institucionales.
- **Territorio desregulado y no estandarizado:** A diferencia de hospitales, escuelas u otras instituciones, el hogar no cuenta con una organización institucional clara, ni con reglas externas que regulen la escena. Esto implica que los encuadres clínicos deben construirse en acto, a partir de cada situación singular, y que los dispositivos deben adaptarse a la lógica propia de esa cotidianidad.
- **Presencia de terceros que inciden en la escena:** En el ámbito domiciliario, la intervención se produce en un espacio compartido con personas significativas para quien padece: familiares, convivientes o red de apoyo. Estas presencias no son neutrales: forman parte del entramado subjetivo que sostiene o reproduce el malestar, y su participación —activa o pasiva— influye directamente en la dinámica clínica.
- **Entre lo clínico y lo cotidiano:** En el hogar, las escenas clínicas se entrelazan con actos comunes: comer, dormir, mirar televisión, caminar por la casa. No hay separación entre lo terapéutico y lo cotidiano. Esta continuidad impone una lectura clínica compleja, en la que cada gesto y cada silencio puede tener valor de intervención o de síntoma.

La entrada al domicilio implica una irrupción en un territorio privado, cargado de sentidos, historias, modos de habitar, en la que se expresan una trama de relaciones, de silencios, de mandatos y duelos. El Acompa-

ñante no llega como un familiar ni como un amigo, pero tampoco como un técnico que opera desde afuera. Su posición es ambigua, por momentos desestabilizante, y requiere de una construcción constante de su lugar: un “entre” que demanda tanto sensibilidad como posición clínica.

Las solicitudes de Acompañamiento domiciliario provienen, básicamente, de servicios médicos, obras sociales, instituciones de salud mental, o incluso de las propias familias. En general, estas solicitudes están orientadas por una preocupación concreta: evitar una internación, acompañar una externación, garantizar que el paciente se alimente, se levante, tome la medicación, salga de su encierro. En sí mismas, no son demandas clínicas, sino expresiones de urgencias que requieren ser traducidas.

En muchas ocasiones, estas solicitudes instalan al acompañante en una escena que opera bajo coordenadas de cuidado físico, supervisión o “motivación”. Se espera que el profesional “esté”, “sostenga”, “anime”, “estimule”. Si bien estas acciones pueden formar parte de la tarea, su sola ejecución no constituye una intervención clínica. Es necesario, entonces, que el acompañante no quede capturado en la literalidad de la indicación, sino que pueda leer allí los significantes del padecimiento, los modos en que se tramita el sufrimiento, las posiciones subjetivas de quienes habitan ese hogar. Allí se abre la posibilidad –y también la responsabilidad– de construir un caso.

En este sentido, el núcleo clínico del Acompañamiento domiciliario no reside en la acción puntual, sino en la posibilidad de convertir esa acción en un acto terapéutico

Viñeta:

una joven con diagnóstico de trastorno de la conducta alimentaria ha sido externada recientemente y su equipo tratante solicita un Acompañamiento clínico domiciliario para “sostener la externación”. No se especifica más que la necesidad de evitar una recaída. No hay indicación terapéutica clara.

En una situación como esta, es fácil que el Acompañamiento se transforme en una suerte de vigilancia enmascarada, o en una compañía asistencial sin coordenadas clínicas. Sin embargo, el mismo acto de sentarse a la mesa, de habitar el silencio de una comida, puede volverse escena clínica si el profesional logra sostener allí una lectura transferencial, si se permite escuchar lo que se juega en ese momento: el rechazo, la

evitación, el control, el miedo. Estar, en el Acompañamiento Terapéutico, significa algo más que ocupar un lugar físico, se trata de sostener una posición que habilite el decir.

La intervención domiciliaria posibilita una lectura del síntoma en acto, encarnado en las escenas cotidianas. El acompañante puede advertir lo que está en juego, incluso en situaciones aparentemente banales. Pero para que esa lectura sea posible, hace falta sostenerse en transferencia, ordenado en un encuadre y bajo una apuesta clínica. No alcanza con estar presente: hay que estar implicado.

La clínica domiciliaria también exige una lectura cuidadosa de la dinámica familiar. Es un hecho que la sola presencia del acompañante interpela dicha dinámica. Muchas veces, la familia no ha solicitado el Acompañamiento y, sin embargo, se ve obligada a alojar esa figura en su cotidianeidad. La presencia del acompañante puede ser vivida como una intrusión, como una mirada que evalúa, que juzga, que “viene a controlar”. En otros casos, se espera de él que se haga cargo de lo que la familia ya no puede o no quiere sostener: contener al paciente, garantizar ciertas rutinas, mediar en los conflictos, cubrir ausencias estructurales.

Estas expectativas, muchas veces implícitas, producen resistencias. El acompañante puede encontrarse con puertas cerradas, con actitudes hostiles, con gestos de desconfianza, o con formas de seducción que buscan capturarlo en una lógica ajena a la clínica. Todo esto no necesariamente es rechazo al profesional, sino expresión de una escena sintomática.

La lectura clínica de esas resistencias es parte constitutiva del trabajo. No se trata de confrontar o forzar la inclusión del acompañante en la vida familiar, sino de leer lo que esa resistencia dice sobre el lazo, sobre el modo en que se tramita el padecimiento en esa red. El acompañante no es un mediador familiar, pero su posición lo ubica en el corazón de las tensiones vinculares. Su intervención será tanto más potente cuanto más logre sostenerse como una presencia que no responde ni al mandato del control ni al mandato de la fusión.

Es parte del trabajo del acompañante leer estos movimientos sin voluntad de confrontación, a los fines de interpretar lo que dicen del lugar que ocupa el síntoma en ese hogar, y ubicar los modos en que esa red vincular tramita el padecimiento.

En ciertos casos, será necesario trabajar con el equipo tratante la posibilidad de abrir un espacio con los familiares, para alojar su angustia,

su cansancio o su desesperanza. La familia también padece, también actúa y también repite. Sin ese registro, se corre el riesgo de culpabilizarla o idealizarla, perdiendo de vista que es parte del entramado clínico y no su obstáculo.

La articulación con los equipos tratantes es fundamental. El Acompañamiento domiciliario no puede pensarse como una práctica aislada ni autosuficiente. Su eficacia está ligada a la posibilidad de hacer red, de introducir en el cotidiano una mirada clínica que dialogue con otros saberes y otros agentes del tratamiento. Cuando esto no ocurre, el riesgo de cronificación o banalización de la intervención es alto. La posibilidad de que lo cotidiano se vuelva escena terapéutica depende, en buena medida, de la interlocución con otros actores del dispositivo y del tratamiento.

La responsabilidad clínica se pone en juego en los múltiples dilemas éticos que emergen en el campo clínico domiciliario. El primero, y quizás el más frecuente, es el riesgo de diluir la función clínica en una tarea asistencial. Ante la ausencia de encuadre institucional, el acompañante puede quedar arrastrado por la lógica del hacer: resolver, ayudar, intervenir. Pero la especificidad del dispositivo reside justamente en no confundirse con otras funciones —el cuidado, la contención, la mediación—, aunque a veces las roce o se superponga con ellas.

Otro dilema frecuente es el que emerge de la asimetría afectiva que el contexto domiciliario puede propiciar. La cercanía física, la cotidianeidad compartida, la reiteración de gestos mínimos puede construir una intimidad que, si no se inscribe en una lógica transferencial clara, desdibuja los lugares. El acompañante puede ser percibido como un hijo simbólico, como un confidente, como un amigo. Evitar que la intervención se vuelva una relación sin encuadre exige supervisión, reflexión y una fuerte inscripción del acompañante en un equipo de trabajo.

También se presentan dilemas vinculados a la confidencialidad y la circulación de la palabra. ¿Qué se puede decir a la familia? ¿Cómo preservar la autonomía del paciente en un entorno que muchas veces es sobreprotector o intrusivo? ¿Qué hacer ante situaciones de violencia, de negligencia, de omisión? La ética del Acompañamiento domiciliario no se resuelve en reglas fijas, en respuestas generalizadas, sino en la elaboración constante de cada escena.

Por todo esto, es fundamental que el Acompañamiento domiciliario no se sostenga en soledad. Requiere de equipos, de supervisión, de

interlocutores que permitan pensar lo que allí se despliega. Lo que está en juego no es solo la eficacia de la intervención, sino la salud mental del acompañante y la posibilidad de sostener una posición clínica clara.

En síntesis, el ámbito clínico domiciliario representa una oportunidad privilegiada para desplegar el Acompañamiento Terapéutico en su dimensión más potente. Es un espacio privilegiado para alojar lo subjetivo. No por su comodidad, sino por su crudeza. Allí donde la institucionalización no llega, donde el síntoma es cotidiano, donde el encierro puede ser invisible, el Acompañamiento puede abrir una posibilidad. Pero también implica riesgos: de dilución, de sobrecarga, de pérdida de horizonte clínico. La clave está, una vez más, en sostener la pregunta por el sujeto y su padecimiento, incluso —y sobre todo— cuando lo que se solicita parece desbordarnos de sentido. La apuesta —como siempre en esta práctica— es a la construcción de lazo.

Hablemos de interdisciplina: entre el ideal de lo común y las fricciones del hacer

El Acompañamiento Terapéutico es un recurso terapéutico que se sostiene en una orientación clínica precisa, enmarcada por una indicación terapéutica que le otorga dirección y sentido. Desde esta perspectiva, el Acompañamiento Terapéutico no actúa en soledad. Por el contrario, su eficacia clínica se teje en articulación con quienes sostienen otras dimensiones del tratamiento: psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, médicos, equipos institucionales.

Es precisamente esa dimensión relacional —ese lazo necesario con otros actores del campo de la salud— lo que vincula directamente al Acompañamiento Terapéutico con la pregunta por la interdisciplina. No como un agregado deseable, sino como condición estructural de su práctica. Sin embargo, esa articulación muchas veces se vuelve esquiva, difícil, interrumpida por jerarquías, sobreentendidos, distancias institucionales y lógicas profesionales disonantes.

El mandato de la interdisciplina

Desde hace décadas, las políticas públicas en salud mental —especialmente aquellas que toman como horizonte los Derechos Humanos y las prácticas comunitarias— han incorporado con fuerza el valor de lo interdisciplinario. No se trata solo de una estrategia metodológica, sino de una posición ética: la de reconocer que ninguna disciplina, por sí sola, es capaz de alojar la complejidad de la existencia humana y sus modos de padecimiento. La Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 lo establece con claridad: los abordajes deben ser integrales, y los equipos, interdisciplinarios.

Pero esa afirmación, que en el plano de los principios parece indiscutible, se vuelve problemática cuando desciende a la escena concreta del trabajo cotidiano. ¿Qué quiere decir, en la práctica, que un equipo sea interdisciplinario? ¿Cómo se traduce esa consigna en la trama real de intercambios, decisiones, silencios y fricciones entre profesionales?

En Acompañamiento Terapéutico —territorio inestable y movedizo, muchas veces periférico al corazón de las instituciones— estas preguntas se vuelven especialmente agudas. El Acompañamiento es convocado desde la necesidad, pero no siempre reconocido desde el saber. Participa de los tratamientos, pero con frecuencia queda fuera de las decisiones.

Desde sus orígenes el dispositivo de Acompañamiento Terapéutico se inscribe en una lógica de articulación. No se trata de una intervención espontánea o aislada, sino de una práctica que toma iniciativa, adquiere sentido y define su función en el marco de una indicación previa. El Acompañamiento Terapéutico se piensa como parte de una estrategia clínica más amplia. Su sentido se construye en función de ese entramado, y por lo tanto, conlleva desde el inicio una exigencia de articulación entre quienes participan del tratamiento.

Esa lógica organiza para el Acompañamiento un mandato de articulación entre actores intervinientes que, en muchos casos, queda automáticamente ligado a la idea de trabajo interdisciplinario. El Acompañamiento espera, entonces, no solo coordinarse con quien dio la indicación, sino formar parte de una trama común de lectura, decisión y cuidado. Cuando eso no ocurre, el dispositivo queda capturado en un doble movimiento: por un lado, se lo convoca como recurso articulador; por el otro, se lo deja fuera de los espacios donde esa articulación podría efectivizarse.

Esta tensión entre el ideal de la interdisciplina y las condiciones reales de posibilidad para construirla es el eje que pretendemos recorrer. Una tensión que no se resuelve, pero que puede pensarse.

El desencuentro como experiencia fundante

En el terreno del Acompañamiento Terapéutico, hablar de interdisciplina es —más que un hecho consumado— una apuesta incierta. No se trata solo de articular con otros saberes, sino de hacerlo desde una posición históricamente desvalorizada, mal comprendida o directamente invisibilizada.

Lo interdisciplinario no es lo que está escrito en una historia clínica, sino lo que se sostiene en el lazo. Un lazo que muchas veces no está.

La experiencia concreta muestra que la colaboración con otros profesionales —médicos, psicólogos, trabajadores sociales, psiquiatras, docentes— no siempre se da en condiciones de igualdad o de diálogo. Con frecuencia, el Acompañamiento Terapéutico es convocado como ejecutor de indicaciones ajenas, sin que se le otorgue lugar en la construcción diagnóstica, en la toma de decisiones o en la elaboración de estrategias.

Esta exclusión no siempre es explícita. A veces se disfraza de burocracia (“después te paso el parte”), otras veces de sobrecarga (“no llegué a leer lo tuyo”), y en muchas ocasiones, de jerarquías tácitas que no se discuten, pero que ordenan la escena. Se intercambia información por WhatsApp, se comentan aspectos puntuales del tratamiento por mail, pero no se genera un espacio de lectura compartida.

Sabemos que en los grupos de WhatsApp no se produce interdisciplina. Se intercambia información, pero no se construye una lectura común del padecimiento.

Hay, en muchos casos, una fragmentación del abordaje. Cada profesional actúa desde su lenguaje, su tiempo, su lógica, sin un marco común que habilite la conversación. Esta disgregación atenta contra la eficacia clínica, pero también —y sobre todo— contra el sentido ético de lo terapéutico.

En este escenario, el Acompañamiento Terapéutico queda muchas veces como operador de una escucha que no circula, de un saber que no encuentra cauce, de una práctica que roza los bordes de las instituciones sin terminar de ser alojada por ellas. La exigencia de articular se convierte en una carga que no siempre se corresponde con una posibilidad real.

Ahora bien, asumir la dificultad de la interdisciplina no implica renunciar a su búsqueda. La mirada crítica no tiene por qué ser cínica. Reconocer los obstáculos, los desencuentros y las jerarquías que atraviesan el campo no clausura la posibilidad de pensar otras formas de encuentro.

Cecilia López Ocariz en diálogo con quien suscribe, en un texto publicado en el libro “Acontecimiento y Emancipación” de Viviana Balsamo, propone una lectura que recupera el valor de la conversación entre saberes. No lo propone como armonía forzada ni como suma de especialidades, sino como posibilidad de generar un pensamiento común allí donde las diferencias no se suprimen, se alojan. La interdisciplina, en este sentido, no es un punto de llegada, sino un trabajo sostenido en el tiempo, una construcción que exige apertura, disponibilidad y cierto descentramiento del propio lugar.

Quizás la interdisciplina no sea una armonía, sino una conversación inconclusa, hecha de cortes, malentendidos y gestos de hospitalidad entre lenguajes.

El Acompañamiento Terapéutico, por su propia lógica de intervención —situada, flexible, encarnada— puede ofrecer claves para pensar esa conversación. Porque opera en los márgenes, porque presta una escucha en la intimidad, porque insiste donde otros se retiran. Pero para que esa potencia no se diluya, es necesario crear condiciones simbólicas e institucionales que reconozcan su valor. Y eso implica un trabajo al interior del campo del AT, para generar espacios de formación y reflexión colectiva, compartir lecturas y experiencias, planificar de manera conjunta. O sea, que la intervención situada no se sostenga solo en la práctica individual, sino en una trama colectiva que le dé densidad conceptual y política.

El desafío no está en idealizar lo interdisciplinario, sino en construirlo como práctica viva, con sus tensiones, sus bordes y sus zonas de incertidumbre. Tal vez allí, en ese lugar incómodo, se juegue lo más fecundo de la apuesta futura que el Acompañamiento Terapéutico encarna.

La terceridad clínica delegada: una forma posible de articulación

Aun en contextos donde la construcción de una verdadera interdisciplina se ve obstaculizada por distancias, jerarquías o desencuentros, el Acompañamiento Terapéutico, bajo ciertas condiciones, no pierde su capacidad de intervención. Puede —y muchas veces debe— continuar asumiendo su lugar clínico dentro del tratamiento, reconociendo el

marco que lo ha convocado y la función que le ha sido asignada. Lejos de quedar paralizado por la falta de articulación efectiva, el Acompañamiento se sostiene en una lectura singular de la escena, al tiempo que inscribe su práctica en una red simbólica que lo antecede.

Decíamos que el dispositivo se inscribe en una escena clínica que ya está en curso. No inicia el tratamiento, sino que se suma a él, convocado por la indicación de un profesional tratante —psiquiatra, psicólogo, neurólogo— que define su incorporación como parte de los recursos terapéuticos para el abordaje de la problemática. Esa indicación inicial no es neutra: otorga un marco, delimita una función esperada, legitima la presencia del acompañante. Es, en algún sentido, una autorización simbólica que habilita la intervención.

Ahora bien, esta forma de entrada al dispositivo plantea una relación singular con quien indica. No se trata de una co-construcción del dispositivo desde sus cimientos —como ocurre, por ejemplo, cuando un equipo clínico diseña en conjunto una estrategia de abordaje—, pero tampoco de una mera relación de obediencia o subordinación. El acompañante no responde de forma automática a una orden ni se limita a ejecutar indicaciones. Porta una lógica propia, una escucha específica, una clínica que lee más allá de lo que se le pide.

¿Cómo nombrar entonces esta relación? Proponemos pensarla como una “terceridad clínica delegada”.

La terceridad designa aquí el lugar del profesional que, al indicar el Acompañamiento, se sitúa como figura que habilita y enmarca el lazo clínico sin necesariamente formar parte activa del trabajo cotidiano. Se convierte en un punto de apoyo externo, una referencia que sostiene el dispositivo en términos legales, clínicos o institucionales. Aun cuando no exista un trabajo interdisciplinario efectivo, su presencia actúa como garantía de legalidad, como punto de apelación en momentos de conflicto, como respaldo ante terceros (familia, obra social, juzgado, institución).

La delegación, en este contexto, no implica una renuncia al juicio clínico por parte del acompañante, sino más bien una apuesta a operar en una zona intermedia: una zona en la que se recibe una función asignada, pero se la resignifica a partir de la lectura singular del caso, del vínculo construido, de la experiencia situada.

Este tipo de relación, aunque muchas veces marcada por la asimetría o la falta de diálogo, puede ser clínicamente productiva. Porque incluso en la ausencia de una verdadera interdisciplina, la existencia de una figura tercera que otorga sentido y legitimidad al dispositivo resulta fundamental para sostener la intervención. En esos casos, el Acompañamiento trabaja en tensión: respetando un marco que no siempre lo aloja, dialogando con una indicación que muchas veces no se abre al intercambio, construyendo sentido donde apenas se le ofrece una función.

Reconocer esta forma de lazo —y no reducirla ni al ideal de lo común ni a la lógica de la ejecución— permite comprender mejor las coordenadas reales desde las que muchas veces se ejerce el Acompañamiento Terapéutico. Porque si bien la co-construcción interdisciplinaria sigue siendo un horizonte deseable, no siempre es una condición de posibilidad inmediata. Y sin embargo, aun en esa ausencia, el dispositivo puede sostener su eficacia, construir sentido, habilitar otras formas de cuidado.

Nombrar esta relación como “terceridad clínica delegada” no es clausurar su complejidad, sino abrir un concepto que nos permita pensar mejor dónde estamos parados cuando acompañamos. Porque aun cuando no haya interdisciplina, hay dispositivo; y aun cuando no haya encuentro, hay apuesta.

Entre la fragilidad simbólica y la potencia del lazo

Ahora bien, si nos detenemos a pensar qué es lo que efectivamente hace posible esa articulación, no basta con invocar el ideal de la interdisciplina como consigna institucional. En última instancia, el trabajo interdisciplinario se juega siempre en la relación concreta entre al menos dos sujetos, que representan —cada uno— una disciplina, una formación, una mirada sobre el padecimiento. Lo que permite o impide esa articulación es, muchas veces, el tipo de lazo que se construye entre ellos.

En este punto, no podemos dejar de reconocer una realidad que atraviesa estructuralmente nuestra práctica: el Acompañamiento Terapéutico, más allá de su potencia clínica, no ha logrado aún construir un cuerpo conceptual suficientemente consolidado desde el cual disputar sentidos en el campo de la salud. Esta fragilidad simbólica se expresa también en las relaciones personales: el Acompañamiento Terapéutico no cuenta con una representación de saber tan densa como para ser

escuchado con una predisposición anticipada. No se espera de antemano que aporte a la construcción conceptual del caso. Esa posición nos exige redoblar la apuesta: sostener con inteligencia, paciencia y respeto un vínculo con quienes articulamos, de modo tal que ese reconocimiento se construya en la experiencia misma del trabajo compartido.

Porque al final, lo interdisciplinario no es una escena de saberes distribuidos de manera equitativa por diseño, sino un lazo que se construye. Un lazo en el que, para que dos discursos distintos puedan influirse mutuamente, tiene que haber confianza, apertura y reconocimiento recíproco entre quienes los encarnan.

Quinta parte

Módulo 4

LA GESTIÓN DEL EQUIPO

Capítulo 10

ORGANIZAR PARA CUIDAR

Lo que hacemos también se inscribe

Hasta aquí hemos recorrido la experiencia del Acompañamiento desde su interior: cómo se implementa, cómo se sostiene, cómo se piensa y se transforma en equipo y como se incluye en diversos contextos. Hemos trabajado las escenas clínicas, los afectos, las posiciones, los conflictos y las decisiones que le dan cuerpo a una práctica que, si algo no es, es espontánea.

Pero el dispositivo de Acompañamiento Terapéutico no flota en el vacío. No se despliega solo en función del deseo de quienes lo llevan adelante. Se inscribe —quiera o no— en un entramado complejo: legal, institucional, económico, político. Está atravesado por discursos, regulaciones, dispositivos normativos y estructuras de poder que condicionan su posibilidad de existencia, su forma, su legitimidad.

En este capítulo retomamos el cuarto módulo de formación, al que nombramos: “*Entre discursos*”. Este módulo nos invita a mirar esa escena más amplia. A elevar la cámara para ver dónde se inscribe lo que hacemos, el Acompañamiento y su contexto. Qué tensiones aparecen cuando el dispositivo se encuentra con quienes lo financian. Cómo se regula lo que hacemos. Cómo se nombra. Qué se espera de nuestra práctica cuando entra en relación con instituciones que miden, autorizan o rechazan.

Hablar de articulación no es sólo hablar de conexiones. Es hablar de fricciones, de desencuentros, de puntos ciegos, pero también de posibilidad. Lo que aquí nos proponemos es desarmar la idea de un Acompañamiento cerrado sobre sí mismo y pensarlo como lo que efectivamente es: una práctica en permanente negociación con su contexto.

Este capítulo no apunta a cerrar definiciones, sino a abrir preguntas: ¿Cómo se transforma el dispositivo cuando se articula con discursos tan ajenos?, ¿Qué tensiones emergen cuando la clínica entra en contacto con la lógica administrativa?

Y quizás la pregunta más importante: ¿qué condiciones necesitamos construir para que esta práctica, aun cuando se articule con otros sistemas, no pierda su potencia clínica ni su anclaje ético?

La gestión como apuesta clínica y política

Trabajar en salud mental desde una práctica como el Acompañamiento Terapéutico implica, más tarde o más temprano, tener que negociar con las condiciones materiales que permiten —o dificultan— sostener una intervención en el tiempo. El deseo clínico, que es motor de nuestra práctica, no alcanza cuando hay que responder un cuestionamiento de auditoría, redactar un informe, tramitar una disminución de horas o una ampliación, cobrar una prestación o garantizar la continuidad de un caso.

Asumir la necesidad de una gestión estratégica del equipo no es una tarea ajena a lo clínico. Es una herramienta para cuidar lo que hacemos, y para cuidar a quienes lo hacemos. No hablamos de una gestión técnica, sino de una organización que sostiene una práctica situada, en permanente tensión con el contexto. La organización del trabajo produce condiciones de posibilidad: condiciona las intervenciones, define los márgenes de lo posible, habilita o restringe los lazos que se tejen en torno a la tarea.

Como plantea Mario Rovere¹, gestionar no es simplemente administrar lo que hay, sino “decidir qué vale la pena sostener en contextos donde todo parece urgencia y carencia”. En ese sentido, la gestión en salud mental —y particularmente en Acompañamiento Terapéutico— es una tarea clínica, ética y política. Es un modo de intervenir sobre el contexto que rodea nuestras intervenciones.

En los equipos de AT, la organización tiene al menos dos dimensiones complementarias. Por un lado, una organización que articula “puertas

1. Rovere, M. R. (2006). *Planificación estratégica de recursos humanos en salud*. Segunda edición ampliada y corregida. OPS

afuera”, hacia el mundo institucional: sistemas de salud, obras sociales, juzgados, familias, programas estatales. Esa organización es la que permite garantizar condiciones formales para la intervención: facturación, informes, cobros, planificación. Sin esa estructura mínima, los acompañantes quedan expuestos a vínculos desiguales con los financiadores, atrapados en la lógica del caso aislado, sujetos a la discrecionalidad del sistema.

Hay otra dimensión de la organización, tan presente como la primera: la organización interna del equipo como espacio clínico de sostén, de elaboración conjunta y de posibilidad de encuentro entre pares. Hacer equipo es construir una red que aloje la práctica. Es poder hablar de los efectos, compartir una escena, hacer lugar al anecdotario sin perder el eje clínico. Es poder no saber y confiar en que otros también están pensando.

No hay crecimiento posible sin una organización que sostenga la práctica y al mismo tiempo la potencie. Un crecimiento organizado no alcanza con sumar acompañantes o multiplicar tratamientos. Si el equipo no cuenta con mecanismos claros de coordinación, tiempos de encuentro, espacios de formación continua, acuerdos éticos compartidos, el crecimiento se vuelve pura expansión cuantitativa, sin anclaje subjetivo ni sentido clínico.

Por eso, insistimos: la gestión no es neutra. Encierra concepciones sobre qué vale y qué no vale cuidar. Diagramar una gestión a conciencia es una apuesta a sostener lo propio. Es una forma de resistir, de habilitar condiciones. Es construir, desde la organización, un modo de estar con otros. La gestión, entonces, no es solo un asunto de trámites y administración. Es una forma de alojar lo colectivo, de cuidar la práctica, de construir futuro.

Aprender a organizarnos. La experiencia del Equipo Ágora

No se parte sabiendo cuál es el modelo de organización correcto. En los comienzos, lo que hay es una apuesta: una voluntad de construir algo que permita alojar la práctica del Acompañamiento Terapéutico de forma colectiva, digna y sostenida. Luego vendrán las preguntas, las tensiones, los momentos de crisis que marcarán las discusiones fundamentales. Y será en ese vaivén donde la gestión se transforme en una experiencia clínica, política y profundamente situada.

La historia del equipo Ágora es una muestra de ese recorrido. Desde sus inicios —en los primeros años del 2000— la preocupación por ordenar la tarea y construir un equipo con sentido fue una constante. En aquel momento, el Acompañamiento Terapéutico todavía no era un dispositivo masivo ni ampliamente reconocido. Los principales derivadores eran psiquiatras y psicólogos, y uno de los primeros desafíos fue el de visibilizar el trabajo. El vínculo con clínicas psiquiátricas de prestigio, como INEBA, se convirtió entonces en una estrategia central: no sólo habilitó un flujo sostenido de derivaciones, sino que consolidó una red de interlocutores que fortalecía la legitimidad del equipo.

En ese contexto inicial, las decisiones organizativas se tomaban en reuniones abiertas, con fuerte impronta horizontal. Todos los integrantes participaban de las definiciones estructurales: la frecuencia de los encuentros, las tareas de coordinación, las fechas de pago, los honorarios, la distribución interna del ingreso y las dificultades administrativas eran discutidas colectivamente. Era posible porque el equipo aún era pequeño, y el crecimiento era pausado. En ese clima de compromiso compartido, el equipo fue bautizado por sus propios miembros: “Ágora”, en alusión al espacio de deliberación pública de la antigua Grecia.

Con el tiempo, el crecimiento del equipo volvió evidente que la horizontalidad absoluta ya no resultaba operativa. La llegada de nuevos integrantes y la complejización de la tarea pusieron en escena la necesidad de nuevas formas organizativas. En ese marco, se incorporó formalmente un segundo coordinador, Ezequiel Urribarri, quien ya venía asumiendo tareas de gestión de forma comprometida, aunque sin reconocimiento institucional ni retribución económica. Esa decisión marcó un punto de inflexión: la organización ya no podía sostenerse solamente en la buena voluntad. Era hora de institucionalizar funciones.

Fue en medio de una discusión sobre los honorarios y el vínculo con INEBA que emergió una tensión de fondo: ¿cómo conciliar los intereses individuales con un proyecto colectivo? Algunos acompañantes cuestionaban la relación con la clínica, centrando su mirada en maximizar el ingreso personal. Otros —entre ellos quienes asumían responsabilidades de organización— entendían ese vínculo como un valor estratégico para el sostenimiento y el crecimiento del equipo. Esa diferencia de criterios fue clave para iniciar una segunda etapa en la construcción organizativa.

A partir de allí, se propuso una nueva estructura: una dirección del equipo, con la tarea de proyectar a mediano y largo plazo, y un

conjunto de espacios de interlocución con el resto del equipo donde se discutían las decisiones y se tomaban las sugerencias. El objetivo no era centralizar el poder, sino ordenar la toma de decisiones sin desdibujar el lazo colectivo. Cada nuevo coordinador que se incorporaba se sumaba a una suerte de comisión directiva, lo que habilitaba una circulación más compleja de funciones y responsabilidades. Llegaron a ser cuatro directores, cada uno con tareas diferenciadas y con roles claramente establecidos en la organización del equipo. Una vez conformado ese directorio, se fueron sumando coordinadores con funciones específicas de coordinación.

Con el tiempo, esta estructura fue madurando. En la actualidad, el equipo cuenta con dos directores generales, dos directores de área y un equipo de coordinadores, que se dividen dentro de cada una de las áreas, y organizan junto a los acompañantes el armado de cada caso.

Ezequiel Urribarri y quien escribe conformamos hoy la dirección de Ágora. Mi tarea está orientada hacia el afuera: la articulación con instituciones, con financiadores de la salud, el análisis del contexto, la estrategia de crecimiento. Ezequiel, en cambio, sostiene la mirada hacia el adentro: el cuidado de quienes conforman el equipo, la escucha del pulso clínico cotidiano, la identificación de los lugares donde el desgaste amenaza con volverse ruptura. Las decisiones, entonces, no se toman por imposición, sino por confianza: discutimos, debatimos, y cuando no estamos de acuerdo, sabemos escuchar, ceder y sostener el horizonte común. Nos sostiene un punto de apoyo firme: La confianza de que ambos buscamos lo mejor para el equipo.

Esa tensión entre lo estratégico y lo cotidiano, entre lo externo y lo interno, no sólo no es un problema: es la base de la vitalidad del equipo. Porque el contexto rara vez ofrece condiciones ideales. La demanda no llega ajustada a lo que el equipo desea. Es allí donde la gestión adquiere su dimensión más política: saber interpretar el momento, tomar decisiones que no fragmenten ni exijan más de lo que el equipo puede, sin dejar de proyectar hacia el futuro.

La experiencia de Ágora muestra que la organización no se define de una vez y para siempre. Se construye en el hacer, se revisa en cada conflicto, se redefine en función del crecimiento. Lo importante no es tener desde el inicio un modelo cerrado, sino sostener el deseo de construir una organización que haga lugar a la práctica, que habilite el lazo. Una organización que sea, en sí misma, una apuesta.

Un poco de actualidad: Un equipo sin garantías y el lazo como apuesta

En línea con la idea de un equipo que se construye en un trabajo de redefinición permanentemente, tomemos algo de la actualidad de Ágora.

La pandemia fue un punto de inflexión para muchos espacios de trabajo colectivo, pero especialmente para los equipos de Acompañamiento Terapéutico. En Ágora, su impacto fue profundo. No solo alteró las dinámicas cotidianas, sino que erosionó los lazos que sostienen la construcción de una práctica compartida. Lo que hasta entonces era un espacio vivo, cargado de sentidos, se volvió una rutina mediada por pantallas y notificaciones, perdiendo la densidad afectiva que solo el encuentro presencial puede garantizar.

La escena se volvió extraña: acompañantes que nunca habían cruzado palabra compartían tratamientos intensos, sin haberse estrechado siquiera la mano. Las reuniones de equipo pasaron de los cafés compartidos y las discusiones encendidas en ronda, a un desfile de micrófonos apagados y cámaras cerradas. Las palabras, a veces, no encontraban dónde posarse. Se podía hablar, pero era difícil resonar.

El aislamiento nos obligó a sostener las intervenciones a través de dispositivos virtuales. Si bien esta modalidad permitió cierta continuidad, también desdibujó el sentido de pertenencia, la implicación ética y el intercambio espontáneo. Comenzamos a conocer acompañantes nuevos a través de recuadros de Zoom, a organizar tratamientos con personas a las que nunca habíamos visto cara a cara. Lo que antes nacía del cuerpo presente —una mirada, un gesto compartido, una conversación entre mate y mate— quedó reducido a lo que posibilitaba una interfaz. El calor de la escena clínica fue sustituido por la frialdad de un relato ajeno. Esto impactó directamente en la posibilidad de construir una trama colectiva, y en la transmisión de una lógica de trabajo que había sido siempre más encarnada que teórica.

La sensación era la de estar haciendo lo posible dentro de lo imposible, y eso tenía un costo subjetivo altísimo. El compromiso ya no se construía en la experiencia conjunta, sino que debía sostenerse casi por acto de fe. Los más nuevos no conocían otra forma de habitar el equipo que la que veían en la pantalla, y los más antiguos comenzaban a sentirse extraños en su propia casa. La pregunta era: ¿cómo volver, si ya no somos los mismos?

La vuelta a la presencialidad no fue inmediata ni sencilla. Muchos profesionales ya habían reorganizado su vida alrededor de la virtualidad. El cuerpo, convocado nuevamente, planteó resistencias: tiempos, traslados, energías. Y si bien se intentó retomar la dinámica anterior, quedó claro que el equipo, tal como lo conocíamos, ya no era el mismo. Algo había cambiado de manera irreversible.

En ese escenario, la apuesta fue redoblar la exigencia del encuentro. Al menos para los espacios de reflexión colectiva, así como para las reuniones de equipo. Allí comenzamos a reconstruir lentamente una lógica común. No se trataba de recuperar lo que fuimos, sino de abrirnos a lo que podíamos ser a partir de las condiciones actuales. Fue necesario aceptar que el equipo ya no podía definirse por una identificación espontánea, sino por una voluntad sostenida de construir con otros.

En la actualidad, Ágora transita una etapa de reconstrucción. Se han creado espacios para que los coordinadores piensen juntos su función, se abrieron nuevas instancias para que los acompañantes se sientan parte activa del equipo, y se sostiene una búsqueda constante por generar sentido en ese encuentro. La realidad es que aún no hemos encontrado la respuesta...

Ahora sabemos que un equipo, entendido como construcción intersubjetiva y ética, nunca puede darse por hecho. Es una apuesta que debe renovarse en cada encuentro, en cada conversación, en cada gesto que habilita la palabra y reconoce al otro como interlocutor. No hay fórmulas para lograrlo, pero sí hay condiciones mínimas: disponibilidad, implicación, y una cierta disposición a dejarse afectar por el otro.

En tiempos de incertidumbre y transformaciones aceleradas, pensar el equipo como un espacio que habilita la elaboración, la diferencia y la construcción compartida, se vuelve una tarea política. Un modo de resistir al aislamiento y a la fragmentación que amenaza con instalarse en los vínculos laborales.

Hoy, más que nunca, el equipo es un horizonte: algo que se construye en movimiento, entre singularidades que se atreven a no hacerlo solas.

La construcción de equipos en tiempos de fluidez

Nos proponemos trabajar algunas ideas para pensar una realidad que se nos presenta, en muchos aspectos, como enigmática. Nos refe-

rimos a los modos de relación que emergen en las nuevas generaciones y cómo estas formas impactan en la construcción de equipos dentro del campo del Acompañamiento Terapéutico. Más difícil aún resulta pensar su participación en marcos organizacionales como Ágora, que heredaron otras lógicas de pertenencia, de estructura y de compromiso. Sin embargo, lejos de entender estas transformaciones como un déficit, pretendemos interrogarlas como una oportunidad para imaginar nuevas formas de colectividad y de lazo.

Hubo un tiempo en que los equipos podían pensarse como estructuras relativamente sólidas. Esa fue nuestra experiencia. Un conjunto delimitado de integrantes, funciones estables, cierta permanencia en el tiempo, referencias comunes. Podían ser leídos bajo la lógica del acontecimiento clásico: una ruptura con una institucionalidad previa que daba lugar a una nueva configuración. Esa ruptura exigía fidelidad, compromiso con una verdad que emergía al irrumpir en el campo clínico, social o político. Era posible trazar una línea: antes de este equipo había un modo de hacer; a partir del ingreso al equipo hay una nueva forma de hacer, de pensar, de sostener el trabajo con el sufrimiento.

Pero claramente estamos en otra época. Una época que no necesariamente niega el compromiso, pero que ya no lo organiza desde la permanencia, el arraigo o la estructura. Vivimos, como ha señalado Lewkowicz retomando a Badiou, un tiempo donde la subjetividad se produce no tanto por ruptura, sino por ligadura. No se da por confrontación con un orden instituido, sino por la creación contingente de un espacio común allí donde antes no lo había. Donde el encuentro —y no el acontecimiento— se vuelve la figura clave para pensar los modos actuales de relación, incluso dentro de nuestras propias prácticas.

En este marco, los equipos no son estructuras previas que se consolidan para contener y organizar, sino efectos de encuentros parciales, discontinuos, que sin embargo logran sostener prácticas comunes. En lugar de pensar al equipo como institución sólida, se nos impone pensarlo como máquina deseante, en el sentido deleuziano: un dispositivo de producción de sentido, de intensidades, de invención colectiva. No hay garantía, no hay contrato simbólico previo: lo que hay es una red de afectaciones, una economía libidinal que se organiza en torno a una tarea. El equipo aparece, entonces, como un ensamble, una configuración transitoria pero potente que inventa sus propios modos de existir.

Esto no implica desvalorizar lo laxo, lo provisorio, lo inestable. Lo importante no es si algo es “fuerte” o “débil”, sino si produce sentido, si abre posibilidades, si se conecta con otras fuerzas para sostener lo que allí sucede. En ese sentido, creemos que los equipos en estos tiempos no deben pensarse como versiones degradadas de una estructura sólida perdida, sino como formas actuales de existencia colectiva. Son multiplicidades —no conjuntos cerrados— que se componen y recomponen según las necesidades del trabajo, las disponibilidades afectivas, las condiciones materiales y los desafíos clínicos.

Por eso, ya no tiene sentido evaluar un equipo según su estabilidad formal, sino según su capacidad de sostener prácticas. Equipos que no se fundan en una pertenencia, sino en una co-implicación. Que no buscan homogeneizar posiciones, sino alojar diferencias. Que no se organizan en torno a una identidad compartida, sino en torno a una función colectiva, entendida como el arte de cuidar la posibilidad de trabajar con otros. Son equipos que se arman por contagio, por resonancia, por alianzas menores.

Claro que esto tiene consecuencias. No siempre hay continuidad. No siempre se puede prever el devenir de un equipo. Hay riesgos: dispersión, agotamiento, fragilidad. Pero convive con la potencia de hacer lugar allí donde no lo había, de generar una práctica entre quienes no se conocían, de alojar sin identidad previa. Si en tiempos sólidos la apuesta era la institución, en tiempos fluidos la apuesta es el lazo.

Este lazo —ligadura, conector, encuentro— no se apoya en la completud de los integrantes del equipo, sino en su falta. En el vacío que comparten, en la pregunta que los atraviesa, en la tarea que los convoca. No hay tradición que los sostenga, pero sí un deseo de practicar juntos, de pensar con otros, de habitar el terreno inestable del sufrimiento sin garantías, pero con compañía.

Tres viñetas de Ágora en tiempos de fluidez

El grupo de iniciantes

Una vez por semana, los viernes al mediodía, se reúne un grupo de acompañantes que comparten relatos de tratamientos con personas muy diferentes entre sí. Hay un marco institucional que los contiene,

pero no es eso lo que los convoca. Los llama la novedad y la incertidumbre. Todos vienen de experiencias diversas. No se conocen, pero cada encuentro habilita un tiempo y un espacio para poner en común eso que no tiene lugar en las historias clínicas.

Ese grupo no tiene un reglamento ni una línea teórica única, pero tiene una ética: la de escuchar sin juzgar, la de no dejar a nadie solo en la escena clínica, la de sostener la pregunta aunque no haya respuesta. A veces son quince, a veces treinta. Si bien hay una convocatoria explícita para la asistencia, no se toman registros. La gente espera para participar, hay deseo de volver. Se comparten situaciones, tensiones, perplejidades. Un acompañante trae la angustia que le dejó una madre que le gritó que se fuera. Otro habla de la dificultad para armar un lazo con un joven que no habla. En ese espacio, esos relatos no quedan como experiencias individuales, sino que son procesados colectivamente. Lo importante es que ahí, en ese vacío compartido, algo se tramita. Algo del orden del equipo aparece, sin que haya un equipo formalmente constituido.

Una coordinación que no ordena desde arriba

Cinco acompañantes comparten el seguimiento de un tratamiento. Hay algunos puntos de cruce y otros puntos reflejan perspectivas completamente independientes. Lo que los reúne no es una institución, ni un organigrama, ni siquiera un objetivo formal compartido. Lo que los sostiene como equipo es una figura de coordinación que, sin ejercer mando, cuida el lazo, aloja las diferencias y regula los tiempos de encuentro.

Las reuniones tienen carácter de obligatorias y se realizan con alguna sistematicidad: a veces con todos presentes, otras con quienes pueden. Se trata de un espacio más clínico que administrativo, más ético que operativo. Ahí se revisan escenas complejas, se comparten perplejidades, se arman hipótesis. La coordinación no impone una línea, sino que abre el juego, amplifica las voces, detecta los hilos que podrían ligarse.

No hay un saber que se administre desde arriba. Hay un cuidado por lo común que se construye cada vez, incluso en la discontinuidad. Un acompañante relata cómo se sintió desbordado en una salida; otro aporta una lectura que no había sido pensada; la coordinadora escucha, pregunta, a veces propone, pero sobre todo sostiene la posibilidad de ese encuentro.

En este espacio, el equipo no es anterior a la práctica: se constituye con ella, en ella. Y esa práctica, aunque fragmentada y fluida, logra componer una forma de hacer con otros, una forma de no quedar solos.

El espacio compartido que nunca fue formal

Durante más de dos años, un grupo de cinco acompañantes se cruzaba todos los viernes después de sus reuniones por caso, en distintos horarios, a la espera de los espacios comunes del equipo. Nadie les pidió reunirse, pero empezaron a hablar. Primero eran comentarios aislados, luego preguntas, después decisiones.

Con el tiempo, empezaron a generar recursos compartidos: el almuerzo de los viernes, una red informal de chats por WhatsApp, encuentros informales para divertirse pero donde intercambiaban experiencias. Nunca fueron reconocidos como “equipo”, pero sostuvieron prácticas colectivas, estrategias coordinadas, incluso posiciones políticas frente a decisiones de la organización. Ese espacio nunca fue oficial, pero fue real. Lo que los unía no era una estructura institucional, sino una práctica compartida nacida del deseo de no quedar solos.

Algunas conclusiones

Pensar la construcción de equipos en estos tiempos de fluidez es asumir que ya no hay fundamentos estables sobre los que se asiente el lazo. Que las formas tradicionales de agrupamiento —aquellas que suponían jerarquías fijas, continuidad institucional o pertenencia identitaria— ya no alcanzan para nombrar lo que hoy acontece en la práctica del Acompañamiento Terapéutico. Pero no se trata de lamentar la pérdida de estabilidad, sino de leer en esa transformación una posibilidad: la de inventar otros modos de comunidad, otras formas de coexistencia que respondan a la lógica de nuestro tiempo.

En este punto, el pensamiento de Deleuze nos ayuda a desarmar la nostalgia por lo sólido sin caer en la euforia de lo fragmentario. Nos enseña a rastrear en lo múltiple, en lo provisorio, en lo inconexo, las condiciones de posibilidad de algo común. A entender que el lazo no es una sustancia que se hereda, sino una producción que se crea. Y que esa creación no es un capricho individual, sino una política. Una política del encuentro, del afecto, del cuidado mutuo.

Así, los equipos no son entidades a las que se pertenece, sino prácticas que se ejercen. No son estructuras a las que se entra, sino espacios que se sostienen. Son más bien como esos puentes colgantes que se arman mientras se caminan: precarios, sí, pero reales. Y es en esa precariedad donde aparece, una y otra vez, la oportunidad de hacer lazo.

El Acompañamiento Terapéutico, con su raíz artesanal y su vocación por alojar lo singular, está particularmente preparado para asumir este desafío. Porque siempre fue una práctica en tensión, una clínica que se hace en el borde. Por eso, tal vez, sea también el terreno privilegiado para pensar —y para habitar— estas nuevas formas de estar con otros. No desde la seguridad de lo instituido, sino desde la potencia del encuentro.

Capítulo 11

LA ARTICULACIÓN CON LOS FINANCIADORES

Si bien una gestión saludable nos permite organizar mejor nuestro trabajo, comprender las condiciones materiales que lo sostienen y construir equipos menos expuestos al desgaste, también nos lleva a reconocer que nuestras prácticas no se desarrollan en el vacío, sino dentro de un sistema de salud heterogéneo, fragmentado y lleno de tensiones. En ese entramado, las obras sociales y las prepagas no son enemigos a vencer, sino actores necesarios, con quienes compartimos —aunque desde lugares distintos— la responsabilidad de garantizar el acceso a cuidados de calidad. Son instituciones que operan bajo lógicas propias, con criterios de evaluación, regulación y financiamiento que a veces no coinciden con los tiempos ni con los fundamentos clínicos del Acompañamiento Terapéutico. Pero justamente por eso, por ser parte del mismo sistema, es imprescindible conocer cómo funcionan, cómo se organizan, qué priorizan, qué solicitan, cómo dialogan con nuestras intervenciones y bajo qué condiciones las habilitan.

Lejos de una mirada ingenua o confrontativa, se trata de asumir que nuestra tarea clínica está entramada en una red de relaciones institucionales, legales y económicas que también debemos poder leer e interpretar. Cuanto más comprendamos las lógicas de estos actores, más capacidad tendremos de articular con ellos.

Sistema de Salud Argentino

Un sistema fragmentado, con múltiples lógicas en tensión

En Argentina, el sistema de salud está compuesto por tres grandes subsistemas: el sector público, el de la seguridad social (obras sociales) y

el sector privado (medicina prepaga). Cada uno con normativas, formas de financiamiento, lógicas de funcionamiento y criterios de legitimación propios. Esta coexistencia, lejos de ser armónica, genera una fragmentación estructural que impacta directamente en el acceso, la equidad y la continuidad de los tratamientos.

El Acompañamiento Terapéutico —como práctica clínica, comunitaria y situada— se ve particularmente afectado por estas tensiones. Se trata de un dispositivo que no encaja fácilmente en los esquemas tradicionales de atención, que suele desarrollarse en domicilios, escuelas o espacios comunitarios, que trabaja sobre la vida cotidiana más que sobre eventos puntuales, y que no siempre cuenta con manuales, protocolos ni tiempos estandarizados. Esto lo vuelve difícil de categorizar, de prescribir, de auditar y de financiar bajo los criterios que habitualmente manejan las instituciones que regulan las prestaciones en salud.

En esta ocasión nos vamos a estar ocupando de las obras sociales y las prepagas. Cada una de ellas —con distintos niveles de desarrollo, solvencia, y regulación— adopta decisiones respecto del AT según su interpretación del marco normativo, sus propios criterios técnicos y administrativos, y su capacidad de articular con profesionales externos. Algunas lo reconocen como una prestación dentro del Plan Médico Obligatorio o del régimen de discapacidad; otras lo consideran una práctica complementaria; muchas directamente lo invisibilizan o lo rechazan por no encajar en su lógica de funcionamiento.

A esto se suma una asimetría estructural: mientras el AT interviene desde una lógica clínica flexible, artesanal y situada, los financiadores suelen exigir informes con plazos, objetivos y criterios de evaluación que responden a una racionalidad más burocrática o a veces economista. Esta tensión no es necesariamente malintencionada: es expresión de que hablamos desde marcos de sentido distintos. Por eso, más que oponer frontalmente dos mundos, lo que necesitamos es construir puentes, encontrar modos de traducir nuestros fundamentos clínicos en formatos legibles para los sistemas de autorización y auditoría, sin desdibujar la especificidad del dispositivo.

Comprender las lógicas de financiamiento no es una tarea técnica secundaria. Es parte de nuestra responsabilidad como agentes implicados: saber cómo se legitiman las prácticas, qué regulaciones las enmarcan, qué actores intervienen, qué condiciones habilitan o impiden que un tratamiento se sostenga. No alcanza con prescribir un Acompa-

ñamiento Terapéutico si luego no hay quien lo autorice, quien lo pague, quien garantice su continuidad. Y no se trata sólo de una cuestión económica: lo que está en juego es el derecho de las personas a recibir una atención acorde a sus necesidades, y el derecho de quienes trabajan a hacerlo en condiciones dignas.

En este capítulo nos proponemos revisar críticamente las formas en que el Acompañamiento Terapéutico se inserta en el sistema de salud argentino, con especial atención a las obras sociales y a las empresas de medicina prepaga. No para juzgar ni idealizar, sino para comprender sus lógicas, identificar las tensiones recurrentes, y pensar estrategias que nos permitan dialogar con esos actores desde un lugar claro, argumentado y clínicamente fundamentado.

Si queremos que el Acompañamiento Terapéutico se consolide como una opción real dentro de los dispositivos de salud mental, necesitamos también disputar su lugar en los circuitos administrativos, en los criterios de financiamiento y en las políticas públicas que regulan el acceso al cuidado.

Obras sociales y prepagas en el sistema de salud argentino

Para comprender en qué condiciones se habilita —o se restringe— el acceso a los dispositivos de cuidado en salud mental, es imprescindible entender cómo funciona el sistema de salud argentino. En particular, resulta clave diferenciar dos figuras que muchas veces se confunden: las obras sociales y las empresas de medicina prepaga. Ambas pueden cubrir tratamientos de Acompañamiento Terapéutico, pero lo hacen desde lógicas diferentes, lo que impacta directamente en los modos de acceso, las autorizaciones, los tiempos de respuesta y las posibilidades de continuidad de los tratamientos.

Las obras sociales forman parte del sistema solidario de la seguridad social. Como su nombre lo indica, tienen en su origen una lógica solidaria y colectiva. Nacieron asociadas a estructuras sindicales y gremiales como una forma de organizar espacios de protección para los trabajadores en relación de dependencia. Se financian mediante aportes obligatorios de empleadores y empleados. Funcionan como instrumentos de redistribución interna entre los trabajadores afiliados a un gremio, en un modelo de salud en el cual cada persona aporta un porcentaje de

su salario, sin importar el nivel de ingreso, y todos reciben la misma atención médica.

Este modelo se funda en un principio profundamente igualitario: el gerente general y el trabajador de maestranza hacen aportes proporcionales a su ingreso, pero acceden a los mismos derechos en salud. En su concepción original, entonces, la obra social no es una empresa que vende un servicio, sino una herramienta de protección y cuidado colectivo, sostenida por la comunidad de trabajadores.

Su función es garantizar el acceso a prestaciones de salud a toda persona que trabaje formalmente o que tribute en calidad de Monotributista y acceda por esa vía a la obra social.

Por otro lado, las empresas de medicina prepaga se inscriben en el ámbito del mercado de salud. Se trata de entidades privadas que ofrecen distintos planes de cobertura a cambio del pago mensual de una cuota. A diferencia de las obras sociales, su afiliación es voluntaria y su lógica de funcionamiento está atravesada por criterios comerciales: se paga más por mayor cobertura, se accede a ciertos prestadores según el plan, y no todos los tratamientos son contemplados de base. Aunque están reguladas por la Ley N° 26.682, las prepagas no pertenecen al subsistema de seguridad social, sino al de provisión privada de servicios de salud.

La diferencia entre obras sociales y empresas de medicina prepaga no radica únicamente en su forma jurídica, sino que expresa dos modos profundamente distintos de concebir el acceso a la salud: por un lado, como derecho social, ligado al principio de solidaridad; por otro, como servicio de mercado, regido por la lógica del consumo individual. Sin embargo, y a pesar de esta distinción conceptual, sus dinámicas no siempre son fácilmente separables. En la práctica, conviven, se superponen, se articulan e incluso se confunden, generando un panorama fragmentado que impacta directamente en la atención en salud mental.

Para comprender cómo llegamos a esta situación, es necesario hacer un poco de historia. A partir de la década de 1990, el sistema de obras sociales comenzó a mostrar signos de un franco deterioro. No se trató solo de los efectos de la desregulación impulsada por el Estado, sino de un proceso más profundo: una crisis de legitimidad dentro del mundo gremial, particularmente en lo que respecta a la gestión de los recursos institucionales.

Así como muchas estructuras sindicales fueron perdiendo su capacidad de representar colectivamente a los trabajadores, las obras sociales

—que dependen de esos mismos gremios— empezaron a ser percibidas no ya como expresiones solidarias del movimiento obrero, sino como espacios opacos, a menudo asociados a lógicas clientelares o directamente a redes de corrupción. Fue sobre esa representación social —no siempre infundada— que se construyó la narrativa que habilitó políticamente la desregulación: si las obras sociales eran ineficientes, corporativas y manejadas por intereses particulares, entonces permitir la libre elección y someterlas a la competencia del mercado parecía un camino legítimo hacia su mejora. Ese fue el argumento que permitió instalar el debate legislativo que culminaría en la desregulación de las obras sociales en la década de 1990. La promesa era simple: si cada obra social debía competir por sus afiliados, entonces se vería forzada a mejorar su calidad prestacional, su eficiencia administrativa y su atención al usuario. Pero el resultado distó mucho de ese ideal. Lo que ocurrió en la práctica fue un proceso de segmentación y vaciamiento.

La desregulación de las obras sociales habilitó un mecanismo conocido como “descreme”, que favoreció la migración de los afiliados con mayores ingresos hacia el sistema de medicina prepaga. Esto fue posible gracias a convenios entre ciertas obras sociales y empresas prepagas, que permitían a los usuarios derivar su aporte sindical a esas obras sociales y, a cambio, recibir un descuento en la cuota mensual del seguro privado de salud. De esta manera, los sectores con mayor capacidad contributiva abandonaron progresivamente las obras sociales tradicionales, debilitando su financiamiento. Lo que quedó fue, en muchos casos, una base de afiliados con menores ingresos y mayores necesidades sanitarias, profundizando así el deterioro de esas estructuras solidarias.

El impacto sobre el sistema fue devastador: la pérdida de equidad en la distribución de los recursos, el vaciamiento progresivo de las estructuras propias de atención y, en muchos casos, la tercerización de servicios a través de convenios con prepagas forma parte de los efectos de la desregulación. Muchas obras sociales dejaron de gestionar salud directamente y se limitaron a funcionar como intermediarias que derivan su cápita a una empresa privada. El valor solidario original fue diluyéndose, y solo unas pocas obras sociales —aquellas con una fuerte decisión política y una gestión eficaz— lograron sostener una estructura propia que aún hoy da respuesta a las necesidades de su población afiliada.

Hoy, con tres décadas de distancia, resulta evidente que el efecto no fue la mejora de la calidad, sino el debilitamiento de un sistema soli-

dario, sin haber construido una alternativa pública universal que lo reemplace.

A diferencia de las obras sociales, las empresas de medicina prepaga funcionan bajo una lógica comercial clásica: son empresas privadas que venden seguros de salud, en un mercado competitivo. Su ecuación económica es directa: a mayor cantidad de afiliados y menor gasto en prestaciones, mayor rentabilidad.

Es importante comprender que a diferencia de una fábrica o empresa tradicional, cuya lógica comercial se basa en vender la mayor cantidad posible de productos para maximizar su rentabilidad, las empresas de medicina prepaga funcionan bajo un modelo inverso, más cercano al de un seguro que al de un mercado de bienes. En el sistema prepago, el ingreso se produce a través de las cuotas que los afiliados pagan mensualmente, mientras que el egreso está determinado por los servicios de salud que esos afiliados efectivamente utilizan. En otras palabras, cuanto más se use el servicio, mayor es el costo para la empresa, y cuanto menos se use, mayor es su ganancia.

Por eso, su rentabilidad no depende de “vender más salud”, sino de mantener una promesa de atención de alta calidad que, en la práctica, intenta administrarse al mínimo costo posible. Esto produce una tensión estructural: la prepaga debe presentarse como una prestadora de excelencia para atraer afiliados, pero su ecuación financiera interna se sostiene cuanto menos prestación efectiva brinda, o dicho de otro modo, cuanto más y mejor optimiza su recurso. Este modelo —donde se gana evitando que se consuma— diferencia radicalmente a las prepagas del sistema solidario original de las obras sociales. La salud deja de ser un derecho gestionado solidariamente y pasa a ser un servicio diferenciado según la capacidad de pago. La lógica del negocio obliga a estas empresas a ofrecer niveles crecientes de calidad en la atención —al menos en lo formal— para atraer nuevos clientes. Pero al mismo tiempo, su rentabilidad depende de contener costos, seleccionar riesgos y limitar prestaciones cuando es posible. De este modo, se explica muchos de los conflictos actuales en la relación entre las empresas de salud y sus afiliados, sobre todo cuando se trata de prestaciones prolongadas o de alta intensidad, como el Acompañamiento Terapéutico.

Tratamientos prolongados, salud mental y los límites estructurales del financiamiento

Tanto para las obras sociales como para las empresas de medicina prepaga, los tratamientos crónicos y prolongados —especialmente en el campo de la salud mental— constituyen un desafío estructural que tensiona los modelos de financiamiento vigentes. A diferencia de otras prácticas médicas que tienen inicio, duración y egreso definidos, muchos abordajes en salud mental —como el Acompañamiento Terapéutico— no pueden predecir con certeza la duración del tratamiento, ya que se inscriben en trayectorias vitales atravesadas por múltiples determinantes sociales, clínicos y subjetivos.

Esta particularidad implica que, desde el punto de vista administrativo, no es posible proyectar de manera lineal un presupuesto asociado a la intervención, ni tampoco anticipar cuándo terminará una prestación, ni cuánto costará a lo largo del tiempo. Esta imprevisibilidad, estructural al padecimiento psíquico y a las formas clínicas que lo abordan, entra en contradicción con la lógica de gestión de las entidades financiadoras, cuya planificación económica requiere criterios de previsibilidad y control presupuestario.

En el caso de las obras sociales, esta tensión se volvió especialmente delicada. Dado que muchas de estas instituciones, particularmente desde los 90 para acá, manejan estructuras con presupuestos acotados, un pequeño grupo de tratamientos crónicos intensivos —por ejemplo, varios afiliados con internación prolongada, Centros de día, Acompañamiento Terapéutico diario, etc.— podía representar una amenaza real para su sostenibilidad económica. Ante este panorama, y reconociendo que la lógica solidaria del sistema podía colapsar frente a casos de alto impacto financiero, se creó un sistema de reintegro colectivo entre obras sociales. Es un Fondo Solidario de Redistribución (FSR), al que cada obra social debe ceder entre el 15% y el 20% de los aportes y contribuciones que los trabajadores y sus empleadores hacen a la obra social. Con este fondo que administra la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) se financia el Sistema Único de Reintegro por Gestión de Enfermedades (SURGE), a partir del cual se le da apoyo financiero a las obras sociales nacionales en la cobertura de prestaciones médicas de baja incidencia pero alto impacto económico, así como en tratamientos prolongados en el tiempo.

En resumen, es un sistema organizado en torno a un principio simple pero potente: todas las obras sociales aportan un porcentaje de su facturación mensual a un fondo común, y ese fondo es luego utilizado para financiar prestaciones prolongadas y costosas, entre ellas todas las incluidas en el nomenclador de discapacidad. Esta lógica de redistribución interna permite que los costos no recaigan exclusivamente sobre la obra social de origen del paciente, sino que sean asumidos por el conjunto del sistema, protegiendo así su equilibrio general.

Sin embargo, este sistema de reintegros funciona exclusivamente para prestaciones que estén incluidas en el Nomenclador de Discapacidad. Y aquí aparece una cuestión crucial: el Acompañamiento Terapéutico no se encuentra incluido dentro de ese nomenclador. Eso significa que las obras sociales deben financiarlo con fondos propios, sin posibilidad de solicitar reintegro. Esta situación coloca la prestación en un lugar de alta fragilidad: aunque clínicamente sea fundamental, administrativamente se vuelve un gasto directo que la obra social debe asumir por su cuenta, lo que en muchos casos lleva a negar, reducir o limitar su indicación.

Paradójicamente, otras prestaciones que también pertenecen al campo de la salud mental —como el Apoyo a la Integración Escolar, cuando se canaliza a través de la figura del Integrador Escolar— sí están incluidas en el nomenclador, lo que permite que la misma obra social que rechaza un Acompañamiento Terapéutico prolongado acepte sin inconvenientes una prestación escolar de igual o mayor duración y costo, simplemente porque puede ser reintegrada por el sistema.

Esta asimetría normativa y económica genera efectos concretos en las decisiones de cobertura, en los modos en que se estructuran los tratamientos y en la accesibilidad real a los dispositivos clínicos. En términos prácticos, el lugar que una prestación ocupa en el entramado del financiamiento no depende solo de su valor terapéutico, sino de su posibilidad de ser reembolsada, facturada, clasificada.

A diferencia de las obras sociales, las empresas de medicina prepaga se constituyen como actores privados que operan bajo una lógica comercial, ofreciendo planes voluntarios a la población o gestionando afiliaciones a través de la derivación de aportes del sistema de seguridad social. Desde la entrada en vigencia del Decreto 600/2024, aquellas prepagas que reciben aportes y contribuciones provenientes del régimen de obras sociales —es decir, cuando el afiliado está en relación de dependencia y deriva sus aportes hacia la prepaga a través de una obra social

sindical o de dirección— están obligadas a realizar un aporte del 15 % al Fondo Solidario de Redistribución (FSR), en igualdad de condiciones que las propias obras sociales.

Esta medida busca equiparar las obligaciones entre los distintos agentes del seguro de salud, reconociendo que las prepagas que actúan como receptoras de aportes del sistema deben también contribuir al financiamiento solidario. El FSR es un fondo colectivo destinado a sostener el acceso a prestaciones de alto costo, baja incidencia o tratamiento prolongado, tales como medicamentos oncológicos, tratamientos por discapacidad, trasplantes o enfermedades poco frecuentes.

Sin embargo, a diferencia de las obras sociales, las empresas de medicina prepaga no acceden de forma automática a los mecanismos de reintegro gestionados por la Superintendencia de Servicios de Salud, como el Sistema Único de Reintegros (SUR). Su acceso a los recursos del FSR se encuentra limitado a las situaciones mencionadas, en las que actúan como prestadoras dentro del régimen de seguridad social, es decir, cuando el afiliado involucrado deriva aportes de su salario. En esos casos, pueden presentar solicitudes de reintegro bajo los mismos criterios que las obras sociales, siempre que acrediten el cumplimiento de los requisitos técnicos, administrativos y médicos exigidos por el sistema.

Esto implica que, aunque las prepagas aportan al fondo solidario en casos puntuales, no cuentan con el mismo respaldo estructural que las obras sociales para afrontar situaciones excepcionales. Al menos no con la masa de afiliados privados, que abonan su cuota mensual de modo directo. En estos casos, cada empresa debe asumir con sus propios recursos los tratamientos de alto costo que autorice, lo que las lleva a implementar mecanismos de control, auditoría y restricción más rígidos. Esta situación se vuelve particularmente crítica frente a prestaciones que no tienen un inicio, duración y egreso claramente delimitables, como es el caso del Acompañamiento Terapéutico.

En algunas ocasiones, las prepagas suscriben seguros o reaseguros privados para cubrir enfermedades catastróficas, pero se trata de acuerdos individuales, no transparentados para los afiliados y ajenos al control público. En este contexto, la tensión entre rentabilidad empresarial y derecho a la salud se hace especialmente evidente: los tratamientos prolongados en salud mental, que requieren continuidad y Acompañamiento sostenido, suelen ser los primeros en ser cuestionados, limitados o directamente negados.

Este contraste expone con claridad las diferencias estructurales entre un sistema de salud fundado —al menos en sus orígenes— sobre principios solidarios, y un sistema basado en la competencia y la lógica del rendimiento financiero.

El lugar de las auditorías: entre la administración del recurso y la ética del cuidado

En el entramado complejo del sistema de salud argentino, las auditorías ocupan un lugar tan técnico como decisivo. A menudo invisibilizadas por el funcionamiento cotidiano del sistema, son las auditorías las que, en última instancia, definen si una prestación será cubierta, qué duración tendrá, en qué condiciones será autorizada y cómo será evaluada. Más allá de lo que diga una ley, una resolución o un nomenclador, es en la figura del auditor donde el financiamiento se vuelve acto concreto.

Formalmente, la función de la auditoría es proteger el recurso económico de la institución —sea una obra social o una empresa de medicina prepaga—. Esto implica verificar que lo que se solicita tenga fundamentos clínicos, que se inscriba dentro de lo posible según los marcos prestacionales, que no se superpongan recursos innecesarios o que no se perpetúe una indicación sin evaluación. Desde este lugar, el auditor es una pieza clave en el equilibrio del sistema, porque debe resguardar la sustentabilidad del conjunto frente a un universo de demandas infinitas.

Sin embargo, esa definición técnica no agota el sentido de su tarea. En muchos casos —y afortunadamente en la experiencia de Ágora cada vez en más— los auditores son también profesionales de la salud con experiencia clínica, sensibilidad institucional y compromiso con las trayectorias de quienes están del otro lado del expediente. Su función ya no se limita a aplicar un criterio binario entre “autoriza” o “rechaza”, sino que se vuelve una práctica de lectura, de análisis y de diálogo entre mundos que muchas veces no hablan el mismo idioma: la administración y la clínica, la norma y la singularidad, el presupuesto y el padecimiento.

En esa encrucijada, la calidad de la auditoría no depende exclusivamente de las políticas de la institución, sino del criterio humano y profesional de quien ocupa ese rol. Por eso, una misma obra social

puede ofrecer experiencias muy distintas según quién audita, cómo se posiciona y qué margen se da para sostener la complejidad de lo real.

Desde esa perspectiva, podríamos decir que la ética de una institución se juega, en gran parte, en su mesa de auditoría. Es ahí donde el sistema de salud, en su dimensión financiera, se encuentra con los relatos clínicos, los informes de Acompañamiento, las justificaciones de tratamiento, las demandas familiares, los tiempos subjetivos. Y es en esa instancia donde se define, finalmente, si la salud es entendida como un gasto o como un valor.

El auditor —cuando asume su función desde esta complejidad— cuida el recurso, sí, pero lo cuida no solo para la institución, sino también para la persona que lo necesita. No se trata de autorizar por inercia ni de rechazar por sistema, sino de sostener una práctica situada, fundada, que dé cuenta tanto del sentido clínico como del cuidado colectivo.

Claro que ese mismo auditor, luego, debe responder ante su institución, justificar sus decisiones y, muchas veces, traducir al lenguaje administrativo situaciones que no siempre encajan en los criterios clásicos de costo-efectividad. Ahí se revela otra dimensión de su tarea: la de mediador entre lógicas, la de quien busca construir sentido común entre quienes leen planillas y quienes trabajan con el sufrimiento humano.

En definitiva, el lugar de la auditoría es mucho más que un trámite. Es un punto de inflexión en el circuito de salud, donde las decisiones tienen impacto directo en la continuidad o interrupción de un tratamiento, en la posibilidad o no de acceder a una intervención necesaria, en la tranquilidad o la angustia de una familia. Que esa instancia sea habitada con humanidad, conocimiento y responsabilidad clínica no solo es indispensable para que el sistema no se vacíe de su razón más profunda, que es cuidar la vida en condiciones dignas.

Construir una relación de diálogo y alianza con los auditores del sistema de financiamiento de la salud no solo es estratégico: es fundamental para que los tratamientos puedan sostenerse y avanzar en condiciones reales de cuidado. En la medida en que comprendemos el funcionamiento interno del sistema, los marcos normativos que lo regulan y las obligaciones que debe responder cada auditor, también podemos convertirnos en interlocutores clínicos válidos, capaces de traducir la complejidad del padecimiento en criterios que habiliten respuestas concretas. Armar equipo con la auditoría no significa ceder en lo clínico, sino habilitar una interlocución que potencie el acceso y la continuidad

de las prestaciones. Y aunque puede haber diferencias, tensiones o decisiones no compartidas, lo que no puede faltar es la confianza mutua para argumentar, revisar y volver a pensar juntos qué es lo mejor para quien está en el centro de todo esto: el paciente.

Capítulo 12

LA GESTIÓN COMO HERRAMIENTA DE ARTICULACIÓN

La apuesta por una gestión organizada del equipo: el Acompañamiento Terapéutico y su vínculo con obras sociales y prepagas

Los financiadores del sistema de salud —obras sociales y prepagas— cumplen un rol estratégico en la arquitectura sanitaria de la Argentina. Su función es, administrar recursos económicos con el objetivo de garantizar prestaciones de salud para su población afiliada. En ese sentido, su tarea debería orientarse a lograr la mayor cobertura, calidad y eficacia posibles en función de un principio de equidad.

El Acompañamiento Terapéutico es, dentro del sistema de salud, una prestación más; sin embargo, su lugar es profundamente singular. A diferencia de otras prácticas estandarizadas —como las consultas médicas, los estudios diagnósticos o las terapias convencionales—, que suelen organizarse en unidades de tiempo precisas y delimitadas, el Acompañamiento Terapéutico se inscribe en una lógica distinta, ya que interviene en lo cotidiano, se construye en el vínculo, y trabaja sobre la experiencia subjetiva y la complejidad de lo real. Aunque administrativamente se lo reconozca por hora, el tiempo clínico que implica no puede ser protocolizado en cronogramas rígidos. Determinar cuánto tiempo de Acompañamiento es el “correcto” no es una medida objetiva ni universalizable. Depende de múltiples variables clínicas, contextuales y subjetivas, y por lo tanto requiere siempre de un criterio profesional situado, que articule la necesidad del paciente, los recursos disponibles y el sentido que va tomando el dispositivo a lo largo del proceso. Esta condición lo convierte en una práctica difícil de codificar, pero imprescindible allí donde otros formatos no alcanzan.

Esta volatilidad que presenta la estructuración de los Acompañamientos no siempre es bien recibida por los financiadores. De hecho, la heterogeneidad de formaciones y modalidades de ejercicio profesional en el campo del AT genera, muchas veces, desconfianza o incertidumbre en relación a su “rendimiento” como prestación. La realidad del campo AT se caracteriza por un nivel de heterogeneidad profesional excesivo. Desde hace algunos años se observan algunos avances en la homologación de títulos, en el surgimiento de algunas leyes locales, pero pese a ello, las diferencias en formación, encuadre, criterios de intervención, estilo clínico y posicionamiento ético generan una dispersión que afecta no solo la práctica misma, sino también la posibilidad de su legitimación institucional. Para los financiadores del sistema de salud —obras sociales y empresas de medicina prepaga— esta heterogeneidad es un problema.

¿Qué es lo que se paga cuando se financia un Acompañamiento? ¿Cómo se mide su efectividad? ¿Cómo se garantiza la idoneidad del recurso? Estas son preguntas que el sistema no ha resuelto del todo, y que se suelen saldar, en la práctica, con estrategias defensivas.

Una de las estrategias más extendidas consiste en delegar en las familias la elección del recurso profesional. Bajo el argumento de que “nosotros lo cubrimos, ustedes lo consiguen”, los financiadores se desligan de toda responsabilidad directa sobre la calidad del servicio. De ese modo, el vínculo entre prestación y efectividad queda librado a la suerte, al conocimiento previo, o a la recomendación informal. La figura del AT queda así privatizada, externalizada, fragmentada, y el sistema se blindo frente a posibles reclamos, desviando la demanda hacia quien la gestiona de modo individual. Es decir, lo que debería ser una responsabilidad del sistema —la provisión de servicios adecuados, accesibles y seguros— se convierte en una demanda individual que recae sobre quienes, muchas veces, se encuentran en una situación de urgencia o desborde.

Frente a esta realidad compleja, proponemos construir y ofertar a los financiadores una forma de organización colectiva que pueda asumir la responsabilidad de estructurar dispositivos con criterio clínico, sin delegar la tarea en las familias. La decisión de pensar la práctica del Acompañamiento Terapéutico desde una perspectiva de gestión organizada es una apuesta clínica y política: articular a un conjunto de profesionales, generar criterios comunes, producir formación interna, establecer estándares mínimos de calidad y construir un modelo de intervención reconocible para quienes lo financian. Esto no implica burocracia.

tizar la práctica ni homogeneizar los modos de hacer, sino dar un marco que la vuelva sostenible, legible y defendible.

De este modo y con esta perspectiva, se diseña un dispositivo que pueda ser presentado como producto institucional, con un encuadre claro, un equipo con reuniones periódicas, un sistema de supervisión, criterios de admisión y alta, y protocolos de articulación con los demás actores del sistema de salud. Este movimiento es clave para ofrecer a las obras sociales una alternativa distinta al modelo disperso e informal: un dispositivo profesional, clínico, comunitario, pero también gestionado con responsabilidad y criterio.

En este modelo, el Acompañamiento Terapéutico no aparece como un recurso aislado, sino como parte de una propuesta de atención integral. Esta perspectiva de gestión organizada no solo mejoró la relación con los financiadores, sino que permitió algo quizás más importante: brindar mayor seguridad a las familias y a los propios acompañantes, que ya no dependen únicamente de acuerdos personales y vínculos individuales, sino que se insertan en una lógica colectiva que respalda su tarea.

El desafío actual consiste en construir un lenguaje común entre la clínica y la gestión, sin sacrificar la singularidad de la práctica ni ceder ante la lógica del rendimiento vacío. El Acompañamiento Terapéutico tiene mucho para ofrecer como parte de un sistema de salud inclusivo y territorializado, pero para ello necesita ser defendido y sostenido, tanto en su dimensión ética como en su viabilidad institucional.

La experiencia nos permite pensar que la gestión organizada de equipo no es lo opuesto a la clínica, sino que puede ser una forma de cuidar el dispositivo, de garantizar su continuidad y de sostener su dimensión ética incluso en contextos de fragmentación y precariedad. Gestionar es, en este sentido, también una forma de acompañar.

Modelos posibles de vinculación entre equipos de Acompañamiento Terapéutico y financiadores de la salud

Podemos delinear distintos modelos posibles de vinculación entre equipos organizados de Acompañamiento Terapéutico y los financiadores de la salud —sean obras sociales o empresas de medicina prepaga—. Frente a la fragmentación y dispersión que históricamente caracterizaron al campo, estas estrategias aparecen como intentos de construir

modalidades de articulación más responsables, sostenibles y clínicas, capaces de alojar tanto la singularidad del padecimiento como la necesidad de organización institucional.

Uno de los modelos más deseables —aunque aún poco frecuente— es el del “Convenio directo” entre el financiador y un equipo institucional de Acompañamiento Terapéutico. En estos casos, se formaliza un acuerdo con un colectivo profesional que cuenta con encuadre clínico, espacios regulares de supervisión, coordinación responsable y un plantel de profesionales con formación adecuada. Esta modalidad permite no solo mejorar la trazabilidad de los tratamientos, sino también garantizar mayor control de calidad por parte del financiador, al tiempo que ofrece un marco de contención más sólido para los afiliados y sus familias. Para que este modelo funcione, es imprescindible que el equipo se encuentre jurídicamente constituido, que existan estándares mínimos de práctica acordados, y que cuente con capacidad de respuesta ante auditorías o requerimientos institucionales.

Otra estrategia posible es la construcción de un Registro Preferencial de Prestadores Organizados. En este esquema, la obra social define un listado de profesionales o equipos con los que prefiere trabajar, priorizando aquellos que cuentan con algún tipo de aval institucional, funcionamiento interdisciplinario o supervisión clínica. Este modelo tiene la virtud de preservar cierta autonomía del afiliado en la elección de su acompañante, al mismo tiempo que reduce el riesgo de prácticas aisladas, difíciles de evaluar o sostener en el tiempo. Para implementarlo, los financiadores suelen establecer criterios claros de ingreso al registro, así como promover espacios de formación continua y mecanismos concretos de evaluación del desempeño profesional.

En algunos casos, lo que se desarrolla es una articulación mixta, donde la obra social acepta Acompañamientos propuestos por las familias, pero exige que estos estén vinculados a un equipo de referencia que pueda ofrecer informes institucionales, garantizar supervisión clínica y participar de reuniones de coordinación. Esta modalidad respeta las redes de confianza y los recorridos previos de los usuarios, pero a la vez ofrece un marco más robusto para el seguimiento y la evaluación. Para que esta estrategia sea efectiva, es clave documentar la pertenencia del profesional a un equipo organizado, sostener espacios regulares de articulación, y asegurar una figura responsable para la producción de informes y el diálogo con el sistema.

Por último, debemos señalar que el modelo más difundido en la actualidad —aunque el menos deseable desde el punto de vista clínico y organizativo— es el de la “Tercerización no regulada”. En este esquema, el financiador se limita a pagar la prestación una vez que el afiliado ha conseguido por su cuenta un acompañante, sin mediar ninguna instancia de recomendación, supervisión o coordinación. Este modelo traslada toda la carga organizativa a las familias, no garantiza la calidad clínica de la intervención y deja al acompañante en una situación de aislamiento y precariedad profesional. Aunque sea funcional a la lógica administrativa —porque reduce la responsabilidad del financiador—, no construye un sistema de salud sólido, ni ofrece condiciones adecuadas ni para quienes acompañan ni para quienes son acompañados.

Modalidad de operación	Características principales	Implicancias para el AT	Impacto en la familia/afiliado
Delegación total a la familia	No articula ni recomienda prestadores. Financia post-facturación	Práctica informal, precarización del profesional	Alta carga organizativa y emocional sobre la familia
Tercerización con prestadores contratados	Intermedia con empresas o instituciones tercerizadas (no especializadas en AT)	El AT queda subordinado a estructuras externas	Puede haber accesibilidad, pero con baja calidad clínica
Registro de prestadores autorizados	Crea una base de acompañantes aprobados para garantizar calidad mínima	Mayor legitimidad, posibilidad de evaluación	Brinda orientación y contención, aunque con menor flexibilidad
Convenio directo con equipos organizados	Acuerda directamente con colectivos de AT con encuadre institucional	Alta articulación clínica, mejor supervisión y seguimiento	Garantiza calidad, sosten institucional y mayor continuidad
Modelo mixto con validación institucional	Acepta propuestas individuales, pero exige pertenencia a un equipo con encuadre y supervisión	Mayor legitimidad, posibilidad de evaluación	Brinda orientación y contención, aunque con menor flexibilidad

En definitiva, los distintos modelos de vinculación entre equipos de Acompañamiento Terapéutico y financiadores no son meros esquemas administrativos: expresan concepciones más amplias sobre el lugar que el sufrimiento psíquico, la organización del cuidado y la ética profesional ocupan en el sistema de salud. Allí donde se logra construir una relación institucional basada en el reconocimiento mutuo, el trabajo en red y la responsabilidad compartida, se abre la posibilidad de sostener tratamientos más sólidos, accesibles y clínicamente consistentes. Por el contrario, cuando prevalece la lógica del aislamiento, la tercerización sin criterio o la delegación individualizada en las familias, se profundiza la fragmentación y se precarizan tanto la tarea como la experiencia de quien padece.

El desafío sigue siendo el de articular lo singular con lo colectivo, lo clínico con lo institucional, y lo ético con lo posible. Apostar a formas de organización que valoren el trabajo en equipo, el encuadre profesional y la construcción de interlocuciones claras con los financiadores es también una forma de defender el derecho a una salud mental digna, compleja y humanamente alojada.

La negociación de los honorarios: entre la lógica del mercado y la ética del cuidado

La relación entre un equipo organizado de Acompañamiento Terapéutico y los financiadores de la salud nunca es neutral. Se trata de un vínculo donde se ponen en juego no solo condiciones económicas, sino también formas de reconocimiento, legitimidad y poder dentro del sistema de salud. Cuando un equipo sostiene una cantidad significativa de pacientes derivados por un mismo financiador —50 o 60 afiliados en simultáneo—, esa relación se vuelve estructural. El equipo depende del financiamiento para garantizar su subsistencia, y la obra social se apoya en el equipo para responder a una demanda compleja que excede sus marcos tradicionales de atención.

En este escenario, se configuran relaciones de fuerza asimétricas, pero interdependientes. La obra social o seguro de salud ocupa una posición dominante en tanto agente de financiamiento: tiene el poder de aceptar, rechazar o demorar las prestaciones; de regular los pagos; de modificar criterios de facturación. Pero el equipo también se vuelve

una pieza clave: al centralizar la demanda de AT, ofrece una solución concreta, profesionalizada y controlable frente a un universo que muchas veces la propia obra social no sabe —ni puede— gestionar. El equipo, en ese sentido, reduce el riesgo institucional de la obra social, aporta trazabilidad, produce informes, responde a auditorías y articula con los demás efectores del sistema.

En este marco, la negociación sistemática de honorarios se convierte en un momento clave donde se ponen en juego tres dimensiones: clínica, política y económica. Entender esta tríada permite dimensionar no solo las tensiones propias de la negociación, sino también los márgenes de maniobra posibles para transformar esa relación en un vínculo más equilibrado, ético y sustentable.

Desde la coordenada clínica, la legitimidad del equipo no proviene, en la mayoría de los casos, de un reconocimiento institucional formalizado, sino de la continuidad práctica de las derivaciones. La acumulación de experiencias exitosas, la capacidad de sostener tratamientos complejos y la disposición a intervenir en situaciones de alta vulnerabilidad —como externaciones, urgencias o casos judicializados— hacen que el equipo termine cumpliendo una función operativa dentro del sistema, incluso en sus márgenes más difíciles. Esa legitimidad fáctica, construida en la práctica y sostenida en el tiempo, puede y debe convertirse en capital negociador. No se trata de una amenaza (“sin nosotros no pueden”), sino de una afirmación clínica: el trabajo realizado impacta positivamente en la salud de los afiliados, descomprime el sistema de internación y permite construir tratamientos territorializados que muchas veces el sistema no está en condiciones de ofrecer por sí solo.

En paralelo, la coordenada económica introduce un conjunto de tensiones inevitables. Para las obras sociales, el Acompañamiento Terapéutico suele ser una prestación costosa, sobre todo cuando implica varias horas semanales. Muchas veces representa un gasto mayor que una consulta psiquiátrica o psicológica convencional. Así, aunque se reconozca su eficacia, las áreas médicas y administrativas tienden a ajustar su financiamiento al mínimo posible, en un intento constante por controlar egresos. Este escenario se vuelve aún más complejo ante la ausencia de nomencladores oficiales o aranceles de referencia específicos para el AT, lo que deja a los equipos en una zona gris, donde todo se negocia artesanalmente, sin marcos claros ni reglas compartidas. En ese terreno, el pedido de recomposición de honorarios en función de la

inflación, la complejidad del trabajo o la profesionalización de los acompañantes suele chocar con lógicas de presupuesto que priorizan el corto plazo por sobre la calidad del tratamiento.

Finalmente, la coordinada política remite al tipo de vínculo que se establece entre el equipo y el financiador. La concentración de un número alto de pacientes derivados por una sola obra social puede ser una oportunidad estratégica, pero también una fuente de riesgo estructural. Cuando una única entidad concentra un porcentaje significativo de los ingresos del equipo, se genera una relación de dependencia económica que puede limitar su capacidad de acción y su margen de negociación. El temor a represalias —como demoras en pagos, baja de prestaciones o exigencias arbitrarias— instala una forma de fragilidad que va más allá de lo financiero: afecta la autonomía clínica e institucional del colectivo.

El desafío, entonces, es transformar esa relación asimétrica en un vínculo más simétrico y respetuoso, que reconozca al equipo como prestador institucional, no como una sumatoria de monotributistas aislados. Para eso, resulta indispensable avanzar en la formalización de convenios marco que incluyan aranceles actualizados, criterios de trabajo consensuados, mecanismos de auditoría y procedimientos claros para la resolución de conflictos. También es clave construir indicadores propios de calidad clínica, capaces de dar cuenta del valor singular que aporta el Acompañamiento Terapéutico, más allá de lo cuantificable. Y, por último, articular con otras redes de Acompañamiento Terapéutico permite evitar la competencia precarizante, fortalecer posiciones colectivas y sostener criterios profesionales que dignifiquen la tarea y amplíen el derecho a la salud mental de quienes acompañamos.

Algunas estrategias para negociar con legitimidad y cuidado

Es importante reconocer que toda negociación se encuentra inevitablemente atravesada por el contexto social en el que se desarrolla. No es posible pretender aumentos sostenidos ni defender un esquema intocable de honorarios cuando, a nivel social, se vive un proceso generalizado de deterioro en las condiciones de vida. La inflación, el empobrecimiento de amplios sectores, la retracción del gasto público y el achicamiento de los sistemas de salud también afectan a los financia-

dores, que se ven forzados a administrar sus recursos en un escenario cada vez más restrictivo. Negociar de manera responsable implica leer ese contexto, asumir sus tensiones y no perder de vista que la sustentabilidad de una práctica no puede sostenerse a costa del colapso del sistema que la financia. Se trata, entonces, de encontrar un equilibrio dinámico entre la defensa de la dignidad profesional y la comprensión de los límites estructurales que impone la realidad. Una ética de la negociación no puede estar desconectada de una ética de lo colectivo.

Sostener una negociación saludable con los financiadores de la salud —en particular con las obras sociales y las prepagas— requiere algo más que reclamar aumentos o discutir tarifas. Supone construir una estrategia económica que esté en sintonía con la ética del cuidado, la sostenibilidad del dispositivo y la dignidad de quienes lo sostienen. Esa estrategia puede organizarse en torno a tres pilares fundamentales, que no solo ordenan la negociación, sino que le dan sentido clínico e institucional.

El primer aspecto a considerar es la definición de un honorario que se ubique dentro de un rango medio de mercado. En un campo caracterizado por la dispersión de valores, es importante evitar tanto la precarización por debajo del umbral de dignidad, como el aislamiento que produce colocarse por encima de los márgenes accesibles para los financiadores. Mantener un valor razonable, consensuado y sostenido permite, al mismo tiempo, garantizar la continuidad de las derivaciones, evitar negociaciones constantes caso por caso y posicionarse como un interlocutor clínico serio, confiable y predecible. Esta elección no implica resignar calidad, sino todo lo contrario: es una forma de alinear el valor económico de la prestación con el valor simbólico y profesional del Acompañamiento Terapéutico, que debe ser accesible, reconocido y sostenido.

Un segundo eje estratégico consiste en vincular las actualizaciones de honorarios con alguna referencia compartida. Esta decisión introduce una referencia externa, colectiva y legitimada que permite ordenar los procesos de ajuste sin quedar a merced del malestar económico del momento. En lugar de depender de negociaciones individuales o de la presión de circunstancias particulares, referenciarse en un lugar tercero —aunque no sean específico del AT— aporta un criterio operativo, reconocible por los financiadores y ajustado al contexto general del sistema de salud. Esta práctica no solo reduce el desgaste de los reclamos aislados, sino que favorece una negociación previsible, transparente y menos expuesta a conflictos innecesarios.

Por último, es fundamental comprender que la negociación económica forma parte del cuidado clínico del dispositivo. Sostener condiciones laborales estables, evitar la lógica del “salvataje económico”, garantizar previsibilidad en los ingresos y respetar la tarea profesional son elementos que inciden directamente en la calidad de los tratamientos y en la permanencia de los acompañantes dentro del equipo. El valor que se asigna a una hora de trabajo no puede ser pensado como una cifra aislada, sino como una expresión concreta del lugar que se le da a la clínica del lazo en el sistema de salud. En este sentido, negociar no es un acto meramente económico, sino una forma de hacer política desde lo institucional, de defender prácticas dignas y de construir un espacio de trabajo ético y sostenido.

En definitiva, para construir relaciones de negociación más equilibradas con los financiadores, no alcanza con reclamar mejores condiciones: es necesario desplegar estrategias claras, organizadas y colectivas, que hagan del acto de gestionar un modo de sostener el compromiso clínico.

Disputar el lugar del AT en el sistema de salud

Lo que este recorrido nos permite advertir es que el reconocimiento del Acompañamiento Terapéutico en el sistema de salud argentino no depende únicamente de su eficacia clínica o de su encuadre legal, sino del modo en que esa práctica logra inscribirse —o no— en un entramado complejo de regulaciones, decisiones administrativas, criterios de financiamiento e interlocuciones institucionales.

Tanto en el campo de las obras sociales como en el de las prepagas, el AT habita una zona ambigua: a veces reconocido, a veces tolerado, muchas veces ignorado o rechazado. Esa ambigüedad no es casual ni accidental: responde a tensiones estructurales entre una práctica clínica que se define por su singularidad, su proximidad, su orientación ética, y sistemas de cobertura que se rigen por principios de estandarización, control, eficiencia y rentabilidad.

En este punto, replegarse en una lógica de queja o adoptar una actitud puramente técnica no alcanza. Lo que se impone es construir una posición que combine solidez clínica, claridad conceptual y capacidad de interlocución estratégica. No para negociar a cualquier precio,

sino para sostener, desde dentro de las condiciones reales, las condiciones de posibilidad de nuestra práctica.

Eso implica formar equipos capaces de presentar un informe que no pierda sentido clínico por querer ser legible. Implica leer una resolución con la misma atención con la que leemos un síntoma. Implica saber cuándo insistir, cuándo traducir y cuándo disputar.

Pero sobre todo, implica no dejar en manos de los otros la definición de qué es el Acompañamiento Terapéutico. Porque cuando no hay interlocución, alguien más define por nosotros: el auditor que pide un alta anticipada, la prepaga que limita las horas, la obra social que exige una planificación cerrada. Y no lo hace por maldad, sino porque habla desde otro lenguaje, desde otra racionalidad.

Nuestro desafío es construir las condiciones para que el Acompañamiento Terapéutico pueda desplegar su potencia en el sistema de salud actual, sin perder su especificidad ni su ética de trabajo. Para eso, necesitamos herramientas clínicas, jurídicas, administrativas, pero también políticas. Porque esta no es sólo una tarea profesional: es una tarea colectiva, situada e histórica.

Disputar el lugar del Acompañamiento Terapéutico en el sistema de salud es disputar también el modelo de atención en Salud Mental que queremos construir. Uno que no se limite a responder síntomas, sino que habilite vida. Uno que no se mida solo en eficiencias, sino en encuentros. Uno que no borre lo que incomoda, sino que lo aloje. En ese horizonte, la gestión y la articulación institucional no son obstáculos, sino parte del camino.

BIBLIOGRAFÍA

- Alcuaz, C. (2021). Otra sociedad para la locura. Estudio sobre los lazos sociales en la psicosis. Xoroi Ediciones.
- Arendt A. "La condición humana". Ed Paidós, 1957
- Badiou, A. (2008). Lógicas de los mundos: el ser y el acontecimiento, 2. Manantial
- Basaglia, F. (1983). La utopía de la realidad. In Anales de filosofía. Murcia: Universidad, Secretariado de Publicaciones.
- Berenguer, E. (2018). Primera sesión del seminario. En ¿Cómo se construye un caso? Seminario teórico y clínico. NED Ediciones.
- Berger, P. L., Luckmann, T., & Zuleta, S. (1968). *La construcción social de la realidad* (Vol. 975). Buenos Aires: Amorrortu.
- Bion, W. Diferenciación entre las personalidad psicóticas y no psicóticas. En: Volviendo a pensar. Ediciones Horme, Buenos Aires, 1977
- Bourdieu, P., & Bourdieu, P. (1983). *Campo del poder y campo intelectual* (pp. 11-35). Buenos Aires: Folios.
- Buschini, M. y Mitre, J. (2018). El analista y lo social: una política del vacío. En El analista y lo social. Grama Editorial. Disponible en: <https://www.elsigma.com/hospitales/el-analista-y-lo-social-una-politica-del-vacio/12890>
- Di Ciaccia A., "A propos de la pratique á plusieurs", intervención pronunciada en la "Rencontre PIPOL" del 20 junio 2003 en París, en la sección RI3. Jornadas de estudio sobre el psicoanálisis aplicado promovida por la Fondation du Champ Freudien y de la École de la cause freudienne, por el Programme International de recherche sur la Psychanalyse appliquée d'Orientation Lacanienne (PIPOL). https://psicoanalisislacaniano.com/2003/06/20/adiciaccia-practica-entre-varios-20030620/#_ftn1
- Freud, S. (1900) "La interpretación de los sueños" punto VII En obras completas, tomo V, Amorrortu editores, Buenos Aires 1979.
- Freud, S. (1929-1930) "El malestar en la cultura" En Obras completas Tomo XXI, Amorrortu editores, Buenos Aires, 1979
- García, G., El curso de las pasiones, Fundación Descartes en 1999, <http://www.descartes.org.ar/germangarcia/assets/files/1999-lcursodelaspasionesPDF.pdf>
- García, G., *El curso de las pasiones*, Fundación Descartes en 1999, <http://www.descartes.org.ar/germangarcia/assets/files/1999-lcursodelaspasionesPDF.pdf> Grama ediciones.
- Kuras de Mauer, S., & Resnizky, S. (1985). Acompañantes terapéuticos y pacientes psicóticos: manual introductorio a una estrategia clínica. Buenos Aires: Trieb
- Kuras de Mauer, S., & Resnizky, S. (2003). Acompañantes terapéuticos actualización teórico-clínica. Letra viva.
- Lacan J. Libro XVI: El reverso del psicoanálisis". Ed. Paidos, 1992
- Lacan, J. Breve discurso a los psiquiatras. Inédito, 1967.

- Lacan, J. El Seminario, Libro XVII: El reverso del psicoanálisis. Editorial Paidós, 1992.
- Lewkowicz, I. (2004). Pensar sin Estado: la subjetividad en la era de la fluidez. Paidós
- Ley Básica de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N.º 153. (1999). Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 7 de diciembre de 1999. <https://buenosaires.gob.ar/sites/default/files/media/document/2019/10/24/a0198d9e24ed9842512da8328581e9c2c2734a8c.pdf>
- Ley de Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud N.º 26.529. (2009). Boletín Oficial de la República Argentina, 21 de octubre de 2009. <https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-26529-160432>
- Ley de Salud Mental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N.º 448. (2000). Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 12 de julio de 2000. <https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/8111>
- Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657. (2010). Boletín Oficial de la República Argentina, 3 de diciembre de 2010. <https://www.argentina.gob.ar/salud/hospital-carrillo/informacion-util-hcrc/ley-de-salud-mental-26657>
- Lombardi, G. Delirio y lazo social. La mediación de lo imposible. Revista Universitaria de Psicoanálisis. Vol. I. Facultad de Psicología, UBA. Buenos Aires
- Manonni M. Psicosis infantil, Nueva Visión, Buenos Aires, 1980
- Miller, J.A (1999). Las contraindicaciones al tratamiento psicoanalítico.
- Mitre, J. (comp.) (2024). Formación del analista y prácticas en salud mental.
- Nietzsche, F. (2024). *El ocaso de los ídolos: cómo se filosofa a martillazos*. JOP.
- Peusner P. “Reinventar la debilidad mental”, Ed. Letra Viva, Buenos Aires, 2010
- Peverelli, M. Minervino, L. Safa, D. *Propuestas para un modelo educativo en acompañamiento terapéutico: de la experiencia al concepto*. Presentación en el Congreso Internacional de Acompañamiento Terapéutico: Clínica de las fronteras, caminos del AT en lo cotidiano. Córdoba, Argentina, 2015
- Pichon-Rivière, E. (1971). *El proceso grupal*. Buenos Aires: Nueva Visión.
- Pulice, G., & Rossi, G. (1994). Acompañamiento terapéutico: aproximaciones a su conceptualización: presentación de material clínico. Buenos Aires: Xavier Bóveda
- Pulice, G., Rossi, G. & Manson, F. (1995). Primer Congreso Nacional de Acompañamiento Terapéutico: hacia una articulación de la clínica y la teoría. Buenos Aires: Ediciones Las tres lunas
- Quinet, A. Psicosis y lazo social. Editorial Letra Viva. Buenos Aires, 2016
- Revista El Caldero de la Escuela, (69). Pp. 7-13.
- Rossi, G. P. (2007). Acompañamiento terapéutico: lo cotidiano, las redes y sus interlocutores. Polemos
- Rovere, M. R. (2006). Planificación estratégica de recursos humanos en salud. Segunda edición ampliada y corregida. OPS
- Rubinstein, A. La construcción de caso: psicoanálisis e investigación. En: La terapéutica: efectos y terminaciones. Editorial JCE, Buenos Aires, 2012.
- Tatián, D., La cautela del salvaje. Pasiones y política en Spinoza, Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2001 (reed. en Colihue, Buenos Aires, 2015).
- Tatián, D., *La cautela del salvaje. Pasiones y política en Spinoza*, Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2001 (reed. en Colihue, Buenos Aires, 2015).

PARA CONTACTOS CON EL AUTOR DEL LIBRO Y SUS COLABORADORES...

Maximiliano Peverelli - maxpeverelli@fundat.org.ar

Lucas Minervino - lucminervino@gmail.com

Bruno Pietracatella - brunopietracatella@hotmail.com

Miranda Soriano Dagnino - mirandasorianodagnino@gmail.com

Franco de Negri - francodenegri99@gmail.com

Natalia Rotbard - nataliarotbard@gmail.com

Carlos Bove - cabove1981@hotmail.com

María Noelia Gómez González - mngomezg@gmail.com

Nicolas Isla - lic.nicolas.isla@gmail.com

Rodrigo Santillan - santillanrodrigo@yahoo.com.ar

Laura Ramirez Montoya - Laruramarcelarm5@gmail.com

Ezequiel Urribarri - ezequielurribarri@fundat.org.ar

Analia Lopez - lucminervino@gmail.com

Vanesa Carballo - vsacarballo@gmail.com

